

中医概念入门

李文强

电子版制作时间：2025-02-19

中医概念入门

作者简介

书评节选

绪言

第一章 阴阳平衡

第二章 天地自然

第三章 中医人体观念

3.1 人体基本概念及运转机制

3.2 人体元气

3.3 人体地气

3.4 人体天气

3.5 精

3.6 神

第四章 人体运行框架

第五章 人体部位的划分及病证的轻重传变

第六章 人体各类平衡波动

第七章 判断人体失衡情况

附录

附1：再论中医的阴阳概念

附2：证与病的关系

附3：诊治入门目录

后记

作者简介：

李文强，男，1978年出生，原籍辽宁省海城市，现居北京海淀。2000年毕业于北京航空航天大学有翼导弹设计专业。

航天单位工作7年，受航天前辈钱学森钱老的中医观念影响，酷爱中医。

曾作为科技部国家中医战略研究课题组长贾谦老师的助理，做了大量民间中医调研工作。

2018年，拜光明中医函授大学办公室主任、《光明中医》杂志社社长范竹雯老师为师。同时在85级校友、山东烟台名医于云老师指导下刻苦学习光明中医教材。

现为光明中医网校副校长，主持了光明中医教材1000万字的电子化工作。

为解决中医系统学习入门较难的问题，依据教材编写了《中医概念入门》一书，以通俗易懂的方式解释了中医基础理论。

微信



抖音



书评节选

这本书叫《中医概念入门》，其实学完之后不仅仅是了解了中医的一些概念，更重要的是通过这本书中形象例子，将这些抽象的概念串起来，在概念的基础上建立起了中医的基本理念。通过阅读这本书我才真正理解了“谨察阴阳所在而调之，以平为期”的含义。也许这本书的书名并不能概括这本书的全部内容。

李老师把中医里这些难懂、模糊、抽象的概念，写成一本书，让这些概念明确、具体、形象，把以前需要我们挖空脑袋去悟的东西，清晰地成体系地写出来了，我从内心就非常敬佩，觉得这个就是一件很大的实事，很有意义的事。

——学员：doglovecat

今天在公交上看了中医概念入门，一下明朗了许多，解开了很多不解。以前一直对一些虚实寒热把不准，除了一些明显的热寒虚实之外，有些病症错综复杂，但通过书里的描述，感觉顿悟明了。对虚虚实实有了非常明确的理解，对像虚则补之，实则泻之，虚实共存有了非常形象的理解。之前总是知或不知，总是很模糊。现在完全不一样了。

还有就是对疾病的部位有了非常明确的理解。我是医疗设备工程师。之前跟了上万台手术，但总是自己去理解，不敢确定病在皮肤、筋膜、腑、脏的哪一个阶段更重。书里有了明确的定义，这也是之前的书没有的。

——读者：四逆汤

学完李文强先生的《中医概念入门》，感觉此书是中医划时代的标志！从此，中医从玄学变为一门有逻辑的正式学科，以后普通人都能理解中医道理。

我以前学过其它入门书籍，比如《中医基础理论》、《圆运动的古中医》等等。这些书籍入门都不容易，主要是基本名词模糊，让人不

懂，对问题的解释很牵强，像诡辩。

《入门》首先解决了阴阳定义的问题，在此基础上，对虚实、寒热、天人合一、证、诊、治等概念做出了清晰解释。中医各家学说都可以在其中找到自己的位置。理清了中医理论的很多难点，却通过生活常识使人非常容易理解，担得起“深入浅出”四个字。

以前中医总说“悟”，就是说不清道理，要通过大量学习，自己联想体会。过程艰难不说，每个人都能悟出点东西，都不全，就是盲人摸象。中医内部互相争吵。外人不学中医，太难。

《入门》的讲解过程应是经过深入思考的，由浅入深，每个概念都要说清楚，后面才会使用。这点与以前的中医书有明显不同。推荐给几个朋友，都说能看懂！还是理科生能把事说明白！

该书应该成为所有中医学习者的第一本入门书，可为学习者节省大量的学习时间，如能普及，真是利国利民的好事！

——读者：中医小跑堂

《中医概念入门》是基础中的基础，是入门的垫脚石，是决定中医学习程度与准确性的起点与坐标，非常重要。

《中医概念入门》全书章节内容设置就很清晰。从整个天地阴阳讲起，用温室做比喻，引入“功能决定平衡点”，“平衡点决定阴阳属性”等概念，尤其是“平衡点确定后才能谈阴阳”这一条件，一下子令我茅塞顿开。作为一个中国人，生活中总是能听到、看到、遇到关于阴阳的各种说辞，中医中阴阳属性的划分尤其至关重要。对阴阳的正确认识，也是决定能否做一个明白人和名医的先决条件。虽然我只是个中医爱好者，也很下功夫的读过一些医书，比如《中医基础理论》等，书中对阴阳概念的解释，就是以概念解释概念，简单划分，枯燥难懂，遇到具体问题还是似是而非，判断不清。所以，我觉得《中医概念入门》这本书真的很好，对学习中医打基础帮助很大，我会细心阅读，认真做笔记，体会、理解，建立正确理念。

——读者：chengwencui258

绪言

建国以来的中医教材以光明中医教材口碑为最好。这套教材是80年代，由老中医司长吕炳奎集合当时最好的一批名老中医共同编写出来的，实用性非常强。很多人通过这套教材踏入中医之门，成为合格中医师。有“中医ICU”之称的李可老中医，认为其是“最好的中医教材”，推荐广大中医从业者学习。

这套教材的学习特点是先难后易。开始学习的时候难度比较大，需要学习者在花费大量时间反复研读后，才能悟出背后的真意。很多学习者因为无法突破前面的难点，失去学习信心，导致半途而废。而本书的主要目的就是要降低学习者前期学习的难度。

中医学的基础理论是由各种晦涩概念组建起来的，比如阴阳、天地、五行、六气、三阴三阳、气血津液、表里、寒热、虚实等等。中医对这些概念的解释非常抽象。大多数初学者，包括经过四年专业学习的中医院校学生，花了很多时间依然读不懂。而基础理论不清晰，则在使用针、砭、灸、药等方法调理人体的时候，就没有方向，效果也差强人意。就像盖房子地基不牢固，盖起的房子一碰就倒，非常脆弱。

因此如何把这些概念用简单、具体的方式讲解清楚，是对中医意义重大的事情，也是本书要解决的重点问题。我们将教材各个课程中对这些概念的讲解做了详细的整理，然后用生活中常见的现象进行了解释，同时附上教材及经典原文，这样既保证了解释的正确性，又达到了容易理解的目的。

这里，我们抛开那些难懂的概念，举一个简单例子来解释中医是如何看待人体的，中医到底在做什么？如下图：

图1：人体内驱动蛋白移动囊泡

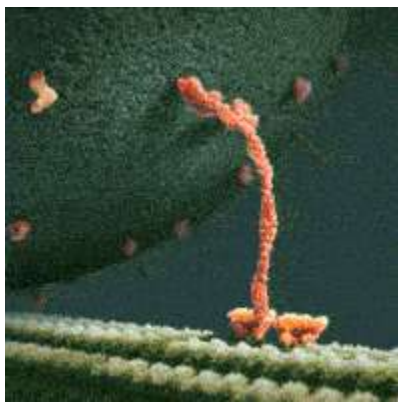


图2：自然界蚂蚁喝水



第一张图为国外某大学制作的动画，演示人体内细胞有序工作，形成了一个细胞社会。第二张图为自然界蚂蚁喝水的过程。可以看出，两者有很大相似之处，都是一种生命活动。

中医是把人的身体理解为一个类似温室花园的小自然界。人体中的各种细胞看做温室中的花草鱼虫。中医是养护生命的医学，其原理和园丁养护温室花草的道理很相似，以调节生命所处的环境平衡为主要任务。

养护花草有四大要素，阳光、水、土壤、空气，缺一不可。园丁的责任就是经常关注花园中这四大要素是否适量平衡，比如水少要浇水、水多要排水，其他要素也是如此。环境调节好后，花草自然会长的好的。园丁不太需要关注花草树木的物理特性或者化学成分，比如树干

硬度是多少，花朵鲜艳的颜色是因为哪些化学成分等等。那是物理学家和化学家的工作，大家分工不同。

同样对应人体而言，人的脏腑、皮、肉、筋、骨等组织器官也是生命，像花草树木一样由细胞构成，在合适的环境中能够自行生长。所以人体也需要类似自然界四大要素的东西来构成一个适宜生命生长的内在环境。

无论是自然界也好，还是人体也好，都包含了大量复杂的物理、化学变化，以及各种微小生命的活动。想搞清楚这些变化的细节是很困难的一件事情。中医的做法不是要搞清楚这细节，而是帮助人体搞好整体的环境平衡。人体内在的环境平衡了，这些小生命就能够健康的生长和工作。想搞好人体的内在环境，就需要了解人体的能量与物质的产生、传输、分配以及人体的固、液、气态物质互相配合的原理，并且知道如何判断失衡的部位、性质，并能进行调节。

所以说中医的思维是园丁思维，不是物理、化学思维。学习中医的人一定要明白这一点，否则很容易被现代医学对人体的细节研究搞偏方向。

那好，有了这种中医思维，我们就可以开始进入中医的世界了。

李文强

2020年11月06日

第一章 阴阳平衡

中医中大量使用了阴阳概念，所以学习中医，必明阴阳二字之含义。本章将对阴阳概念做出清晰的解释。

1、阴阳平衡与失衡

1.1、阴阳平衡是世间万物的规律，不只用于中医

阴阳平衡是中国传统的概念，可以用于解释各种事物。其本质上是指各种事物为了正常的运转，在很多指标上都有其合适的度。让指标保持在合适的范围内，使事物正确的运转，是为平衡。指标超出正常范围，使事物的运转失常，是为失衡。这本是生活中很常见、很简单的道理。

阴阳的传统解释非常抽象，导致很多人不能直观的理解阴阳的含义。这里我们用一个简单的例子来解释”阴阳“。

下面是一个房间温度平衡的例子。

假设我们有一个20平米的房间，用作卧室。

我们希望室温控制在25度上下，波动不超过5度，也就是20--30度之间，这是一个适宜温度范围，住起来比较舒服。

如果室温波动超过5度不到10度，表明室温出了问题，但还不算严重。比如若向下处于15度-20度之间，称为寒；若向上处于30-35度之间，称为热。寒与热都视为居住功能受到影响，但勉强可住。

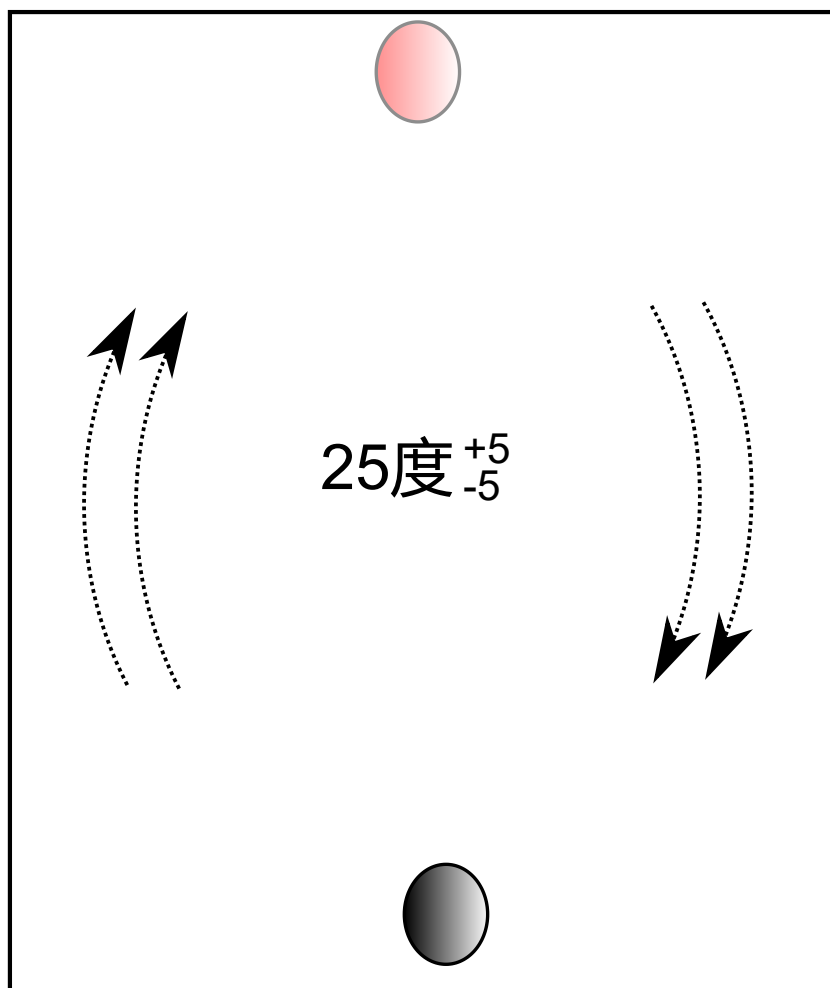
如果室温波动超过10度，处于低于15度或者高于35度的情况，视为失去居住功能。

为了实现这种温度控制，我们配备了一台2匹制冷空调、一个3000瓦电暖气用来调节室温。

暖气可以让温度上升，称为阳。空调可以让温度下降，称为阴。

卧室

电暖气3000瓦



制冷空调2P

这段话描述的小例子，已经把阴阳常见的要素包含在内了，下面解释一下：

1、这个例子首先确定了功能，功能是卧室，用来住人。这点很重要，因为功能决定了平衡点。如果房间功能是用来住人，室温平衡点是25度。如果房间用来做冷库，平衡点要定在-10度。所以我们谈阴阳、谈平衡，一定要先说清楚功能是干什么。不同的功能决定了不同的平衡点，进而决定了不同事物的阴阳属性。

2、平衡点确定后才能谈阴阳：这个例子中，以25度作为平衡点，那么低于这个温度的物体都算阴，比如房间里放一个10度左右的物体，因为它能让房间温度下降，所以算阴。但是如果房间作为冷库，平衡点在-10度，那么放一个10度左右的物体，就算阳，因为它的温度比平衡点高。由此可见，一个物体是阴还是阳，是指其相对平衡点而言。

在中医教材中，用阴阳基本属性和事物本身的阴阳属性来解释。这种描述很抽象，难以让人快速理解阴阳的本质。比如教材说阴阳基本属性中，热的属阳，寒的属阴。那么多少温度为热、多少温度为寒呢？其实这里隐含着以人的体温作为平衡点，高于人的体温为热、为阳，低于人的体温为寒、为阴。如果换一个事物，平衡点变化，原来的属阴属阳也会变化。

比如一个10度的物体，人的触觉感受会觉得是凉的，属阴。但是把它放到冷库里，它又属阳。那这个物体到底是阴还是阳呢？可见，如果不以平衡点作为前提，是无法谈阴阳的。同一个事物，相对不同的平衡点，其阴阳属性是不确定的。任何事物的阴阳属性都以其相对平衡点的差异而定。

阴阳的基本属性可归纳如下：凡是动的、升的、浮的、上的、外的、热的、明的、无形的等等属阳；凡是静的、降的、沉的、下的、内的、寒的、暗的、有形的等等属阴。即天在上、无形属阳；地在下、有形属阴。日是明亮的、热的属阳；月是晦暗的、寒冷的属阴。疾病中的热证、实证、表证属阳；寒证、虚证、里证属阴。

阴阳的基本属性是绝对的、固定的，但事物本身的阴阳属性却是相对的、变动的。这种事物本身的阴阳属性的相对性和变动性，一方面表现为在一定条件下相互关联的相对事物之间可以互相转化，即阴可以转化为阳、阳可以转化为阴；另一方面表现为一事物内部阴阳属性的无限可分性，即“阴中有阳，阳中有阴，阴阳之中复各有阴阳”（《类经·阴阳类》）。

《中医学概论-阴阳五行学说-阴阳的基本属性》

清阳与浊阴都是相对的概念，在不同的地方，有着不同的含义。

1.2、阴阳失衡的描述与调节

中医用虚、实来描述失衡的原因性质，用补、泻来描述失衡的调节方法。

虚

该有不够就是虚（“精气夺则虚”）。虚会导致房间调节平衡的能力不足，受到一般的干扰就会产生失衡。

在我们这个例子中，如果空调出了毛病，输出冷气的能力下降一半，导致夏天气温正常变热的时候，不能提供足够的冷气，这就是虚，因为空调属阴，所以这是阴虚。

空调没有提供足够的冷气，导致室温上升到30度以上，超出了正常范围，称之为热。

这种因为阴虚(空调能力不够)而导致的热，称为虚热。

同理，如果暖气出问题，提供热气能力下降，为阳虚。由此导致冬天的时候，室温低于20度，称为寒。因阳虚而寒，称为虚寒。

阳虚则表现为虚寒；阴虚则表现为虚热。

《中医学概论-病机》

过度的虚称为亡。阴虚到极点，称为亡阴。阳虚到极点称为亡阳。

若阴津耗损到极点，可以出现亡阴证；阳气虚衰到极点，可以出现亡阳证。

《中医学概论-病机》

实

不该有而有就是实（“邪气盛则实”）。实是说房间受到超出常规的干扰，这样即使自身调节平衡的能力是正常的，也会因为干扰的力量过大

而失衡。

本例中，如果空调、暖气的功能都没有问题，但是有人在房间里生了一堆火，导致房间温度上升，此时即使空调全力开动，依然不能维持室温在合理范围。室温升到30度以上，成为“热”。这个热是因为不该有的火造成的，所以是**实热**。

同理，如果在房间里放一大块冰，导致室温下降到20度以下，暖气开大也无法调节，成为“寒”。这种寒叫**实寒**。

调节平衡的方法（补、泻）

了解了虚实寒热的道理，那么调节的方法也就自然明白了。

如果是空调或者暖气的问题，那就修理空调或暖气，这就是**补**。空调为阴，修理空调就是补阴。暖气为阳，修理暖气就是补阳。

如果是房间里多了火或者冰，那就把它们清理出去，这就是**泻**。把火弄出去叫“**泻热**”，把冰弄出去叫“**散寒**”。

所以说“虚则补之，实则泻之”。总的来说，补虚叫做扶正，泻实叫做祛邪。所以说中医的治法无非扶正祛邪而已。

虚实共存

因虚指正气不足，实指邪气过多，所以同一个部位**虚实**两者并不对立，可以共存；不同部位则可以此处虚而彼处实。一般来说，单纯的**正气虚**或者**邪气实**往往只是疾病的初起阶段，病因单一，治疗相对简单。慢性病、老年病、严重疾病往往是**正气虚**与**邪气实**共存，既有一个部位的**虚实共存**，也有不同部位的**此虚彼实**等等。解决这种问题要根据轻重缓急，确定先补还是先泻，或者补泻同用。如果补泻同用，又有补泻同等力度，或者重补轻泻、轻补重泻的区别。

错误的调节

一定要注意，必须分清虚实，再采取对应的补泻方法；如果判断错误，比如本来是有火的**实热**，误判成了**虚寒**，采取了补阳（增强暖气）的措

施，就会火上浇油，让室温更加偏离平衡点。或者本为虚寒，误判为实热，采取泻热的方法等等，都会造成更严重的问题。

阳明病，不能食，乃胃中虚寒所致...医者误认...手足濇然汗出，大便初硬后溏为胃家实热，妄用苦寒攻下之品，使中气更为虚寒，胃失和降，而生哕逆，此即“攻其热必哕”。...病本属胃家虚寒，攻下则犯虚虚之戒，因而有哕逆之变。

《伤寒论讲解-194条》

所以一定不能让虚的更虚（虚虚）、实的更实（实实），不能犯虚虚实实的错误，这是中医需要遵循的最基本原则。

无盛盛，无虚虚，而遗人天殃，无致邪，无失正，绝人长命

《黄帝内经-五常政大论》

张景岳说：“人之疾病，无过表里寒热虚实，只此六字业已尽之，然六者之中又惟虚实二字为最要，盖凡以表证、里证、寒证、热证无不皆有虚实，既能知表里寒热而复能以虚实二字决之，则千病万病可以一贯矣，且治病之法无逾攻补，用攻用补，无逾虚实。”

《黄帝内经讲解-治则学说-补虚泻实》

经曰：“虚虚实实，补不足，损有余，”是其义也。余脏准此（4）

《金匱要略》

扶正的方法可能会有留邪的隐患。比如我们想补一个地方的水，但是水没有流到这个地方，去了它处，使不缺水的地方水过多，就反而补出了邪气。祛邪的方法往往会伤正。比如我们想排除一些废水，同时也可能把好水一同排掉了，这就伤了正气。所以无论是扶正还是祛邪，都要注意对应的负面作用。

很多不愿意系统学习的中医爱好者，不识药性，不懂辨证，在不能全面把握人体虚实状态的情况下，往往只看见到一方面之虚，看不到其它方

面的实，进而片面用药，犯虚虚实实之戒，造成严重后果的例子非常常见。

暮世之病也，则不然，治不本四时，不知日月，不审逆从，病形已成，乃欲微针其外，汤液治其内，粗工凶凶，以为可攻，故病未已，新病复起。

《素问-移精变气论篇》

小结

保持指标平衡的要素称为正，其能力不足称为正虚。原则上，维持指标平衡的能力越强越好。比如城市楼房与农村平房相比较，楼房维持平衡的能力强，遇到狂风、暴雨、寒潮的时候，楼房更具有抵御这些外邪的能力，所以人们更喜欢住楼房。对于人来讲，健康的人抵御外界风、寒、暑、湿的能力强，也就是维持自身平衡的能力强大。反之，不健康的人维持平衡的能力弱，稍受干扰就有疾病发生。

不该有的干扰平衡的因素称为邪，过多叫邪实。原则上最好没有邪，如果有的话要控制在一个可接受的范围内，不要超过人的调节平衡能力，超过则发病。

注意，虚、实是描述病态失衡情况的用词，正常情况一般不用这两个词。维持平衡的要素足够叫正气足，破坏平衡的因素很少叫邪气弱，两者是正常平衡的必要条件，不用虚、实描述。所以基本没有正实、邪虚的说法。中医经典中偶尔有用“实”来表示“正气充实”之意，情况不多，结合语境不难判断。

如果该有的要素超出了正常的量，就会由正变为邪。比如如果暖气的控制出现问题，在室温已经较高的情况下，依然大功率输出热气，使室温上升到30度以上。热气本为维持室温平衡的要素，但此时超过了所需的量，就转变为破坏平衡的邪气，造成邪实的情况。

阳胜则人体功能亢奋而见热证；阴胜则人体功能抑制而见寒证。

《中医学概论-病机》

另外，中医在对邪的性质进行描述的时候，有实体物质的邪称为实邪，无形气态或能量类的邪称为虚邪。以后遇到要注意与正气虚、邪气实的概念进行区分，不要混淆。

邪热与痰水、肠胃糟粕、宿食、湿浊等有形之邪相结，皆可致心烦，甚则心中懊憹，以其邪之有形，故称“实”。本条所述，乃因汗、吐、下后，表邪入胸，无形之邪热留扰蕴郁胸膈，并未与有形之邪相结，故称“虚”，并非指正气虚衰。

《伤寒论讲解-76条》

1.3、平衡的控制

在这个例子中，需要有人来对房间的温度进行判断，如果温度高了，需要开放空调，温度低了需要开放暖气，保证房间温度在一个合适的范围之内。现在科技发达，也可以使用传感器侦测温度，用程序进行自动控制。

这个控制的功能对应中医精气神中的神，具体在后面的章节会介绍。

1.4、平衡的机制

为了让房间的温度均衡，要制造空气的流动，让暖气产生的热气流向冷的一面，空调产生的冷气流向热的一面，这就是房间寒热平衡的机制，也叫阴阳的交互。

现代人熟知的热传导、对流、辐射等热传递方式，在自然界和人体的温度平衡机制中都有体现。比如自然界云、雨的形成就包含对流的原理。太阳给自然界提供能量就包含了热辐射的原理。

中医将这类平衡机制用“升降出入”四个字来概括。比较大的方面包括人体上、下部之间“升降”平衡，里、外部的“出入”平衡；至于小方面的“升降出入”就更多了。升降出入做的好，称为“阴阳相交，水火既济”，是生之象；做的不好，则叫“阴阳分离、水火未济”，是死之象；

中医常说的上热下寒或者内热外寒等，就是人体热量的平衡机制出现问题，造成一部分偏热而另一部分偏寒，严重的话会产生阴阳分离而死亡的后果。

李中梓则具体指出：“天地造化之机，水火而已矣。宜平不宜偏，宜交不宜分。火性炎上，故宜使之下，水性就下，故宜使之上，水上火下，名之曰交，交则为既济，不交则为未济，交者生之象，不交者死之象也”。这是以水火说明阴阳相互依存、制约的重要意义。临床虚劳内伤疾病，多见阴阳水火升降失常，心肾不交，甚至导致阴竭阳脱，危及生命。

《黄帝内经讲解-阴阳对立统一的例证》

1.5、多方面的平衡

前面这个例子，重点谈的是温度平衡，其实一个房间实现卧室的功能，还有很多其他指标需要平衡，比如湿度、墙壁隔热度、采光度、地面光滑度等等，也就是有多个维度需要平衡。

每个维度指标都和温度指标一样，有平衡范围和失衡范围。比如湿度就要有一个合适的范围，湿度过大变得潮湿或者湿度过小变得干燥，都会影响居住功能。温度失衡，我们用“寒、热”来描述，但是湿度失衡，不能再用这种词，可以用“湿、燥”来描述湿度失衡。

无论哪种指标的失衡，都离不开“虚、实”两种情况，因为所有的失衡，无非是“该有的太少”或者“不该有的太多”而已，再或者两者兼有的“虚实夹杂”情况。

从“敏感度”角度看，有些指标是敏感的，比如说温度指标，它随着季节、昼夜经常变化，需要经常关注调节。还有一些指标是不敏感的，比如墙壁厚度，一旦房子建好后，多年不变，除非遇到特殊情况，否则一般不需要关心它的变化。人体也是一样，因温度变化比较敏感常见，所以中医经常“寒热虚实”并称。但我们要知道“虚实”是各种指标失衡的统称，“寒热”是温度指标的特指。

从“重要度”角度看，大部分指标都很重要，任何指标失衡，都会导致功能的下降，严重的会导致失去功能。所以即使一个指标是不敏感的，但是一旦遇到特殊情况，这个指标失衡了，依然要重视，将其调节回平衡。

这里提到的多方面平衡，对于人也一样，温度平衡是人体平衡的一个重要方面，但是还有其他方面的平衡，比如身体有气的平衡、血的平衡、水的平衡，对应就有气虚、气滞、血虚、血瘀、津液虚、痰饮等各方面的失衡，这些要等后面介绍完人体的运转机理后才能解释。

在光明教材《概论》的阴阳章节，谈到中医用阴阳概念阐述人体的部位、生理、病理、诊断、方药等内容，就是指这种多维度的平衡。

阴阳学说，贯穿于中医学理论和临床体系的各个方面，用以认识和阐述人体的形体、脏腑、经络、生命过程、疾病过程、以及辨证治疗等等。

《中医药学概论-阴阳学说在中医学中的应用》

1.6、平衡要素

综上所述，我们可以根据房间的例子总结出平衡的几个要素：

作用：居住

载体：房间

指标：温度、湿度、墙壁隔热度、采光度、地面光滑度.....

功能、载体、指标，是我们谈阴阳平衡需要关注的三个要素。

其中每个指标都有其合适的平衡点，以及正常的上下波动范围。以平衡点为参照，让指标向上为阳，向下为阴。

指标又分敏感指标，比如温度，以及不敏感指标，墙壁隔热度、采光度等。

中医学中谈的阴阳，之所以让人难以理解，关键就是讲述人经常没有说清楚功能是要做什么？平衡点在哪里？从而导致了不同系统、不同层次

阴阳概念的混乱、滥用，不利于中医学的传播，让中医学习者思维混乱。

比如朱丹溪说“人身阳常有余，阴常不足”，而火神派说“阳常不足，阴常有余”，两者看起来是矛盾的。都是中医大家，何以在语言描述上出现如此对立的情况？两者谈的阴、阳是否是同一系统、同一层次下的阴阳？有余、不足的原因何在？表现怎样？这些问题如果能把其语境下的功能、平衡点说清楚，理解起来应该是极简单的事情。而不说清楚这些前提，就变成模模糊糊、似是而非的话语了。

在本书，只要谈阴阳，一定要先说功能是什么、平衡点是什么。也就是没有功能不谈平衡，没有平衡不谈阴阳。若确有说不清楚的地方，存疑待考，而不能囫囵吞枣，敷衍而过。

中医教材说阴阳即对立又统一。在本例中，“统一”就是指房间控制温度这件事，“对立”是指空调与暖气的对立关系。一个房间的空调与本房间的暖气是一对阴阳关系，而与另一个房间的暖气，就不是一对阴阳，因为两者没有发生交互作用。所以谈阴阳对立，前提是基于一个统一的事物，也就是这里说的功能、载体、指标。

阴阳的相互关系，概括起来，可以归纳为对立和统一两个方面。... 阴阳两方面的相互对立，主要表现在阴阳之间的相互制约、相互斗争。阴阳两方面的统一，主要表现在阴阳之间的相互依存、相互为用、相互转化，以及阴阳的相互包涵和无限可分性。

《中医学概论-阴阳的相互关系》

1.7、中西医的指标差异

通过上面的叙述，我们知道中医的阴阳平衡、寒热虚实和西医的指标平衡是一个意思，只是描述术语上的差别，解释清楚中医的指标概念后，这种差异就不存在了。西医的高血压要降压、高血糖要降糖也是调节某些指标平衡。

那么中医和西医为什么还是很难融合呢？是因为双方在重要指标的选取标准上的差异。人体是非常复杂的系统，其中有非常多的指标需要调节，作用各有不同。中医认为西医的血压、血糖、蛋白等指标，过于细化，层级偏低。调节这些指标虽有一定作用，但不能从宏观上解决根本问题，有时还会让其它更重要的指标更加失衡。而西医认为中医的精、气、神、血、津液等指标，描述模糊，无法量化，难以纳入现代医学体系。这应该是中西医学矛盾的根本所在。

客观的讲，双方都有一定道理。中医的指标确实模糊，掌握起来有难度。但我们既然学习中医，就一定要搞清中医几大指标的意义，其失衡的表现，以及调节的办法。

2、阴阳平衡的高级内容

前面所述是对平衡的一些简单理解，下面我们要对平衡过程做一点深入分析，为下面学习天地自然打一点基础。

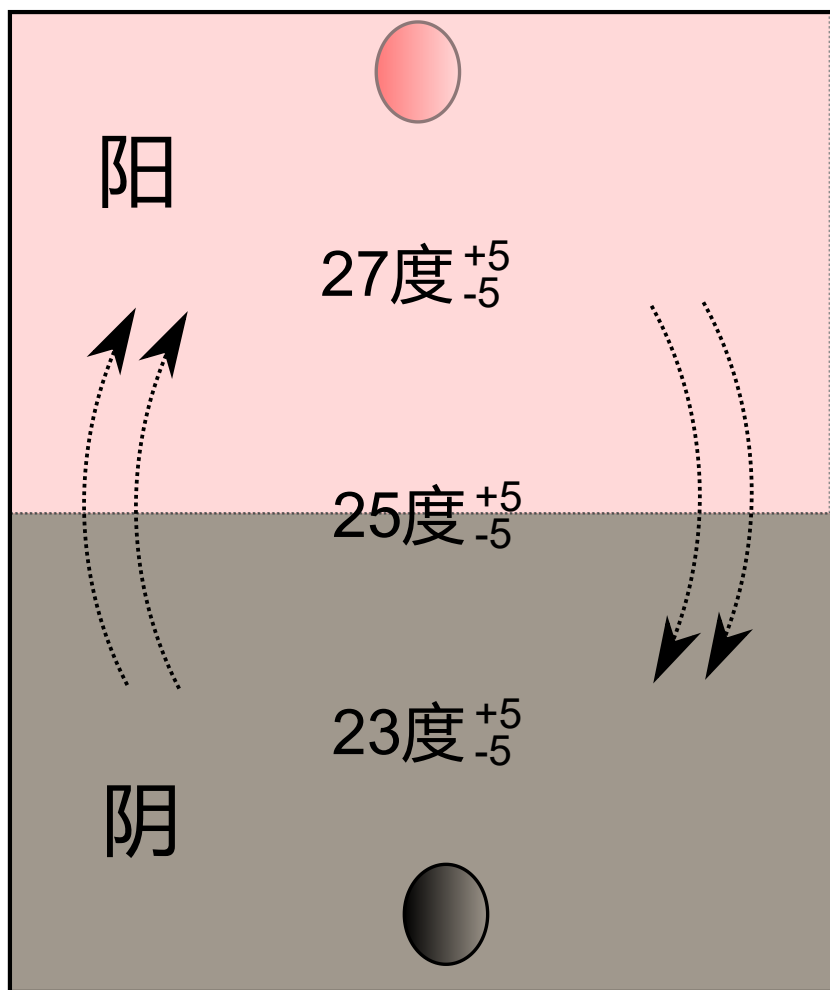
2.1、大平衡下的小平衡

当我们定下一个系统的平衡目标后，为了完成这个目标，相关的各个方面都有各自的任务。为了完成各自的任务，其又有各自的平衡点。这些方面的平衡点可以理解为大平衡下的小平衡。

房间温度的例子：把房间以阴阳中线为界一分为二的话，在靠近暖气的一面整体上要比靠近空调的一面温度要高些，成为偏阳的一面。反之，另外一面称为偏阴的一面。偏阳的一面，假设以27度为平衡点上下波动；偏阴的一面以23度为平衡点上下波动。这种偏阳或偏阴的一面，本身都有各自的平衡点，即为大平衡下的小平衡。

卧室

电暖气3000瓦



制冷空调2P

小平衡对事物的影响

当一个系统大小平衡确定后，系统中的各项事物会根据自己的偏性选择适合的位置。

比如，如果我们洗了衣服要在房间里面晾干，一定会把衣服晾在偏阳的一面，这样干得快。如果有蔬菜要保存，一定会放在偏阴的一面才不容易坏。

在自然界中，有些动植物适合生存在南方，有些适合生存在北方，都是因其各自偏性而在自然界中选择合适的地方。

空间与时间上的指标变化

房间的温度在不停的波动，高于平衡点则下降，低于平衡点则上升。所以房间各个空间点的温度随着时间在不停的变化。

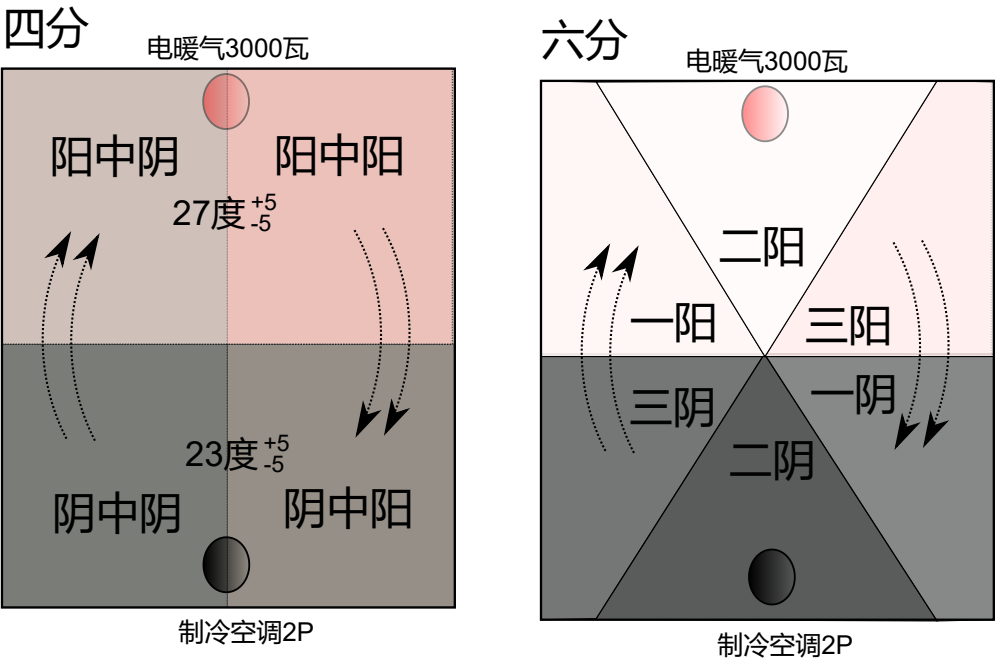
时间变化：房间里任何一空间点，其温度都是随着空调与暖气调节室温的过程，上下波动的。

空间差异：在任意时间点，房间不同位置的温度有高低不同，这是温度在空间分布上差异。

阴阳从时间角度看就是指标在正常范围内的波动，从空间角度看就是不同空间范围内指标的差异。

2.2、阴阳的进一步划分

阴阳可以根据阴阳比例进行多种形式的划分，并不局限于二分法。这里演示一下四分法和六分法。



四分法中，偏阳的一面可以按照比例再分阴阳，称为“阳中阴”与“阳中阳”，偏阴的一面也是同理。

六分法中，阴阳两面各自三分，则用一阳、二阳、三阳、一阴、二阴、三阴的命名方法。

不同的情况可以有不同的分法，比如一年可以分为4季，也可以分为12月、24节气、365日等等。选择合适的划分方法是为了方便观察、分析与调节。

就像踢足球要11个人，打排球要6个人、打篮球要5个人一样，不管用哪种分法，最终都是通过阴阳往来平衡的方式实现目的。

黄帝问曰：余闻天为阳，地为阴，日为阳，月为阴。大小月三百六十日成一岁，人亦应之。今三阴三阳不应阴阳，其故何也？

岐伯对曰：阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数，然其要一也。

《素问-阴阳离合篇第六》

3、取类比象

依然以房间温度平衡的例子来说明。温度高于平衡点的事物属阳，比如暖气、火等，低于平衡点的事物属阴，比如空调、冰等。那么暖气和火就属于同类，空调和冰就属于同类，或者说针对当前平衡点，它们具有类似的象。

这种同类事物是可以互相补充替代的，比如房间温度低的时候，恰巧暖气有问题不能输出足够的热气，这时我们可以考虑生点火，帮助提升房间的温度。反之亦然，空调出毛病的时候，我们可以放点冰来弥补其降温能力的缺失。古代没有空调、暖气的时候，就是用冰、火来调节房间的温度。两者性质是一样的，只是现代的方法更方便而已。

中医治病是以自然之偏纠正人体之偏就是这个意思。我们要了解人体不同部位各种失衡情况的表现，这样就能根据表现判断出失衡的部位和性质。然后还要了解药物的偏性、方剂的作用性质。这样就可以选择正确

的药物方剂来对应调节人体的失衡情况。比如脾的阳虚，可以用热的干姜；肾的阴虚可以用地黄、阿胶；心的阳虚可以用桂枝甘草汤等等；

前面我们谈虚实中的实热的时候，说房间中多了一团火，会造成实热。而这里又说，温度低而暖气不足的时候可以放一团火帮助升温。那么这团火到底是致病之因还是纠偏之药呢？这个完全取决于原本房间温度是平衡还是失衡的。原本房间温度低，一团火有助于房间温度趋近平衡，这个火就是良药。如果原本房间温度是平衡的，这团火会打破平衡，那它就是毒药。总之，一切以平衡为准，任何药物或者疗法，能维护平衡就是好的，破坏平衡就是坏的。

由此可见，中医中的偏性之药，如果抛弃平衡而谈其有益或有害，是错误的，会误导人。正确的使用，砒霜也可以救人；不正确的使用，人参也可以害人。

4、一些扩展内容

4.1、平衡的有效区域：

我们说房间在空调、暖气的作用下达到20-30度的均衡温度。这是大概情况，严格来讲，房间中临近空调和暖气的地方，温度是超出这个范围的。空调的制冷温度在15度左右，暖气在80度左右。这两者附近的温度是超出范围的，所以我们不会居住在这两者附近。

房间中部的温度是符合均衡温度范围的，所以这个区域我们可以理解为房间的有效区域。

空调和暖气附近作为房间温度的两极，不适合居住，但是对有效区域的形成有重要的作用。

明确这一点是为了后面更好的理解中医对自然界气交之地的叙述。

4.2、物极必反

物极必反是指标在波动过程中，升到一定程度则降，降到一定程度则升，以此来保持平衡。内经中，以四季变化来举例，夏天气温最高，之后就要转凉，冬天气温最低，之后就要变暖。

四时之变，寒暑之胜，重阴必阳，重阳必阴。故阴主寒，阳主热。故寒甚则热，热甚则寒。故曰寒生热，热生寒，此阴阳之变也。

《灵枢·论疾诊尺》

房间温度的调控也是如此，室温超过上限后，会启动冷气，超过下限后，会启动暖气，如此波动以控制平衡。

物极必反的概念不能滥用，当事物自身调节平衡的能力较强的时候，可以有物极必反的现象，热极生寒、寒极生热等等。若平衡能力弱，物极而不能反，就是死亡的结局了。

第二章 天地自然

1 、概述：

绪论中说过，中医把人体看做一个温室花园，而我们生存的自然界则是一个更大的温室花园，两者的运转机制有相似之处，中医中三阴三阳、六气、五行等概念皆来自于自然界。另外人生存于自然界中，其物质与能量都从自然界获得，所以人体受自然界的影响非常大。

中医有“天人合一”的说法，认为研究人体的健康问题，需要非常重视自然界对人体的影响。因此，在学习中医的人体观念之前，需要先了解中医的自然观。

“人以天地之气生，四时之法成。”

《黄帝内经讲解一天地形气的相互关系及其作用》

《内经》认为宇宙是一个大天地，人体是一个“小天地”，而且人与天地相参应。

《中医学概论-阴阳学说在中医学中的应用》

1.1、气的概念

中医中大量使用气的概念，非常重要。但是气的定义却有些模糊。这里需要做一些分析：

1、气一元论中的气

在中国古代哲学里面有“气一元论”的说法，认为气是宇宙的本原，是构成天地万物的基本物质。

关于物质最基本单元的问题，现代科学在微观领域不断的探索，已经从原子论向下探索到弦理论。虽然还不能完全解决这个问题，但是已经可以证明所谓山河大地等各种物质，无非是更微观的基础物质的不同组合而已。

另外，从质能方程、波粒二象性、弦理论的内容看，物质与能量在本质上可能是统一的。

所以中医中的气，大家可以先简单理解为物质与能量的基本单元，所以其既可以表达物质也可以表达能量。如果有一天，现代科学彻底解决了物质本源问题，我们可以拿来和气的观点对照一下是否一致。在此之前，学习中医的人先这样理解就可以。

中医用气来表达各种事物，比如天气、地气、金气、木气等等。这些词中的气，同时具有物质和能量的双重属性，也就是说不但描述了物质，还描述了物质所处的能量状态。

“气”不仅具有物质性，而且还具有运动的特征，它既是万物的原始物质，又是推动万物发展变化的动力源泉。

《黄帝内经讲解-自然界是生命的源泉》

一般来说，中医更关注气的能量属性，所以中医中的气和现在的能量概念有很大的相通性。

气具有很强的活力，不断运动的特性，对人体生命活动具有推动和温煦的作用，因而中医学中以气的运动变化来阐释人体的生命活动。

《中医药学概论-藏象-气、血、津液》

2、形气中的气

这里气是与形相对的，形指的是固态或液态的物质，气指的是气态的物质。对于自然界来说，泥土、石头、木材、水都属于形，空气、水蒸气属于气。

物质固、液、气三态随温度、压力等条件的变化而变化，比如水在0度以下为冰，100度以下为水，100度以上为水蒸气，4000度以上分解为氢氧。而气态物质在温度降低后可以变为固态或者液态，比如空气在零下193度左右会变成液态。就是说在特定条件下，形可以转化为气，气也可以转化为形。

在天为气，在地成形，形气相感而化生万物矣

《素问-天元纪大论》

“形”，指具有形体的物质。《内经》认为天和地的相互作用，是自然界运动变化的重要原因，在天的无形之气与在地的有形之质相互交感，相互作用，于是化生万物。

《黄帝内经讲解-天地形气的相互关系及作用》

形气互转是中医理论中非常重要的内容。在自然界有云雨的形气互转现象，这是液态水变为水蒸气升入空中，在空中受冷又变化为雨降落于地面。中医认为在人体的水液运转过程中，也有这种类似云雨的形气互转现象，中下焦（脾、胃、肾、膀胱）中的水有一部分以水蒸气的形式上升到肺，在肺化为液态，重新输送到全身。另外也有营气、宗气与血液的形气互转情况。

阳的化气过程，即是把体内有形之质，化为无形之气，或转化为能量，如“精化为气”，“水化为气”等等，都依赖于阳的气化作用；阴的成形过程，即是把外界的物质，合成自身的形质，如精血的生成，形体的发育等等，都要依靠阴的成形作用。

《黄帝内经讲解-阴阳学说-（十二）阴阳的性质和作用》

3、小结

以上两种气，一为质能基本单元的气，另一个是气态物质的气，这是两个范畴的概念，应该用不同的词来表示。现在两者混用确实增加了理解的难度。学习中医的人要理解不同语境下气的含义。

1.2、天地的概念

天地指的是我们生存的自然界。

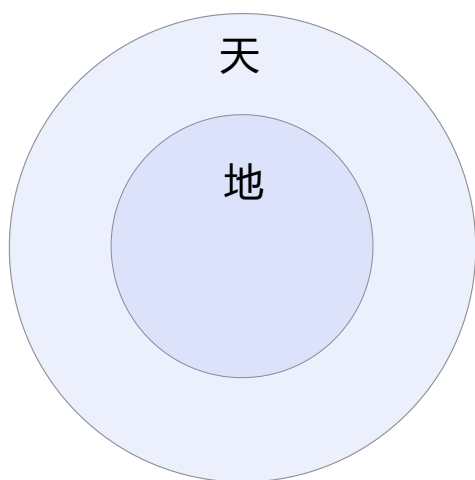
天地实际上是对地球上生命产生和生物生存的各种必要自然条件，如阳光、温度、空气、水分、食物等的概括。

《黄帝内经讲解--天地形气的相互关系及其作用》

天指的是无形的大气，也可以理解为大气层。地指的是有形的大地物质，可以理解为地球的实体。两者的主要区别在于密度。密度大而下降的物质叫浊阴，形成大地；密度小而上升的气体属于清阳，形成天空。

《内经》认为天是由轻清上浮的阳气积聚而成的，故属阳；地是由重浊下沉的阴气凝结而成的，故属阴。地悬浮于太虚之中，天包裹乎大地之外，所以说天气主外，地气主内，这反映了古天文学浑天说的先进认识。

《黄帝内经讲解——阴阳分主内外、虚实的规律》



天气包含空气的能量，比如空气的热能或者动能（上升、下降、横向流动）等等。地气包含有形物质的能量，比如泥土的温度、河海的流动、山丘的形成等等，地气虽然主静，但是这个静是与天气的强烈运动对比，相对安静，而非绝对的静止不动。

这样大家就可以理解内经说的“积阳为天，积阴为地”、“阳化气，阴成形”、“清阳为天，浊阴为地”等等概念。

天地是以地面为界限。比如水在地下以液态存在的时候，就算地气，一旦气化为水蒸气，离开地表，就可以算为天气的一部分。再比如土，以固态形式存在于地面就算地气，一旦被风吹到空中，成为漂浮的灰尘的时候，就算天气的一部分。反之，空气以气态的形式在空中是天气，如果其存在于土壤的缝隙之中或者溶解于液态水中，就算是地气的一部分。

以煮菜这件事做比喻的话，煮菜时，菜与水为浊阴，蒸气为清阳。两者类似自然界的大地与天空。

这里地气的理解是一个难点，很多人第一次接触这个概念的时候理解不了地气是什么。大家想象冬天的时候，大地冰封，泥土冷硬；到了春天，大地解冻，泥土开始变得潮湿。泥土由冷硬到温软的过程，或者水温由冰冷到温暖的过程，就是大地能量变强、地气变得活跃的一个现象。

故积阳为天，积阴为地。阴静阳燥，阳生阴长，阳杀阴藏，阳化气，阴成形。...

故清阳为天，浊阴为地；

《素问-阴阳应象大论》

阳可以把物质转化为精微之气，以促进万物的生长；转化为动力，以促进人体的生命活动，所以称为“阳化气”；“阴”，指有形可见的物质（如精、血、津液等），它可以充养形体组织，有促进万物成长壮大的作用，所以又称为“阴成形”。

《黄帝内经讲解-阴阳学说-（十二）阴阳的性质和作用》

《内经》认为天和地的相互作用，是自然界运动变化的重要原因，在天的无形之气与在地的有形之质相互交感，相互作用，于是化生万物。因此，天地是化生万物的物质基础，是生命的起源。

《黄帝内经讲解-五行学说-（三）天地形气的相互关系及其作用》

帝曰：地之为下否乎？岐伯曰：地为人之下，太虚之中者也。帝曰：凭乎？岐伯曰：大气举之也。...

《黄帝内经-五运行大论》

1.3、气交之地—地表上下的生命繁荣区域

天气、地气包含了整个地球和地球外面的大气，是非常大的区域。

而动植物生命的繁衍区域，主要处于地表上下的一定范围内。这个区域是天气和地气的交接处，同时受二者影响，称为气交之地。

就像前面说的房间的例子，空调、暖气附近都是不适合居住的，因为过热或者过寒，只有中间的部分是温度合适的，适合居住。但是这两个过热过寒的地方是有存在的必要的，有了他们才能给中间部分提供合适的温度。

同样天地的存在也是为了让气交这个位置形成适合生命生存的自然界。在这个区域生存的各种动植物生命，都需要从大地和天空获得必要的物质和能量来维持生存。

岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之气交。

帝曰：何谓气交？

岐伯曰：上下之位，气交之中，人之居也。

故曰：天枢之上，天气主之；天枢之下，地气主之；气交之分，人气从之，万物由之，此之谓也。

《素问-六微旨大论篇第六十八》

天覆地载，万物方生。未出地者，命曰阴处，名曰阴中之阴；则出地者，命曰阴中之阳。

《素问-阴阳离合篇第六》

为什么称为中运？

是说五运之气经常处于天气和地气之间，故称中运。天气和地气上下相交之处，所谓“气交之分”，相当于大气的底层，是人类生活在大自然中的位置。《素问·六微旨大论》说：“上下之位，气交之中，人之居也。”

《黄帝内经讲解-运气学说-五运》

2、自然界平衡机制：

自然界运转的基本机制是太阳光作用于地球，将能量传递给大地和天空，形成适宜的地气和天气。天地之气互相配合，形成了适于生命生存的气候环境。这个机制中有两大平衡过程要重点考虑：一是太阳阳气与地球阴气的阴阳平衡，简称日地平衡；二是地球上以地表为分界线，天气和地气之间的平衡，简称天地平衡。

为了方便大家的理解，后面我们会经常将自然界、人体、室温取暖、烧水煮菜等例子进行对比讲解。因为这几个事物都有共同的机制，即在一个相对温度较低的外界环境中维持了一个较高温度的内部环境，并有气、液、固三态之间的互转过程，进而完成各自的目的。比如自然界如果没有太阳的照射，原本是一个很寒冷的环境，有了太阳这个热源后，自然界才形成了适宜的温度，天地交互，云升雨降，各种生命才能在其中生长。再比如北方冬天，室内要有暖气提供热源，否则不能住人。煮菜的时候需要有火加热到一定温度，才能把菜煮熟。人体也是一样，人体温度37度左右，比室温高，所以人体也要有热源来维持温度平衡，同时人体也有气态和固液态物质的相互转换、交换过程。

中医学很多概念是围绕这个核心原理发展而来，后面会慢慢说明。

2.1 日地平衡

2.1.1、能量的总量均衡

适宜的能量是自然界温度平衡的前提条件。这个能量主要来自太阳。

太阳的能量（阳气）与地球自身的阴气形成一对阴阳平衡，维持了自然界的总体能量平衡。

如何理解地球阴气？在这里地球阴气是指地球天气和地气的合称。只需要假设把太阳与地球的距离拉远，或者把太阳的能量减少甚至去掉，这样地球就会变成一个冰封的星球。这种冰封的状态就是地球阴气的作用。

如何理解太阳的阳气？假设把太阳的距离拉近，地球就会变成一个火热沸腾的星球，这就是太阳阳气的作用。

而太阳和地球保持在一个合适的距离范围，让地球拥有了合适的能量来源，这个能量既不过多也过少，这是能够形成自然界的一个先决条件。

要注意天气和阳气的区别，二者经常被混为一谈。阳气是在太阳阳气和地球阴气整体平衡系统中，属阳，给地球提供合适的能量，天气是在地球（天气、地气）自身以密度为指标分阴阳的情况下，密度小的物质上浮为天气属阳，密度大的物质下沉为地气属阴。

以前面煮菜的例子而言，阳气是灶中之火，与锅中的物质形成平衡。天气是锅中的蒸汽，与锅中的水、菜形成平衡。两者是分属不同阴阳体系的不同指标。所以说，阴阳是万事万物规律的总体概括。但是落实到具体事物的时候，一定要说清楚作用和指标，否则非常容易引起理解混乱。在以后的叙述中，会尽量把能量之气和气态物质之气分别说明。

2.1.2、一年周期的三阴三阳

地球绕太阳一周为一年，此周期内，太阳阳气与地球阴气互有进退，形成波动。根据阴阳比例的不同，分为三阴三阳六个阶段。（六个阶段的具体时间，内经没有给出说明）

一阴为厥阴，二阴为少阴，三阴为太阴，一阳为少阳、二阳为阳明、三阳为太阳。

这就相当于我们烧水的时候，柴火的大小变化，火大为阳，火小为阴。

注意，三阴三阳只是阴阳六分法。这里指的是一年周期按照六份划分出的三阴三阳。其它事物如果采取六分的形式，也能划分出三阴三阳。但是因为所指事物不同，其内在含义也可以不同。

三阴三阳是四时、昼夜阴阳消长变化的自然规律，它根据不同的时空条件，把阴和阳各自一分为三。

即一阴为厥阴，二阴为少阴，三阴为太阴，一阳为少阳、二阳为阳明、三阳为太阳。

....可见三阴三阳在定位方面，有上下左右之分，在定性方面，有阴阳盛衰之分，在定量方面，有太、少、厥、阳明之分。紧接着指明：“此谓气之标，南面而待也。故曰：因天之序，盛衰之时，移光定位，正立而待之，此之谓也。”....而这些变化的测定，是在日当中午的时分，观察日影投射在圭表（古代测量日影长度数值的天文仪器）的长度数值测知的。如冬至节日影最长，夏至节日影最短，春分、秋分日影长短相等。……故《生气通天论》曰：‘天运当以日光明。’正此移光定位之义。”这说明三阴三阳的划分，依据的是天文学的六气变化规律。

《黄帝内经讲解-阴阳学说-（五）三阴三阳的划分》

阴阳之气各有多少，故曰三阴三阳也。

《素问-天元纪大论》

因此，三阴三阳的运转总是按一阳（少阳）→二阳（阳明）→三阳（太阳）→一阴（厥阴）→二阴（少阴）→三阴（太阴）→一阳（少阳）这样的次序进行，如此周而复始，如环无端。它们在一年之中各有一定位置，按照一定规律进行运转。这也就是原文所谓的：“上下有位，左右有纪。”

《黄帝内经讲解-三阴三阳配六气及标本中气之间的关系》

2.1.3、四季与昼夜将能量进行均衡分配

在地球获得的太阳能量总量均衡的前提下，能量在地表不同部位的分布也要尽量均衡，避免出现某处获得的能量过多，而其他地方获得能量太少的情况。

四季与昼夜是将能量在地表进行均匀分配的机制。

四季

地球南、北半球随着太阳直射点的变化形成一年四季春夏秋冬。南北半球的冬夏时间相反，南半球冬天的时候北半球是夏天。北半球6-8月从太阳获得的能量多，是夏天。南半球12-2月从太阳获得的能量多，是夏天。

中医发源于中国，属于北半球，所以在谈论一年四季、方位、二十四节气等内容的时候，是以北半球为基准。

太阳的能量半年集中在南半球，另外半年集中在北半球。这种轮换机制，让南北半球都不至于过热或过寒。否则，南、北半球将一个永远是夏天，一个永远是冬天。

如果没有黄道与赤道相交（“地球一边公转，一边自转。有公转就有轨道平面，即黄道平面。有自转，就有赤道平面。在黄道平面与赤道平面之间有一个交角，叫做黄赤交角。目前的黄赤交角是 $23^{\circ}26'$ 。地轴同轨道平面斜交的角度为 $90^{\circ}-23^{\circ}26'=66^{\circ}34'$ ，并且地轴在宇宙空间的方向不同因季节而变化。因此，在地球绕日公转过程中，太阳有时直射到北半球，有时直射在南半球，有时直射在赤道上。），就不可能分阴分阳，也就不会有四时寒暑的变化。

《黄帝内经讲解-（三）四时阴阳、寒热的变化规律》

昼夜

另外一个均衡太阳能量的方式就是地球的自转。地球自转形成了昼夜，让一个地区有白天黑夜。如果地球停止自转，无日夜，则面向太阳的地方过热，而背对太阳的地方则过寒。

这与烤羊肉串要不停旋转，炒菜要不断翻炒的原理是一样的，都是起到均衡能量的作用。

平旦至日中，天之阳，阳中之阳也；日中至黄昏，天之阳，阳中之阴也；合夜至鸡鸣，天之阴，阴中之阴也；鸡鸣至平旦，天之阴，阴中之阳也。故人亦应之。

《素问-金匱真言论》

这是根据太阳周日运动时，地面接受太阳光热的多少来分析昼夜阴阳的消长情况。如张介宾注云：“一日之气，自卯时日出地上为昼，天之阳也；自酉时日入地中为夜，天之阴也”。白昼虽属阳，但上午与下午的阳气有所差别，张志聪注云：“平旦至日中，阳气正隆，应长夏之气，故为阳中之阳”。……

昼夜阴阳消长与人体的关系，无论在生理活动或病理变化方面，都有比较明显的反映。……继《内经》之后，仲景早已把这一理论运用于临床，提出了六经病欲解的具体时间，这对于把握病理机转，大有裨益。……仲景云：少阴之病欲解时，以子至寅，乘此阳道方亨之时而投之，药易以入，故仲景《伤寒论》中，逐时分治，不可不考。”

《黄帝内经讲解-人与自然-（六）人体与昼夜阴阳相应》

2.2、天地平衡

大气的底层和陆地海洋的顶层是各种生命存在的的地方，称为气交之地。前面太阳阳气与地球阴气达到平衡只是满足了一个基本前提，气交之地要想形成温度合适，适宜生命存在的区域，还需要天气与地气之间保持平衡。而天地平衡又包括两个方面，即能量交互平衡和物质交互平衡。

2.2.1、天地能量交互平衡

2.2.1.1、天气地气各自的能量波动

天气地气的能量随太阳能量的变化而变化，一年四季变换的总体趋势是春温、夏热、秋凉、冬寒，这是和太阳照射到气交之地的能量成正比的。能量越多，天气、地气就热；能量少，天气、地气就寒。

天气地气的变化一般与地表接受到太阳能量的变化有30天左右的延迟，比如夏至是太阳能量最多的时候，但是气候最热的时候大约出现在30天以后的大暑。冬至是太阳能量最少的时候，气候最冷的时候大约是30天以后的大寒。这就像我们烧水，火最旺的时候，并不是水最热的时候，中间有个加热延迟的过程，两者一个道理。

故阳之动，始于温，盛于暑；阴之动，始于清，盛于寒。春夏秋冬，各差其分。

《素问-至真要大论》

“各差其分”，指实际气候变化与季节相差的时间。《素问·六元正纪大论》和《素问·至真要大论》认为时间差数为：三十天，或三十日有余。

《黄帝内经讲解-阴阳五行学说-（二）四时阴阳之气的运动变化规律》

因为大寒是一年气候最冷的时候，所以天气、地气的计算都是以此节气作为起点。

中医把一年天气的能量变化分为六个阶段，为风、火（热）、暑、湿、燥、寒，为六气，每气六十天八十七刻半。一年地气的能量变化分为五个阶段，为木、火、土、金、水，为五运（又叫五行），每运七十三日零五刻。

鬼臾区曰：寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之，木火土金水，地之阴阳也，生长化收藏下应之。

《素问-天元纪大论》

“五运”，亦称五行。张介宾说：“五运，即五行也。”

《黄帝内经讲解-五行、阴阳是自然界的根本规律》

• 天之六气

天之六气时间划分为：

从节气大寒开始，经过立春、雨水、惊蛰，到春分，为厥阴风木；

从春分开始，经过清明、谷雨、立夏，到小满，为少阴君火；

从小满开始，经过芒种、夏至，小暑，到大暑，为少阳相火；

从大暑开始，经过立秋、处暑、白露，到秋分，为太阴湿土；

从秋分开始，经过寒露、霜降、立冬，到小雪，为阳明燥金；

从小雪开始，经过大雪、冬至、小寒，到大寒，为太阳寒水；

例如一年六气主时，是从上年的十二月中的大寒起算...天气至此，行遍一周，故以太阳寒水为终气。

这是一年六个季节的正常气候变化。可见六气分主一年二十四节气，是有其天文学根据的。

《黄帝内经讲解-阴阳五行学说-三阴三阳与六气的关系》

• 地之五运

地之五运时间划分为：

从大寒到春分后十三日，为木运；到芒种后后十日为火运；到处暑后七日为土运；到立冬后四日为金运；再回到大寒，为水运；

初运木运是从大寒节当日开始...五行气运就是这样相互沿袭，分主一年五季的气候，年年如是，终而复始，成为常年气候运动变化的一般规律，所以《素问·六节脏象论》说：“五运相袭，而皆治之，终朞之日，周而复始，时立气布，如环无端，候亦同法。”

《黄帝内经讲解-运气学说-五运》

代表地气和天气的五运六气中，五运属阴，守于地内，代表地气，而六气属阳，周于天外，代表天气。

关于天气，这里要注意天之六气和三阴三阳的关系。两者之间的关系很紧密，又不完全等同。三阴三阳是地球和太阳之间系统的阴阳划分，代表一年之内的太阳阳气与地球阴气的比例波动变化。六气是天气、地气系统中，天气自身的阴阳划分，代表一年内天气的波动变化。两者不在一个系统中，但是有一定的对应关系。三阴三阳的变化导致了天气的变化。

2.2.1.2、气交之处的能量交互平衡

气交之处指的大气的底层，贴近地面的部分，是人在自然界中所处的位置。此处的能量状态受天之本源六气和地之五运之气的共同影响。如果理解有困难可以想象一下，我们睡觉的时候，如果用了电热毯，那么被子里的温度由室温和电热毯的温度共同影响，这里电热毯的温度类似地气，室温类似天气，而被子里的空间就是气交之处。

地气五运对气交之处的影响称为五运之气：风、热、湿、燥、寒，又称中运，分别与地气的木、火、土、金、水对应。

神在天为风，在地为木，在天为热，在地为火，在天为湿，在地为土，在天为燥，在地为金，在天为寒，在地为水，故在天为气，在地成形，形气相感而化生万物矣。

《素问-天元纪大论》

为了概括和说明五气（风、火、湿、燥、寒）的基本性质及其运动规律，故分别以木运、火运、土运、金运、水运相称。同时又根据五行属性配以天干，所以张介宾说：“五行之应天干，是为五运。”……

五运之气经常处于天气和地气之间，故称中运。天气和地气上下相交之处，所谓“气交之分”，相当于大气的底层，是人类生活在大自然中的位置。《素问·六微旨大论》说：“上下之位，气交之中，人之居也。”

《黄帝内经讲解-运气学说-五运》

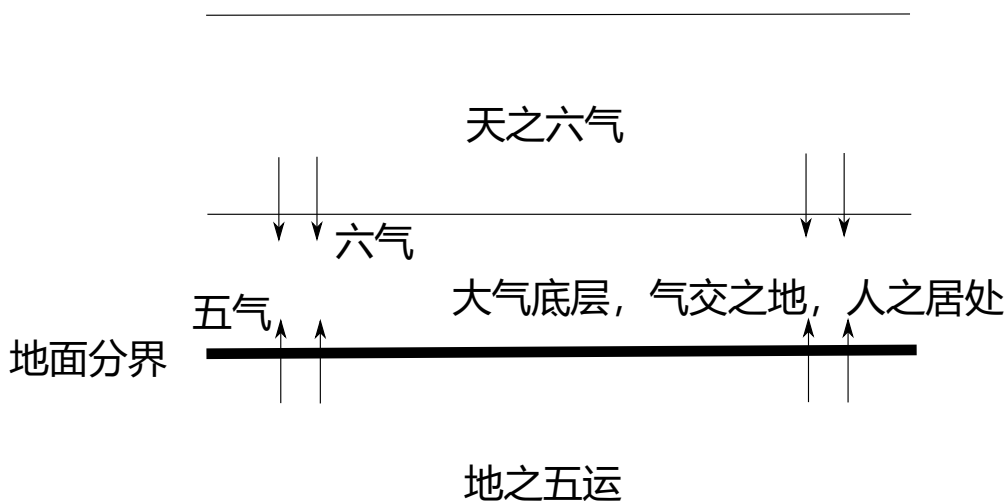
五气风、热、湿、燥、寒，其时间分配和地气五运的分配是一致的，都是从大寒起算，将一年分为五份，每份七十三日。

一年分作五季，每季各七十三日有零，即每年从大寒日起，历时七十三日，气候温和，属风气主令；从春分后十三日起，历时七十三日，气候炎热，属火气（包括暑气在内）主令；从芒种后十日起，历时七十三日，气候潮湿，属湿气主令；从处暑后七日起，历时七十三日，气候干燥凉爽，属燥气主令；从立冬后四日起，历时七十三日，气候寒冷，属寒气主令。

这就是一年的五行气运，它是空间因素和地面因素相互作用的结果。

《黄帝内经讲解-阴阳五行学说-天、地、人之间的五行联系》

所以对于气交之处而言，五气与六气是同时起作用的。



五运和六气都要分主一年各个季节、气候的变化，.....

而自然气候的运动变化，又是空间因素和地面因素相互作用的结果，亦即天气与地气相互作用的结果。

亦即“五运”与“六气”彼此相应，相互影响。阴，指五运；阳，指六气。阴阳相错，即五运和六气彼此交错，亦即天地阴阳之气交相作用。

《黄帝内经讲解-运气学说》

注意气交之地的五气“风、热、湿、燥、寒”与天气本源六气“风、热、暑、湿、燥、寒”，又是非常容易混淆的概念。前者应为气交之地受地气五行影响而形成的。后者为整体天气受太阳阳气多少影响而形成的。

现代对大气层的分层命名中，大气的底层是对流层。对流层的特性与中医的气交之处相似。比如云雨都发生在对流层，而云雨是中医天地相交的一个重要过程；对流层的温度受地面因素影响很大等等。

中医的三阴三阳、五运、六气是通过“移光定位”，也就是影子长度来判断。而影子长度即是我们现代所说的太阳高度角，其大小与季节有关。这个角度代表了地面接受太阳辐射能量的多少。所以自然界三阴三阳是由太阳辐射能量的多少而形成的。

现代地理课讲解的大气受热过程提到，阳光的能量只有一半能到达地面，另一半被大气吸收和反射了。对照前面的五运六气可以发现，大气吸收太阳能量后形成六气，大地吸收太阳能量后形成五运。

气交之处的能量就是由六气和五运共同作用来决定的。用现代的语言就是对流层的温度由大气吸收的太阳短波辐射和地面发射的长波辐射共同起作用。这些属于现代地理和物理的基本知识，不了解的可以查找一下相关资料。所以，自然界的气候与热辐射关系紧密，涉及到不同波长的能量波。从天人合一的理念看，人体也应该有这类道理。近些年，有中医从人体热像和波长、频率的角度研究中医诊断和治疗方法，是有其理论基础的。

2.2.1.3、天气、地气的动态平衡与失衡

一年的天气按照六气划分，地气按照五运划分。天气与地气共同形成适宜的气候。自然界的生物已经适应在各个时间段有不同的气候，所以有相应的生命活动与之对应。春天温暖，种子发芽；夏天炎热，植物长大；秋天凉爽，植物结果；冬天寒冷，植物凋谢。

假设春天以气温10度为平衡点，夏天以30度，秋天以10度，冬天以-10度为平衡点，可以看出平衡点是随着时间动态变化的。气温30度如果是出现在夏天就是正常的、平衡的，如果出现在春天或者冬天，就是异常的、失衡的。这种平衡点随时间变化的情况就是中医所说的动态平衡。因这种动态平衡是太阳阳气与地球阴气此消彼长而形成的，所以又叫阴阳消长动态平衡。

因此，自然界生物的正常生长，需要天地之气按照正常的规律运转。如果在某个时间段没有出现对应的气候，比如春天该温暖而没有温暖，甚至出现倒春寒，这就是非时之气。非时之气会造成自然界的生物生病，也容易让人体生病。

帝曰：至而不至，未至而至，何如？岐伯曰：应则顺，否则逆，逆则变生，变生则病...

全句意为六气有的及时而至，即本气所主的季节到来之时，就出现相应的气候变化，如春温、夏热、秋凉、冬寒之类。不过在实际观察时，必须按六气所主的具体时间考察气候变化，以下均仿此。.....

与季节不相应的反常气候会引起灾变，不利于万物的生长发育，所以导致疾病的产生。

《黄帝内经讲解-运气学说-六气的常变》

2.2.1.4、地气五行的特殊性

1) 地气五行与生命生长的关系

地气的变化对动植物生命的成长过程有重要作用。在平衡范围内，温度偏高的时候，生命活动活跃；温度偏低的时候，生命活动低沉。因此，地气五行与生命的生、长、化、收、藏的过程相对应，比如地气处于木气阶段的时候，土壤开始温暖，种子开始发芽，所以木气主生。其它类似，火气主长、土气主化、金气主收、水气主藏。

木火土金水，地之阴阳也，生长化收藏下应之。

《素问-天元纪大论》

2) 地气五行之间的生克乘侮

五行作为地气能量阴阳变化的五分法，每一行都要有合适的度才能保持总体平衡。五行之间关系紧密，一行出现虚实失衡，都会影响其它四行。五行维持平衡的机制为五行生、克、胜、复，五行失衡的机制为五行乘、侮。这些内容在教材中叙述的比较好。大家可以参考光明教材《概论》和《内经》的五行学说部分，因篇幅较大此处不细说。

夫五运之政，犹权衡也，高者抑之，下者举之，化者应之，变者复之，此生长化收藏之理，气之常也，失常则天地四塞矣。

3) 五行与五方

前面讲阴阳的时候说过，阴阳从时间角度看是指标的波动，从空间角度看是不同位置的指标差异。

自然界的温度，在任何地点，从时间角度看，一年都是按照春温、夏热、秋凉、冬寒进行变化；在任何时间点，从空间角度看，都是南热、北寒、东温、西凉。因此南方与夏天都为热，北方与冬天都为寒，也就是方位与时间具有相似的象。因此方位的东、南、中、西、北与五行的木、火、土、金、水对应。

南方的冬天和北方的夏天，因为寒热互相抵消，更接近温度平衡点，所以舒适。而南方的夏天，因为夏天为热、南方也为热，两热叠加，使气候相对于平衡点向偏热方向的失衡过多，所以南方的夏天，候鸟北迁，以躲避这种失衡。同理，北方的冬天，是气候偏寒的失衡，所以北雁南飞。

有的疾病与季节有关系，比如一个人的病是冬天严重而夏天舒服，那么说明此人自身的失衡方向是偏寒，与冬天的寒叠加所以严重，此人适合选择南方居住。反之亦然。当然这是大概原理，涉及具体情况还要具体分析。

五方温度的差异会形成空气和海洋的流动。冬天的时候，北方的寒冷空气向南流动，形成西北风；夏天的时候南方的温暖空气向北流动，形成东南风。海洋的洋流、自然界的河流也随季节的变化而变化。这种气体、液体的流动有利于自然界的温度平衡。

4) 五行是五种物质么？

因为五行的名称是金、木、水、火、土，一般人容易将其理解为五种物质。这个理解是片面的。

五行是从时间角度看，是地气（固、液态物质）在自身温度波动平衡的过程中，处于五个不同能量状态的符号。土壤加热到较高温度，就是火

象，降低到较低温度就是水象。从空间角度看，是地理五个方位的地气能量状态。

五行木、火、土、金、水这五种代号所指的五种物质，其本性和五行的内涵有一定相似性，比如一般情况下，水润下偏寒，火炎上偏热，木有生发特性，金有杀伐收敛的特性，所以被用来代表平衡过程中的五种状态，但不可机械的认为五行就是五种物质。

《尚书·洪范》对五行的基本属性作了部分概括：“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡”。...

五行的基本属性，是由原始的五种具体物质的属性引伸并高度抽象、概括而成。因此，它又不完全局限于原始五种具体物质的范畴，而是概括了自然界五大类事物的属性。

《中医学概论》

2.2.2、天地物质交互平衡

前面说的是天地之间的能量交互，除此之外天地之间还有物质上的交互。

内经讲“地气上为云，天气下为雨；雨出地气，云出天气。”这明显是自然界的对流。

在天地这个循环系统中，地表的物质受阳光照射后，形成比较活跃的地气；地气受热上升，离开地面成为天气，天气越向上越冷，升到一定程度后，受寒下降，落于地面，又回归为地气。通过这种升、浮、降、沉的循环运动，天地之间进行了物质上的交互，让气交之地的温度、湿度趋于平衡。

比如海水为液态，受热成为水蒸气上升到天空形成云，天空为阳，天空的云就可以理解为阳中之阴。

空气存在于空中为气态，但其可以溶于水或者存在于疏松的土壤中。因地面水土为阴，其中所含的空气就可以理解为阴中之阳。土壤中的空

气含有的氮、氧等元素对植物的生长有很好的作用。农民种地的时候需要松土，有利于植物的根接触空气；养鱼的时候，需要向池塘中加气增加水的含氧量，也有利于鱼类的生长。

这样，地面的水升到天空，滋润了空气；天空的空气下降到大地，肥沃了土壤。这就是中医中的阴中有阳、阳中有阴、阴阳互根的道理。

故清阳为天，浊阴为地；地气上为云，天气下为雨；雨出地气，云出天气。

故清阳出上窍，浊阴出下窍；清阳发腠理，浊阴走五脏；清阳实四肢，浊阴归六腑。

《素问-阴阳应象大论》

气之升降，天地之更用也。……升已而降，降者谓天；降已而升，升者谓地。天气下降，气流于地；地气上升，气腾于天。故高下相召，升降相因，而变作矣。

《素问-六微旨大论》

自然界大气的运动，是天地阴阳二气相互作用的结果。天之阳气具有温暖、发散的特性，地之阴气具有寒冷、凝结的特性，这两种属性不同的气，常常相互作用，相互影响，因而引起大气不断上升下降的运动。《内经》曾举云雨的变化为例来说明这一问题，比如地面的水，由于天空（太阳）热力的蒸发，可以化气上升而为云，所谓“地气上为云”，“云出天气”；天空的云，遇到寒冷的阴气，便会凝结下降而为雨，所谓“天气下为雨”，“雨出地气”。可以看出天地阴阳之气在不断地进行上升下降的运动。

天气下降，气就下流于大地；地气上升，气就上腾于天空。天气属阳，下流于地后便转化为阴；地气属阴，上腾于天后便转化为阳。这就形成了天地阴阳之气的相互转化。

《黄帝内经讲解-阴阳五行学说一（十四）天地阴阳之气的升降转化》

自然界的水循环过程是海水在太阳的照射下，变化为水蒸气进入空中成为云，云在风的作用下漂浮到陆地上空，变为雨下降到大地，滋润万物生长，然后形成河流，最后又流回大海。中医认为人体的水液循环也是这种道理，有液态与气态的相互转变，以及气态物质的传送和液态物质的传送。所以说天人合一，天地是一个大自然环境，人体是一个小的自然环境，想理解中医的人体观必须从自然观入手。

2.2.3、小结

天气、地气在能量与物质上各自平衡，并且能正常的交互，是自然界生命繁荣生长的重要条件。后面学习人体的时候，会谈到人体有多种天地关系。比如脏为地、腑为天，互为表里，说明两者会象自然界的天气、地气一样相互影响。其它天地关系也是这个原理。

天地相交的道理对理解中医治病原则有重要意义。以沙漠为例，沙漠的天气干燥，土壤也干燥沙化，所以沙漠无法生长植物。天气中应该包含一定量的水蒸气才能适合生物生长，也就是阳中有阴才能平衡。天气过于干燥就是一种失衡，会导致动植物的生存困难。地气也是如此。沙漠这种环境失衡既可以通过改善天气增加降雨来解决，也可以通过在地上引入水源来解决。总之，要让此处的天气、地气的交互恢复正常状态即可。中医认为人体中也经常出现这种天地交互障碍的病证。这类病证，有时看似地气的问题，却可能从天气解决；有时看似天气的问题，却可能从地气解决。

如张志聪注：“天有阴阳，地亦有阴阳”，“阳中有阴，阴中有阳”，主要说明五运与六气虽然分别代表天气和地气，但不能把天气看做是绝对的阳气，地气看做是绝对的阴气，而是天气地气里面都有阴阳之气的存在。为什么呢？因为天气要下降于地，地气要上腾于天，所以天气也包含着阴气，地气也包含着阳气，正如张介宾所注：“天本阳也，然阳中有阴，地本阴也，然阴中有阳，此阴阳互藏之道。”惟阳中有阴，故天气得以下降；阴中有阳，故地气得以上升，此即上下相召之本。”懂得这个道理，才对五运六气中阴阳互根互用有一定的认识。

《黄帝内经讲解-运气学说-运气学说的基本概念》

3、平衡三要素：

上一章谈到了平衡三要素，即作用、载体和指标。套用这个思路对大自然进行总结的话，其三要素为：

作用

维护自然界的生物生长

载体

地表上下，气交之地。

天地者，万物之上下也；

《素问-阴阳应象大论篇第五》

指标

自然界平衡机制包含日地平衡和天地平衡，既涉及能量也涉及物质，所以其维持平衡相关的指标是非常多的。最主要的包括以下几项：

1、空气

2、土壤

3、水

4、温度（阳光）

温度指标最为敏感多变。自然界的温度是空气、土壤、水在阳光的作用下形成，适宜波动范围在-20度~40度之间。自然界生命大部分生活在这个温度范围内。

温度本质上是代表能量。自然界四季温度的波动实际上是从太阳获得的能量的波动。这种能量为自然界生物的生长提供了能量来源。

5、各大要素的配合平衡

空气、土壤、水、阳光几大要素除自身的质与量要平衡外，相互之间的配合也要平衡。比如地气要有一定的量升入空中，天气要有一定的量降入地下。这就是升浮降沉的平衡，既不能升之太过也不能升之不及，既不能降之太过也不能降之不及。升降出入的异常也是疾病的主要原因之一。

这个几个指标是最顶层的大指标。如果细分的话，每个指标都应该包含一系列的小指标。比如空气中氮气、氧气的比例要合适才是合格的空气，否则就不是合格的空气，不能形成健康的自然界。同理，土壤中含有的元素比例也要合理。前面说过，所有指标，无论大小都很重要。大平衡是由一系列小平衡组成的。小平衡失常也会引起大平衡的失常。中医的定位是花园的园丁，关注的是这几种要素的大平衡。如果真的出现元素成分失调之类的小指标失衡，也可导致植物无法生长。这种情况就不是园丁擅长的内容，用现代科技的元素分析法就很适用。

4、总结

关于自然界的气候规律，大部分都是常识的东西。这里只是从阴阳平衡的角度重新梳理了一下，并从中引出了中医一些重要概念的来历。比如三阴三阳（厥阴、少阴、太阴、少阳、阳明、太阳）、六气（风、热、暑、湿、燥、寒）、五行（木、火、土、金、水），还有升浮降沉、寒热温凉和阴阳互根互用等等。

需要强调一下，上述这些概念都是在平衡范围内的差异，是一种符号，比如六气中的寒，指的是其正常波动过程中偏低的部分，热指的是正常范围中偏高的部分。五行也是如此，代表地气能量正常变化范围内的差异。

中医用六气（风、热、暑、湿、燥、寒）六个符号代表天气一年正常变化的六个阶段，五行（木、火、土、金、水）五个符号代表地气一年正常变化的五个阶段。

另外，前面阴阳平衡章节谈到寒热是指的温度向上超出平衡范围为热，向下超出平衡范围为寒。这个寒热与六气（风、热、暑、湿、燥、寒）中的寒热是两个意思。两者混用又增加了中医的理解难度。

这里的知识很重要，如果这些概念不掌握，后面谈人体的时候，就理解困难。比如伤寒论的三阴三阳辨证，其中太阳病、少阳病等等是什么意思？什么是风湿、风寒、风热、湿热、伤寒、中风等等？

这些概念掌握后，才初步具备学习中医的基础，后面我们就可以开始谈人体了。

5、探讨

自然界的奥秘是无穷的，还有很多方面是目前没有完全清晰的，下面列出一些有待进一步探讨的问题。

5.1、如何理解自然界海洋中的生物？海洋也算气交之地么？

根据天气地气相交的道理看，海洋中生物密集的区域也是气交之地。海洋的生物特别是深海的生物，虽然没有直接接触到空气，但是需要海水中溶解的氧气才能生存。而深海的氧气是海洋表面的含氧水通过升降循环的方式送到深海处，因此深海生物也是从天地中获取物资和能量来生存的。

探讨这个道理可以给我们一些启发，人体大部分组织器官是在液体当中，其获得氧气的原理是否和海洋生物获得天气的原理有相似之处？

5.2、为什么天分六气、地分五运？

天气为何分成六份，地气为何分为五份？这个问题目前还没有明确答案。目前是因为内经如此划分，并且中医学中到处都使用了这个概念，所以我们学习的时候需要记住。至于其原理，下面是一些相关探讨，供参考。

一个周期如何离散化是数学上常见的情况，比如一年分成365天，是一种离散方式。分为12月，是另一种离散方式。所以天气六分与地气五分，也无非是一种离散方式而已。难度在这种分法的根据是什么？能否进行准确的测量？

前面说过五运与六气很可能是和频率有关系，但是目前的科学研究还没有明确证明这种天气六分和地气五分的证据。

音律学在中医中有很重要的地位。古代音律学包括五音十二律，五音是指宫、商、角、徵、羽，十二律是黄钟、大吕、太簇、夹种、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。十二律又分为阴阳两类，凡属奇数的六种律称阳律，属偶数的六种律称阴律。另外，奇数各律称“律”，偶数各律称“吕”，故十二律又简称“律吕”。大家可以在网上查询一下音律学的基础知识。音律的本质是空气的不同振动频率。

不同颜色的光有不同的频率，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫频率依次增大。所以颜色的本质是光子的不同震动频率。

内经中多处提到五行、十二经络与音律、颜色的关系。比如在木在音为角、在色为苍；火在音为征、在色为赤；土在音为宫、在色为黄；金在音为商、在色为白；水在音为羽、在色为黑；

东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天为玄，在人为道，在地为化。化生五味，道生智，玄生神，神在天为风，在地为木，在体为筋，在脏为肝。在色为苍，在音为角，在声为呼，在变动为握，在窍为目，在味为酸，在志为怒……

六律建阴阳诸经而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者，此五脏六腑之所以应天道。

《灵枢-经别》

基于这些资料，从频率的角度探讨中医内涵可能是一条让传统中医与现代科学结合的道路。

5.3、天不足西北，地不满东南

内经起源于中国，处于北半球，所以谈到南热北寒东温西凉都是在中国这个地域角度上说的。

对于北半球来说，太阳在南，所以在同一时间，南方热而北方寒。

由于地球自转，所以太阳东升西落。所以在同等地面条件下，都是东方温度先提高，过了中午之后，西方的温度再升高。所以东温西凉。

这样造成北半球的地表，东南方地表偏温热，西北方地表偏寒凉。

中医中“天不足西北，地不满东南”的说法，推测是东南偏温热，地气上升的较多，所以叫地不满东南。西北偏寒凉，天气下降较多，所以叫天不足西北。

当然这只是大气运动的一个规律，实际上的大气运动还受陆地、海洋、山、湖、沙漠等等地面因素的影响，情况是很复杂的。

岐伯曰：东方阳也，阳者其精并于上，并于上则上明而下虚，故使耳目聪明而手足不便。西方阴也，阴者其精并于下，并于下则下盛而上虚，故其耳目不聪明而手足便也。故俱感于邪，其在上则右甚，在下则左甚，此天地阴阳所不能全也，故邪居之。

《素问-阴阳应象大论》

帝曰：天不足西北，左寒而右凉；地不满东南，右热而左温，其故何也？

岐伯曰：阴阳之气，高下之理，太少之异也。东南方，阳也，阳者，其精降于下，故右热而左温。西北方，阴也。阴者，其精奉于上，故左寒而右凉。是以地有高下，气有温凉。高者气寒，下者气热，故适寒凉者胀之，温热者疮，下之则胀已，汗之则疮已，此腠理开闭之常，太少之异耳。

帝曰：其于寿夭，何如？

岐伯曰：阴精所奉其人寿；阳精所降其人夭。

帝曰：善。其病也，治之奈何？

岐伯曰：西北之气，散而寒之，东南之气，收而温之，所谓同病异治也。故曰气寒气凉，治以寒凉，行水渍之；气温气热，治以温热，强其内守，必同其气，可使平也，假者反之。

《黄帝内经-五常政大论》

5.4、五运六气与三阴三阳的对应问题

阴阳的划分经常体现在一个平衡系统中，某一要素的波动。对波动周期的不同划分可以产生不同的阴阳。一般单一要素波动往往表现为标准的起落波形。但如果有多要素同时波动，则各种波形之间可能发生叠加。叠加后，就会表现出不标准的波形。类似向湖面两个位置同时投入石子，会产生两个涟漪互相叠加。叠加后的波形即不是标准的波形。如果投入多个石子，产生的波动会更加混乱。

内经给出了三阴三阳六个阶段的标准顺序，也给出了三阴三阳与五运六气的对应结果，如下表。

序号	一	二	三	四	五	六
标准顺序	厥阴	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳
三阴三阳对五运六气	风木	君火	湿土	相火	燥金	寒水

这里有两个明显的问题：

- 1、太阳为阳，应该偏热，为什么对应了冬季的寒水？少阴为阴，应该偏寒，为什么对应了君火？
- 2、六气的顺序本应为风、热、火、湿、燥、寒，但是上表中的最后一行序号三、四，火与湿调换了顺序，变成了湿与火，这是为什么？

这两个问题，中医界似乎没有公认的合理解释。教材对此只说三阴三阳是一个标识，来标示六气，并未过多解释。

三阴三阳为标。这是因为三阴三阳本身只是作为一个标识或标志，分列以之代表六气。厥阴代表风，少阴代表热，太阴代表湿，少阳代表火，阳明代表燥，太阳代表寒。

《黄帝内经讲解-三阴三阳配六气及标本中气之间的关系》

帝曰：其于三阴三阳，合之奈何？鬼臾区曰：子午之岁，上见少阴；丑未之岁，上见太阴；寅申之岁，上见少阳；卯酉之岁，上见阳明；辰戌之岁，上见太阳；巳亥之岁，上见厥阴。少阴所谓标也，厥阴所谓终也。厥阴之上，风气主之；少阴之上，热气主之；太阴之上，湿气主之；少阳之上，相火主之；阳明之上，燥气主之；太阳之上，寒气主之。所谓本也，是谓六元。

《素问-天元纪大论》

前面阴阳章节说过，谈阴阳一定先说清功能、平衡点等要素，否则必然引起混乱。产生这个情况应该是有多个波动进行了叠加，导致湿与火的顺序发生改变。因为我们不清楚相关各个波动的原理，所以这个问题解决不了。这就像复杂的数学计算缺少重要条件，所以无法推演。如果勉强解释就只能牵强附会。

中医的知识主要来自经典，但经典中经常只讲了结论和用法，却没有详述原理。所以这类不能清晰解读的内容还不少，重要部分只能记住。这类问题能搞清最好，搞不清也不必纠结，只要理清了寒热虚实等基本原理解，再熟悉诊断与治法，大部分问题是可以解决的。

内经说，天之道像浮云一样变幻莫测。期待以后有水平更高的人把这个知识点讲清楚。

黄帝问曰：呜呼，远哉！天之道也，如迎浮云，若视深渊。视深渊尚可测，迎浮云莫知其极。夫子数言谨奉天道，余闻而藏之，心私异之，不知其所谓也？愿夫子溢志尽言其事，令终不灭，久而不绝，天之道，可得闻乎？

《素问-六微旨大论》

第三章 中医人体观念

3.1、人体基本概念及运转机制

前面天地自然章节提到自然界有两大平衡需要重点关注，即日地平衡和天地平衡。日地平衡是能量与物质的平衡，即太阳能量与自然界物质形成的适度配合状态。天地平衡是气态物质与固液态物质的适度配合状态。

而人体要维持合适的温度，形成适宜的体内环境，也有这两类平衡，其原理与自然界很相似，所以称人体是一个小自然。

人体的阴与阳，大多情况下是指人体维持内环境平衡时用到的物质与能量。人体总的阴阳平衡就是物质与能量像自然界的水土与阳光一样，处于一种合适的配合状态。其中对维持平衡起正面作用的物质称为正阴，破坏平衡的物质称为邪阴。同样，对维持平衡起正面作用的能量称为正阳，破坏平衡的能量称为邪阳。

“阳”，指物质的能量。阳可以把物质转化为精微之气，以促进万物的生长；转化为动力，以促进人体的生命活动，所以称为“阳化气”；“阴”，指有形可见的物质（如精、血、津液等），它可以充养形体组织，有促进万物成长壮大的作用，所以又称为“阴成形”。

《黄帝内经讲解-阴阳的性质和作用》

又因阴阳术语在中医学中广泛应用，所以阴阳也可指其它方面，需要具体情况具体分析。比如阴阳有时用来代表内外部位、固液态物质与气态物质、功能的低沉或亢奋、干扰平衡的因素性质等等。

在进一步介绍人体机制之前，因中医有一些基础专用名词，初学者不一定了解，所以需要先对这些名词做一个初步介绍。

1、基本概念

1.1、元气

元气是人体的初始能量，对应于自然界的阳光。正像阳光的作用是给自然界的土壤、水、空气提供能量一样，人体的元气给物质提供能量，形成合适的人体内环境，各个器官才能完成各自的生命活动

元气，又称“原气”、“真气”。是人体诸气中最基本，最重要的气，是人体生命活动的原动力。

《中医学概论-藏象-气》

阳气者若天与日，失其所则折寿而不彰，故天运当以日光明。是故阳因而上，卫外者也。

《素问-生气通天论》

可见阳气代表着人体具有阳性特征的精微物质，及其产生的热能和动力。它的物质基础是精，它的属性是火，来源于先天，但要靠后天的补充和营养。

《黄帝内经讲解-阴阳学说-（十六）阳气的重要性》

1.2、形

肉眼可见的人体组织器官都属于形，包括皮、肉、筋、骨、脏腑器官等，对应自然界的土壤等固态物质。

1.3、津、液与痰、饮

人体内的水，中医称为津液，对应自然界的水。

干净的水进入体内，与营养物质混合，滋润各个脏腑组织，然后携带代谢废物，主要以小便的形式，辅以汗液等形式排出体外。

其中清稀的为津，粘稠的为液。

津的流动性强，分布偏表，布散于体表皮肤、肌肉和孔窍，并能渗注于血脉，起滋润作用。

液的流动性小，分布偏里，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织，起濡养作用。

该有的水不够，称为津液虚，属于正虚的一种类型。

不该有的水聚集，叫痰饮，属于邪实的一种类型。一般将稠厚的叫痰，清稀的叫饮。

1.4、血与瘀血：

血是水与营养物质混合形成的赤色液态物质，在心肺的共同作用下，在血管中通行全身，具有濡养全身脏腑组织的功能，也对应自然界的水。

血为气之母，血能滋养气。

该有的血不够，称为血虚，也是正虚的一种类型。

血的瘀滞，称为瘀血，是邪实的一种类型。

瘀血与上面提到的痰饮即是身体机能不正常后的病理产物，又会直接或间接的影响脏腑组织的功能，成为新的病因。

1.5、天气、地气

人之饮食入口、吸气入鼻，饮食为自然界地气，吸入的空气为自然界天气，所以人以自然界的天地之气而生。饮食、空气进入人体以后，经过处理成为人体的天气、地气。人体的地气，包括形、津液、血等。人体中的气态物质为天气，包含自然空气以及血、津液蒸化而成的气态物质等。

“人以天地之气生，四时之法成。”

《黄帝内经讲解-天地形气的相互关系及其作用》

天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，音声能彰。五味入口，藏于肠胃，味有所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生。

《素问-六节藏象论》

人体的天地之气像自然界天地之气一样相互转化，也就是气态物质与固、液态物质会发生频繁的转化。津液、血由液态转化为气态物质，就

成为天气的一部分。空气溶于津液、血中就成为地气的一部分。这就是人体中的天地平衡。

人体中全身各处都有天气、地气存在，但因两者特性的不同，可以分出多种天地关系。天气倾向于向外、向上，地气倾向于向内、向下，从此角度对人体进行划分的话，人体的肌表、四肢等形体属天，五脏六腑属地；上窍属天，下窍属地；上半身属天，下半身属地；三焦中的上焦属天，中下焦属地；脏腑对比的话，腑属天，脏属地。

夫言人之阴阳，则外为阳，内为阴。言人身之阴阳，则背为阳，腹为阴。言人身之藏府中阴阳，则藏者为阴，府者为阳。肝心脾肺肾五藏皆为阴，胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦六府皆为阳。所以欲知阴中之阴，阳中之阳者何也？为冬病在阴，夏病在阳，春病在阴，秋病在阳，皆视其所在，为施针石也。故背为阳，阳中之阳，心也；背为阳，阳中之阴，肺也；腹为阴，阴中之阴，肾也；腹为阴，阴中之阳，肝也；腹为阴，阴中之至阴，脾也。此皆阴阳表里内外雌雄相输应也，故以应天之阴阳也。

《素问-金匱真言论》

黄帝曰：余闻天为阳，地为阴，日为阳，月为阴，其合之于人，奈何？岐伯曰：腰以上为天，腰以下为地，

《灵枢-阴阳系日月第四十一》

清阳出上窍，浊阴出下窍；清阳发腠理，浊阴走五藏；清阳实四肢，浊阴归六府。

《素问-阴阳应象大论》

阳者，天气也，主外；阴者，地气也，主内。故阳道实，阴道虚。

《素问-太阴阳明论》

这里的属天指的是相对而言，气态物质的比例高一些或者作用强一些。属地则相反。这种方式定义的几种天地，相互之间都有类似自然界气交之地的交互形式，包括物质交互和能量交互等。比如脏腑之间，腑包括

胃、大小肠、胆、膀胱等，都是空腔器官，属天，里面有较多气态物质；脏包括肝、心、脾、肺、肾，为实体器官，属地，相对而言气态物质比较少，固液态物质比较多。脏腑之间互为表里，有频繁的物质或能量的交互。

岐伯对曰：脑、髓、骨、脉、胆、女子胞，此六者，地气之所生也。皆脏于阴而象于地，故藏而不泻，名曰奇恒之府。

夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱，此五者天气之所生也，其气象天，故泻而不藏。此受五藏浊气，名曰传化之府，此不能久留，输泻者也。

《素问-五藏别论篇第十一》

大多情况下，单独使用“气”这个名词，指的是气态物质，也就是天气。在中医中，气态物质的作用非常大，与各器官的功能紧密相关。气足则功能偏强，气虚则功能偏弱。

何谓气？岐伯曰：上焦开发，宣五谷味，熏肤，充身，泽毛，若雾露之溉，是谓气。

《灵枢-决气》

饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。水精四布，五经并行。合于四时五藏阴阳，揆度以为常也。

《素问-经脉别论》

上焦如雾，中焦如沤，下焦如渫。

《灵枢-营卫生会》

阳的化气过程，即是把体内有形之质，化为无形之气，或转化为能量，如“精化为气”，“水化为气”等等，都依赖于阳的气化作用；阴的成形过程，即是把外界的物质，合成自身的形质，如精血的生成，形体的发育等等，都要依靠阴的成形作用。

《黄帝内经讲解-阴阳学说-（十二）阴阳的性质和作用》

1.6、精

精指一种比血更为精华的物质，精可以与能量(元气)进行相互转化。在需要能量的时候精转化为能量(精化气)，也可以在能量充足的时候，把能量存储起来(气化精)。所以精类似现代能源的概念。

肾中之精，对各个脏腑的功能活动起着极其重要的作用。中医学认为：精气之间是可以而且能够相互转化的，故有“精可化气”、“气可生精”的说法，其中，肾精与肾气之间亦可相互转化，故中医古籍中，“肾气”与“肾精”常可互称。

《中医学概论-肾、膀胱》

另外精血同源，二者是可以互相转化，精可以稀释为血，血可以浓缩为精。在血不足的时候，精可以转化为血作为补充，可以理解为血的提炼浓缩品。

肝藏血，肾藏精，精血之间相互滋生、相互转化，故有“肝肾同源，乙癸同治”之说。

《中医学概论-肝与肾的关系》

1.7、神

神是人体的管理者，可以调动气、血、津液等资源完成各种功能，对人体的各种平衡起到控制、管理作用。神主要藏于心，五脏皆有。

心在人体诸脏腑中居于首要的地位，对各个脏腑的功能活动起到统领与调节的作用。《灵枢·邪客》说：“心者，五脏六腑之大主，精神之所舍”。《素问·灵兰秘典论》说：“心者，君主之官也，神明出焉。……故主明则下安，……主不明则十二官危”。都突出强调了心在脏腑中的统帅作用。

《中医学概论-心、小肠》

1.8、腠理

腠理是肌表、肌肉、脏腑之间的间隙和纹理。因中医非常关注气态物质，所以腠理这种能流通气态物质的组织间隙对中医有重要作用。

腠者，是三焦通会元真之处，为血气所注；理者，是皮肤脏腑之文理也。...

所谓腠理，腠，是三焦交通融会元真的地方，又是血气所灌注的处所；理，是皮肤肌肉的纹理。总之，腠理是营卫气血交会出入的门户，又是抗御外邪的屏障。

《金匱要略讲解》

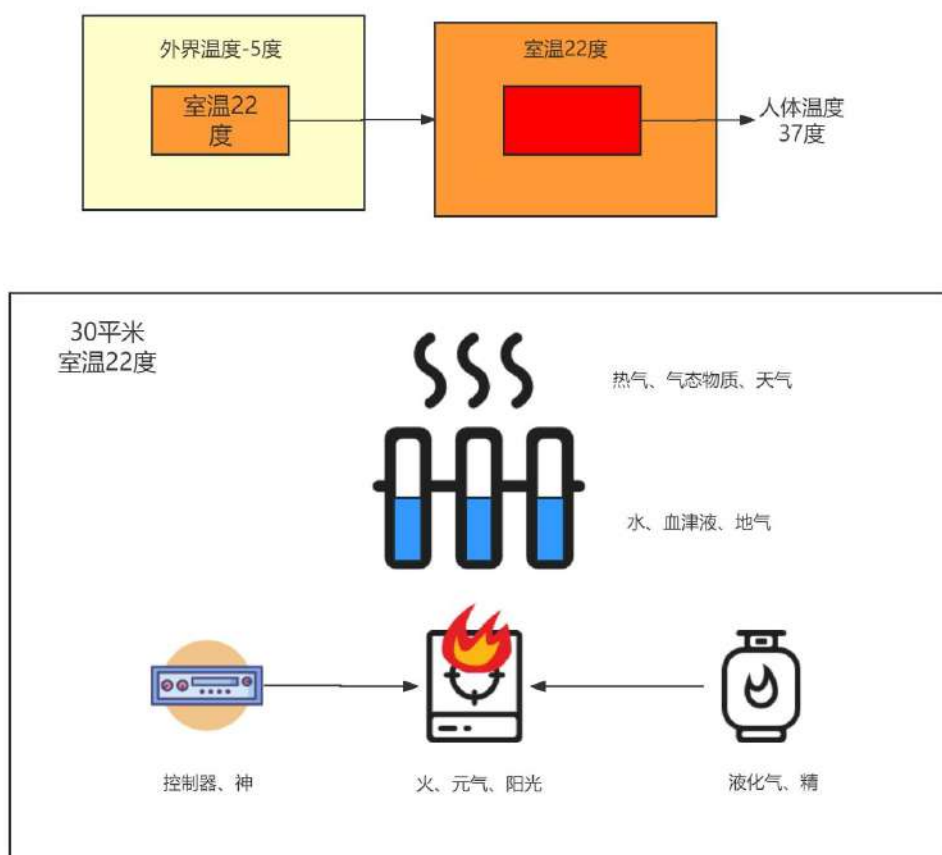
2、运转机制概述

2.1、基本原理

2.1.1、内环境平衡的基本原理

人体的要素包括精、神、气、血、津液、形、元气等，这些要素是如何配合形成适宜的体内环境呢？这个问题是中医的核心问题，也是学习中医的几大难点之一。

人体像一个温室花园，其保持温度的原理和北方家庭用暖气片进行烧水取暖有相似之处，我们将两者进行对比讲解。



为了容易理解，我们按照最简单的暖气的原理进行说明。假如有一个30平米的房间，在北方的冬天，房间想维持在22度左右的适宜温度。经过计算，需要一组暖气片来取暖，暖气片里的水是80公斤。然后用炉火给暖气片里的水加热。炉火用的是相当于60千瓦功率的煤气灶，由煤气罐中的液化气做燃料。有一个控制系统用来根据室温调节炉火的大小，以保证室温不会偏差太大。

这个例子中有几个指标需要平衡，缺一不可。

- 1、根据房间的面积，暖气需要提供一定范围内的热量。此热量过高则房间过热，过低则房间过冷。
- 2、根据所需的热量，暖气里的水量需要在一定范围之内。过少、过多都不能提供所需的热量。

3、炉火的大小需要在一定范围之内，过小则不能将水加热，过大则容易把水烧干。

4、煤气罐中的液化气要足够，否则不能提供足够的火量。

5、控制系统的控制能力要正常，在火量调节方面不能出现大的偏差。

人体这个房间要维持相对恒定的温度，维持体温就需要热量，热量由气、血、津液带来，其中血和津液相当于上面例子中的水，气相当于水蒸汽和被加热后房间空气。气、血、津液的热量由元气给予，元气相当于上面例子中的炉火，是原动力。元气由精产生，精相当于上面例子中的液化气，是人体的能源。神则类似控制器，起到管理调节作用。

从能量与物质的平衡关系角度看，阴指固液气三态的物质。阳指能量，这里指元气。从密度平衡关系角度划分，阳指气态物质，阴指固液态物质。这两种关系对应自然界的日地平衡和天地平衡。这两种平衡关系中，气态物质比较特殊，其在能量与物质的平衡关系中，为物质属阴；在密度平衡关系中，为气态属阳。

阴阳学说不仅认为阴阳二气是人体整个生命的根本基础，而且认为人体中的每一脏腑器官都有阴阳二气存在，这就是阴精和阳气。...

以阴阳概括某些生命物质和生命现象：营、血、精、津、液等有形物质属阴；卫、气、神等生命活动为阳。

《中医学概论-阴阳学说在中医学中的应用》

元气与气态物质容易混淆。两者的关系就像蒸汽机中火与蒸汽的关系。火作用于水而产生蒸汽，火虽然是原动力，但是最终起直接作用的是蒸汽。人体元气虽然是原动力，但是对组织器官起直接作用的还是气态物质。所以中医中常用气态物质代表某部位的功能。说某处气足，就代表其工作能力强。反之说某处气衰弱，则其功能必然下降。

固液态物质在两种平衡关系中皆属阴，所以阴虚就是固液态物质不足。又因为液态物质相对固态物质变化更敏感，所以通常阴虚指血、津液等液态物质的量低于正常范围，对应暖气里的水量不足。水量不足而火量

不变的话，容易烧干，也就是阴虚火旺。这种情况会有一系列表现可供判断。调理方法是加水补阴了。

通常阳虚指元气的量低于正常范围，对应暖气例子中的炉火不足。火不足，则水烧不热，所以屋子寒凉。调理方法是调大阀门，让火旺起来，就是补阳了。当然此时必然会消耗更多原料，对于人体就是耗精。

如果阴阳都不足，对应暖气的水和火的量都不足，则需阴阳双补。

由此可知，气、血、阴、阳的不足是中医虚证的主要原因，其中气、血虚为轻，阴、阳虚为重，对应则有补气、补血、补阴、补阳的方剂。

阳虚者多兼有气虚，而气虚者易导致阳虚，气虚和阳虚表示机体活动能力的衰退。阴虚每兼血虚，血虚也可导致阴虚，血虚和阴虚表示体内精血津液的损耗。

《本草备要讲解-补益药》

补益的方法很多，在临证应用时主要针对气、血、阴、阳之虚而为补气、补血、气血两补、补阴、补阳等法。

《方剂讲解-补益剂》

人体任何部位都涉及到能量与固、液、气三态的相互作用与转化，所以这是中医理论中人体平衡的基本原理。

按：能量与物质的固、液、气三态其实就是佛教所说之火、地、水、风，即四大。能量为火，固态为地，液态为水，气态为风。人体四大不调则生病，四大平衡则健康。

经说，地水火风，和合成人。凡人火气不调，举身蒸热；风气不调，全身强直，诸毛孔闭塞；水气不调，身体浮肿，气满喘粗；土气不调，四肢不举，言无音声。

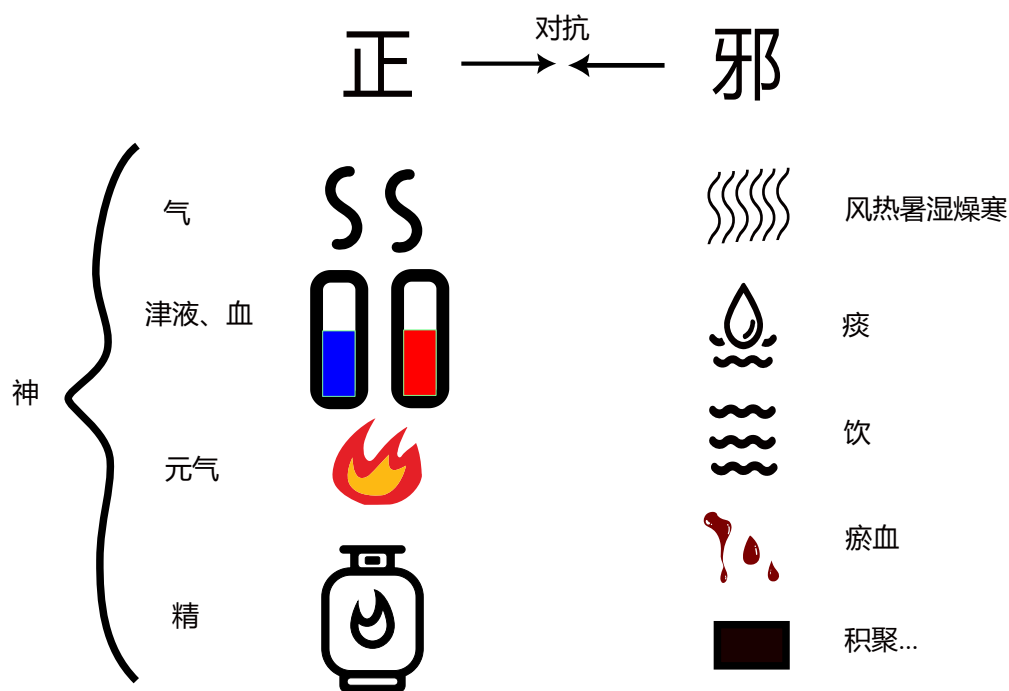
《备急千金要方-诸论-论诊候第四》

身者，四大所成也。地水火风，阴阳气候，以成人身八尺之体。

《外台秘要-叙眼生起一首》

2.1.2、正邪基本原理

人体内到脏腑、外到皮肉筋骨，各种组织器官都各有其功能。正常行使功能需要其处于适宜的内环境中，而形成适宜内环境需要精、神、元气、天气、地气等要素都有合适的度。这些要素就是人体的正气。人体正气足代表各要素充足且配合协调，所以维持人体环境平衡、抵御失衡的能力强。邪气一词则包括所有破坏平衡的因素。其形态上，包括不该有的气态物质、痰饮瘀血等液态物质、不正常的固态物质、过度的能量以及各种毒素等等。其来源上，可能为外入也可能是内生。正气与邪气的关系其实就是维持平衡与破坏平衡的关系。正、邪双方时刻进行着对抗。任何位置，如果正气的力量弱于邪气的力量，就会功能下降，甚至失去功能，从而产生疾病。



2.1.3、资源传递的基本原理

大自然有风云的流动，也有江河的流动，这种气体与液体的流动可以起到均衡自然界能量与物质的作用。

在人体要素中，气、血、津液等气液物质是流动之物。其流动可均衡人体的资源。血是营养身体器官的特别重要的液态物质。气是推动人体各

项功能的直接动力。为了叙述方便，常用“气血”二字代表这种流动之物。元气能量之阳与物质之阴适度配合产生足够的气血。气血流动全身，使各处都可形成适宜的内环境。这些流动之物周行于全身内外、上下，即为人体的升降出入。

体内具有营养、传导、联系职能的流动物质，气、精、血、津液等，是所有器官组织赖以产生机能活动的物质基础，也是脏腑与脏腑之间，脏腑与器官组织之间整体联系的重要媒介。

《黄帝内经讲解-脏腑组织的内在联系》

脉有三部，阴阳相乘，荣卫血气，在人体躬，呼吸出入，上下于中，因息遍布，津液流通。

《伤寒论-伤寒例》

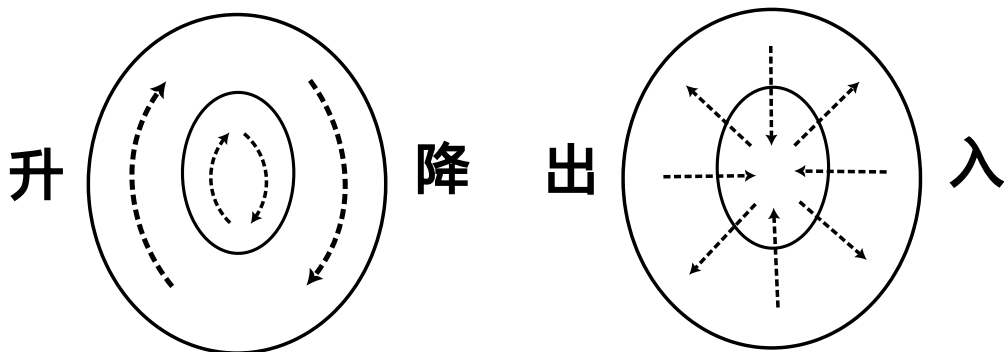
气的运动，称作“气机”。气运动的基本形式是升降出入。气的升降出入运动，是人体生命活动的根本，它贯穿于生命过程的始终。若气的升降出入运动一旦止息，也就意味着生命活动的终止。

《中医学概论-气》

气血在全身的分配应尽量均匀，不同部位之间气血量可有一定的差异，但不能过大。自然界河流的流动可以调节相关区域的水分布。如果河流堵塞，则可出现上游水泛滥，下游干旱的问题。对人体来讲，升降出入失常，可造成气血分布不均的病证。

出入废则神机化灭，升降息则气立孤危。故非出入，则无以生长壮老已；非升降，则无以生长化收藏。是以升降出入，无器不有。故器者生化之宇，器散则分之，生化息矣。故无不出入，无不升降。化有小大，期有近远，四者之有，而贵常守，反常则灾害至矣。

《素问-六微旨大论》



2.2.4、小结

本节所述三个部分的内容，是人体能够正常运转的基本原理，即：

- 1、全身各处的精、神、元气、气、血、津液、形都能适度配合，形成适宜内环境
- 2、全身各处维持平衡的正气力量大于破坏平衡的邪气力量
- 3、流动之物能在全身上下、内外正常的升降出入

其中以第1项内环境平衡最为根本，后2项是其保证条件。正气大于邪气，能够保证各处的平衡不被破坏。正常的升降出入能够给全身各处带来足够的资源使其维持平衡。

中医认为疾病产生的机理都不出这三个方面，所以教材《中医学概论》的病机章节，列出了三大病机：阴阳失衡、正邪相争、升降失常。

虽然疾病的种类繁多，其发生发展错综复杂，千变万化，但就其病变过程来讲，总不外乎正邪相争、阴阳失调、升降失常等三个主要方面。

《中医学概论-病机》

2.2、资源的产生及流转大致过程

人体各处都需要气血，而这些资源是由饮食以及呼吸的空气转化而来，过程中任何一个环节出错，都会导致正气不足，进而引发疾病。因此必须熟悉这些资源的产生、传递过程。

首先，按照资源的传递过程划分，人体可以划分为两大部分：资源使用者和资源生产者。

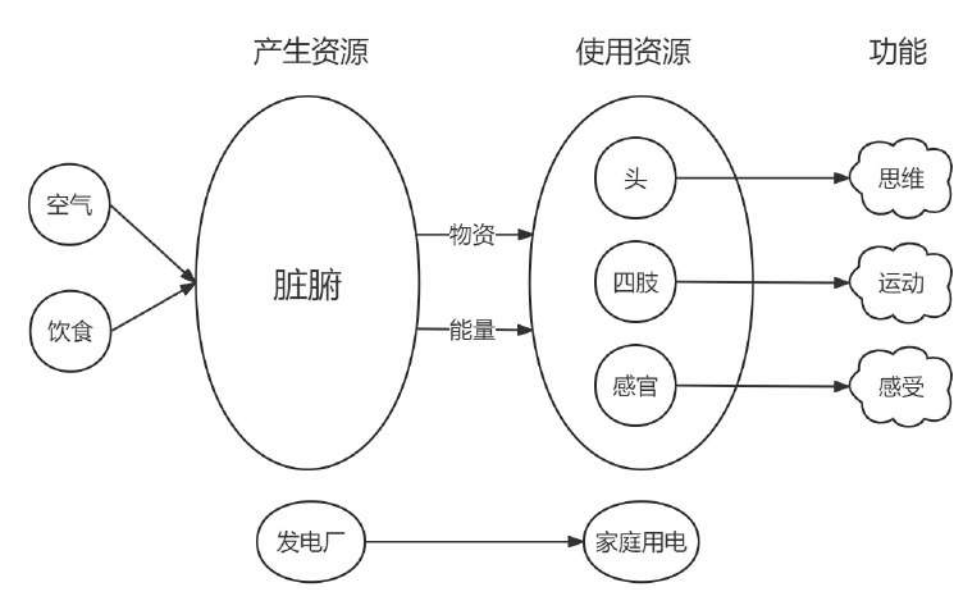
所谓资源使用者，指的是四肢、头部、感官、皮、肉、筋、骨等部位，简称为形体。这些部位本身不产生资源，主要是使用资源来完成人体运动、思维、感受以及护卫等功能。

形体指整个躯体而言，包括头面官窍、项背胸腹、四肢手足，是由五体（皮、肉、筋、骨、脉）有机联合，与经络的相互联属而成完整躯体。

《中医内科学-身形病证门》

所谓资源生产者，指的是胸腹腔内的脏、腑。脏、腑的主要功能是产生和存储资源，供给形体来使用。当然脏腑本身也消耗资源。

如下图所示：



饮食、空气进入脏腑处理后，产生能量和物资，供给形体，用来进行各种生命活动。这是人体资源的大致流转过程。

下面分别说明。

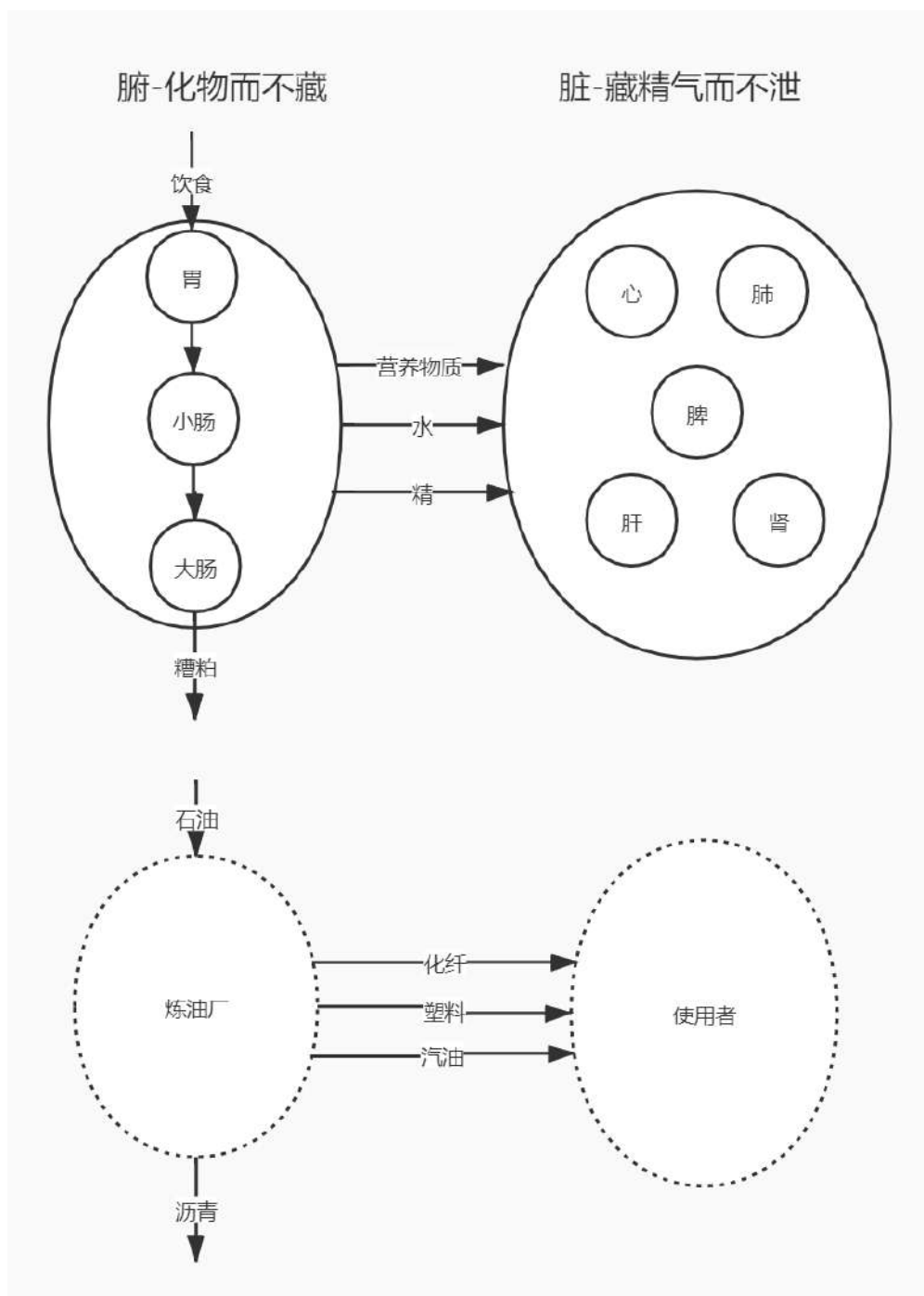
2.2.1、脏腑

脏腑负责资源的处理与存储，其中脏与腑的功能可以进行一个大致的区分。

腑主导饮食的消化，从饮食中提炼出营养物质、水分、能源等，剩余的残渣排除体外。这个过程，中医称为“化物”，类似炼油厂从石油中提炼出各种有用的物质，剩余的沥青还可以用来铺设公路。内经说“腑化物而不藏”。

李东垣说：“元气之充足，皆由脾胃之气无所伤，而后能滋养元气。若胃气之本弱，饮食自倍，则脾胃之气即伤，而元气亦不能充。”（《脾胃论》）

而脏则对腑提取出的精华物质进行存储、处理和分配，使其能正确的输送到全身。脏存储精华物质的功能，中医称为“藏精”，内经说“脏藏精气而不泄”。



五脏的主要功能是藏精气，而六腑则主要是传化水谷，排出糟粕。五脏的功能特点是“藏而不泻”，故“满而不实”；六腑的功能特点是“传化物而不藏”，故“实而不满”。此处“满”是指精气而言，“实”是指水谷而论。

脏腑对比而言，腑的气态物质多，而脏的固液态物质多，所以两者之间，腑为天，脏为地。

2.2.2、形体

形体也包括固、液态物质和气态物质。固态物质包括皮、肉、筋、骨、脉的组织。液态物质包括血、津液、髓等。气态物质则包括自然空气、血和水的蒸汽等等，这些气态物质用宗气、营气、卫气、脏腑之气等名词描述，详细见后面章节。

固态物质正常需要其所在的环境正常。而其环境是由气、液等流动之物带来的能量与物资所维持。气、液之间，液态物质由气态物质统帅，即血、水等液态物质的运行由气态物质推动和维护，称为“气为血之帅”。所以形体健康以气的正常运行为前提。慢性疾病往往是以能量和气的失常为先导，逐渐波及液态的津液和血，再延伸至固态的形体组织。

“故治病以理气为先，而用药以通络为主。盖人之经络不通，则转输不捷，药不能尽其功。

《医论三十篇》

初病胀痛无形，久则形坚似梗，是初为气结在经，久则血伤入络。

《临证指南医案-叶天士治积聚案》

另外，因液态物质与气态物质可以互相转化，所以血也是气的一个来源，称为“血为气之母”。人在意外大量失血的时候，气也跟随减少，需要补血兼补气。

2.2.3、通道

脏腑与形体之间的资源交互要有通道。元气、血、津液、气态物质各有其通道。

津液以三焦为通道，所以三焦称为水道。血以血管为通道，所以血管也可以叫血脉。气态物质以经络为通道，所以经络也可以叫气脉。

元气以三焦为通道，所以三焦也是元气通道。另外，元气是能量，作用于血、津液、气态物质，所以也可以说各种通道都携带了元气。

各种通道中，以经络通道为最重要，这是因为经络中运行的气态物质有统帅作用，可以带动血、津液的通畅。所以广义的经络系统包含了前面的三焦、血脉等通道。

通道的堵塞或其它异常，可使人体的资源分配，即“升降出入”出现问题。

2.2.4、小结

从部位角度看，内在脏腑与外在形体是人体比较大的一对阴阳关系。脏腑为阴，形体为阳。

脏腑为阴，负责将外界的饮食、空气转化为精气血并存储，像地，以五行划分，即木、火、土、金、水；其中脏为阴中之阴，腑为阴中之阳。因脏腑像地，以固液态物质为根本，所以阴中之阴的脏为主。

形体为阳，接受脏腑传输来的各种资源，进行使用消耗，完成感受、思维、运动以及保卫脏腑等功能，像天，以六气划分，即厥阴风木、少阴君火、少阳相火、太阴湿土、阳明燥金、太阳寒水。其中气态物质为阳中之阳，津血皮肉筋骨为阳中之阴。因形体像天，以气态物质为主导，所以以阳中之阳的气态物质为主导，即经络通畅为关键。

阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也。

《素问-生气通天论》

光明教材的《中医药学概论》第二章为藏象，第三章为经络，就体现了这两者的重要性。脏腑为形体的根本，两者之间就像树根与枝干的关系。如果脏腑健康，形体有问题，病情相对轻。如果脏腑有问题，即便形体看似健康，病情也相对重。

若五脏元真通畅，人即安和，客气邪风，中人多死，千般灾难，不越三条：一者，经络受邪，入脏腑，为内所因也；二者，四肢九窍，血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中也；三者，房室、金刃、虫兽所伤。以此详之，病由都尽。

《金匱要略-臟腑經絡先後病脈証第一》

2.3、小结

中医治病的核心概念即“辨证论治”与“整体观”，两者分别对应本节的两项内容。

“基本原理”中谈到维持人体平衡的几个重要方面。若这些方面有问题，即为“证”。分析具体失衡情况，并给出对应调节方法，即为“辨证论治”。

“资源运转”中谈到的内在脏腑产生要素供给外在形体，因此在调理身体、治疗疾病的时候，需要考虑这种因果关系。不只着眼于一处的病证，还能够整体考虑要素的产生与传递关系，寻找真正的根源问题，即为“整体观”。

3、小结

本章先介绍了一些基本概念，然后对人体运转的机制做了概括介绍。

人体作为一个小自然，与大自然对比理解的话。

大自然的日地平衡，即能量与物质的平衡关系。此平衡在人体为人体元气能量与人体物质的平衡，对于维持人体小自然环境温度至关重要。

大自然的天地平衡，即气态物质与固液态物质的平衡。此平衡在人为人体气态物质与固液态物质的平衡，即气与血、津液和组织的关系，对于人体各种生理功能至关重要。

还有大自然的气、液流动平衡。此平衡在人体为气血的上下升降和内外出入，对于人体要素的整体均衡至关重要。

此外，人体还需考虑内在脏腑产生资源总量与外在形体消耗资源总量的平衡。

以上几种主要平衡关系，中医皆用阴阳概念来表达，如不能清晰理解其内在机理，则容易产生各种误解。

下面要对几种要素的产生、流转与分配做更详细的叙述。

3.2、元气

1、人体的元气

1.1、什么是元气

元气，元为起始，气为能量。元气就是人体的起始能量，其对人体的作用，相当于阳光对自然界的作用。

真气，即元气。是人体生命活动的原动力，是维持生命活动的基本物质。

《黄帝内经讲解-藏象学说-真气的生成和输布》

人体的元气有很多别称，比如原气、真气、真阳、真火等。

元气，又称“原气”、“真气”。是人体诸气中最基本，最重要的气，是人体生命活动的原动力。... 元气具有激发和推动脏腑组织功能活动的作用。因而，元气充沛，则脏腑功能旺盛，身体就强健而少病；若元气不足，则脏腑功能低下，身体虚弱而多病。

《中医学概论-藏象-气》

名词“阳气”，大多时候是指“元气”。在人体津血不亏的情况下，元气足则气态物质足，所以有时为了简便可以用“阳气”一词同时代表元气和偏阳性的气态物质。反之，名词“阴气”主要指固液态物质，有时也可以包括偏阴性的气态物质。这里的阴阳平衡是以温度为平衡点，让温度上升为阳，下降为阴。

阳气者若天与日，失其所则折寿而不彰，故天运当以日光明。是故阳因而上，卫外者也。

《素问-生气通天论》

经络协调阴阳，如经络中的阳气（包括卫气、原气）不足，就会出现局部发凉或全身畏寒的症状，即所谓阳虚则寒。

元气提供能量供人体维持正常的体温，以及让各个脏腑组织能够进行正常的生命活动。人体失去元气，就进入死亡状态。

故诊病决死生者，不视病之轻重，而视元气之存亡，则百不失一矣。”...人之死，大约因元气存亡而决。

《黄帝内经讲解-藏象学说-真气的生成和输布》

由于生命活动的存在，不能一时一刻离开阳气，故后世医家把肾中阳气视为“立命之本”，称之为真阳，真火。可见阳气代表着人体具有阳性特征的精微物质，及其产生的热能和动力。它的物质基础是精，它的属性是火，来源于先天，但要靠后天的补充和营养。...

阳气为生命之本，是人体生理机能和代谢活动的动力。因此，无论局部或整体的阳气不足，都会相应地出现生理机能、代谢活动障碍或衰退的病变，如张景岳在《真阴论》指出：“如火亏于下，则阳衰于上，或为神气之昏沉，或为动履之困倦。

《黄帝内经讲解-阴阳五行学说-阳气的重要性》

元气与人体的固液气态物质形成一对平衡关系，元气既不能过多也不能过少，应在一个合理范围内波动。

1.2、元气是如何生成的

元气由精转化而成。精为能源，元气为能量。精遍布全身，主要的精藏于五脏，尤其以肾为仓库。所以元气的产生也对应于精的分布，全身都可以产生，五脏产生的最重要，五脏中又尤其以肾为最多。

原气根源于肾中，禀受于父母的先天之精，由肾中的精气所化生。

《黄帝内经讲解-藏象学说-真气的生成和输布》

元气寓居肾脏，由肾总司。元气与水液在三焦中的输布运化，必须依靠脏气的推动。

《黄帝内经讲解-藏象-三焦的部位和功用》

元气来源于肾，为先天之精所化，又赖后天水谷精气的滋养和补充。故《灵枢·刺节真邪》说：“真气者，所受于天，与谷气并而充身者也”。

《中医学概论-藏象-气》

所谓真气，是由先天之精气，与后天水谷之精气合并化生而成的...

指五脏所藏的真气。虽然真气根源于肾中的先天之精，但又依赖胃中后天水谷精气的滋养。真气具有推动与温煦的功能，能温煦和激发各个脏腑的生理活动。

《黄帝内经讲解-藏象-真气的生成和输布》

1.3、肾中元气如何传输到脏腑、全身

肾做为最主要的元气提供者，其元气是通过三焦传输到其它脏腑和全身的。

三焦的功能有二。一为人体元气通行之通道。《难经·三十八难》指出，三焦“主持诸气”，《六十六难》亦说：“三焦者，原气之别使也，主通利三气，经历于五脏六腑。”原气，又名元气，通过三焦输布五脏六腑，激发，推动各脏腑组织的功能，因此三焦有总司人体气化的作用。

《黄帝内经讲解-藏象-三焦的部位和功用》

《难经》指出，三焦是元气的别使。元气进入三焦，在上焦传输给心肺，中焦传输给脾胃，下焦传输给肾、大小肠、膀胱。如此，各脏腑才能有足够的能量来完成各自工作。

心肺受上焦所宣布的元气，才能宣发输布水谷精微，

脾胃受中焦元气，才能腐熟运化水谷，蒸化气血津液。

肾、大小肠、膀胱赖下焦元气的气化作用，才能灌渗水液，泌别清浊，外泄二便。

《黄帝内经讲解-藏象-三焦的部位和功用》

藏真散于肝，肝藏筋膜之气也……藏真通于心，心藏血脉之气也……藏真濡于脾，脾藏肌肉之气也……藏真高于肺，以行营卫阴阳也……藏真下于肾，肾藏骨髓之气也。

《素问-平人氣象论》

元气作用于脏腑、经络，产生脏腑之气和经络之气。脏腑经络的气态物质在获得元气的能量后，在全身流转，能带动能量到达全身。所以说元气与谷气并而充身。

真气者，所受于天，与谷气并而充身也。

《灵枢-刺节真邪》

人体之气，除以上四种外，还有“脏腑之气”、“经络之气”等。这些气均为元气所派生，元气分布于某一脏腑或某一经络，即成为某一脏腑或某一经络之气。它是构成各脏腑、经络的基本物质，又是推动和维持各脏腑经络进行生理活动的物质基础。

《中医学概论-藏象-气》

诸十二经脉者，皆系于生气之原。所谓生气之原者，谓十二经之根本也，谓肾间动气也。此五脏六腑之本，十二经脉之根，呼吸之门，三焦之原。一名守邪之神。故气者，人之根本也，根绝则茎叶枯矣。寸口脉平而死者，生气独绝于内也。

《难经-八难》

元气通过三焦分布全身，内而脏腑，外而肤腠，无处不达。

《中医学概论-藏象-气》

2、元气在人体的分布

在自然界中，阳光作用于天气、地气。天气、地气各自以能量与物质的多少可以再划分阴阳。天气以三阴三阳六气划分，地气以五行划分。

鬼臾区曰：寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之，木火土金水，地之阴阳也，生长化收藏下应之...

天有阴阳，地亦有阴阳。木火土金水火，地之阴阳也，生长化收藏，故阳中有阴，阴中有阳。

《素问-天元纪大论》

对于人体来讲，人体最大的天地阴阳关系，是内在脏腑与外在形体之间的关系，内在脏腑为地，外在形体为天。因此内在脏腑的元气分布以五行划分，外在形体的元气分布以经络三阴三阳划分。

下面分别介绍：

2.1 脏腑五行的划分

脏腑作为人体最重要的器官，按照五行划分如下：

肝、胆为木，肝为阴木，胆为阳木

心、小肠为火，心为阴火，小肠为阳火

脾、胃为土，脾为阴土，胃为阳土

肺、大肠为金，肺为阴金，大肠为阳金

肾、膀胱为水，肾为阴水，膀胱为阳水

这里的每一对脏腑都有阴阳关系，又叫表里关系，比如肝为阴木，胆为阳木。这种关系是指虽然两者的能量在上一层阴阳中都处于木气这个位置，但在木气再分阴阳的情况下，两者一为阴，一为阳。两者通过经络，在能量和物质上有所互通，并形成了一种平衡。这种平衡类

似天地的关系，阴中有阳、阳中有阴。以肝胆为例，即肝的正常平衡状态需要含有一部分胆的因素，胆的平衡状态需要含有肝的一部分因素。因此肝的疾病除了考虑自身的失衡外，也要考虑是否由胆引起的。同样，胆的问题也要考虑肝。

五行之间需要维持平衡，即五脏各脏的能力应保持相对均衡，这种均衡是通过五行生克、胜复来保持的。具体见《概论》的五行章节。

五行的平衡非常重要，不重视这种平衡关系，很容易犯前面所说的虚虚实实之戒。如《难经》所说，若肝肾之气已绝，反而补心肺，则造成更大的不平衡，会让虚的更虚，实的更实。若病人因此而亡，是医生的责任。

五脏脉已绝于内者，肾肝气已绝于内也，而医反补其心肺；五脏脉已绝于外者，心肺气已绝于外也，而医反补其肾肝。阳绝补阴，阴绝补阳，是谓实实虚虚，损不足而益有余。如此死者，医杀之耳。

《难经-十二难》

夫五运之政，犹权衡也，高者抑之，下者举之，化之应之，变者复之，此生长化成收藏之理，气之常也，失常则天地四塞矣。故曰，天地之动静，神明为之纪，阴阳之往复，寒暑彰其兆。此之谓也。

《素问-气交变大论》

意谓五运之气保持相对平衡，自然界的生物才会有正常的生长发育，所以这是万物生长化收藏过程的自然道理，也是四时正常气候变生规律的体现。否则，平衡失常，天地四时之气就会发生闭塞。

“天地”，指代表天气和地气的五运六气。六气属阳，周于天外，代表天气，五运属阴，守于地内，代表地气。

《黄帝内经讲解-藏象学说-五行气运具有维持自然平衡的作用》

注意五行中的火与阳气的区别。五行的火是指地气偏热的部分。其在大自然中，空间上指南方，时间上指一年中偏热的一段时间，在人体小自然中，指脏腑中的心与小肠；而阳气在大自然为太阳光，为整个自然环境提供热量，在人体小自然为元气，给整个人体提供热量。所以五行的火与阳气是截然不同的两个概念，不要望文生义，混淆两者的关系。人整体热量不足时，应增加元气的释放量，而非从五行的火寻找办法。

五行对应

前面“阴阳平衡”章节提到取类比象的问题，就是对阴阳平衡起到同样作用、或具有强对应关系的事物可以归为一类，叫做具有相同的象。对于按照五行划分的地气平衡来说，很多事物都有五行之象。列表如下：

五行与人体器官、功能的对应关系

五行	五脏	五腑	经脉	五官	五体	五华	五液	五声
木	肝	胆	肝胆经	目	筋	爪	泪	呼
火	心	小肠	心小肠经	舌	血脉	面色	汗	笑
土	脾	胃	脾胃经	口	肌/肉	唇	涎	歌
金	肺	大肠	肺大肠经	鼻	皮	毛	涕	哭
水	肾	膀胱	肾膀胱经	耳	骨	发	唾	呻

可对人体五行产生影响的一些因素

五行	五味	五色	五音	五气	五季	五方
木	酸	青	角	风	春	东
火	苦	赤	徵	暑	夏	南
土	甘	黄	宫	湿	长夏	中
金	辛	白	商	燥	秋	西
水	咸	黑	羽	寒	冬	北

其它五行相关内容

五行	五化
木	生
火	长
土	化
金	收
水	藏

2.2 形体三阴三阳的划分

形体按照元气分布的多少划分三阴三阳六大区域。

一阴为厥阴，二阴为少阴，三阴为太阴，一阳为少阳、二阳为阳明、三阳为太阳。

阴阳之气各有多少，故曰三阴三阳也。

《素问-天元纪大论》

每一个区域以经络通道为主，各包含手、足两条经络。六个区域共十二条经络，称为十二正经。又因经络内联脏腑，外联肌表，所以每个区域也包括对应的脏腑和相应经络管理的皮肉筋骨等组织。

夫十二经脉者，内属于脏腑，外络于肢节。

《灵枢-海论》

下面分别说明：

太阳区域

以太阳为例：太阳区域包括手太阳小肠经、小肠腑、足太阳膀胱经、膀胱腑。太阳区域能量的合适与否（不能过多或过少）影响两个经络通道及其附近部位的健康程度，也影响小肠腑和膀胱腑的功能正常与否。

其它五个区域也是类似的道理。

太阳是指手、足太阳经、腑及其生理功能而言。太阳病则主要包括外邪侵袭肌表，太阳之气受伤，营卫失和，以及太阳经、腑受邪而发生的病证。太阳病和足太阳经、腑关系犹切。

足太阳膀胱经脉，起于目内眦，上额，交巅，络脑，下项，挟脊抵腰，络肾属膀胱，有一支脉从背、腰，经骶，沿大腿外侧后下方行，终于足小趾外侧，下接足少阴肾。其脉上连风府与督脉交会，下络腰肾与少阴相通，籍助督肾阳气支持而主一身之表。

《伤寒论讲解-辨太阳病脉证并治上第五-概说》

伤寒一日，巨阳受之，故头项痛腰脊强。

《素问-热论》

人身经络，三阳为表，三阴为里。太阳为六经之长，统摄阳分，主一身之表，故为人身之藩篱。邪气入侵机体，必首先犯于皮毛，太阳首当其冲。太阳之脉上入巅，下项行腰脊。风寒外束，

太阳经脉运行受阻，营卫不和，经气不利，故见头项痛，腰脊牵强不舒等症。

《黄帝内经讲解-第七章病证学说-二、伤寒类-证候》

阳明区域

阳明包括足阳明胃经、胃腑和手阳明大肠经、大肠腑。

阳明是阳气昌盛的意思。.....

阳明包括足阳明胃和手阳明大肠，代表着特定的脏腑经络。

《伤寒论讲解-辨阳明病脉证并治第八》

二曰阳明受之，阳明主肉，其脉挟鼻络于目，故身热目疼而鼻干，不得卧也。

《素问-热论》

阳明为二阳，故邪在太阳不解，传入阳明。阳明主肌肉，为多气多血之经，故邪入阳明，正邪相争剧烈，身热尤甚。张仲景据此认为，病邪侵袭阳明，多从燥化，故谓“胃家实”，以胃肠燥热实为其特点。身热是阳明病证的主要症状，《内经》在六经病症中唯独提到阳明病有身热一症，从而突出了阳明病的这一特点。如张景岳说：“伤寒多发热，而独此云身热者，盖阳明主肌肉，身热尤甚也。”阳明之脉挟鼻而络于目，邪在阳明，上干目鼻，则鼻干而目疼。“胃不和则卧不安”，邪热在胃，上扰神明，故不得卧。

《黄帝内经讲解-第七章病证学说-二、伤寒类-证候》

少阳区域

少阳包括手少阳三焦经、三焦腑与足少阳胆经、胆腑。

少阳包括手少阳三焦与足少阳胆之经腑..... 由于少阳之阳气为人体初生之阳，其气较为弱小，故少阳亦称嫩阳、幼阳、稚阳，其

抗邪之力也远较太阳与阳明为弱，若少阳抗邪不力，则邪气就有可能内陷太阴。

《伤寒论讲解-辨少阳病脉证并治第九》

三日少阳受之，少阳主胆，其脉循胁络于耳，故胸胁痛而耳聋。

《素问-热论》

少阳胆经起于目锐眦，绕耳前后，至肩下循胁里络肝属胆。

《黄帝内经讲解-第七章病证学说-二、伤寒类-证候》

太阴区域

太阴包括手太阴肺经、肺脏与足太阴脾经、脾脏。

太阴包括手太阴肺与足太阴脾，太阴病则以足太阴脾病为主。

《伤寒论讲解-辨太阴病脉证并治第十》

四日太阴受之，太阴脉布胃中络于嗌，故腹满而嗌干。

《素问-热论》

.....足太阴脾经起于足大趾之端，上膝股入腹，属脾络胃，上挟咽连舌本，散舌下。

《黄帝内经讲解-第七章病证学说-二、伤寒类-证候》

少阴区域

少阴包括手少阴心经、心脏及足少阴肾经、肾脏。

少阴包括手少阴心及其经脉和足少阴肾及其经脉。少阴病也就是心肾的病患。手少阴心和足少阴肾分别与手太阳小肠、足太阳膀胱相表里。

《伤寒论讲解-辨少阴病脉证并治第十一》

五日少阴受之。少阴脉贯肾络于肺，系舌本，故口燥舌干而渴。

《素问-热论》

足少阴肾脉，起于足小趾之下，斜趋足心，循内踝上股，贯脊属肾，上贯肝膈，入肺中，循喉咙，挟舌本。

《黄帝内经讲解-第七章病证学说-二、伤寒类-证候》

厥阴区域

厥阴包括足厥阴肝经、肝脏和手厥阴心包经、心包脏。

厥阴，包括足厥阴肝和手厥阴心包，它们分别与足少阳胆和手少阳三焦为表里。肝藏血，主疏泄，性喜条达。心包为臣使之官，代心而行令。

《伤寒论讲解-辨厥阴病脉证并治第十二》

六曰厥阴受之，厥阴脉循阴器而络于肝，故烦满而囊缩。

《素问-热论》

厥阴肝脉循阴股，过阴器，抵少腹，上贯膈布胁肋。

《黄帝内经讲解-第七章病证学说-二、伤寒类-证候》

中医在治疗疾病的时候，会将三阴病转变为三阳病，然后再将病邪从三阳排出体外。这里三阴指的就是五脏加心包以及各自的经络区域，三阳指的就是六腑以及各自经络区域。

十二正经，各有其巡行部位和交接规律。此外，还有比较特殊的八个经，称为“奇经八脉”。其主要功能是作为十二正经的调节仓库。十二正经的经气充足，多余的经气存储于奇经八脉备用。十二正经的经气不足，则奇经八脉的经气溢出到十二正经进行补充。

曰：其奇经八脉者，既不拘于十二经，皆何起何继也？...

比于圣人图设沟渠，沟渠满溢，流于深湖，故圣人不能拘通也。而人脉隆盛，入于八脉，而不还周，故十二经亦有不能拘之。其受邪气，畜则肿热，砭射之也。

《难经-二十八难》

按：经络除了主干道外，还包括十五络脉、十二经别、十二经筋、十二皮部等等，是完全覆盖全身上下、内外的。这些内容，教材《中医药学概论》和《针灸学》的经络章节已经叙述比较详尽，不再重复介绍。本书后面的内容会假设大家对经络巡行部位已有一定基础。如果没学过，需要查阅一下相关内容。

2.3 小结

以上两种划分方式，在中医中皆有广泛应用。有的中医喜欢从脏腑阴阳五行角度分析疾病，称为脏腑阴阳五行辨证；也有的中医喜欢从三阴三阳六经角度分析疾病，称为三阴三阳六经辨证。

两种辨证方法本质上是一致的。三阴三阳中的三阳就是六腑及其经络，三阴就是五脏加心包及其经络。

三阳病证以六腑病变为基础，三阴病证以五脏病变为基础。所以说，六经辨证实际上是以六经统括其所络属的脏腑，因而它基本上概括了脏腑十二经病证，并以此来标示它们之间的传变规律。

《中医药学概论-六经辨证》

相比较而言，脏腑五行为内在地气，其划分侧重于脏腑产生气血的功能，比较适宜脏腑失衡的时间较长，已经产生了脏腑五行乘侮影响的情况。三阴三阳六气为外在天气，其划分侧重于经络传输气血的功能，比较适宜人体感受外邪，病邪在肌表、经络或者进入脏腑时间较短的情况。两者虽有侧重，但要认识到，因脏腑与经络相连，所以脏腑五行也可以兼顾到经络；因经络与脏腑相连，所以经络三阴三阳也可以兼顾到脏腑。学习者最好两种辨证方法都能掌握。

一般来说，外感热病依据由浅入深，由表入里，由实变虚的规律，即按六经、卫气营血的次序进行预测。内伤杂病依据脏腑的生克乘侮规律进行预测。

《中医临证程序与临床辨证思维方法-七、不时时留心病势》

任何一个脏腑、经络都同时具有五行与三阴三阳的双重属性。比如膀胱腑，从五行角度看，其与肾脏同为五行中的水，膀胱为阳水，肾脏为阴水；从三阴三阳角度看，其为足太阳膀胱经所连的腑器，为足太阳膀胱腑。再比如手少阴心经，从三阴三阳角度看，其为少阴经络；从五行角度看，其为五行阴火心脏所连之经络。

3、元气波动与差异

自然界阳气在不同的时间有强弱的波动，在不同的地域有强弱的差异。人体的元气也是如此。

从空间角度看，人体不同区域的元气强弱差异，形成了前述脏腑五行与形体三阴三阳的划分。

从时间角度看，人体元气的量在正常范围内波动。一年周期内，春夏的时候元气增加，秋冬的时候元气量减少；日周期内，白天元气增加，夜晚减少；运动时元气增加，休息时减少。

4、元气的失衡

肾中元气补充脏腑及形体的元气，其释放的量应在平衡范围之内，不多不少；其分配应该上、下、里、外均衡。

如果释放过少，则脏腑、形体的元气皆不够，会出现整体阳虚的情况，表现为畏寒怕冷、肢体不温等情况，用补阳类方剂增加阳气的释放。

如果释放过多则脏腑、形体的元气过量，会出现整体实热的情况，用清热泄火类方剂恢复平衡。

如果元气未能正确分配，则一部分区域为热证，一部分区域为寒证，即为寒热错杂。从里外角度看，常见里热外寒或者里寒外热。从上下角度看，因热性上升，寒性下降，所以常见上热下寒，少见上寒下热。

阴阳相搏...形冷恶寒者，此三焦伤也。...厥厥动摇者，名曰动也。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元1》

造成寒热错杂的原因很多，比如寒邪闭表、气郁、肾虚元气不藏、中焦淤堵、寒邪格阳、相火妄动等等，中医中的乌梅丸、黄连汤、干姜黄连黄芩人参汤、麻黄升麻汤、大青龙汤、引火汤、四逆汤、白通汤、白通加猪胆汁汤、通脉四逆汤、通脉四逆加猪胆汤、四逆散、知柏地黄丸、大补阴丸、封髓丹等等方剂各有治疗侧重点，以后学习遇到对应方剂的时候应系统整理。

当然，如果津液未能正常分配，也可以形成阴虚的热证或者阴实的寒证等等，此情况不属于元气的问题，此处不细谈。

5、探讨

5.1、元气是否是气态物质？

元气是人体的初始动力，是能量来源。自然界的初始动力来自光照，烧水过程的初始动力来自木材燃烧的火焰。所以不同事物的初始动力的形式有所不同，共同特点是都能提供能量。人体的能量按照现代科学的研究是来自有机物的化学能。中医中的元气是人体的起始能量，其形式是到底气态、电、热辐射或者其它某种未知的能量形式还不确定。很多中医认为元气就是一种气态物质，除了行于三焦外，也行于经络，但是此处为了体现其初始能量的独特特性，将其单独介绍。

阳气代表着人体具有阳性特征的精微物质，及其产生的热能和动力。它的物质基础是精，它的属性是火，来源于先天，但要靠后天的补充和营养。

5.2、脾的位置？脾切除人依然能活？

现在解剖学的脾是西医传入之后，将解剖学发现的一个器官与传统中医中脾的名称对应的。从功能看，脾的功能是从胃中吸收营养，并将营养传递给其他器官。解剖学发现的脾不能完全和传统中医的脾对应。

有学者研究传统中医的脾可能包含现在解剖发现的脾脏和胰脏。

5.3、三焦的位置？

三焦的位置目前还有争议，比较倾向于三焦作为胸腹腔的合称。

自《内经》以来，历代对三焦的形态、部位及功能多有争议。对三焦的解剖形态的认识，历史上有“有名无形”和“有名有形”之争。但从《内经》的论述来看，三焦属六腑之一，是分布于胸腹腔的一个大腑。...手厥阴心包经起于胸中，出属心包络，向下横穿膈肌，也依次联络上、中、下三焦，可见三焦是一分布于横膈上下的有形大腑，而且经手少阳与手厥阴之脉与心包相连属，正如张景岳所说：“三焦者，确有一腑，盖脏腑之外，躯壳之内，包罗诸脏，一腔之大腑也。”

《黄帝内经讲解-藏象学说-三焦的部位和功能》

3.3、 人体地气

人体地气指的是人体中的固、液态物质。其中固态物质包括内在脏腑组织以及外在形体的皮、肉、脉、筋、骨等形体组织。其中形体的皮、肉、脉、筋、骨五种组织简称为“五体”；液态物质则包括津液与血。

人体的固态组织是身体行使功能的基础，非常重要。内经说“骨为干，脉为营，筋为刚，肉为墙，皮肤坚而毛发长”，又说“器者生化之宇，器散则分之，生化息矣”，意思是形体组织是人体气血流转的容器，一旦消散，则生命活动自然终止。

黄帝曰：人始生，先成精，精成而脑髓生，骨为干，脉为营，筋为刚，肉为墙，皮肤坚而毛发长，谷入于胃，脉道以通，气血乃行。

《灵枢-经脉》

但在中医内科中，介绍固态组织的篇幅并不多。这是因为固态组织需要靠液态物质、气态物质以及能量构成的适宜环境来形成。就像自然界植物的树干、枝叶是在适宜的气候环境下形成的。遇到枝叶异常枯萎的问题，园丁不会去直接修复枝叶，而是会从水、阳光等角度查找问题，修复环境。

因此，虽然我们知道固态组织的重要性，但是解决固态组织的问题却要从气、液、能量着手，所以在人体地气方面，我们重点介绍人体的津液和血。

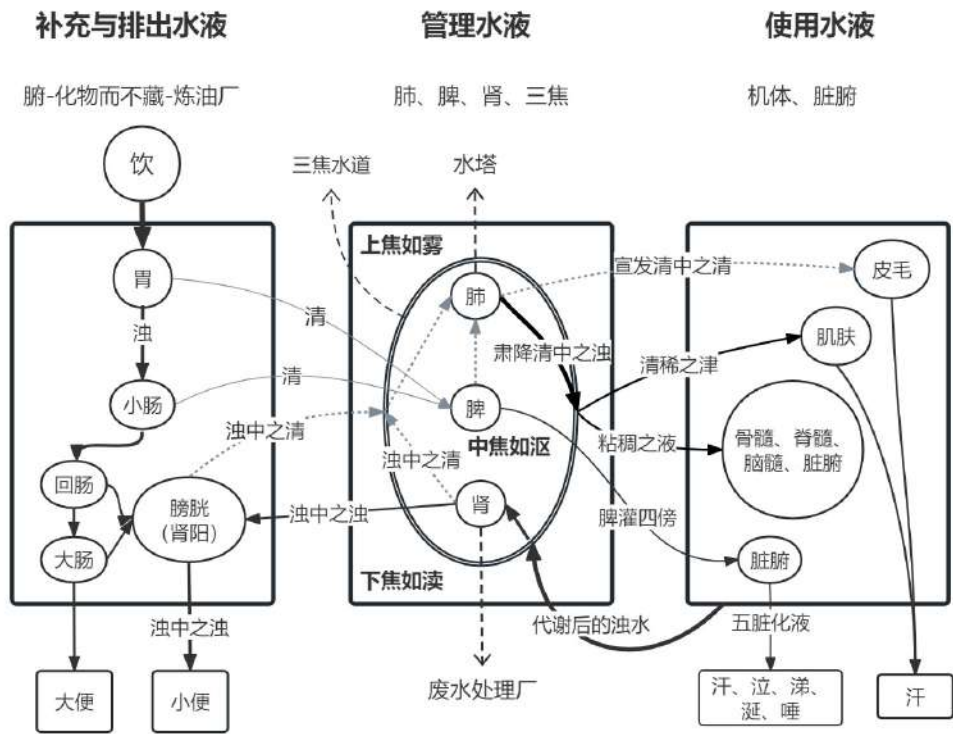
1、津液

1.1、津液的代谢过程

关于津液在人体的代谢过程，中医主要依据《内经》、《难经》等经典中的相关论述。光明教材已经整理出了津液流转的大致过程，如下图所示：

1.1.1、津液代谢图

灰色的线为清。黑色的线为浊。虚线代表气态的水。



1. 1. 2、水的补充过程：

饮水入胃后，通过脾气的传输，分别归藏五脏，变化而为五脏各自的水液。

五液来源于水谷，通过脾气的传输，分别归藏五脏，变化而为五脏各自所主的水液，濡润相关的空窍，是谓五脏化液。

《黄帝内经讲解-藏象学说-五脏与五液的关系》

岐伯曰：脾脉者土也，孤脏，以灌四傍者也。

《素问-玉机真藏论》

未被胃吸收的水液进入小肠，小肠中偏清的部分也通过脾传输各处。偏浊的部分进入回肠、大肠，此时有一部分水进入膀胱，剩余的随大便排出体外。

1.1.3、水的循环过程：

脾将一部分水液以气雾的状态上升到肺。肺为水之上源，类似一栋大楼的水塔，负责水的分配。此处的水偏清的部分通过肺的宣发作用，到达皮毛。这种宣发作用似乎是以气态的形式进行。偏浊的部分通过三焦散布到全身，此过程称为肃降。

何谓气？岐伯曰：上焦开发，宣五谷味，熏肤，充身，泽毛，若雾露之溉，是谓气。

《灵枢-决气》

三焦为水液通道，类似大楼里的水管和水蒸气的通道。

形体中的津液代谢后形成浊水，浊水归于肾。肾类似废水处理厂，对浊水进行过滤。过滤后的浊水进入膀胱；过滤后的清水通过三焦水道又回到肺，通过肺进行再次分配。

膀胱中的水在阳气作用下还进行一次清浊分离，清者上升到肺，浊者成为小便排出。

膀胱贮留的水液，在肾阳的气化作用下，其清者上升于肺，复经肺之宣发，参与全身的水液代谢。其浊者，又在肾阳的气化作用下，变化为尿，排出体外。故膀胱所藏水液复归于肺与排出体外，都是肾阳气化作用的具体表现，所以说“气化则能出焉”。

《黄帝内经讲解-藏象学说-十二脏的生理功能及其相互关系》

资料

饮入于胃，经过胃“游溢精气”，上输于脾；

脾主运化，为胃行其津液，上输于肺；

肺为水之上源，通调水道，津液通过肺的宣发与肃降，敷布体表，输精于皮毛，同时下输于膀胱，

再经肾的蒸腾化气，使清升浊降，清者布散全身，浊者化为尿液，排出体外，

从而，完成水液在体内的代谢。

《中医学概论-藏象-津液》

《素问·灵兰秘典论》说：“三焦者，决渎之官，水道出焉”。决，疏通之意；渎，沟渠。决渎，即疏通沟渠。这就是说，三焦有疏通沟渠、运行水液的作用，是水液运行的道路。若三焦功能正常，则水道通利，水液的运行正常，若三焦不利，则水道不通，水邪泛滥，则可出现肿胀等证。

《中医学概论-藏象-三焦》

水有清浊，清者上升，浊者下降。清中有浊，浊中有清。

上升于肺之水，为清。

清中之清者，由肺输至皮毛；

清中之浊者，从三焦决渎下行以达于肾。

归肾之水液为浊。

浊中之浊者，由膀胱排出体外；

浊中之清者，再经三焦上升至肺、复由肺化水下降至肾，如此循环，以维持人体水液代谢的平衡。

水液的升清降浊，需赖肾阳的气化作用才能进行，膀胱排泄无用水液的作用也需赖肾阳的气化作用。如果肾阳气化失司，水液升降失常，膀胱开合不利，必然导致水液代谢调节障碍。如肾中阳气不足，气化功能失常，可引起小便不利，水液流于四肢、皮肤肌肉为肿，溢于心肺为心悸喘急，甚则引起小便闭结，点滴不通，临床都以温肾扶阳为其施治大法。

《黄帝内经讲解-藏象学说-肾为水脏、主津液代谢》

中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此，故独得行于经隧，命曰营气。

中焦受纳水谷，并对水谷进行消化，泌别糟粕，蒸化津液，化生精微，向上转输于肺脉。水谷所化生的精微与津液相和合，乃化生为血液。

下焦者，别回肠，注于膀胱而渗入焉。故水谷者，常并居者胃中，成糟粕，而俱下于大肠，而成下焦，渗而俱下，济泌别汁，循下焦而渗入膀胱焉。

回肠，包括小肠的下端和大肠的上端，在脐部向左回曲环绕，象树叶一样重迭而下，回行环绕，有十六个弯曲。从部位言，下焦指胃下口以下，包括大小肠、肝、肾、膀胱等。从功能言，水谷受盛于中焦胃，然后转输下焦小肠，进一步消化吸收，糟粕别行于回肠，然后排出体外，水液也在回肠别渗于膀胱。

其次，水液代谢的平衡，虽然必须赖肺、脾、肾、胃、大小肠、膀胱等许多脏腑共同发挥输布，调节水液的功能才能完成，但必须以三焦为通道，才能进行。

《黄帝内经讲解-藏象学说-三焦的部位和功用》

饮食五味都从口入，通过胃、脾、大小肠的作用，其所化生的水谷精微，分别注入五脏四海，以营养全身。而其中的津液以不同的形式，沿不同的道路布散全身。如本篇起首说：“水谷入于口，输于肠胃，其液别为五。”意谓水谷入于口而转输到肠胃，所化生的津液分为五种，上走泪道者为“泣”，走廉泉者为“唾”，走腠理者为“汗”，下走膀胱者为“尿”，内走骨空者为“髓”。

三焦是输出布散水谷精气的通道，所以也是水液运行的通道。在三焦的气化作用下，津液输布充养全身脏腑组织，亦可从腠理排出体外而为汗，从膀胱排出体外而为尿，故三焦有水道之称，

《黄帝内经讲解-藏象学说-津液的生成和功用》

饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。水精四布，五经并行。合于四时五藏阴阳，揆度

以为常也。

肺朝百脉，水精布散，参与代谢，最终回流到肺的为清中之浊。然后依靠肺气的肃降作用，向下输送到膀胱。再经肾中阳气的蒸发，清浊分离，浊中之清者复归于肺，然后输注全身。浊中之浊者变为尿液，排出体外。所以水液的输布虽然是一个几乎所有脏腑都参与的复杂过程，但与肺、脾、肾三脏的关系尤为密切。

《黄帝内经讲解-藏象学说-食物精微的输布》

1.2、津液的分类

1.2.1、泣（泪）

泣为肝液，津液上走泪道者为“泣”。目得肝血的濡养，而能视物，肝血中的津液满溢，则双目润泽。如情志失常，肝气上逆，迫液外泄而为泪，所以泪为肝液。

1.2.2、涕

“涕”为肺液。鼻为呼吸出入之门户，所以鼻为肺之窍。肺的津液上出于鼻为涕，以润鼻窍。

1.2.3、涎

“涎”为脾液，是口液中较清稀的部分。脾开窍于口，脾为胃行其津液，胃中津液，赖脾气的升清作用，才能上出于口，润泽口腔，所以涎为脾液。

1.2.4、唾

“唾”为肾液，是口液中较稠厚的部分。肾藏精，主水液。肾脉循喉咙，挟舌本。舌下廉泉、玉英两穴，为液出之通道。所以肾液可循肾脉上注于舌下，出廉泉、玉英而为唾，润泽口舌。

1.2.5、汗

“汗”为心液。津液从中焦进入肺脉，与营气化合，通过心脏的化赤作用，变化为血。汗未出时为津液，储于血中，既出于皮肤则为汗。心主血脉，汗为血之余，所以可以认为汗为心液所化

1.2.6、尿

水谷所化津液下走膀胱者为“尿”。

1.2.7、髓

髓由精所生，液为补充。水谷所化津液内走骨空者为“髓”，含骨髓、脊髓和脑髓。

津与液都属正常的水液，都由水谷精微所化，故常津液并称。津液散布于体表，能温润肌肤；布散于体内，能灌溉脏腑；渗注于空窍，能润泽目、耳、口鼻；浸润于骨节，使关节滑利；流注于骨髓，能补益脑髓，渗灌于血脉，能补充血液。但津与液两者在性质上、分布部位和作用上有所区别，津清稀，流行于表，以温润肌肤。液浓稠，流而不行，故主里，以润泽空窍，滑利关节，补益脑髓。正如张景岳所说：“津液本为同类，然亦有阴阳之分。盖津者，液之清者也；液者，津之浊者也。津为汗而走腠理，故属阳；液注骨补脑髓，故属阴。”

《黄帝内经讲解-精、气、津、液、血、脉的生成和功用》

1.2.8、小结

泣、涕、涎、唾、尿、汗是津液的外在表现，因此中医通过观察这些物质的状态来判断人体内部津液的状态。若这类体液偏粘稠混浊则代表体内对应部位的津液偏热，若偏稀薄清冷则代表偏寒。

水液浑浊，皆属于热。诸病水液，澄彻清冷，皆属于寒。

《素问-至真要大论》

比如有口粘腻、尿液混浊、鼻涕混浊等情况，可以考虑其对应内部部位的津液有热，反之考虑有寒。

资料：

五藏化液，心为汗，肺为涕，肝为泪，脾为涎，肾为唾，是谓五液。

《素问-宣明五气篇》

〔讲解〕

本文从五脏化生五液的角度，论述了五脏与五液的关系，为临床诊断治疗五液异常，提供了理论依据。

（1）五液来源于水谷，通过脾气的转输，分别归藏五脏，变化而为五脏各自所主的水液，濡润相关的空窍，是谓五脏化液。高士宗注：“化液者，水谷入口，津液各走其道，五脏受水谷之精，淖注于窍，化而为液也。”

（2）心主血，汗为血液所化。津液从中焦进入肺脉，与营气化合，通过心脏的化赤作用，变化为血，汗未出时为津液，储于血中，既出于皮肤则为汗。心主血脉，汗为血之余，所以可以认为汗为心液所化。

（3）肺司呼吸，鼻为呼吸出入之门户，所以鼻为肺之窍，肺的津液上出于鼻为涕，以润鼻窍。

（4）肝藏血，开窍于目。目得肝血的濡养，而能视物，肝血中的津液满溢，则双目润泽。如情志失常，肝气上逆，迫液外泄而为泪，所以泪为肝液所化。

（5）涎为口中津液，其中较清稀的为涎。脾开窍于口，脾为胃行其津液，胃中津液，赖脾气的升清作用，才能上出于口，润泽口腔，所以可以认为涎为脾液。

（6）“唾”，是口液中较稠厚的部分。肾藏精，主水液，肾脉循喉咙，挟舌本，舌下廉泉、玉英两穴，为液出之通道。所以肾液可循肾脉上注于舌下，出廉泉、玉英而为唾，润泽口舌。上述的就是五脏化生五液的情况。

〔临证意义〕

五液为五脏精液所化，所以五液的异常表现，常可反映有关脏器的病变。如心阳不足，失于敛摄，心液不藏，多见自汗；心之阴血不足，血不养心，神气浮越，心液外泄而盗汗，所以汗证应注意从心进行辨证施治。

临床多涕，大多与肺失宣降有关。如肺热壅盛，薰蒸于鼻，则肺液上攻，涕出浓稠。风寒外束，肺气不宣而上逆，肺液外泄、涕出清稀，所以多涕之证应注意从肺进行辨证施治。

肝为风脏，肝气虚不固，风寒之邪内侵，肝经风邪上逆，肝液随之外泄，则多泪。肝血不足，血中津液不能上濡双目，则目涩，所以多泪目涩之症应注意从肝辨证施治。

口中多涎，大多与脾有关，但有虚实寒热之分。脾热上蒸，则口舌生疮而多涎，属脾液外泄之实证。如因脾阳虚寒，失于固摄，脾液上出于口而清稀者，又属虚证，所以口中多涎之证应注意从脾辨证。

口中多唾，大多与肾有关，也有虚实之分。如肾气虚弱，肾液不固而上溢，则口中多唾。肾阴不足，虚火上炎，迫液外泄，则唾亦多，所以多唾之证应注意从肾辨证施治。

《黄帝内经讲解-藏象学说-五脏与五液的关系》

运化水湿，是指脾对水液的转输与布散具有重要的作用。脾不仅营运水谷之精微，同时又运化水湿，促进水液的环流与排泄，以保持人体内水液代谢的平衡。因而，脾运化水湿的功能健全，则水湿不易在体内滞留，若脾失健运，则水湿潴留，产生湿痰、水肿等疾患。

《中医学概论-藏象-脾、胃》

1.3、小结

本节主要介绍中医理论中人体水液的运转过程。

水液是人体的重要组成部分，对于维持人体正常生理功能有重要意义。如果其运转环节中任意节点出现问题，都可能引起对应的病证。

比如脾胃负责将饮入的水蒸腾运化出去，如果胃或者脾的功能减弱，则运水能力不够，可能使水液滞留于胃部附近，变成痰饮，出现口该渴不渴、甚至背寒如掌大的症状，需要用苓桂术甘汤等方剂进行健脾化水的治疗。

再如肺负责将水宣发到肌表，肃降于全身，如果这些功能出现问题，可导致咳、喘的症状。肺气不宣则喘，不降则咳，需要具体情况具体分析，有麻黄汤、小青龙汤、麻杏石甘汤等方剂可供选择。

再如肾负责净水、运水功能。如果肾阳不足，此功能受损，水在胃、头、肌肉、腿等部位停蓄，造成胃脘部悸动、头眩、身上肌肉跳动、站立不稳、小便不正常、肢体浮肿等症状，可以用真武汤。

真武汤与五苓散均治水证，但真武汤证是少阴水脏阳衰，司水无权，而致水邪泛滥；五苓散证是太阳水腑气化失司，而致水液停蓄。一在少阴，一在太阳，证治各异，为临床治水邪为病提供了辨治依据。

《伤寒论讲解-82条》

再如膀胱有蒸发水液上升的功能，如果受到干扰，此功能失常，可使膀胱水液停留，人出现异常的渴，喝水不解渴，且小便不正常的症状，可以视失衡性质的寒热情况选择五苓散、猪苓汤等方剂。

若脉浮，小便不利，微热，消渴者，五苓散主之。...

“小便不利”、“消渴”，则是...膀胱气化不利之证。...水邪内蓄，则小便不利；津液不能输布上承，则见口渴，口渴思饮，而饮又不解渴，便名以“消渴”。

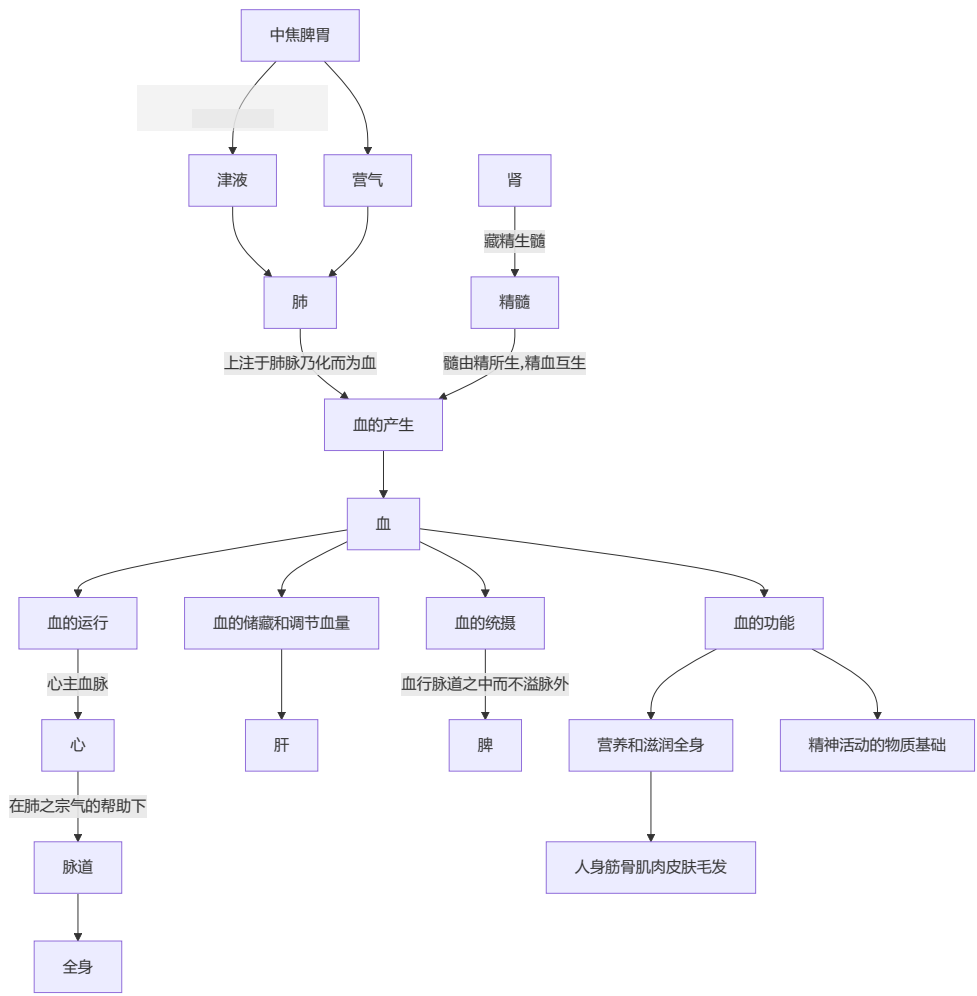
《伤寒论讲解-71条》

人到中年之后，开始出现渴饮的异常，比如经常口干、口渴，喝水而不解，或者长期口不渴，不愿意喝水，就说明体内的水液代谢某些环节开始出现问题，需要重视。水液代谢的问题如长期不能解决，就会引起各

种各样的其它病证，甚至危及心、脑、肺、肾等重要器官，形成严重疾病。而理解水液病证的诊断与治疗方法，需要熟悉水液的运转原理，这就是中医基础理论对中医诊治方法的指导作用。

2、血

血是在心肺的共同作用下，形成的具有濡养全身脏腑组织作用的赤色液态物质。其生成与功能概括为下图：



2.1、生成与变化

关于血的生成，宏观上来说，是人的脾胃从饮食中吸收的精华物质与津液相合，形成了血。

血液主要来源于水谷精微，而水谷精微的化生，有赖于脾胃的运化，所以说脾胃为气血生化之源。《灵枢·决气》说：“中焦受气取汁，变化而赤，是谓血”。就是说中焦脾胃所化生的精微物质是生成血的基本物质。

《中医学概论-藏象-血的生成》

更具体而言，内经提到水谷精微以气态的形式注入肺脉而化生为血。

中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉乃化而为血，以奉生身，莫贵于此，故独得行于经隧，命曰营气。

《灵枢-营卫生会》

营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血。

《灵枢-邪客》

此外，精血互转，所以精也可以转化为血。

此外，精与血之间存在着相互滋生与转化的关系。血能生精养精，精能化血生血。精藏于肾，血藏于肝，若肝血充盛，则肾有所藏，精有所资；若肾精充盈，则肝有所养，血有所充。正如张志聪在《侣山堂类辨》中说：“肾为水脏，主藏精而化血”。

《中医学概论-藏象-血的生成》

2.2、血的运行

血运行于脉道之中，这里的脉相当于现代的血管。

脉是血液运行的通道，所以有约束营血，使之行于一定的通道而不致外溢的作用。

《黄帝内经讲解-精、气、津、液、血、脉的生成和功用》

血的运行以心为基本动力、肺为辅助动力。

心主血脉，心气推动血的运行；肺朝百脉，循行周身的血都要汇聚于肺，通过肺气宣降，敷布全身；

...若心气虚，血行无力，可见血瘀；肺气虚，可出现气血两虚及血瘀；

《中医学概论-藏象-血的生成》

中医学认为，血的运行依赖于气的推动。心气推动，是血运行的基本动力，而心气又有赖于肺气的敷布。正如《医学真传》所说：“气非血不和，血非气不运”。

《中医学概论-藏象-肺、大肠》

肺主气，为相傅之官。肺主宣降，而朝百脉，其宗气贯心脉，具有促进心运行血液的作用，是血液正常运行的必要条件。

《黄帝内经讲解-藏象学说-十二脏的生理功能及其相互关系》

在心肺动力的基础上，肝主血量的调节。睡眠和休息的时候，肌体需要的血液少，血液更多的存储于肝脏。白天和运动时，血液更多分布于肌体。这种分布的调节由肝主导，称为肝藏血。

肝脏能贮藏人体大量的血液，并通过肝气的调节，供给各个器官组织的需要，当人入睡的时候，血液随肝气趋于平静回流到肝脏，使分布在其他方面的血液相对减少，当人醒觉和运动的时候，血液随着肝气的布散，运行于经脉之中，使需要的部分得到补充。...

《黄帝内经讲解-藏象学说-肝主藏血》

脾气可以约束血在脉道中运行而不溢出脉外，称为脾统血。

脾气统血，使血行脉道之中而不溢脉外。...脾失统摄，可出现吐血、衄血、便血等血不归经的证候。

《中医学概论-藏象-血的生成》

所以，在心、肺、肝、脾四脏的作用下，血可以顺利的由脏腑传输到形体。

2.3、血的功能

血液到达形体后，即可营养皮、肉、脉、筋、骨等组织器官。因这些组织器官皆由血转化而成，所以皮肉筋骨等形体也属于“血类”。

“夫血者，水谷之精微，得命门真火蒸化，以生长肌肉皮毛者也。凡人身筋骨肌肉皮肤毛发有形者，皆血类也。

《黄帝内经讲解-人与自然-精、气、津、液、血、脉的生成和功用》

血具体形成哪种组织又与脏气强弱有关，具体见后面五脏之气部分。

血是精神活动的物质基础，血的失衡，包括血虚、血热、血瘀等，可以造成精神失常。

此外，血是人体精神活动的主要物质基础。《灵枢·本神》说：“心藏脉，脉舍神。肝藏血，血舍魂”。都说明血与精神活动密切相关。故若血虚、血热或血瘀，均可出现不同程度的精神情志失常的病变。轻则失眠多梦，烦躁，重则神志恍惚，惊悸不安，或谵语、狂妄、昏迷不语。

《中医学概论-藏象-血的功能》

全身脏腑组织赖心血濡养而维持其正常机能，同时又主神明，为精神思维活动的中枢，所以五脏六腑在心的协调下，才能维持正常的生理活动，假如邪气入侵心脏，就会损伤心脏，以至神气耗散，人即死亡。

《中医学概论-藏象-心为五脏六腑之大王》

血为气之母，血中也包含能够产生气的物质，能随时补充气。

血为气之母，是说气必须依附于血而存在，气需血的滋养。

《中医学概论-气血津液的相互关系》

3.4、人体天气

人体的天气指的是人体中的气态物质，以空气、水蒸汽和气雾状营养物质的形态，存在于经络、腠理以及各种空腔器官、孔窍等处。从功能上主要分为以下几种：营气、卫气、宗气、脏腑之气。

天地之间，六合之内，其气九州九窍、五藏、十二节，皆通乎天气。

《素问-生气通天论》

1、营气

营气是中焦脾胃消化的水谷之气中的精纯部分，其功能是营养全身，内含脏腑，外括形体。

中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此，故独得行于经隧，命曰营气。

《黄帝内经讲解-藏象-三焦的部位和功用》

循行

从中焦注入手太阴肺脉，然后按照十二经顺序依次流转，一日夜行五十周。

营气则沿十二经脉循行次序运行，所不同的是，营卫的循行，在《内经》和历代注家中，某些方面说法颇不一致，尚有待今后进一步研究解决。

《黄帝内经讲解-人与自然-营卫运行的昼夜节律》

与血的关系

营气是气态物质，血是液态物质。营气循行于经络之中，与血关系密切。营气注入脉中，就成为血的组成部分。反之，若不注入脉，则是

气态物质。所以可以把营气理解为气态的血，血理解为液态的营气。

血循行于血管脉道中，营气循行于经络中，两者不可混为一谈。

营者，水谷之精气也，和调于五藏，洒陈于六府，乃能入于脉也。故循脉上下，贯五藏，络六府也。...

营气清柔，所以能灌注于血脉之中，成为血液的组成部分，循着经脉，贯通五脏，联络六腑，运行全身，发挥其营养作用。...

营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末，内注五藏六府，以应刻数焉。...

营气柔和，循行于经脉之中，与津液相和合，化生为血液。营气与血，同行脉中，营气为血的组成部分，血液由营气和合津液变化而成，营气与血，可分而不可离，故常“营血”并称。...

营气之道。内谷为宝。谷入于胃，乃传之肺，流溢于中，布散于外。精专者，行于经隧，常营无已，终而复始，是谓天地之纪。...

就营气的生成而言，营气是水谷精气所化生的营养物质，源于脾胃。中焦有脾胃居其内，其功能是脾胃功能的概括，营气既由脾胃所化生的水谷精气的精纯部分所生成，所以说营气出于中焦。

其次就营气的运行而言，营气源于脾胃，出中焦后，注手太阴肺经，然后循十二经，昼夜不息，运行于全身上下内外各部，所以从营气的运行看，也可认为营气出于中焦。

《黄帝内经讲解-藏象-营卫的生成和功能》

2、卫气

产生

卫气根源于下焦肾精转化的阳气，补充于中焦脾胃消化的水谷之气中的彪悍部分，宣发于上焦。

卫气除根于下焦命门阳气，又赖上焦的宣发以外，卫气也由水谷精气所化生，还必须依靠水谷精气的不断充养，才能发挥作用。因此可以认为卫气根源于下焦，资生于中焦，宣发于上焦，卫气与三焦均有密切的联系。

《黄帝内经讲解-藏象-营卫的生成》

其次就卫气的功能而言，卫气属阳，故又称卫阳。而一身之阳气根于下焦肾，所以卫气也根源于下焦肾中的阳气，卫气只有不断受肾阳的温养，才能发挥其温煦固表的作用，所以说卫气出于下焦。

“下”，《太素》卷十二《营卫气》作“上”，杨上善注：“卫出上焦者，出胃上口也。”张志聪也认为“下，当作上”，并说：“卫者，阳明水谷之悍气，从上焦而出，卫于表阳，故曰卫出上焦。”杨上善、张志聪等人，从卫气的特性及卫气向外敷布部位等角度，认为卫气出于上焦。而张景岳等人，则从卫气的运行及卫气的本源等方面，以为卫气出于下焦。可见两种说法都有根据，只是认识的角度不同而已，应予并存。

《黄帝内经讲解-藏象-营卫的生成》

循行

卫气行于经络之中，血脉之外，遍布全身。

一部分卫气在白天和夜晚走不同的路径，白天走手足三阳经二十五周；晚上走脏器二十五周。因此，卫气的循行与睡眠有着密切关系。

人早晨醒来时，卫气由肾经，从目内眦的睛明穴而出，上行到头部，然后沿手、足三阳经向下运行。足三阳的卫气注入脚心，进入肾经，通过肾经上升回到睛明穴。此为一周，时间约为半小时。一小时两周，则白天十二小时约为二十五周。内经未谈手三阳的卫气是否注入手心？是否对应通过手少阴心经回归睛明穴？此处存疑。

夜晚入睡时，卫气从肾经进入肾脏，然后沿心、肺、肝、脾、肾为一周，时间也是半小时。夜晚十二小时也是二十五周。

本篇下文指出，卫气一日一夜，循行五十周次，白天行于阳分二十五周，夜间行于阴分二十五周。

据《灵枢·卫气行》记载，平旦阴尽，卫气先从目内眦睛明穴出阳，上行至头部，然后循手足三阳经向下运行，最终由足阳明达足心，入足少阴经，循少阴之别跷脉，上行复交会于目内眦足太阳睛明穴，卫气白天循此路线运行二十五周。

卫气夜行于阴，由足少阴肾经传注于肾脏，由肾脏注入心脏，由心脏注入肺脏，由肺脏注入肝脏，由肝脏注入脾脏，由脾脏再传至肾脏为一周，卫气夜间以此次序运行二十五周。...

就卫气的运行而言，卫气慄疾滑利，白天循手足三阳经，分布于四肢、皮肤、肌肉之间。

日西，由足少阴肾经传注肾脏，分布于五脏六腑。

平旦，又由足少阴肾经，经目内眦睛明穴出阳，

故日西阳尽，平旦阴尽，卫气均自足少阴肾经发出，所以说，卫气出于下焦。

张景岳注：“卫气者，出其悍气之慄疾，而先行于四末分肉皮肤之间，不入于脉，故于平旦阴尽，阳气出于目，循头项下行，始于足太阳膀胱经而行于阳分，日西阳尽，则始于足少阴肾经而行于阴分，其气自膀胱与肾由下而出，故卫气出于下焦。”

《黄帝内经讲解-藏象-营卫的生成和功能》

卫气正常情况下循以上道路运转，但特殊情况下，可以不遵循这个道路。比如内经说人饮食热的水谷，有时会立刻出汗，位置在面部、背部或者半身，这是因为卫气彪悍，在腠理开关不正常的情况下，遇到出口就会走出。

黄帝曰：人有热饮食下胃，其气未定，汗则出，或出于面，或出于背，或出于身半，其不循卫气之道而出，何也？岐伯曰：此外伤于风，内开腠理，毛蒸理泄，卫气走之，固不得循其道。此气慄悍滑疾，见开而出，故不得从其道，故命曰漏泄。

《灵枢-营卫生会第十八》

按：卫气的循行在内经中有难解之处，各位注家理解也不尽相同，暂时大家先了解这些即可。

功能

卫气功能主要有下面几个方面：

1、经络中的卫气可以温煦、保卫肌表，防御外邪。此功能异常，则人有怕风、怕冷之类的症状。

一部分卫气白天循行三阳经，内经讲“太阳为三阳主气”，所以卫气在肌表的敷布以太阳经为主导。

为什么以太阳经为主导？教材中提到太阳经的卫气除了来自正常的经络交互外，还有督脉和肾阳两个来源。督脉中的阳气可以通过后脑风府穴注入足太阳经。肾的阳气可以在腰部注入足太阳膀胱经。可以参考。

足太阳膀胱经脉...其脉上连风府与督脉交会，下络腰肾与少阴相通，籍助督肾阳气支持而主一身之表。

《伤寒论讲解-辨太阳病脉证并治上-概说》

岐伯对曰：巨阳者，诸阳之属也。其脉连于风府，故为诸阳主气也。...

《素问-热论》

太阳经出问题，则全身的卫气都不能正常敷布，其表现就是怕冷。

“恶寒”之前用一“而”字，有“而且一定”的意思，以强调恶寒一证在太阳表证中的必见性。风寒之邪外伤太阳之气，使卫气

不能温煦体表，故见恶寒。

《伤寒论讲解-第1条》

2、卫气还能管理皮肤汗孔的开合。此功能异常，则人的出汗功能有问题。问题包括该出汗的时候不出，或者不该出汗的时候反而出汗。

3、脏腑中的卫气可以温煦脏腑。此功能异常，则人容易有大便稀溏、不喜饮冷水等症状。

卫气的功能有三个方面：一是护卫肌表，防御外邪。二是温煦脏腑，润泽皮毛。三是司汗孔开合。

故《灵枢·本藏》说：“卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开合者也”、“卫气和，则分肉解利，皮肤润柔，腠理致密矣”。

《中医学概论-藏象-气》

卫气昼行于形体阳经，夜行于内在脏腑。所以夜晚睡觉的时候，必须盖被子，因此时卫气入里，体表卫气不足，护卫能力不够，容易着凉。长期失眠的人，卫气不能进入五脏，则五脏在夜晚恢复正气、排除邪气的功能受损，五脏衰老的快。

以后学习《伤寒论》，遇到恶寒怕冷、汗出异常、睡眠问题、大便稀溏等症状，常与此处卫气的功能特点有关。

3、宗气

产生

宗气是在上焦胸部心、肺部位形成的一种气态物质，由吸入的自然空气与脾胃上升而来的水谷精微之气结合而成。

肺主一身之气，自然之气由肺吸入，水谷精气经脾上归于肺，合而为宗气，积于胸中气海。上出喉咙以司呼吸，贯心脉而布散周身。

《黄帝内经讲解-藏象-肺为各脏之长》

胸部两乳之间的膻中穴为宗气生成与汇聚之处，称为气海。

膻中指胸中部位，为肺之所居，肺主一身之气，行呼吸，吸入大气，与水谷精气合为宗气，以充养全身。所以膻中为宗气生成和汇聚之处，称为气之海。

《黄帝内经讲解-四海功能及所主腧穴》

循行

宗气聚集于上焦胸部，但能循行于全身，其路线与营气是一致的。

宗气汇聚于胸部膻中，所以膻中又称为气海。

《黄帝内经讲解-藏象-宗气的生成和功用》

上焦为宗气所聚之处，宗气能推动营气运行全身，白天与营气偕行二十五周次，夜晚偕行二十五周次，一昼夜共行五十周次，总会于手太阴肺经。

《黄帝内经讲解-三焦的部位与功用》

宗气与营气一样可以灌注到血脉之中。

故宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉。...

宗气在上积聚于胸中气海，贯注于心脉，行于呼吸之道：故宗气既行于脉内，又布于脉外。《灵枢·刺节真邪》说：“宗气留于海，其下者注于气街，其上者走于息道。”宗气在下汇集于丹田，经足阳明气街，下行于足，可见宗气既行于上，也运于下。说明宗气虽积于胸，而实能循行全身，正如张景岳注《灵枢·刺节真邪论》所说：宗气“其下者蓄于丹田，注足阳明之气街而下行于足；其上者积于胸中，出于息道而为呼吸。”...

《黄帝内经讲解-藏象-宗气的生成和功用》

功能

宗气作用是帮助肺进行呼吸、帮助心运行血液、推动营气运行。前述“气为血之帅”，即血液在脉中运行需要气的推动。其中的气就是指这里的宗气。

肺主呼吸。吸入的自然界空气与脾胃上升之气合为宗气，结合心气，推动血液运转于全身。所以中医说“呼吸为脉之头”、“肺朝百脉”、“肺主气”。

脉有三部，阴阳相乘，荣卫血气，在人体躬，呼吸出入，上下于中，因息遍布，津液流通。

《伤寒论-伤寒例》

病证

宗气不足，则影响呼吸功能和血液的运行功能，可引起血脉凝滞，进而在肢体温度、运动、心脏跳动等方面出现异常。其表现包括：

轻则面色晦暗、心悸、气短、喘促、呼吸不畅。

中则唇面紫绀、爪甲青紫、吸短呼长、喘促难卧、喉中痰鸣、心慌无主、虚里动衣。

重则心神失附、心慌烦躁、神识恍惚、呼吸浅短难续、冷汗淋漓、皮肤发凉、四肢逆冷、脉微欲绝、二便难禁甚或失禁。

宗气与营卫之气相比较，宗气更为基础、重要。人外感风寒，营卫之气受伤，而宗气未受损时，只出现发热、怕冷、汗出异常的表现，还未伤及根本。但若宗气受损，其推动血液流转的功能出问题，如出现上述轻、中、重几种宗气不足的表现，就要严重的多。

故厥在于足，宗气不下，脉中之血，凝而留止，弗之火调，弗能取之。

《灵枢-刺节真邪第七十五》

调节

宗气不足的直接原因往往是心肺功能下降，但也可能是脾胃功能下降。因宗气有一部分为水谷之气，脾胃功能下降，不能产生足够的水谷之气，则宗气自然不足。再更根本的原因可能是肾功能下降，肾藏精而生元气，元气不足，则脾胃、心肺功能皆下降，可导致宗气不足等病证。

因宗气的产生直接来自肺的呼吸和脾胃的消化吸收，因此常规的调节方法就是进行高质量的呼吸以及合理饮食，补益心肺以及健壮脾胃。而实际上宗气的产生、运行与五脏皆有密切关系，除了心、肺、脾外，肝的调节气机，肾的提供元气，都与宗气有关系。所以最终还是要整体分析，辨证论治。

当宗气虚到极点，出现上述病证中的重症的时候，宗气已无力推动血液运转，属于心衰病危。中医的最后手段是参附汤、四逆汤等方剂，用大剂量人参、附子补气补阳，再加生龙骨、生牡蛎、五味子，或可挽回一部分。针对此情况，李可老中医根据救治大量心衰患者的经验，发明了破格救心汤，大家可以认真学习。对于宗气虚的情况，平时应及早重视，如果到了最后阶段，能否挽回在两可之间。

4、脏腑之气

脏腑之气是脏腑所对应的气态物质。元气通过三焦作用于各个脏腑。各个脏腑获得能量后，又可以产生脏腑之气。所以脏腑能量越强，脏腑之气越充足。脏腑及其对应的气态物质可参考前面天地章节，五方地对气交之地的天气产生的影响。

人体的五行脏气分布是肝气左升、肺气右降，心气浮于上，肾气沉于下，脾气在中间灌溉四旁。这种分布对均衡人体上下部气血有重要作用，若出现问题，可以导致气机升降的问题，出现上实下虚或者下实上虚等分布不均的问题。

《素问·阴阳应象大论》说：“左右者，阴阳之道路也。”左右是阴阳升降的道路，左升右降。肝主春，其气从左而升，左为肝气分布的部位。故肝病多见于左。肺主秋，其气从右而降，右为肺气分布的部位，故肺病每见于右。如《难经·五十六难》说：“肝

之积名曰肥气，在左胁下……肺之积名曰息贲，在右胁下。”所以临证积见于左者，多治肝血；生于右者，多治肺气。

《黄帝内经讲解-脏气的分布》

脏腑之气各有通道进入对应的经络，是经络之气的组成部分。比如心气注入手少阴心经，如果心气不足，则在心经通道上会出现能量不足的发冷症状，其它脏腑类似。内经形容脏气进入经络的样子像弓弩发射一样，非常迅捷。

岐伯曰：气之离脏也，卒然如弓弩之发，如水之下岸，上于鱼以及衰，其余气衰散以逆上，故其行微。

《灵枢-动输》

因经络互相连接，所以脏腑之气进入对应经络之后，又随经络散布到全身。人的五体皮肉脉筋骨由血转化而来，但血具体转化为其中哪一种又由脏腑之气控制。肺气侧重于养皮、心气侧重养脉、脾气侧重养肌肉、肝气侧重养筋、肾气侧重养骨。

心之合脉也，其荣色也，其主肾也；肺之合皮也，其荣毛也，其主心也；肝之合筋也，其荣爪也，其主肺也；脾之合肉也，其荣唇也，其主肝也；肾之合骨也，其荣发也，其主脾也。

《素问-五藏生成篇》

初持脉，如三菽之重，与皮毛相得者，肺部也。如六菽之重，与血脉相得者，心部也。如九菽之重，与肌肉相得者，脾部也。如十二菽之重，与筋平者，肝部也。按之至骨，举指来疾者，肾部也。故曰轻重也。

《难经-五难》

因此，五体的状态可以反应对应脏腑的状态，五体的衰弱多因对应脏腑的衰弱。现代的很多疾病，比如肌无力、血管瘤、骨质疏松等，从中医角度看，都要从脏腑中寻找根源。

五脏之气通过经络通于面部，使人的面部呈现出健康的色泽。因此中医望诊通过观察面部色泽了解脏腑的状态。

1. 天有五气，食入入鼻，藏于五脏，上华面颐，

肝青心赤，脾脏色黄，肺白肾黑，五脏之常。

《中医诊法 中药 方剂口诀-望诊》

5、气的升降出入调节

全身气的升降出入活动是在肝的调节下进行，肝主疏泄即为此意。若肝的疏泄功能失常，则可能出现气的上逆，产生头目胀痛，面红目赤，心烦易怒的现象；或者气的运转产生淤滞，进而影响血和津液的运行，产生血瘀、痰饮的现象，妇女可以产生经行不畅、痛经等现象。肝的疏泄功能也管理脾胃的气机升降，若出现异常，对于脾可能出现腹胀、肠鸣、泄泻等脾气不升的症状，对于胃可能出现胃脘作痛，嗳气不舒，恶心呕吐的胃气不降的症状。

一是调畅气机。气机，即气的升降出入运动，它是对脏腑功能活动形式的基本概括。由于肝具有主动、主升的功能特点，这对气机的疏通、畅达、升发，是一个重要的因素。肝的疏泄功能正常与否，直接影响着气机的调畅。如果肝的疏泄功能正常，则气机通畅，气血和调，经脉通利，各个脏腑的功能活动就正常。如果肝的疏泄功能异常，或由于肝的疏泄功能减退，而形成气机不畅、肝气郁结的病理变化，出现胸胁胀痛的病症。或由于肝的升发太过而形成肝气上逆，或肝阳上亢的病理变化，而出现头目胀痛，面红目赤，心烦易怒等病理现象。由于气的升降出入运动，直接影响到血与津液的输布与运行，故肝的疏泄功能异常，常会导致血与津液的病变。如肝气郁结，可形成血瘀、癥瘕，在妇女可导致经行不畅、痛经等症。同样，肝郁气滞，亦可产生痰、水等病理产物，出现痰核、臌胀等症状。

《中医学概论-肝、胆》

6、小结

经络为气态物质的运行通道，存在于各种组织器官的间隙之中。如内经说卫气“循皮肤之中，分肉之间，熏于肓膜，散于胸腹”，张景岳说“凡腔腹肉理之间，上下空隙之处，皆谓之肓”。

岐伯答曰：气之不得无行也，如水之流，如日月之行不休，故阴脉荣其脏，阳脉荣其腑，如环之无端，莫知其纪，终而复始，其流溢之气，内溉脏腑，外濡腠理。

《灵枢-天年》

特殊情况下，气态物质可以弥漫渗透的方式穿过形体组织。在《中医儿科学》的小儿哮喘病中，谈到此病的病根为肺中伏痰，过食冷、酸、咸的食物会诱发，就是因为小儿器官娇嫩，冷酸等气态物质浸入肺腑而发病。

小儿肺脏娇嫩，治节失司；脾气虚弱，运化无权；肾阳不振，失于蒸化，酿生痰湿内停，留伏肺俞，是为潜在内因；而气候变化，寒暖失常，感受六淫；饮食不当，或过食生冷酸咸；以及吸入花粉、绒毛、灰尘，接触油漆、煤气、刺激性气体；甚至啼哭呛乳，均乃诱发哮喘的外来因素。故本病虽发作于肺，而又与脾肾二脏有关。

《中医儿科学-哮喘》

营卫二气互相配合，营气负责营养，为卫气之根，卫气负责温煦与护卫。两者配合不协调，则发生营卫不和的疾病。例如《伤寒论》的太阳中风证，为太阳区域受风邪侵袭，造成卫强而营弱的情况，表现为头痛、发热、汗出、怕风，用桂枝汤调和营卫治疗。

曰：营气之行，常与卫气相随不？

然：经言人受气于谷。谷入于胃，乃传于五脏六腑，五脏六腑皆受于气。其清者为营，浊者为卫，荣行脉中，卫行脉外，营周不息，五十而复大会。阴阳相贯，如环之无端，故知营卫相随也。

《难经-三十难》

寸口脉微而涩，微者卫气衰，涩者荣气不足。卫气衰，面色黄，荣气不足，面色青。荣为根，卫为叶，荣卫俱微，则根叶枯槁而寒慄欬逆，唾腥吐涎沫也。

《伤寒论-平脉法-单元6》

总体来讲：

宗气是气态物质的主体，主要产生于上焦，能入经络与血脉，主要功能是主呼吸，并推动血与营气的运行，失常则有呼吸及血脉淤堵问题。

营气主要来自中焦，能入经络与血脉，主要功能是营养脏腑与形体。

卫气主要来自下焦，通过肾经入经络，不能入血脉，主要功能是温煦与护卫，失常则有寒热问题。

脏腑之气来自各自脏腑，主要入对应经络，也随经络散布全身。

以上各气在进入某经络后，就称为该经络之气。比如宗气、营气、卫气、脏腑之气进入太阳经络，就称为太阳之气，进入少阳经络，就叫少阳之气，其它以此类推。以阴经、阳经角度划分阴阳的话，这些气流经三阳经的时候可以称为阳气，流经三阴经的时候可以称为阴气。人全身的经络之气充足且畅通，则健康无病。

凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。

[337]...

人体三阴三阳经脉，皆在手足交接，使阴阳相贯，循行周身，如环无端，此即阴阳气相顺接，为生理之常

《伤寒论讲解-337条》

如果某一种气失常，则有该气所主功能异常的病证表现。比如卫气不足则怕冷，宗气不足则血脉淤堵等等。

如果某一经络通道有问题，则有该经络相关部位、相关功能以及相连脏腑的病证表现。比如太阳病怕冷、头项僵硬疼痛，少阳病寒热往来、口苦咽干、胸胁痛、耳聋等等。

3.5、精

1、位置

精分布于全身，在形体及脏腑都有。在形体有骨之精、筋之精、血之精、肌肉之精；在脏腑则有肝精、心精、肺精、脾精、肾精。

《灵枢·大惑论》说：“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精。精之窠为眼，骨之精为瞳子，筋之精为黑眼，血之精为络，其窠气之精为白眼，肌肉之精为约束”。此说明五脏之精气上达于目，其中，瞳子为肾精所注，黑眼为肝精所注，眼络为心精所注，白眼为肺精所注，眼睑为脾经所注。故眼部的变化亦可反映出五脏的盛衰。

《中医学概论-肝胆》

五脏是藏精的主要部位。五脏精气充满，则人健康水平高。反之，若五脏精气不足，则健康水平下降。

《素问·五藏别论》说：“所谓五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实……这段话是说：五脏的主要功能是藏精气。

《中医学概论-五脏六腑》

东方青色，...藏精于肝。...南方赤色，入通于心...。中央黄色，...藏精于脾。...西方白色，入通于肺，开窍于鼻，藏精于肺。...北方黑色，入通于肾，...藏精于肾...。

《素问-金匱真言论篇》

是故五脏主藏精者也，不可伤，伤则失守而阴虚；阴虚则无气，无气则死矣。

《黄帝内经-灵枢-本神》

其中肾比较特殊，是精的大仓库。其它脏腑精不足需要肾精补充，精足可以传输到肾藏起来。所以讨论精的时候多指肾精，但也要知道其它脏

腑、形体皆有精的存在。

肾者，主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛，乃能泻。

《素问-上古天真论》

2、分类

精分为先天之精和后天之精。通常情况下，我们说精的时候，指的是两者皆包括。如需特殊说明，需要明确指出是先天之精还是后天之精。

肾所贮藏的生殖之精，来源于父母，亦称先天之精，《灵枢·本神》说：“故生之来谓之精。”即指此而言。

肾所藏的水谷之精，来自五脏六腑，亦称后天之精，《素问·上古天真论》说：“肾者，主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛，乃能泻。”此即水谷之精。

但先天之精需要后天之精的不断充养，后天之精也需先天之精的不断促进，两者有着不可分割的关系。

《黄帝内经讲解-藏象学说-五脏功能与形体组织、四时阴阳的关系》

2.1、后天之精

饮食经过脾胃提炼得到的精称为后天之精。

腑的作用类似炼油厂，主要是对食物（原油）进行消化提炼，吸收其中的水分、营养物质，形成供给人体的津液、营养（化工原料）、精（成品油），剩余的残渣（沥青）成为粪便排出体外。

成品油加入汽车能够直接转化为能量，精在人体里也可以直接转化为能量。

王三尊《医权初编》说：“凡饮食先入于胃，俟脾胃运化，其精微上输于肺，肺气传布各所当入之脏，浊气下入大小肠，是脾胃为分金炉也。若脾胃有病，或虚或实，一切饮食药饵，皆不运

化，安望精微输肺而布各脏耶？是知治病当以脾胃为先。若脾胃他脏兼而有病，舍脾胃而治他脏，无益也。又一切虚症，不问在气在血，在何脏腑，而只专补脾胃，脾胃一强，则饮食自倍，精血日旺，阳生而阴亦长矣。”

《黄帝内经讲解-五脏六腑皆禀气于胃》

2.1.1、来源

后天之精来源于脾胃运化的水谷之精微，脾胃对食物进行消化吸收后而获得，胃主消化，脾主吸收。

2.1.2、使用

脾将精传输到五脏六腑，化为脏腑之精，维持各脏腑功能活动，多余的收藏于肾

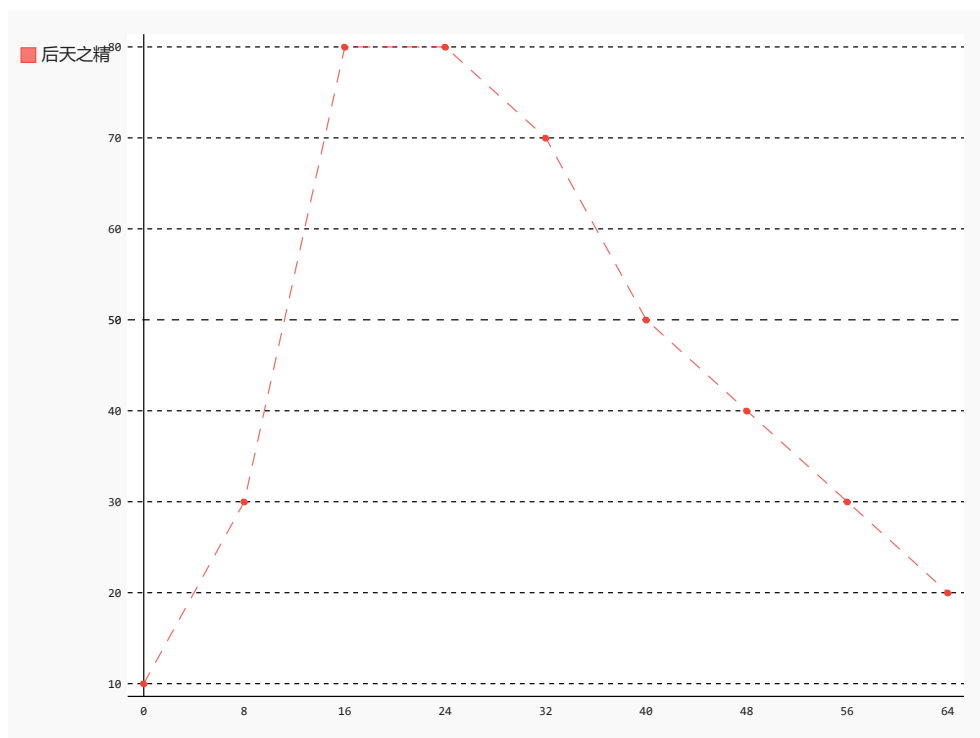
2.1.3、判断标准

脾胃吸收后天之精的能力可以通过饮食是否正常、大便是否正常等现象来判断。

2.1.4、不同年龄的变化

16岁以前是因为形体不足，不能吸收大量的食物精微。

32岁以后是因为消化吸收能力下降而不能吸收大量食物精微。



2.2、先天之精

2.2.1、来源

先天之精为与生俱来，父母给予。

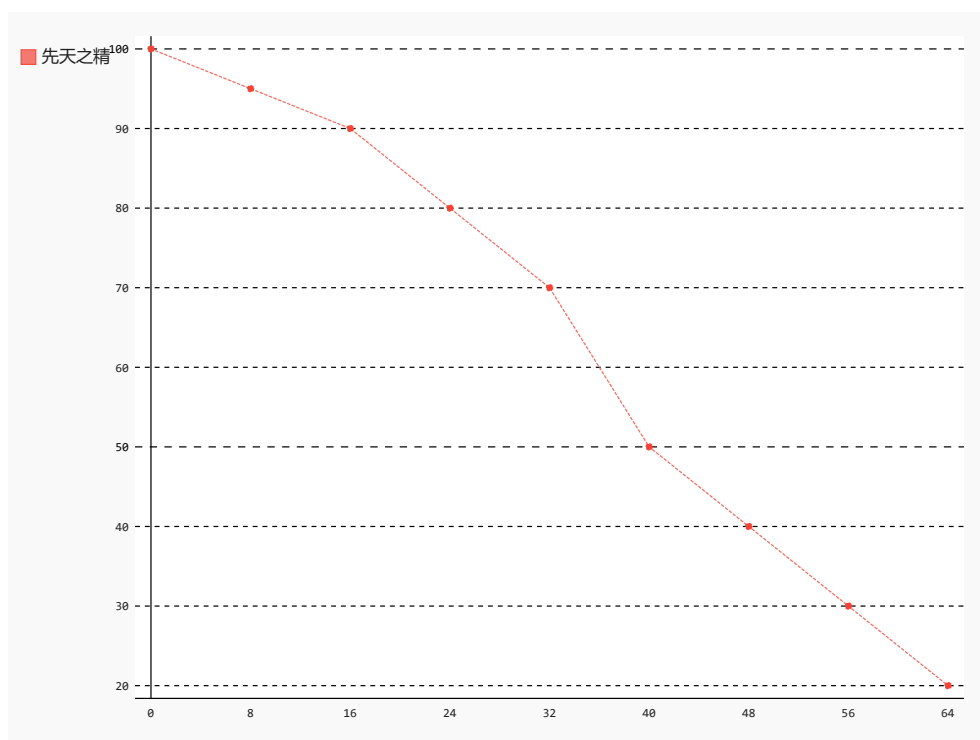
2.2.2、作用

先天之精可帮助后天之精的产生。

先天之精与后天之精共同形成肾精(肾精作用见下面)，是人体正常寿命的主要标志。

2.2.3、不同年龄的变化

普通人先天之精只能消耗，极难补充。



2.3、肾精

2.3.1、来源

先天之精加后天之精

2.3.2、功能

1、产生元气

肾精可转化为元气，供给各个脏腑以及全身使用。肾精不足，转化的元气不够，也可以导致脏腑、全身的阳气不足。

2、濡养各个脏腑

肾精可转化为阴液与阴血，濡养其它脏腑。肾精不足，则可能导致各个脏腑、全身的阴不足。

3、生殖

肾精足则男子溢精、女子来潮。不足则男女不能生子。

由于肾中精气的盛衰，直接影响到人体的生殖机能，所以当肾藏精的生理功能发生病变时，常会导致生殖机能的种种病变，...

肾精对各个脏腑组织所起的滋养、濡润作用称为肾阴，将对各个脏腑起到的温煦、促进作用称为肾阳。并将其称为元阴与元阳，真阴与真阳。肾中阴阳是人体各脏腑阴阳的根本，肾阴乃一身阴液之源，肾阳乃一身阳气之根，二者同居肾中，故有“肾为水火之宅”的说法。...

《中医学概论-藏象-肾、膀胱》

4、人体的生长发育

精主导人的生长发育，包括长身体、长头发、长牙齿。精不足则小儿发育迟缓，青少年青春期发育不良。老年人肾精减少，头发枯，牙齿落，形体衰。

两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精……

对新形体而言，精是在形体尚未形成之前就已存在的物质，是繁衍后代，构成形体的基本物质。……

精者，血之精微所成，生气之所依也。生气者，卫气之根，即命门真火是也，精竭，则生气绝矣。

《黄帝内经讲解-气血精神-精、气、津、液、血、脉的生成和功用》

5、肾精滋生骨髓，充养骨骼，所以骨髓的生长、发育、修复都与肾有密切关系。脑为髓海，髓海有余，则肢体活动敏捷有力、耳目聪明、头脑清醒，智力好。

由于肾精滋生骨髓，充养骨骼，所以骨髓的生长、发育、修复都与肾有密切关系。例如有因先天禀赋不足，肾气虚衰，不能充养骨髓，致使小儿生长发育障碍，出现五迟（立迟、行迟、齿迟、发迟、语迟）、鸡胸（胸廓向前突出）、龟背（脊骨弯曲隆起）、解颅（头颅骨缝分裂）等症，皆可从肾虚论治。以地黄丸为主，酌加鹿茸、龟板等药。成人有因肾精亏虚，骨髓不充，出现腰脊

酸痛，不能屈伸，下肢痿软，行动乏力，或因努力负重致痛，或跌仆损伤筋骨，日久不愈。凡此等等。均宜以补肾为主。

《黄帝内经讲解-藏象学说-五脏功能与形体组织、四时阴阳的关系》

2.3.3、不同年龄的变化

通常情况下，人随年龄增长肾精的存量是有规律的，以男子为例：

丈夫八岁，肾气实，髮长齿更，

二八，肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；

三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；

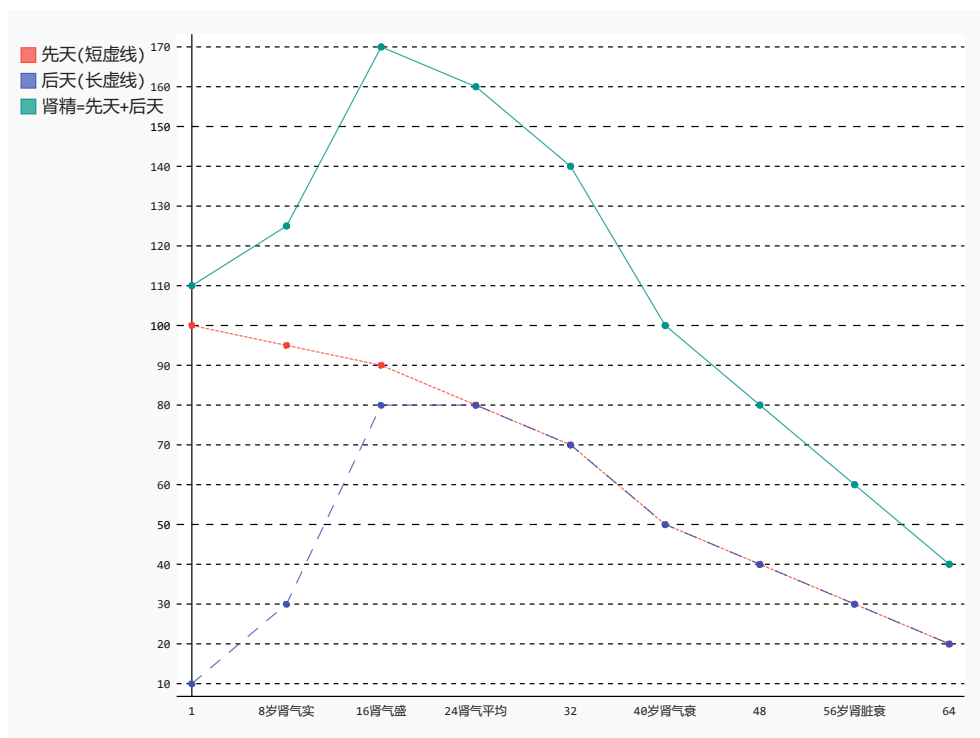
四八，筋骨隆盛，肌肉满壮；

五八，肾气衰，髮堕齿槁；

六八，阳气衰竭于上，面焦，髮鬓颁白；

七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极；

八八、则齿髮去。



这是普通人的规律，如果人善于保养或者过度消耗，则时间有延后或者提前。

因肾精为五脏之精的代表，肾精的多少也即代表了五脏藏精的多少。所以这种肾精随年龄变化的规律其实也就是五脏藏精量的变化规律。

2.3.4、判断多少

通过一些人体现象可以判断精的状态，比如男子溢精、女子月经来潮代表肾精充足；人体的齿、骨、髮的状态也与肾精的状态相应。

内经中还有通过面部形态初步判断人的先后天精气是否旺盛的方法。内容包括：

- 1、以额角、鼻头、下颌三处高起不平陷为好
- 2、以面部肌肉高厚，轮廓方正为好
- 3、以人中沟深而长为好

马蒔注：“面之三里，即三部也，皆已耸起。”《内经》认为，从面部的特征可以判断人的寿夭。骨为肾所主，肾为先天之本；肉为脾所主，脾为后天之本。如果人中沟深而长，面部肌肉高厚，轮廓方正，面部上、中、下三部耸起而不平陷，肌肉丰满，骨骼高起者，则提示先后天精气皆旺盛，所以人能长寿，活百岁而终其天年。当然，通过望面部特征，测候先后天精气盛衰的方法，判断寿夭有一定的道理，但是不能将面部特征与寿夭的关系绝对化，应结合全身其他方面情况综合考虑。

《黄帝内经讲解-藏象学说-寿夭与先后天的关系》

3、精的重要性

精之所以为精华是有其深刻道理的，精既可以转换为身体的阴也可以转换为身体的阳。身体阳不足的时候，精可以转化为阳气；阴不足的时候，精可以转化为津液、血液，而五体由又都由血转化而成。由此可见，整个人体，无论阴阳都是由精转化而来的。

精足的话，人就不容易虚，因为无论身体各处的阴虚、阳虚，都可以通过精的转化来补充。如果精不足，则脏腑组织在出现阴、阳不足的情况时，就不能及时补充，从而表现出阴虚或者阳虚的证。严重的话会影响脏腑组织的功能，出现疾病。

然上文既云气归精，是气生精也；而此又曰精化气，是精生气也。二者似乎相反，而不知此正精气互根之妙也。

《黄帝内经讲解-味、形、气、精的阴阳互用关系》

肾精对各个脏腑组织所起的滋养、濡润作用称为肾阴，将对各个脏腑起到的温煦、促进作用称为肾阳。并将其称为元阴与元阳，真阴与真阳。肾中阴阳是人体各脏腑阴阳的根本，肾阴乃一身阴液之源，肾阳乃一身阳气之根，二者同居肾中，故有“肾为水火之宅”的说法。

《中医学概论-肾、膀胱》

精大量藏于肾，所以精充足与否主要看肾精是否充足。若肾精充足，则可以补人一身的元气和阴血，使各个脏腑的阴阳都不虚，人就不容易生病。又因为肾主骨生髓，肾精充足，髓就可以得到足够的充养。骨髓、脑髓充满，人的运动、思维能力都很强，人就年轻不衰老。因此《内经》以肾精的充足与否作为年轻与衰老的标志。

肾中所藏之精，为人生命之源，对人体的生长发育与生殖，起着极为重要的作用。

《素问·上古天真论》说：“女子七岁，肾气盛，齿更髮长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七，肾气平均，故真牙生而长极；四七，筋骨坚，髮长极，身体盛壮；五七，阳明脉衰，面始焦，髮始堕；六七，三阳脉衰于上，面皆焦，髮始白；七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。丈夫八岁，肾气实，髮长齿更，二八，肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八，筋骨隆盛，肌肉满壮；五八，肾气衰，髮堕齿槁；六八，阳气衰竭于上，面焦，髮鬓颁白；七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极；八八、则齿髮去”。

此段论述，指出了人体的生、长、壮、老、已的自然规律，与肾中精气的盛衰密切相关。

《中医学概论-肾、膀胱》

如果想保养身体，延缓衰老，需要尽量保持肾精的充足。达到这个目的需从开源和节流两个角度来实现。

开源即是增加肾精的补充来源，在先天之精难以补充的前提下，主要是补充后天之精。后天之精主要来自脾胃对饮食的消化吸收。

节流指的是减少肾精的无谓消耗。首先要节欲以减少生殖之精的消耗；另外不要进行过度的脑力或体力活动以免透支肾精；再有就是顺应自然规律，作息有常、饮食有节、注意寒暑变化等等，因为每一次违背自然规律的行为，都需要消耗肾精进行补偿，会加快肾精的消耗速度。

所以，内经《上古天真论》对真、至、圣、贤的长寿之人会谈到的问题，真人“呼吸精气”、至人“积精全神”、圣人“精神不散”等等。

4、精与髓的关系

髓存在于以下几个位置：骨腔、脊柱、脑，分别称为骨髓、脊髓、脑髓。

髓由精产生，由津液中的液作为补充。

中医认为，精与髓是高度相关的，五脏藏精足，则髓足；五脏藏精不足，则髓空虚。“精髓”一词通常用来描述事物的根本精华，确实人体的根本就在精与髓。

五谷之津液，和合而为膏者，内渗入于骨空，补益脑髓，而下流于阴股。

阴阳不和，则使液溢而下流于阴，髓液皆减而下，下过度则虚，虚，故腰背痛而胫酸。

《灵枢-五癃津液别》

冬时肾水当令，阳气内敛，肾气闭藏，故五脏真气亦下藏于肾，化精生髓，充养骨骼。

《黄帝内经讲解-气血精神-真气的生成和输布》

骨得到骨髓的营养，则骨骼健壮，活动有力。骨髓不足，骨骼脆弱无力。

肢体筋脉弛缓，痿弱无力，失于自行活动及行走为主证。

久病体虚，或房劳过度，损伤肝肾致精血亏虚，精亏不能滋髓养骨，血虚不能荣筋养脉而致痿软无力。……肾主身之骨髓。……肾气热则腰脊不举，骨枯而髓减发为骨痿。

《中医内科学-痿证》

脑为髓之海，是大量髓汇聚之地。充足的脑髓为大脑的活动提供了物质能量基础。脑髓不足，则头晕、目眩、耳鸣、腿酸、视力下降、无力、喜卧。

“脑户，督脉穴，在枕骨上，通于脑中，脑为髓海，乃元阳精气之所聚，针入脑则真气泄，故立死”。...

《灵枢●海论》说：“髓海不足，则脑转耳鸣，胫酸眩冒，目无所见，懈怠安卧”。...

《灵枢●口问》也说：“上气不足，脑为之不满，耳为之苦鸣，头为之苦倾，目为之眩”。...

脑之为言在也，人精在脑。

《中医学概论-奇恒之腑-脑》

《灵枢●经脉》云：“人始生，先成精，精成而脑髓生，骨为干，脉为营，筋为刚，肉为墙，皮肤坚而毛髮长”

《中医学概论-绪论-对生命认识的唯物观》

脊柱是肾精上通于脑的通道，是脊髓所在之处。脊髓的作用中医中没有特别明确说明。中医只谈到髓不足的话，可造成肢体筋脉弛缓，痿弱无力，失于自行活动及行走的能力。这和脊髓相关病变的表现是一致的。

髓为肾精所化生，藏于骨腔及脊柱中，脊髓上通于脑，为髓汇聚之处，所以《灵枢·海论》称脑为髓之海。如果肾精亏虚，髓海不足，就会出现头旋耳鸣，腿酸眩晕，视物不清，周身懈怠无力、常欲安卧等症。

《黄帝内经讲解-藏象学说-（二十一）脉、髓、筋、血、气与目、脑、节、心、肺的所属关系》

结合现代医学对神经的研究，我们可以做一些合理的推断：

髓对于神经有滋养作用。中医中对神经没有介绍，但是对于精、髓与运动思维能力的关系有比较详细的介绍。

所以推断，髓与神经的关系就像前面介绍气与血的关系一样，神经固然重要，但是其主导根源在于髓，由髓来滋养。两者如根与叶的关系，所以中医更重视精髓的调理。髓足则神经更健康，人的思维、活动能力更强。其关系如下：

肾精→脑髓、脊髓→{脑神经、脊柱神经}→思维能力、行动能力

牙齿是观察髓的充盈状态的一个指标，因为齿为骨之余，而骨由髓来营养。所以，牙齿洁白坚固代表骨质好、髓充盈。如果牙齿黄黑、松动，在排除牙龈炎、吸烟等问题后，可以代表髓的不足。

肾精的几大作用中，应特别注意生殖功能与生髓功能的关系。如果长期纵欲，过度使用精的生殖功能，就会打破肾精的补充与消耗之间的平衡，造成肾精数量减少，生髓能力下降，导致骨髓、脊髓、脑髓的不足，使人的健康水平快速下降，变得衰老。这就是《素问·上古天真论》中提到的“以欲竭其精，以耗散其真，不知持满……故半百而衰也”的道理。

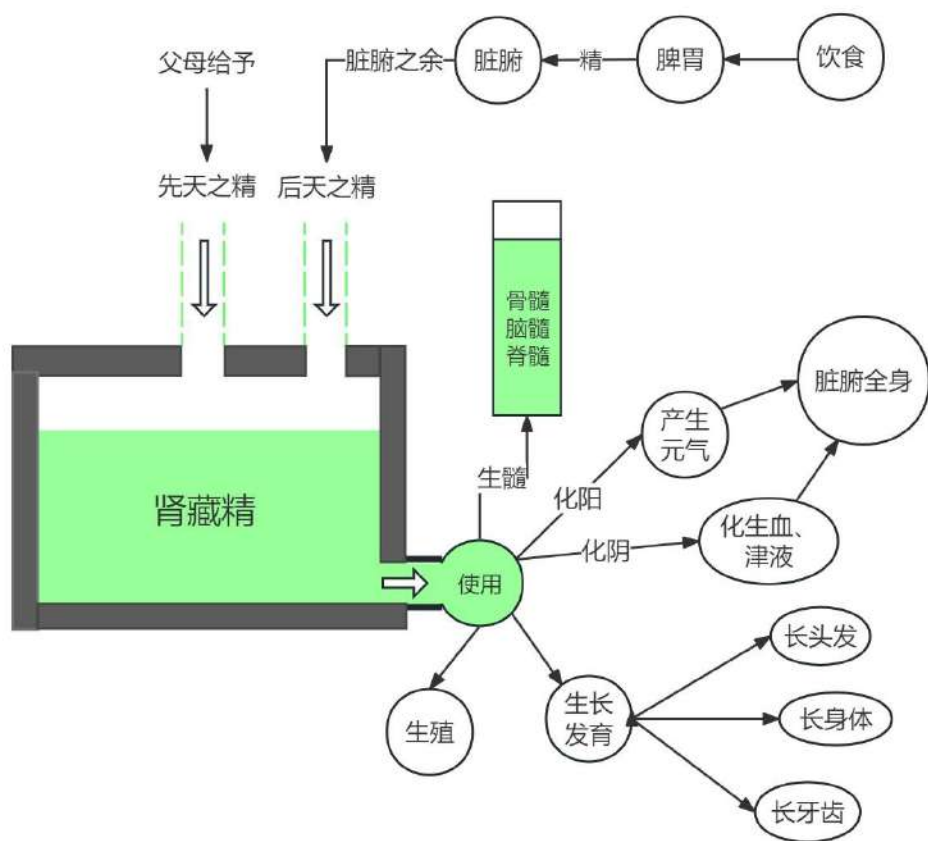
是以圣人陈阴阳，筋脉和同，骨髓坚固，气血皆从。如是则内外调和，邪不能害，耳目聪明，气立如故。

《素问-生气通天论》

5、肾精出入图

下图表示了肾精的出入情况，用来做本章的总结。

肾藏精进出图



3.6、神

1、简介

教材对神的定义分广义和狭义。广义的神，是指整个人体生命活动的外在表现，是对人体生命活动现象的总称。狭义的神，是指人的精神、意识、思维活动。

在中医学中，神有广义，狭义之分。广义的神，是指整个人体生命活动的外在表现，是对人体生命活动现象的总称。...狭义的神，是指人的精神、意识、思维活动。

《中医学概论-心、小肠》

这个定义比较难理解。如果把神定义为一种表现、现象，那其主体是什么？可能是因为在八十年代，教材必须以唯物主义的形式进行表述，所以其对神的介绍非常简略。

从功能看，神应该是身体的管理者，对内能管理元气、气、血、津液等要素的平衡，对外则通过感受、思考与反应来正确应对各种外在境遇。

因教材中对神的介绍比较简略，所以本章会参考一些道家经典《云笈七签》的内容。

2、生成

人的气血已通、五脏发育完成，神就自然生成，安住于心中。所谓“神气舍心、魂魄毕具，乃成为人”。

何者为神？岐伯曰，血气已和，营卫已通，五藏已成、神气舍心，魂魄毕具，乃成为人。

《黄帝内经讲解-神的产生及其物质基础》

3、功能

神的功能是对人体进行管理，所以神的作用遍布全身，有需要平衡的地方，就有神的作用存在。

其功能又可进行细分，主要的两个方面为高级管理功能和低级管理功能。高级管理功能指的是意识、思想方面。低级管理功能指的是生理功能方面。

3.1、高级功能

人的意识思想属于高级功能。内经对人的意识思维过程有较详细的描述，就是人通过感官对外界刺激产生印象，此为意；存储印象变成记忆，此为志；对记忆进行分析、比较，此为思；在思的基础上，预估未来的变化，此为虑；经过思虑后，能够支配行为对事物做出恰当的反应，此为智；

意、志，属于感性，是感官接受到外界刺激后自动产生的连锁反应，不需要思考；思、虑，属于理性，是人在意、志基础上主动进行的思维分析；智则是根据思、虑的结果做出恰当的行为反应。意、志、思、虑、智等五种形式，使人的认识能够由现象深入到本质，由低级进入高级。说某人智力高，就代表了该人具备感官灵敏，记忆力强，能准确判断事物的真实状态，预估其正确发展方向，并做出合适反应的能力。

理解了智力的原理，对于智力方面的疾病就有治疗方向。像反应迟钝、记忆力差、思考能力差、行为异常等智力问题，需要考虑是否为神的功能异常所导致。

3.2、低级功能

神的低级功能是指本能活动和低级反应，主要是调节人体气血等要素的产生、传递和使用，其特点是可以通过本能运行，不需要人的主观思维控制。比如人摄入饮食后，会自主进行消化吸收。吸收后的精、津液会自主送到其它器官进行处理，会自主生成血液、元气。人体的废水会自动汇聚到膀胱。人能自我调节体温，以维持相对恒定的温

度。感到寒冷的时候，会自主关闭毛孔。感到热的时候，会自主出汗等等。此外，还有直觉、自主呼吸、代谢、排毒等能力。

这种低级功能强大的话，神对体内环境的控制能力强，可以高效的调节元气、精、气、血、津液的产生、传递、使用，则人营造内环境平衡的能力、未病时的抵御能力、已病时的康复能力，都很强大。

3.3、小结

以上的高级功能和低级功能是神的一体两面。高级功能侧重于与外界的交互，低级功能侧重于对内在气血等要素的管理调控。

因两种功能关系紧密，所以大多情况下，可以通过观察人高级功能是否正常，来判断其低级功能的状态。若人耳聪目明、记忆力强、思路清晰、判断准确、反应迅速，说明其神的高级功能强大，通常其低级功能也比较正常。如果人视听反应迟钝、记忆力差、言语逻辑不清、做事颠三倒四、难与人正常交流，说明神的高级功能异常，其低级功能往往也有问题。

4、神的平衡点与波动

神以心的安静为平衡点，以心情变化为阴阳波动。适度的情绪变化为正常。过度的情绪变化为异常。

这是因为人体的阴阳气血应充足且均衡的分配于全身内外上下。当心情平静时，神可以均衡的调配气血。当情绪变化时，气血会随着情绪而动，其分配就发生偏颇。情绪变化有不同形式。中医有时称“七情”，即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊；有时称“五志”，即怒、喜、思、悲、恐。两者合称“情志”。不同的情志会使气血或偏上、或偏下，或偏内、或偏外、或偏于某个脏腑。如果气血长期、过度的偏颇，会造成此处过多而实，彼处过少而虚，进而形成各类虚实病证。

自然界很难总是保持晴天，必然有云雨雷电霜雪等气候变化。人也一样，很难总是保持心情安静，必然会有情志变化。适度的情志变化是

正常的，并不产生过大影响。过度的情志变化会使神的功能失常，称为伤神。

岐伯曰：有喜有怒，有忧有丧，有泽有燥，此象之常也，必谨察之。

《素问-气交变大论》

伤神在高级功能的表现为意识思虑等智力方面的问题；在低级功能则表现为内部气血平衡的失控，进而伤害到身体。内经说悲哀过度，会使内脏精气衰竭而丧失生命；喜乐过度，会造成精神涣散，神不能内守，失去自主能力；忧愁过度，则气机闭塞而不通，引起胸中闷乱，四肢不能举动；盛怒，会造成精神迷乱，难以自制；恐惧太过，使神志荡散而不能收持。失神不能控制精气血津液，可导致体液失去约束而流出体外，包括流泪、流涎、小便失禁、滑精等等。所以过度的情志是病因的一种，称为“内因七情”，主要内伤五脏，。

是故怵惕思虑者则伤神，神伤则恐惧，流淫而不止；因悲哀动中者，竭绝而失生；喜乐者，神惮散而不藏；愁忧者，气闭塞而不行；盛怒者，迷惑而不治；恐惧者，神荡惮而不收。

《灵枢-本神》

余知百病生于气也，怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。

《素问·举痛论》

忧思伤心；重寒伤肺；忿怒伤肝；醉以入房，汗出当风伤脾；用力过度，若入房，汗出浴，则伤肾。

《灵枢-百病始生》

喜怒不节则伤藏，藏伤则病起于阴也

《灵枢-百病始生》

5、位置

神在人体中的位置以五脏为主，五脏中又以心为主，具体为：心藏神，肝藏魂，肺藏魄，脾藏意，肾藏志。

五脏有七神，各何所藏那？

然：脏者，人之神气所舍藏也。故肝藏魂，肺藏魄，心藏神，脾藏意与智，肾藏精与志也。

《难经-三十四难》

心者，五脏六腑之大主也

《灵枢-邪客》

5.1、心神

心中之神是人所有神的主宰。内经讲“任物者谓之心”，是说心接受外界事物的刺激，进行思考分析，并做出反应。

心神统御其它脏器的精神活动，其它脏器的精神活动都在心的统帅下完成。

心神受损，会出现多种精神类疾病症状，比如怔忡、烦躁、胡言乱语、啼笑无常等情况。

心藏神，为君火，……本病，诸热瞀瘈、惊惑、谵语、烦乱、啼笑、詈骂、怔忡、健忘、自汗诸痛痒疮。

《肝脏虚实标本用药式》

把人体比作一个国家的话，心神就是君主，其它脏腑为大臣。心神问题严重的话，会导致其它脏腑皆出问题，使气血通道闭塞不通，进而使形体也大受损伤。

主不明则十二官危，使道闭塞而不通，形乃大伤，以此养生则殃。...

比拟一个国家而言，领导英明，各部门配合得好，国家就一定强盛。反之，如心脏功能不足，则人体脏腑之间相互协调的关系

便会破坏，各脏腑都要受到危害，气血通行的道路也会闭塞不通，使形体遭受很大的损伤，就会影响人的健康和寿命。譬之国家，则必使天下大乱，政权不稳，这是必须引起深刻注意的。

《黄帝内经讲解-藏象-十二脏的生理功能及其相互关系》

心包

心包络是心的宫墙，保护心脏。有外邪侵犯的时候，先由包络代受。

同时心包络还是心传达喜乐情志的使者。

病邪到达心包的时候，已经就比较严重了，神志会出现问题。如果透过心包到达心，则非常危险，接近死亡。

《灵枢-邪客》说，“心者，五脏六腑之大主也，邪弗能容也，容之则心伤，心伤则神去，神去则死矣。故诸邪之在于心者，皆在于心之包络”。

“膻中”，这里指心包络。如《灵枢·胀论》说：“膻中者，心主之宫城也”。他处有指气海的。“臣使”，表达君主命令、意志的官员。此指膻中有保护心脏，代心行令的功能。外邪侵犯心脏，心包络代心受邪，所以具有保护心脏的作用。《灵枢·邪客》说，“心者，五脏六腑之大主也，邪弗能容也，容之则心伤，心伤则神去，神去则死矣。故诸邪之在于心者，皆在于心之包络”。

心包代心受邪，故外邪侵犯心脏，常是心包先受影响，如叶天士所说：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包。”心志喜，膻中为臣使之官，代心行令，所以能传达心脏的喜乐情志，心的喜乐情志由它发出。

《黄帝内经讲解-十二脏的生理功能及其相互关系》

5.2、肝魂

肝中所藏之神为魂。魂辅佐心神进行思维认识活动。如魂失去神的支配而单独活动，就会出现幻觉、梦语、梦游等情况。

魂是在神支配下的思维意识活动，由肝所主，如肝不藏血，魂不守舍，就会产生梦游、梦语及幻觉，应从肝论治。《灵枢·本神》说：“肝悲哀动中则伤魂，魂伤则狂妄不精，不精则不正。”肝藏魂，悲哀太过则伤魂，魂主意识思维，故使人狂妄迷乱而不精明，言行失常。治宜补养肝血以安魂。但临床所见魂伤之证，大多病久，不是单纯补益肝血所能速愈，如《医宗必读》记载一例，峻补精血而愈，“一儒者，久困场屋吐衄盈盆，𦓐（wang）羸骨立，梦斗争恐怖，遇劳即发，补心安神，投之莫如。一读《素问》，乃知肝藏魂，肝藏血。作文苦衄血多，则魂失养，故交睫即魇。非峻不可？而草木力薄，以酒溶鹿角胶，空腹饮之，五日而安卧，一月而神宁、鹿角峻补精血，血旺神自安”。

《黄帝内经讲解-神的产生及其物质基础》

魂传统上称“三魂”。关于三魂，《云笈七签》中提到三魂为：第一魂胎光，第二魂爽灵，第三魂幽精。

三魂的功能，主要体现在人的高级功能方面，比如思维、情感、智慧等，特点是由人的主观思维进行主导。

夫三魂者。

第一魂胎光，属之于天，常欲得人清静，欲与生人，延益寿算，绝秽乱之想，久居人身中，则生道备矣；

第二魂爽灵，属之于五行，常欲人机谋万物，摇役百神，多生祸福灾衰刑害之事；

第三魂幽精，属之于地，常欲人好色、嗜欲、秽乱昏暗、耽著睡眠。

爽灵欲人生机，生机则心劳，心劳则役百神，役百神则气散，气散则太清一气不居，人将丧矣；

幽精欲人合杂，合杂则厚于色欲，厚于色欲则精华竭，精华竭则名生黑簿鬼录，罪著，死将至矣。

《云笈七签》

肝主谋虑。这与肝气的升发作用以及肝藏血的功能有关。当人们深谋远虑，筹划策略，进行紧张思维活动的时候，需要肝气的升发和肝血的供给。

因肝、胆互为表里，这里再介绍一下胆在神方面的作用。胆主决断。有的人性格为擅长谋略，而不擅于做决定，甚至多疑、易惊恐，可能是胆气不足。

胆者，中正之官，决断出焉。

《素问-灵兰秘典论》

前面在气的章节谈到肝主疏泄，管理气，使其以升降沉浮的形式在全身进行合理的分配。如果肝疏泄功能出问题，则气的运转不正常，进而对精神也有影响。肝气郁结，可出现郁郁不乐，闷闷欲哭的症状。若肝气上逆，则出现急躁易怒，失眠多梦的症状。

5.3、肺魄

肺中所藏之神为魄。魄辅助心神管理本能活动与低级反应，即前述神的低级功能。魄与构成形体的精同时形成。

肺藏魄失常的病证，可见感觉失常，产生幻觉，错觉，动作失常，可见手足妄动。如《灵枢·本神》说：“肺喜乐无极则伤魄，魄伤则狂，狂者意不存人，皮革焦。”临床治疗，应以益气补肺为主，《名医类案》曾载一例说：“一个忽觉自形两，并卧，不别真假，不语，问乃无对，乃离魄、用朱砂、人参、茯苓浓煎服，真者气爽，假者即化。”本案为魄伤后产生幻觉、错觉，故以参、苓益气补肺为主，朱砂重镇虚怯为佐。

《黄帝内经讲解-神的产生及其物质基础》

魄传统上称“七魄”。《云笈七签》中提到七魄为：第一魄尸狗，第二魄伏矢，第三魄雀阴，第四魄吞贼，第五魄非毒，第六魄除秽，第七魄臭肺。

其第一魄名尸狗，其第二魄名伏矢，其第三魄名雀阴，其第四魄名吞贼，其第五魄名非毒，其第六魄名除秽，其第七魄名臭肺。

《云笈七签》

5.4、脾意

脾中所藏之神为意，主管对事物表象的认识。内经说“心有所忆谓之意”。

5.5、肾志

肾中所藏之神为志，负责将意保存下来，即对事物表象认识的积累。内经称之为“意之所存谓之志”。

5.6、神与脑的关系

现代医学认为人的思维意识是脑的作用。中医也认为脑为元神之府和髓之海，对精神活动很重要，但中医还认为脑的资源由脏腑提供，因此脏腑功能强健，脑的功能才能正常。每个脏腑对脑的对应功能有支持作用，如果某个脏腑功能衰弱，则对应脑的功能也下降。以肾藏志为例，志代表人的记忆力。肾的功能下降一段时间后，脑对应记忆的功能也会随之下降。其它脏腑也是如此。

5.7、小节

人的情志活动与五脏有着密切的关系，如肝“在志为怒”，心“在志为喜”，脾“在志为思”，肺“在志为忧”，肾“在志为恐”。

因心神为主宰，喜怒忧思等情感过度的话首先伤心，其次才伤及对应脏器。比如怒先伤心再伤肝、思先伤心再伤脾等。

人的精神意识思维活动，虽分属五脏，与五脏的心理功能有密切的联系。但又由心产生，由心主宰，因此七情所伤，总由心先受之，而后影响他脏。如心神思虑过度则伤脾、心神忧伤太过则伤肺，所以从心主神明，直接影响着五脏六腑生理功能协调平衡这一点而言，心是藏神的处所，又是五脏六腑的主宰。正如张景岳所说：“心为脏腑之主，而总统魂魄，并赅意志，故忧动于心则肺应，思动于心则脾应，怒动于心则肝应，恐动于心则肾应，此所以五志唯心所使也。”

《中医学概论-心、小肠》

上面谈到的脾意和肾志，对控制情绪有重要作用。同样受到外在不良刺激，“意志”强大之人，更能控制自己的情绪与行为，不至失态；而“意志”薄弱之人，则很容易因外界刺激而产生情绪的波动变化。

精神不进，志意不治，故病不可愈

《素问-汤液醪醴论》

6、影响神的因素

6.1、身体内环境的影响

神位于身体之内。当气血调和，内环境平衡的时候，神就可以安稳的居住。当人体的内环境失衡的时候，神就会受到影响。

血脉和利，精神乃居。故神者，水谷之精气也。

《灵枢-平人绝谷》

比如心偏热的时候，会有心烦的表现。在《伤寒论》中，出现“烦”的症状，多与心脏受直接或间接因素影响，失衡偏热，导致心神不安有关。

“烦”有热与心烦双重含义，即因热以致烦。心中懊恼(ào nǎo奥恼)，是心中烦乱特甚，无可奈何之状。“虚烦”是和实烦相对而

言，邪热与痰水、肠胃糟粕、宿食、湿浊等有形之邪相结，皆可致心烦，甚则心中懊憹，以其邪之有形，故称“实”。

《伤寒论讲解-76条》

肝气郁结的时候，会有精神抑郁，情绪不宁。

金匱中有妇人五脏阴不足，使燥热偏多，表现为悲伤欲哭的情况。

妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸，甘麦大枣汤主之。...

血枯津竭，脏阴不足，燥热乘之，致神志不清，而证见悲伤欲哭，哭笑无常，象如神灵所作

《金匱要略讲解》

人体下腹部有热邪与瘀血结合的情况，人会有发狂的表现。

太阳病，六七日表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当鞕满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也，抵当汤主之。[124]...

太阳病，身黄、脉沉结、少腹鞕、小便不利者，为无血也；小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵当汤主之。[125]

《伤寒论讲解》

人体环境失衡，引起情绪、神智变化的情况非常多，这里就不一一列举。如果有人某段时间性情发生较大改变，比如由性格温和变成烦躁易怒，需要考虑身体内环境是否出现了问题。

6.2、外界刺激的影响

外界刺激通过感官进入体内，使心神波动，产生七情。心为神主、关心则乱。外界刺激对神产生怎样的影响，主要在心。

悲哀愁忧则心动，心动则五藏六府皆摇。

内经谈到，人们过于关心的事物大多体现在嗜好与欲望上。人对自己的嗜好与欲望要有节制，适可而止。如果过度追求，即为内经所说“嗜欲无穷”，必然会患得患失（忧患不止），导致体内气机逆乱、精津血流失（精气驰坏，营泣卫除），最终神伤不能调控气血，患病而不愈（神去之而病不愈也），此时即使用药也效果不大。

嗜欲无穷，而忧患不止，精气驰坏，营泣卫除，故神去之而病不愈也。”

《素问-汤液醪醴论》

养神的方法，内经也有论述。从正面讲，应该“志闲而少欲，心安而不惧”，“恬惔虚无、精神内守”，“高下不相慕”。从负面讲，不要“嗜欲无穷、忧患不止”，不要“醉以入房，以欲竭其精”，不要“不时御神，务快其心”。

通俗说法，就是不要胡思乱想，不要总是忧虑、恐惧，不要过度追求名利地位，不要纵欲，这些都会动摇心神，损耗精气。应该顺其自然，保持天真的本性，多听圣贤教诲，提升道德修养，即“德全不危”。

故美其食，任其服，乐其俗，高下不相慕，其民故曰朴。

是以嗜欲不能劳其目，淫邪不能惑其心，愚智贤不肖，不惧于物，故合于道...

其次有圣人者，处天地之和，从八风之理，适嗜欲于世俗之间，无恚嗔之心，行不欲离于世，被服章，举不欲观于俗，外不劳形于事，内无思想之患，以恬愉为务，以自得为功，形体不敝，精神不散，亦可以百数。

《素问-上古天真论》

6.3、小节

以上分别是从内外两个方面谈了影响神的因素。无论是内在身体环境失衡，还是外在的感官刺激，都可能导致神出现异常。当神出现异常的时候，轻则失眠、多梦、烦躁不安，重则抑郁、癫狂、健忘、神昏。治疗这类疾病应从形、神两方面着手。一方面是心理疏导，安抚其思维情绪；另一方面则是调理气血失衡之处，健壮脏腑形体。这是中医“形神合一”理论的原理。

中医学形神合一理论，在认为形体对精神起决定作用的同时，强调精神意识也对形体的健康发生着重要的影响。所以志意调和，不但能使思想集中，精神专一，魂魄不致散漫无常，懊悔愤怒等异常情绪也无从产生。而且还使五脏的功能，不至因为精神情志的变化，而引起气运失常，从而使五脏功能正常，正气健旺，不会受邪气的干扰而生病。

《黄帝内经讲解-血气精神的重要作用》

7、神与其它要素的关系

精、神、阴、阳、气、血共同维持人体内部环境，分工各有不同。阴（物质）与阳（能量）平衡可以产生足够的气血，进而形成健康体内环境。精是阴阳的来源储备。神是这些过程的管理者。

其中，神的管理调节能力至关重要。神统御其它要素，建立适宜的体内环境，排除干扰平衡的邪气。没有神的管理，其它要素就是死物，不能互相配合形成适宜环境，更不能对失衡情况做出自动的调节。

神与阴、阳、气、血等要素共荣互损。从共荣角度看，神足可以合理的调配气血；气血足则可以养神。从互损角度看，如果神先异常，则逆乱损耗气血；而气血先失衡，则神无所养，可导致神的异常。

精与神的关系参考前面暖气的例子，其中控制器就是神，是管理者；液化气就是精，是能源储备；两者之间，如果控制器正常而能源不足，在需要调大火苗的时候，就无足够的能源来转化。如果能源充足，而控制器失常，则不能在恰当的时候增强或减弱火苗的大小，此时能源再多也起不到调节平衡的作用。精与神的关系就如这里的能源

与控制器的关系。两者各司其职，缺一不可。前述精为一身阴阳气血之本，需要开源节流以保养。而节流的诸多方面中，最重要就在于神。人的心神平静，则精的消耗就比较平稳、缓慢。神思一动，精的消耗就加速。欲念过重，精就流失。

各要素相比较，神的重要性毋庸置疑，但是也要与其它的要素共同配合才能形成适宜的身体内环境。

第四章 人体运行框架

1、运行框架

通过第三章的学习，我们应该建立起一个人体运行的基本框架。

1.1、功能与形体

人体的主要功能是行动、思维、感受、表达及抵御外邪。功能正常需要头、四肢、身躯的皮、肉、脉、筋、骨等形体组织能正常工作，因此形体为功能之本。

1.2、形体与气血

形体组织能正常工作需要其处在一个适宜的人体内部环境中。适宜的人体内部环境由气血等要素维持，因此气血为形体之本。

形与气相任则寿，不相任则夭。皮与肉相果则寿，不相果则夭。血气经络胜形则寿，不胜形则夭。...

气血等基本物质，经络等脏腑组织的功能，是人体的根本，而人体的躯壳好象树木的枝叶。如果气血的强盛胜过形骸，是人体生命力旺盛的表现，就长寿。反之，如果不能胜过形骸，就夭亡。

《黄帝内经讲解-寿夭与先后天的关系》

形体与气血应匹配。形体大而气血过少，或者形体小而气血过多皆为失衡。

形盛脉细，少气不足以息者危。形瘦脉大，胸中多气者死。形气相得者生。

《素问-三部九候论》

在平衡范围内，如果气血供应量适度超过形体的正常需求，则人精力旺盛、活泼好动。如果气血低于形体的需求，则人气力不足、身体沉重。

因此，人一旦出现肢体沉重的现象，就要注意补充气血、疏通经络。否则形体组织就开始弱化，容易先在眼、耳、口、鼻等关键且脆弱的孔窍部位出现病变。

四肢才觉重滞，即导引、吐纳、针灸、膏摩，勿令九窍闭塞；

《金匱要略讲解-脏腑经络先后病脉证第一》

形体组织的变化一般延后于气血变化。气血失衡持续一段时间后，形体组织上会有可见的病态改变。气血恢复平衡后，需要保持一段时间，病态的形体变化才可能恢复正常。这与温室花园里的环境失衡后，花草会逐渐枯萎；环境恢复平衡后，花草需要一段时间才能长好，是一个道理。

全身各处获得的气血应充足且均匀，同时在均匀的基础上，上、下、内、外有一定差别。这种差别即为气血分配角度的阴阳。这与自然界的水、土、气、阳光等资源应均匀分配，但是又随着方位的差异而有所不同一样。

1.3、气血与脏腑经络

气血等要素由脏腑产生，由经络系统主导输送。脏腑功能强健，则可以产生足够气血。脏腑功能虚弱，则气血不足。因此脏腑为气血之本。

气血的产生过程中，五脏的作用最大，比如五脏藏神、心主血脉、脾主消化吸收、肾藏精、肝藏血、肺主气等等，所以五脏功能最为关键。若五脏失衡，对人体要素的产生、体内环境的形成影响最大。病至五脏就非常严重，所以内经说“治五藏者半死半生”。

帝曰：人有精气、津液、四肢、九窍、五脏十六部，三百六十五节，乃生百病，百病之生，皆有虚实。今夫子乃言有余有五，不足亦有五，何以生之乎？

岐伯曰：皆生于五脏也。夫心藏神，肺藏气，肝藏血，脾藏肉，肾藏志，而此成形。志意通，内连骨髓而成身形五脏。五脏之道，皆出于经隧，以行血气。血气不和，百病乃变化而生，是故守经隧焉。

《素问-调经论》

邪风之至，疾如风雨，故善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治筋脉，其次治六府，其次治五藏，治五藏者，半死半生也。

《素问-阴阳应象大论》

五脏之中，心肺为上焦。因心主血脉，肺主呼吸，两者共同产生宗气，推动营卫气血流转于全身。其所需的能量物质大多来自中下焦的肝、脾、肾。所以五脏以此角度细分的话，中下焦的肝脾肾为上焦心肺之本，而上焦心肺为形体气血之本。

上部无脉，下部有脉，虽困无能为害。所以然者，人之有尺，譬如树之有根，枝叶虽枯槁，根本将自生。脉有根本，人有元气，故知不死。

《难经-十四难》

曰：五脏俱等，而心肺独在鬲上者，何也？

然：心者血，肺者气。血为荣，气为卫，相随上下，谓之荣卫。通行经络，营周于外，故令心肺独在鬲上也。

《难经-三十二难》

脏腑相比较，脏为主，腑为辅。脏在内，主吸收存储后天之精并转化阴阳气血供给全身。腑与外部相通，既是饮食地气入脏的通道，也是脏的代谢废物和邪气的排出通道。

两者从正邪角度看，脏给腑提供正气，腑帮助脏排出邪气。正气方面，脏将精转化为阴阳气血提供给腑，若脏器正气虚，不能传正气于腑，则腑也会跟随虚弱。邪气方面，脏在内，难以直接排邪，其产生的废物、邪气应传输到腑，再由腑排出体外。如果腑不通，会导致脏之邪也排不出去，进而引起脏器邪实的病证。

由于脏与腑的这种独特关系，所以脏病虚证较多，因为若其正气不虚而只有邪气实，通常会自动将邪气排出到腑。五脏若出现邪气多的实证，

往往有以下几种原因：1、脏气过虚，无力排邪到腑；2、脏产生的邪气太多，超过腑排邪的能力；3、腑器堵塞，无法为脏排邪；

而腑病实证较多，因为如果其正气虚，则脏会为其补充。六腑出现虚证，原因多为：1、脏气不足，不能为腑补充足够正气；2、腑消耗的正气太多，超过了脏为其补充的量。

治法上，五脏常补，六腑常泻。中医概括为“五脏以补为先，六腑以通为用”。对五脏进行补虚泻实的时候，如果六腑通畅，可以直接补泻。如果六腑不通畅，则需兼顾通腑，否则五脏的补泻皆难以奏效。这是脏腑表里关系的重要体现。

太阳与少阴为表里，若少阴阳气充实，则太阳阳气不虚，卫外有力，寒邪不能内传

《伤寒论讲解-283条》

由于五脏以藏为主，治疗上常以补为先；六腑以通为用，治疗多以泻为主。

《中医学概论-五脏六腑》

夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱，此五者天气之所生也，其气象天，故泻而不藏。此受五藏浊气，名曰传化之府，此不能久留，输泻者也。

《素问-五藏别论篇第十一》

经络、血脉、三焦作为要素传递通道，需畅通无阻，使要素能充足、均匀的分配于全身。各通道中，以经络通畅为主导。

1.4、脏腑与精

脏腑功能的强健，需要脏腑的阴阳平衡，即能量与物质充足且配合协调。脏腑阴阳来自脏腑所藏之精，精可以补阴阳，精足则脏腑不易失衡。精不足则脏腑功能虚弱。精亡则脏腑失去功能。因此脏腑所藏之精为脏腑之本。

各脏腑精足才能藏精于肾，因此肾精为各脏腑精气的代表。又肾主生殖，生殖能力强则代表肾精充足，进而代表各脏腑精气充足。因此内经以能否有子作为身体健康的重要标志。

肾者主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛，乃能泻。

今五脏皆衰，筋骨解堕，天癸尽矣，故发鬓白，身体重，行步不正，而无子耳。

帝曰：有其年已老，而有子者，何也？

岐伯曰：此其天寿过度，气脉常通，而肾气有余也。此虽有子，男子不过尽八八，女子不过尽七七，而天地之精气皆竭矣。

帝曰：夫道者年皆百岁，能有子乎？

岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年虽寿，能生子也。

《素问-上古天真论》

1.5、精与先后天之本

脏腑所藏之精分别来自先天与后天。后天之精主要来自脾胃，人无胃气则亡。先天之精主要存于肾与髓，若耗尽，人亦亡。因此脾胃被称为后天之本，肾被称为先天之本。

脾脉者土也，孤藏以灌四傍者也。

《素问-玉机真藏论》

胃者，五藏六腑之海也，水谷皆入于胃，五藏六腑皆禀气于胃。五味各走其所喜，谷味酸，先走肝；谷味苦，先走心；谷味甘，先走脾；谷味辛，先走肺；谷味咸，先走肾。

《灵枢-五味》

人体的形、气血与脏腑所藏的后天之精皆来自对自然界天气、地气的吸收，所以呼吸与饮食都很重要。

天食人以五气，地食人以五味。五气入鼻，藏于心肺，上使五色修明，音声能彰。五味入口，藏于肠胃，味有所藏，以养五气，气和而生，津液相成，神乃自生。

《素问-六节藏象论》

普通人都知道饮食、呼吸重要，但是难以意识到脾胃吸收能力的区别，所以中医重点提示这一点。

地之五味由口摄入，贮藏于肠胃，经过脾胃的消化转输，水谷精微得以充养五脏之气。故在一般情况下，食欲旺的人，五脏精气相应充足；食欲差的人，五脏精气相应衰少。《灵枢·五味》说：“谷不入，半日则气衰，一日则气少”。说明五脏之气的盛衰，与摄取饮食的多少有密切的关系。

《黄帝内经讲解-人类生存的自然条件》

人一日三餐，饮食留于肠胃。胃空虚的时候，水谷在肠。肠空虚的时候，又有水谷补充到胃。肠与胃交替保存着水谷，保证人一直有地气可以吸收。若肠胃都空虚，人无地气补充，就快要死亡了。由此可见，人体吸收后天之精，补充五脏精、气、津、血，是持续性的，不能中断。

肠胃之长，凡五丈八尺四寸，受水谷九斗二升一合合之大半，此肠胃所受水谷之数也。平人则不然，胃满则肠虚，肠满则胃虚，更虚更满，故气得上下，五脏安定，血脉和利，精神乃居，故神者，水谷之精气也。故肠胃之中，当留谷二斗，水一斗五升；故平人日再后，后二升半，一日中五升，七日五七三斗五升，而留水谷尽矣；故平人不食饮七日而死者，水谷精气津液皆尽故也。

《灵枢-平人绝谷第三十二》

肠胃主要功能是消化、存储水谷，而水谷精华的吸收过程是由脾来完成的，在肠胃补充水谷充足的情况下，脾的吸收能力就成为关键因素。现代社会疾病，因脾功能弱，对水谷的吸收不充分，造成五脏精气不足，进而造成的疾病的情况非常普遍。

1.6、神与其它

神总管以上全部过程，无论是高级的意识思维还是低级的人体本能，所有平衡过程都由神来控制。若神的控制能力强，则即便精、气、血、形的数量稍少，也能配合的很好。反之，如果神的控制能力弱，则即便其它要素较多，也可能出现分配不合理的情况。

1.7、小结

人体以五脏为中心，吸收天地之气，生成并存储精、神、元气、气态物质、液态物质（血、津液）等要素，再以经络系统为主导，将要素传递到全身组织器官，形成适宜的体内环境，完成人体的整体功能活动。这个过程如果换成现代语言描述，就是指用能源、能量、控制信号、物资等要素动态构建一个生态环境。这些构建活动从人出生开始，一直运转不息，直到死亡结束。其间，任何一个环节出问题，都会形成疾病。关键环节出问题，就会死亡。

这个人体生态环境的构建是动态的，其维持过程包含很多因果（标本）关系。上述功能、形体、气血、脏腑经络、精、神是其中比较主要的部分，相互之间皆如树干与树根的关系。根为干之本，树根有问题必然影响树干，而树干的问题则即可能来自树干本身也可能来自树根。形体的组织的损伤可能是其本身受到外力冲击造成，也可能是气血未能对其进行濡养造成。气血的问题可能是其本身问题，比如气受寒、血中毒等原因造成，也可能是脏腑经络失衡未能正常产生和传输气血造成。脏腑的失衡可能是其本身问题也可能是精衰神乱造成。所以在治病时，并非哪里发病就治疗哪里，而要分析根源，以治本为主，除非紧急或特殊情况才以治标为先。明辨标本，急则治标，缓则治本。这就是中医的整体观。

阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，治病必求于本。

《素问-阴阳应象大论》

夫标本之道，要而博，小而大，可以言一而知百病之害。言标与本，易而勿损，察本与标，气可令调，明知胜复，为万民式，天之道毕矣。

《素问-至真要大论》

中医整体观是人体运行的大框架。框架中的每个部分都包含很多知识。在总体框架下学习，中医知识就有条理次序。不掌握整体观，中医知识会显得杂乱无章。

对于中医整体观，不同人群认知的深浅不同。普通人认知最浅，通常只在功能出问题，比如无法行动，昏迷，疼痛，不能视听，出现饮食、呼吸、排便困难等等情况时，才会意识到疾病的发生；而高一级的认知可发现形体组织、津液、血等地气层面的问题；再高级的认知可到天气与能量层面；再高级可到精、神层面，即能源与控制的问题。

2、指标失衡-证

2.1、证的概念

人体的脏腑经络、皮肉脉筋骨、头项胸腹肩背腰、四肢关节等全身各部位，都需要阴阳气血等要素来维持其环境平衡，也都有可能出现各自的失衡。比如肝可以有精的虚实、神的虚实、元气的虚实、天气的虚实、地气的虚实等等，肺、心、脾、肾也是如此，皮、肉、筋、骨也是如此。这类要素的失衡就是中医的证。

教材《概论》的辨证章节，只是列出了一些常见的情况，比如肝只列出了肝气郁结、肝火上炎、肝火亢、肝风内动、肝胆湿热、寒滞肝脉等几种情况，这些应只是肝失衡的常见情况，并非全部，其它部位也是类似。

证的基本类型如下表：

	精	神	元气	气	血	津液	形
正虚	精不足	神不足	阳虚	气虚	血虚	津液虚	肉槁、骨陷
邪实	精浊	七情太过	阳亢、郁热	六淫太过、气郁、气滞、气逆...	血瘀、血热、血寒...	痰饮	宿食、癭、瘤、积、聚（癥瘕）...

血、脉、营、气、精、神，此五藏之所藏也。

《灵枢-本神》

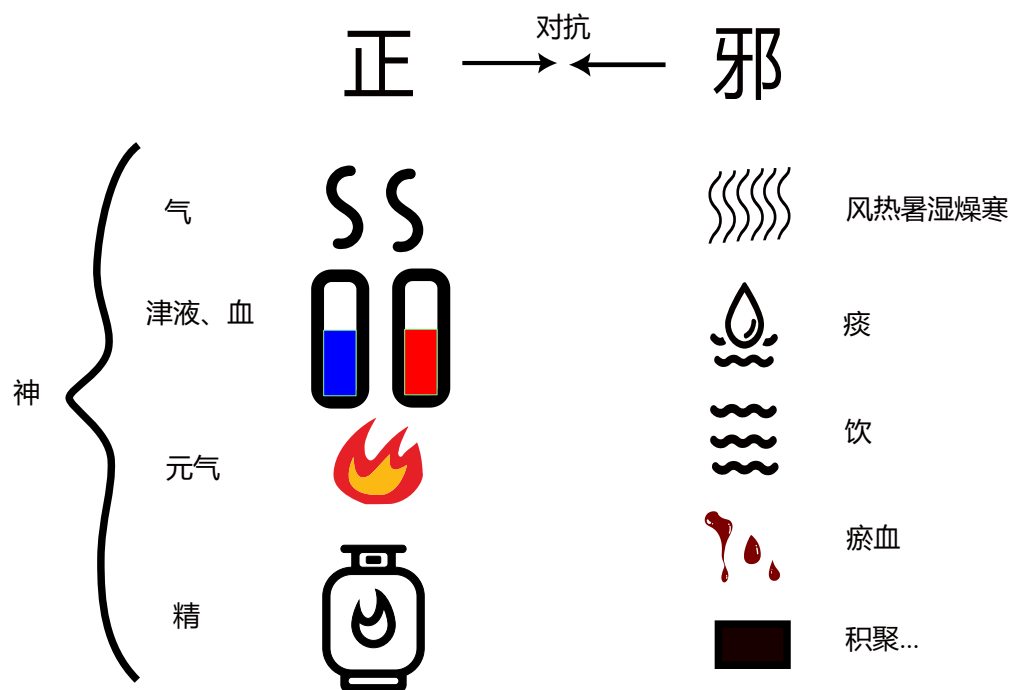
帝曰：人有精气、津液、四肢、九窍、五脏十六部，三百六十五节，乃生百病，百病之生，皆有虚实。

《素问-调经论》

癥瘕之病，即积聚之别名。

《景岳全书-妇人规》

下图表示人体某部位的常见的正虚邪实关系。



辨证论治就是要分辨出哪些部位分别有哪种失衡？程度如何？即辨别病位、病性和程度，进而进行对证治疗。

... 六经病证中，每经病皆有表里、寒热、虚实、阴阳之分证...

《伤寒论讲解-243条》

近代医家蒲辅周曾提出过：任何一脏皆有气血阴阳，肝脏也不例外...

《肝病证治概要（刘渡舟）-十章肝虚证治-五肝阳虚》

2.2、证的组合

从指标角度看，几大指标可以单个失衡也可以组合失衡。阳虚就是单指阳气这指标不足的失衡。痰热就是两个指标痰与热过量的失衡。比如伤寒论的小陷胸汤证，是胃脘（又叫心下）部位的痰热互结，属于在一个部位上有两个指标（痰、热）失衡。

从部位角度看，也可以有多个部位同时失衡。比如大青龙汤证，是内热外寒，属于内有热、外有寒两个部位的组合失衡。小青龙汤则是外寒内

饮，也是两个部位的失衡，分别是外有寒和内有饮。

小结胸病，属痰热互结，法当清热开结涤痰，用小陷胸汤治疗。本方由黄连、半夏、栝蒌实组成。黄连苦寒，苦降下，寒胜热，为清泄心下热结最得力的药物；半夏辛温滑利，开结气，化痰蠲饮；栝蒌实甘寒滑利，有润便化痰之功，配黄连以清热，协半夏以蠲饮。三药合用，痰热各自分消，则无结滞之患。

《伤寒论讲解-138条》

寒邪闭表而不能入里，阳气内郁而不能外泄，从而形成表寒内热之证。此时用麻黄汤则无清里之效，用白虎汤则证未见烦渴引饮，尤其是寒邪在表，则易冰伏其邪。故治用大青龙汤，峻汗以解表闭，清里以除烦躁，为表里两解之法。

《伤寒论讲解-38条》

小青龙汤主之：证为外寒内饮，故用小青龙汤外散风寒，内消水饮，以达到表里两治的目的。

《伤寒论讲解-40条》

人体有很多部位，每个部位又有多种性质的失衡。各种部位、证型进行组合是非常复杂的。

然临床上由于瘀血为病伴有其它因素，这就必须在“活血祛瘀法中佐以行气药”的基础上加以兼顾。其有寒者，兼以温经散寒；其有热者，兼以凉血清热；其有湿者，兼以行水利湿；其有燥者，兼以滋血润燥；其有风者，兼以祛风和肝；其有痰者，兼以燥湿化痰；其有气滞者，兼以理气；其有坚结者，兼以软坚；其有痞塞者，兼以泻痞；其有脾虚者，兼以建中；其有气虚者，兼以益气；其有血虚者，兼以养血。还有正气虚弱，不能运血，以致血液瘀滞，而为正虚瘀微者，则治又当专补正气，使正复而瘀自化

《金匱要略讲解-惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六-十一》

2.3、证与功能的关系

人体每个部位都有其特定的功能。当该部位出现环境失衡后，其功能就会出现异常。比如肌表部位功能包括护卫身体、出汗排邪等。当肌表要素失衡后，就可能出现怕冷，怕热，出汗异常，身体疼痛等问题。再如胃的功能是消化食物，其环境失衡后，可能出现呕吐、吃不下饭、喜冷饮或喜热饮等问题。可见不同部位的失衡会有其特殊表现，在以后的学习中要能仔细捕捉这类表现。比如大青龙汤证内热外寒的特异表现为“不汗出而烦躁”；小陷胸汤证为“心下部位按之痛，脉浮滑”。小青龙汤证则为“遇寒而咳，咳吐白痰、舌苔水滑、脉弦”等等。

辨桂枝证重在汗出；辨麻黄证重在无汗；辨大青龙证重在不汗出而烦躁，如此则临证方有所本。

《伤寒论讲解-38条》

小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。

《伤寒论讲解-138条》

小青龙汤……寒饮射肺之咳喘，多在寒冷季节发作，常咳吐大量白色泡沫样痰，且落盂成水，或咳嗽吐白色半透明胶粘之冷痰，宛似蛋清。寒饮郁遏阳气，若见面色青暗或黧黑，则谓之“水色”；寒饮阻滞营卫气血，若致面部出现块块色斑，则谓之“水斑”；水饮上泛，若致使面部庞浮或眼睑轻肿，则谓之“水气”。水气、水斑、水色，以及舌苔水滑、脉弦等，皆为辨寒饮内盛之依据。

《伤寒论讲解-40条》

2.4、阴证与阳证

不同部位的功能不同，所以重要程度也不同。同样的失衡，发生在重要部位就很严重，发生在不重要部位就影响不大。

人体以五脏最为重要。若五脏功能正常，则人体正气充足，抗邪有力。五脏失衡，则精、神受损，产生气、血、津液的一些关键环节受到破

坏，使人体产生正气的能力下降，无力抗邪。

若失衡部位只在形体或六腑，五脏正常，则有足够正气抵抗外邪，大多表现为正邪相争剧烈的整体实证，内经称之为“阳道实”。此时人体机能多呈现为亢奋状态，所以叫阳证。

若失衡部位在五脏，则正气不足，虽邪气较多却无力相抗，成为整体虚证，内经称之为“阴道虚”。此时身体机能多呈现为低沉状态，所以叫阴证。

阳证与阴证的核心划分标准就是正气的充足程度。阴证为根本受伤导致正气不足，无力抗邪，所以较阳证更严重。

岐伯曰：阳者天气也，主外；阴者地气也，主内。故阳道实，阴道虚。故犯贼风虚邪者阳受之，饮食不节，起居不时者，阴受之。阳受之则入六腑，阴受之则入五脏。入六腑则身热不时卧，上为喘呼；入五脏则瞋满闭塞，下为飧泄，久为肠澼。

《素问-太阴阳明论》

以国家为例，通俗的理解阴证、阳证。当发生战争时，阴证就是首都等重要城市受到攻击，非常危险。阳证就是国家边境受到攻击，未波及首都等重要城市。阳证转阴证就是敌人由边境进攻到首都。阴证转阳证就是反击将敌人由首都赶到边境。简单的说，就是阴证近死，阳证近生。

《中医学概论》的辨证章节，有阴阳、表里、寒热、虚实的八纲辨证之说；内经讲“善诊者，察色按脉，先别阴阳”。这些地方提到的阴阳就是指阴证、阳证。即人体生病时，总体上是处于五脏健康、气血充足、抗邪有力、拒邪于表或腑的状态，还是五脏虚弱、气血不足、抗邪无力、邪气内侵的状态。其次才是一些局部部位的阴阳失衡情况。阴证之人面色晦暗、脉象沉细而微弱无力，阳证之人面有光泽、脉象浮大而有力。阴阳不分，举手便错！

阴证、阳证是人体生病时，宏观上的正邪状态。在微观局部部位，则各处都可以有自身的寒热虚实的失衡情况。可以将局部的正邪相争理解为战术层面，整体的正邪相争理解为战略层面。

比如，一个人的肺部正气不虚，但有痰饮，所以是肺部邪实的情况。肺脏为五脏之一。肺部痰饮影响了肺部的功能，使其呼吸功能变弱，进而不能给全身提供充足的气，使全身都处于虚弱状态。这种情况，从整体角度看，属于整体正气不足的阴证，但是从肺部看，属于肺部正邪相争的局部实证（肺属五脏，脏气不虚的情况下，大多会排邪到腑，但也有排不出的特殊情况）。

再如，一个人的肌表部位气不足，为肌表气虚的证。肌表、形体、六腑都是以五脏为根。如果该人五脏无病，只要加强五脏的气血输出，同时再注意经络通道的通畅，则肌表气虚的情况可以很快解决。所以虽然肌表、形体、六腑都可以有虚证，但是真正的虚证是指五脏虚。只要五脏不虚，其它部位的虚证比较容易解决。

纯阴证和纯阳证是两种极端情况。纯阴证多发于老弱之人，五脏衰弱，正气非常不足。纯阳证多发于身体强壮的年轻人，五脏健康，正气充足。大多数人的状态处在两者之间，各脏腑经络功能有一定下降，但是还不算特别衰弱。所以辨阴阳，多是辨偏阴证、偏阳证，少见绝对的阴证、阳证。一般以病位主要在阳经、腑器、形体为偏阳证，病位主要在阴经、脏器、骨髓为偏阴证。

八纲辨证，首辨阴阳。其目的是确立病人体内正、邪的大格局，以决定治疗的大方向。偏阴证之人，以调理五脏，培养正气为主，祛邪为辅。偏阳证之人，以祛邪为主，养正为辅。阴证之人在治疗好转过程中，随着正气的恢复，通常会驱邪外出，从而经历一个正邪对抗表现激烈的阳证阶段。

光确立治疗大方向，还不足以进行具体的治疗。阴证、阳证各有更细的病位、病性划分，需要进一步明确后才能选择合适的治法，这是以后的内容。

2.5、病证的复杂性

人体病证的产生和分布可以是非常复杂的。下面从时间的先后关系和空间的分布关系两个角度来说明其复杂性。

2.5.1、不同证在时间上的先后因果关系

人体不同部位互相协作，产生并传输阴阳气血来动态维持体内环境。当一个环节失衡后，经常会引发连锁反应，所以证之间经常互有因果关系。下面举例说明：

1、有人先有情绪过度的神病，导致神对气的调控失常而产生气郁、气逆的证。而气为血之帅，气的失常进而可以导致痰饮、血瘀等证。

2、也有因外伤或者妇女生产等原因导致先有血瘀。瘀血可以影响气的运行，出现气郁、气滞。瘀血也可能影响神，产生狂躁、抑郁的情况。

3、还有人是先受外感风寒，产生经络的气病，然后影响水、血的传输，形成痰饮、瘀血等等。

4、还可以是先有虚证再引发实证。比如某人脾胃虚弱却饮水多，多余的水就会变为痰饮。痰饮在身体的不同部位，会干扰各个部位的功能而产生继发病症。

例如：外感寒邪可以因寒生热转化为热病，也可以因寒生湿转化为湿病，也可以因寒收引拘急转化为风病，也可以因寒生燥转化为燥病。外感热邪可以因热生寒转化为寒病，也可以因热生湿转化为湿病，也可以热极生风转化为风病，也可以因热生燥转化为燥病等等。

《温病条辨讲解-第一章-第二节》

这类连锁反应随着病情的进展或者治疗的干预，经常发生变化。治疗需要找到当前影响最大的证和最根源的证进行解决，并随着证的变化调整治法。因气的主导性较强，所以如有气病，原则上应先调理。但有时痰饮、淤血、积食阻碍气的运转，不先去除则气无法调理好，此时又可能先调理痰饮、淤血等。这些没有定论，都是按照“急则治标，缓则治本”的原则相机而动。

这也是为什么《伤寒论》虽然以寒为因，但是全书并不是只治疗寒证，还提出了热、痰饮、淤血、阳虚、阴虚等等很多证型的治法。

2.5.2、多种病证在空间分布的复杂性

一个人的病证在同一时间可以存在多种证型。

以五脏虚证为例。每一脏都可以有阴虚、阳虚、气虚、血虚四种类型。

再以五脏中的心脏为例，就有心阳虚、心气虚、心血虚、心阴虚四种。理论上讲，这几种类型是可以同时出现的。如果两种叠加，则可以有心的阴阳两虚、阴血两虚、气阴两虚、气阳两虚，气血两虚，阳血两虚等六种类型。如果三种叠加，则可以有阴阳气三虚，阴阳血三虚、阳气血三虚、阴气血三虚等四种类型。如果四种叠加，则有阴阳气血四虚一种类型。以上类型相加，共有四加六加四加一，共十五种类型。

上面是单纯考虑心的虚证。如果同时考虑肝、心、脾、肺、肾五脏的虚证。因每脏有四种单类，则五脏共有二十种单类。这二十种单类，如果进行任意组合，则有大约一百万种组合。

这是只考虑五脏虚类，如果再加入实类病证。因五脏各有气态、液态、固态邪气，所以需要加入风、热、暑、湿、燥、寒气态六种，痰、饮、淤血液态三种，固态暂定为一种，合计十种邪气。每脏为四虚十实，五脏共为七十个单类。计算后可以发现，五脏的虚实组合可以达到 10^7 的数量级。

这只是五脏的虚实组合。如果再同时考虑五体皮、肉、脉、筋、骨的虚实情况，那就更无法计算了。

对于这些复杂的病证组合，中医使用方剂来处理。合格中医需要掌握几百种经典方剂。如果只是机械的套方，则区区几百个方剂是无法应对这么复杂的病证组合，所以还需要加减和合方。对于简单的病证，可以在一个比较适合的方剂基础上适当加减药物。如果病证比较复杂，一个方剂难以处理的时候，也可以将多个方剂合并使用。病证再复杂的时候，就无法一次性解决全部问题，需要根据病证的轻重缓急确定治疗次序，分步解决。

2.5.3、小结

这里之所以重点强调病证的复杂性，是因为这是中医最大的一个难点。因为病证复杂，所以其对应的方剂也很复杂。对病证组合及因果关系的理解本就困难，再加上需要掌握准确的辨别方法，并且能选好合适的方剂，所以“辨证论治”是极端困难的。这四个字虽然简单，却是很多中医学习者一辈子也突破不了的难关。

传统上的中医教育都要求背诵诊断、方剂口诀。这是前辈们摸索出的提升诊治能力的有效方法。但是这种背诵也只是基本功。后期必须在实际临床中反复验证，才能深刻的理解并熟练的掌握。

3、自我调节能力与病证的关系

当内环境出现各类失衡的时候，人体会进行自我调节。这种调节能力是在神的主导下，由各种要素共同配合而形成的。越健康的人，调节能力越强。如果对人的健康水平进行打分的话，精、神、阴、阳、气、血皆充足的人为标准健康人，其调节平衡的能力定义为满分100分。老弱之人的平衡能力则为50分或更低。

前述人体有三大病机：阴阳失衡、升降出入失常、正邪相争。因满分之人调节能力强。遇到阴阳失衡则自我调节阴阳，遇到升降出入失常则自我调节升降出入，遇到正邪相争则自主强正祛邪。所以，其很少生病，或者说大部分病已经被其自己治愈了。

正气是形成这种调节能力的要素的合称。正气足则调节能力强。正气虚则调节能力弱。正气足并不是指某单个要素充足，而是指精、神、能量、天气、地气等要素都充足，且配合协调。因各要素都有其独特功能，都是不可缺的，所以任何一个要素不足，都会造成正气虚。

如果有邪气干扰，要视干扰的力度大小。

如果干扰力度超过100分，比如严寒、火灾、剧毒、古代的刀兵、现代的枪弹等因素。这种破坏的力度太大，所有人遇到都会生病或者死亡。

如果干扰力度为50-100之间，则平衡能力100分的人不会生病，而50分的人就会发病。解决这种疾病，最根本的做法当然是提升正气，只要正气的力量大于邪气，人体自己就可以治愈疾病，不再需要做其它事情。

但是对于老弱之人，短时间将其正气提高到满分是不现实的，就需要双管齐下，一方面帮助其适度提高正气水平，另一方帮助其减轻邪气的干扰力量，即扶正祛邪。最终实现正胜邪，而治愈疾病。

有些所谓的难治疾病，中医有时健一下脾胃就好了，或者调理一下肝肾就好了。看起来这种调节似乎与疾病无关。其实这是中医准确找到了该人产生正气诸多环节中的薄弱之处，进行加强后，人体的正气就快速提升了。正气提升，自我调节能力加强到可以战胜邪气的程度，疾病就自然好了。这种情况，并不是中医直接治愈了某种疾病，而是帮助提升了人体的自愈力，间接治愈了疾病。

以糖尿病为例，一般说长期血糖高就是糖尿病，而血糖高这个现象并不能代表中医理解的正邪状态。同样是糖尿病人，有人正虚邪实程度较轻，就容易治愈，程度较重，就难以治愈。严谨的中医即便治好过一些糖尿病人，也不会说一定能治愈全部糖尿病人，因为每个病人情况不同，任何病人到了正虚邪实非常严重的阶段都很难治疗。内经讲，病至五脏，半死半生。伤寒论中也有很多难治证或者死证，大多与三阴五脏有关。所以中医并不是包治百病，五脏藏精藏神，如果受损严重，恢复就很困难。

精是各类正气要素的基础，所以五脏藏精是否充足是健康水平的重要标志。五脏藏精充足时，人会觉得精力旺盛，有很多愿望想要实现，此时神容易放纵，做耗散精气的事情。比如大量饮酒，喝酒像喝饮料一样，这叫“以酒为浆”；晚上不睡觉，白天不起床，阴阳颠倒成为常态，这类事情叫“以妄为常”；喝醉之后肆行房事，这叫“醉以入房”；这类行为快速消耗了五脏之精，这叫“以欲竭其精，以耗散其真”。

人保养精，应该像端着装满水的水杯一样，小心翼翼，不要洒落。年轻人的五脏精气充满，应该保持这种充盈的状态，不要随意消耗，这叫“持满”。而不知持满，花费心思追求各种刺激，让自己开心，这叫“不时御神，务快其心”。最终，因不注重养精与神，贪图一时的快乐，违反正常的生活规律，而使精、髓快速消耗，不到五十岁，人就衰老了。

今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。

《素问-上古天真论》

精充足、神端正，人才可能有强大的正气。生病的本质就是人体某些方面的失衡已经超出了自身正气调节能力，难以自我恢复，所以需要医药的帮助。内经《移精变气论》说，古人治病只需要用祝由的方式帮助精转化为气，使正气提升就可以治好了，后来治病为什么必须内服汤药调理脏腑、外用针砭疏通经络，甚至即使如此也不一定能治好呢？这是因为古人作息符合自然规律、心神的欲望少，所以脏腑正气充足，病邪不能深入，稍加调理既可以治愈。后人反之，则正气虚弱，病邪很容易进入五脏、骨髓等重要部位，所以小病变重、重病则死。

黄帝问曰：余闻古之治病，惟其移精变气，可祝由而已。今世治病，毒药治其内，针石治其外，或愈或不愈，何也？

岐伯对曰：往古人居禽兽之间，动作以避寒，阴居以避暑，内无眷慕之累，外无伸宦之形，此恬淡之世，邪不能深入也。故毒药不能治其内，针石不能治其外，故可移精祝由而已。

当今之世不然，忧患缘其内，苦形伤其外，又失四时之从，逆寒暑之宜。贼风数至，虚邪朝夕，内至五脏骨髓，外伤空窍肌肤，所以小病必甚，大病必死。故祝由不能已也。

《素问-移精变气论篇》

医药的作用是帮助精、神调节身体的失衡，有其能力限度。相对精、神而言，其作用是局部、临时、辅助性的，而精、神是持续、全面的管理人的健康平衡。如果精已极少或者神的管理能力极弱，单靠医药是不行的。所以养精、养神显得极其重要。所谓“精神不进...病不可愈”、“得神者生，失神者死”。

“精神不进，志意不治，故病不可愈。今精坏神去，营卫不可复收。”

“病为本，工为标，标本不得，邪气不服”（《素问·汤液醪醴论》）。《明医杂著》也指出：“必须病人受命，坚心定志，绝房室，息妄想，戒恼怒，节饮食，以自培其根，否则虽服良药，亦无他用。”治疗不但要准确辨证，选用适当的治疗手段，而且要健全志意，控制情绪和行为，自我调节精神活动，才能有利于疾病的痊愈。

《黄帝内经讲解-血气精神的重要作用》

是故用针者，察观病人之态，以知精、神、魂、魄之存亡，得失之意，五者以伤，针不可以治之也。

《灵枢-本神》

总结，本节内容主要想说明任何病证都要从正、邪两个角度考虑。邪的角度是考虑造成失衡的邪气有哪些？正的角度是考虑正气为何未能自我调节？扶正与祛邪贯彻了中医治疗的始终。其中，正气角度比较复杂。因产生正气涉及的环节较多，要从功能开始分析，一路沿着形体、气血、经络、六腑、五脏的路径，直到精神为止。这个过程比较繁琐。不同的病人出问题的位置不同，需要个性化调节。很多医疗从业者不具备这种知识储备，容易形成见病治病的思维。某些病在正气不虚的时候，是可以有定式成法可以遵循的。如果兼有正气虚，若还是套用成法，祛邪而进一步伤正，会虚上加虚、加重病情。这就是犯了“只见病，不见人”、“只见邪实，不见正虚”的错误。

吴又可虽然注意到了正气和邪气的关系，但是他在一定程度上过份地强调邪气，因而在某些议论中也就不自觉地违反中医学辨证论治的原则。...这种只见病不见人的论点与中医学辨证论治理论体系毫无共同之处，应该说是错误的。

《温病条辨讲解-总论-第一章-第一节》

但病至五脏俱伤，脾肾元气将亡境地，绝不可见病治病。若先认定“结核”二字，妄投清骨散、秦艽鳖甲之类，必致重伤脾阳，速其致亡。

《李可老中医急危重症疑难病经验专辑-肺结核临证得失录》

第五章 人体部位的划分及病证的轻重传变

1、部位划分

关于部位的划分，在前面的章节中已经部分提及，但因这个内容比较重要，这里再做一个总结梳理，使大家能有更清晰的印象。

从不同的角度看，人体的部位有很多种分法。就像一个国家的划分可以根据不同的标准，比如按照省来划分，或者按照方位划分，按照边境与内地的标准划分，按照城市等级划分等等。每个部位可以视为一个单元，有自身的要素平衡与失衡。

人体的部位划分主要有以下几种：

1.1、脏腑与形体

这种划分方法是按照资源的产生与使用来划分的。

形体是资源的使用者，从质地上分皮、脉、肉、筋、骨，位置包括头、颈项、胸、腹、背、腰、四肢手足、关节。

脏腑即是气血的产生者又是使用者，包括五脏六腑，五脏为肝、心、脾、肺、肾，六腑为胆、小肠、胃、大肠、膀胱、三焦。

脏腑按照上下方位可以分为三焦：上焦主要包括心肺，中焦主要包括脾胃，下焦包括肾、膀胱、大小肠等。

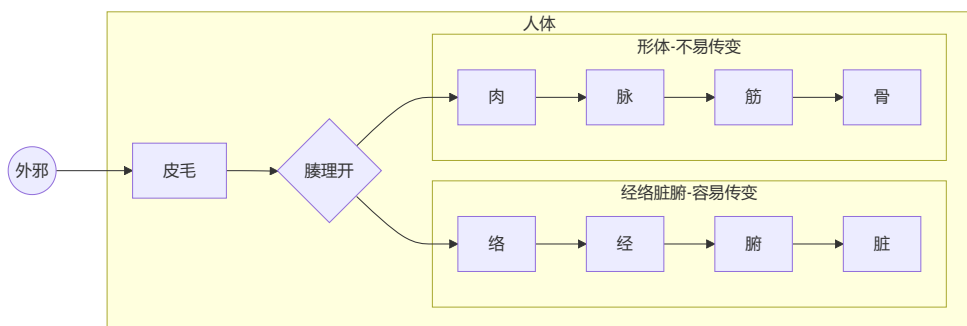
1.2、三阴三阳

按照元气与物质阴阳比例，可划分为三阴三阳区域。比如太阳区域包括足太阳膀胱腑、膀胱经、手太阳小肠腑、小肠经，其它五个区域类同。

依据三阴三阳进行疾病的区分，简称为六经辨证。这种划分方法适用于外感风寒邪气，由经络入侵人体的情况，是《伤寒论》采用的方法，对中医至关重要。后世医家拓展六经辨证，用于治疗一些内伤杂病，效果也很好。

1.3、外邪侵入过程划分

从外邪的侵入角度划分，可以分为皮、脉、肉、筋、骨、经、络、脏、腑。



如上图所示，外邪先侵袭皮毛。若皮肤的汗窍腠理打开，则邪气容易入侵，或入络经腑脏，或入肉脉筋骨，依次发展。至于走哪条通路，最终到达哪个部位，主要取决于该部位的正邪力量对比。邪气能通过的部位，必然是该位置的正气不足，所谓“邪之所凑，其气必虚”。而正气充足的部位，邪气必然难以通过，即为“正气存内，邪不可干”。

注意这里的经络也是一种部位，有寒热虚实的失衡。因经络是气的通道，所以变化很快。又因为经络外连皮肉筋骨、内通脏腑，所以涉及范围很广。再因为不同经络互相连接，所以其病证很容易互相传变。

而肉脉筋骨为固态，所以其相互传变并不快。

百病之始生也，必先于皮毛，邪中之则腠理开，开则入客于络脉，留而不去，传入于经，留而不去，传入于府，廕于肠胃。邪之始入于皮也，沂然起毫毛，开腠理；其入于络也，则络脉盛色

变；其入客于经也，则感虚乃陷下；其留于筋骨之间，寒多则筋挛骨痛，热多则筋弛骨消，肉烁腠破，毛直而败。

《素问-皮部论》

如《医学源流论》说：“故邪之伤人，或在皮肉，或在筋骨，或在脏腑，或在经络，有相传者，有不相传者，有久而终不传者，其大端则中于经络者易传；其初不在经络，或病甚而流于经络者，亦易传；经络之病，深入脏腑，则以生克相传；惟皮肉筋骨之病，不归经络者，则不传，所谓躯壳之病也。故识病之人，当直指其病在何脏何腑，何筋何骨，何经何络，或传或不传，其传以何经始，以何经终，其言则历历可验，则医之明者矣。……至治之难易，则在经络者易治；在脏腑者难治，且多死；在皮肉筋骨者易治，亦不易死，其大端如此。至于躯壳之属于某经络，以审其针灸用药之法，则《内经》明言之，深求自得也。”

《黄帝内经讲解-外邪的传变与病理》

如果邪气中於络，则络脉不和，营卫不运，肌肤不养，所以麻木不仁；若邪气中於经，则经脉不利，气血不通，周身不贯，所以肢体重滞不举；若邪气入於腑，阻遏神识，则昏不识人；若邪气入於脏，脏气受邪，气机将息，所以出现舌蹇难言，口吐涎涎等证。这就是邪气中络、中经、入腑、入脏所产生的不同证状。

《金匱要略讲解-中风历节》

1.4、表里划分

从人体与外界的关系角度，有表、里的划分方法。表指的是皮肤、肌肉及涉及到皮肤、肌肉的经络。里指的是除了表之外的部位，包括脏腑、筋骨等。

表指经络、肌表部位，里指脏腑、筋骨、气血等。

《中医学概论-八纲辨证》

之所以把表提出来做一个单独的部位重点提示，是因为表这个部位是人体与外界边界，外部的邪气通过这里进入体内，体内的邪气也可能通过这里排出到体外。

人生活在自然界中，自然界的气温比人的肌表温度低。肌表时刻都在散发着卫气，护卫身体，防范外界寒气的侵入。如果肌表卫气不足，就会出现异常的怕冷，此时外界寒气就容易入侵肌表，甚至进入更深的内部。这是邪气由外入内。而一些内部脏腑疾病在治愈好转过程中，随着正气的增加，通常会有正气驱逐邪气出表的过程。这是邪气由内出外。

因此表这个部位出现失衡的时候，有哪些表现，如何治疗，学习中医的人应该掌握。表部位失衡包括我们常说的感冒或者一些皮肤病。感冒对于健康人是小病，因其五脏正气足，常能自愈。但是对于有脏腑疾病的人，感冒治疗正确与否，决定了其脏腑疾病的减轻或者加重。内经说“善治者治皮毛”，也有中医说“不会治疗感冒就不会治疗癌症”，即为此意。

表是一个概括词，包含人体表层的皮毛、肉、经、络。

失衡部位在皮毛，可能有发热、恶寒及汗功能异常等症状；

失衡部位在肌肉的话，可能有身痛的症状；

失衡部位在经的话，通常会在经络分布区域中的一些脆弱部位表现出典型症状。以寒邪侵袭经络为例：

邪在太阳经则有头、项、腰、脊僵硬疼痛的症状；

太阳经脉行于项背，太阳之气行于体表，邪伤太阳，有病偏于表者，中风、伤寒是也，有病偏于经者、太阳经输不利证是也。但二者又不可截然分开，表证中可见头项强痛之经输不利，经输不利证中又可见汗出（或无汗）恶风寒等表证。太阳表证，治用汗法解表；经输不利证，重用葛根解经中之邪并配合解表，证与方药丝丝入扣。

《伤寒论讲解-14条》

在阳明经，有身热、目痛、鼻干、不得卧的症状；

在少阳经，有胸胁痛、耳聋等症状；

在太阴经，有腹满、咽干的症状；

在少阴经，有口燥、舌干而渴的症状。

在厥阴经，有烦闷，囊缩（男子阴囊上缩，女子外阴内缩）等症状。

尺寸俱浮者，太阳受病也，当一二日发。以其脉上连风府，故头项痛，腰脊强。

尺寸俱长者，阳明受病也，当二三日发。以其脉夹鼻络于目，故身热、目疼、鼻干、不得卧。

尺寸俱弦者，少阳受病也，当三四日发。以其脉循胁络于耳，故胸胁痛而耳聋。此三经皆受病，未入于府者，可汗而已。

尺寸俱沉细者，太阴受病也，当四五日发。以其脉布胃中络于嗌，故腹满而嗌干。

尺寸俱沉者，少阴受病也，当五六日发。以其脉贯肾络于肺，系舌本，故口燥，舌干而渴。

尺寸俱微缓者，厥阴受病也，当六七日发。以其脉循阴器络于肝，故烦满而囊缩。此三经皆受病，已入于府，可下而已。

《伤寒论-伤寒例》

以上是失衡在表，如果失衡在里，比如筋、骨、髓、血脉、脏、腑，则各有不同的表现。

1.5、卫气营血

卫气营血也可以理解为一种部位划分方法，在温热邪气侵袭人体的情况下，这种划分方法比较有利于区分病情的轻重。

卫分指的是肺与皮毛。气分指胸膈、肺、胃、大肠、小肠、肝、胆等部位。营分指血中的营气或者心包；血分指的是心、肝、肾等部位。卫气营血的病位定义稍显模糊，主要是根据所影响的功能和舌脉等特征判断。

1.6、小结

人体部位的划分非常重要，各个部位都可以视为一个单元。每个单元都有阴阳气血的平衡，以及自我调节平衡的能力。如果出现寒热虚实的失衡，就会影响到该单元的相关功能，进而出现特定的表现。按照哪种方法划分要视情况而定。《概论》辨证章节要学习的各种辨证方法，比如八纲辨证、六经辨证、脏腑辨证、气血津液辨证等等，就是从不同角度进行部位划分后产生的，各有特点，适用于不同的情况。

2、病证的轻重传变

在了解了人体部位的划分后，我们可以对病证的变化做更详细的说明。

中医的病证是指人体内环境失衡。这种失衡可以从一个部位传导到另一个部位，称为病证的传变。

邪气由此经进入彼经，则谓之传。随着邪气的转移，临床证候也必然相应地发生变化，有传必有变，故称传变，也即传经。

《伤寒论讲解-绪论》

病证从部位分布角度看，越向外越轻，越向里越重，所以病在皮毛为最轻，在肌肤为次轻，在脉筋稍重，在腑及阳经则更重，在脏及阴经为最重。

邪风之至，疾如风雨，故善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治筋脉，其次治六腑，其次治五藏，治五藏者，半死半生也。

《素问-阴阳应象大论》

病证的轻重对于某一个具体部位而言，主要观察该部位正邪力量的对比，即正虚与邪实的程度。正虚邪实的程度越轻，病证越轻，反之越重。再有，从正邪失衡的性质看，一般按照气、液、固由轻到重。即失衡在气为轻，到津血痰饮瘀血为重，到固态组织为更重。

以上两者结合，病证最轻的情况是只在皮毛部位有轻微的正虚邪实，其它部位无病。健康人的一些小感冒即为此种情况，大多数情况下能自愈。最重的情况是五脏部位有严重的正虚邪实，往往预后不良。

病证的轻重转化规律就是：部位上由外入里，程度上正气减少、邪气增加为病证加重；反之部位上由里向外，程度上正气增加、邪气减少为病证减轻。

时气不和，便当早言，寻其邪由，及在腠理，以时治之，罕有不愈者。患人忍之，数日乃说，邪气入脏，则难可制。

《伤寒论讲解-伤寒例》

病证能够向某部位转化，必然是因为该部位的正气不足，否则不会受邪，即使受邪也会迅速排出。以后我们学习伤寒金匮的时候，无论是伤寒外感六经的传变还是内伤脏腑五行的传变，都是符合此原则的。比如金匮中说“见肝之病，知肝传脾，当先实脾，四季脾旺不受邪，即勿补之”，说明虽然肝实之病倾向于向脾传变，但若脾的正气足，是可以抵御这个过程的。伤寒论中说太阳病可以依次传阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴，也经常有不依此次序的情况，即是因为不同人正气程度不同所致。

传与不传与邪气的盛衰，正气的强弱，治疗与护理之是否得当有关，尤以正气的抗邪能力大小为关键。若正气虚衰，邪气则可由表传里，由浅入深，使病证渐趋沉重；若正气恢复，抗邪有力，邪气又可由里达表，由阴出阳，使病向愈。

《伤寒论讲解-绪论》

伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪。其人反能食而不呕，此为三阴不受邪也。

太阴病应见腹满而吐，食不下等证，今则反能食而不呕，表明脾胃之气调和而无病。太阴气旺，能为三阴之屏障，则少阴、厥阴也不会受邪，故曰“三阴不受邪”，可见仲景辨传与不传，并不以日数计，而仅依脉证断。

《伤寒论讲解-270条》

中医治病的核心原则就是：对五脏疾病存在严重正虚邪实的情况，以扶正祛邪的方法，恢复正气，减少邪气，使其向腑病转化，由吐或下的方式排出邪气；或由里病向表病转化，以汗的形式排出邪气。病位由里到外，程度由重向轻，即是“阴证转阳证”，直至治愈。

凡由阴证转化为阳证，或由阳证转化为阴证的，即是疾病性质的根本转变。这种转变，常常取决于邪正双方力量的对比。凡正气充足的，大多由阴转阳，疾病向轻浅转化，正气虚衰的，大多由阳转阴，疾病向重深发展。例如：《伤寒论》太阳篇：“病发热头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，宜四逆汤。”（92条）《伤寒论》阳明篇：“脉浮而迟，表热里寒，下利清谷者，四逆汤主之。”（225条）这是阳气衰微，正气不足，或治疗失当，重伤其阳，致使阳经之病，从阴化、寒化，转为阴证的证候。

《黄帝内经讲解-阴阳互根互用的关系》

原则清楚后，治法也随之而出。中医将治法总结为八法：汗、吐、下、和、温、清、消、补。其中温、补法可以补各部位的阴阳气血，为扶正；清、消法可以祛除各部位的邪热、痰饮、瘀血以及各种积滞邪气，为祛邪。病属气机不调和的可用和法。应用这些方法后，正进邪退，病邪可被传送到人体与外界的边界（肌表或腑）处。如到达边界而未能排出，则表现出阳证。此时若邪在肌表可用汗法，若邪在腑可用吐、下法。最终，病邪通过边界排出体外，就完成了一次治疗。重病之人，可能会多次重复这个过程。

一般来讲，阴证往往表现在饮食差、睡眠差、体力差、手脚凉等方面。阳证往往饮食、睡眠、体力尚可，可能会表现出发热、怕热、大

便干燥等情况。所以民间以能吃、能睡、能干活作为身体健康的简单标准。

要注意的是，阴证的外在表现有时不如阳证的表现剧烈。比如发热这个症状，中医认为发热多为正邪对抗。脏病之人正气不足，驱邪无力，往往发热不明显，而腑病或表病反而会有高热的现象。所以当脏病向腑病转化或者里证向表证转化的时候，虽为阴证转阳证的好事，但有时病人自我感觉可能会更不舒服。

实践中，常见阴证病人经治疗转阳证后，出现感冒发热或者大便干燥不通的阳证情况。病人会以为治疗错误而停止治疗。这种情况即考验医生的技术水平，也考验病人的信任程度。正确对待方法应该是依据阳证治法继续治疗。如果不懂原理，处理不当，会重新由阳证返回阴证，功亏一篑。

病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳，七日愈；发于阴，六日愈，以阳数七阴数六故也。[7]

《伤寒论讲解-第7条》

凡伤于寒则为病热，热虽甚不死。若两感于寒而病者，必死。...

《伤寒论讲解-伤寒例》

疾病的势头会向哪里转变，即为病势。判断病势需要全面了解病人各部位的正气与邪气的分布情况，根据正邪力量对比及可能传变的道路，预估疾病的变化。通过各种治疗手段，提前截断疾病转重的通道，引导疾病向轻、浅发展。因不同病人身体各部位的正邪情况不一，同样初始病证，同样的治法，不同病人的病证传变道路可能都不一样，所以需要医生随着变化调整方药治法，这个过程与打仗时根据战场势态随时调整兵力部署很相似，所以说“用药如用兵”。

要根据其疾病传变的规律，治其已病之脏腑，安其未病而又可能生病之脏腑。...

问曰：脉脱入脏即死，入腑即愈，何谓也？师曰：非为一病，百病皆然。譬如浸淫疮，从口起流向四肢者可治，从四肢流来入口者不可治；病在外者可治，入里者即死

《金匮要略讲解-脏腑经络先后病脉证第一》

理解了这个道理，就知道中医治病并无定法。同样的战场态势，不同的将帅可以选择不同的打法。有人先守再攻，有人先攻再守，有人选择此处进攻，有人选择彼处突破。兵无定势，水无常形，只要能用最小的代价取得胜利，都是好将军。同样一个病人，有的中医先攻后补，也有先补后攻或者攻补同用，有人先去热，有人先去湿，并无一定的规范，只要能治好病且对病人的伤害最小，都是好大夫。

即使不同的中医对同一病人的初始判断不一样，只要能在治疗过程中，根据反馈逐渐调整，使病人总体趋势向好，就是正确的。在病情复杂情况下，如不了解病位、病性、病势，只靠病名即开出方药，可能偶尔有效，但更多的是无效甚至产生其它不好的变化，这是典型的刻舟求剑！

实际上，此处谈到的疾病轻重传变原则，是中医唯一不变的原则，也就是治疗手段可变，但治疗原则不能变。手段可以选择中医的汤药、针灸、按摩，也可用心理疗法、音乐疗法以及西医疗法等等，但是医者心中应有这种疾病轻重的整体观念，不但要有解决病人当前病证的基本功，还要有驱使病情由重向轻转变的全局观。

因此，判断一个中医是否合格，并非以方法而论，而是以原则为准。表面上能开方子、扎针灸的人不一定是合格中医，开口闭口谈经方的人也不一定真懂伤寒论，也就是“不谋全局者，不足以谋一隅”。

附：中西医标准的一些差异

西医疗法往往要求量化、可重复，即科学方法。这种科学方法的研究特点是：当对一个事物的全部主要变量都可控的时候，就能非常稳定的重现这个事物。比如制作某一型号的枪械，只要控制好流程，就可以实现大批量重复生产，且质量稳定。但是，如果一个事物非常复

杂，无法控制主要变量的时候，该事物就难以重复。就像我们无法重现历史上的某一场战争，因为当时战争发生时，相关的人物、气候、地理、器械都发生了变化。这些要素无法量化重复，这场战争就无法重现。学科有很多种，不懂枪械的工作原理并不影响指挥打仗。中医的理论，特别是“用药如用兵”的思路类似战争学、管理学、系统学、园艺学等，而非物理学、化学或者机械学。

西医的研究特点决定了其在能够量化重复的方面表现很好，在难以量化的方面则相对较弱。人体几大要素中，固、液要素较容易量化，能源、能量、气态物质、控制等要素（精气神）较难量化。所以西医疗法在固液层面的应用偏多。一个问题如果其根本原因在固液层面，用西医疗法就较好，如果根本原因在其它要素，固液层面只是表象，那么对固液的治疗就只能治标。治标之法只要不伤本，也是可以选择的。但若只在标的层面控制症状，则本的层面虽有一定的比例会自愈，也有一定的比例会加重。

人体是一个非常复杂的系统，不同部位、不同要素之间存在着非常复杂的关系。西医在对某一局部位置、局部指标进行精确干预的时候，很难判断这种干预对其它部位的影响是好还是坏，即难以比较总体上所获得的好处与副作用孰大孰小，不知是“得大于失”还是“得不偿失”。为了弥补副作用评价的不足，西医引入统计学，用大样本调查的方式跟踪副作用，有一定作用。但因复杂系统涉及变量过多，所以短期、明显的副作用容易被发现，而长期、隐藏的副作用则难以发现。从中医理论看，如果阳证经干预变成阴证，虽然阳证症状消失，但是病情是加重的。这种情况，因阴证的判断需要较专业的中医知识，所以普通人是难以发现问题的，甚至还会认为非常有效。中医在中医理论的指导下，对人体疾病的轻浅与深重有独特的判断方法，虽然只是模糊的阴阳定性，但却能总体把握疾病的走向。

钱学森先生作为“中国航天之父”，认为人体属于复杂巨系统，适合使用系统论的方法进行研究，并且认为中医包含了很多系统论的思想，是未来医学的发展方向。不是现代科学无法研究中医，而是应该采用合适的研究方法才能研究中医这种正邪动态变化的学问。

因方法论的不同，中西医指标有一致的时候，也常有矛盾之处。

有时中医认为病情减轻，西医却认为是加重。西医多使用验血的方法了解疾病的轻重。肝肾疾病，中医调理的初期可能有某些血液指标升高的情况。这是因为血液作为一种载体，会将肝肾废物运载到腑或肌表，以大小便或汗的形式排出。肝肾功能好转过程中，会排出更多废物到血液中。此时化验血液，就会出现指标升高的现象。据此西医会认为病情加重，而中医通过病人面色、脉象、体力、饮食、睡眠等角度判断病情在减轻，至于血液指标，要等到肝肾功能完全好转，废物全部排出，才会恢复正常。若病人同时选择中西医结合治疗，因不理解中医的道理，可能就放弃了中医的治疗。

也有时西医认为病情减轻，中医却认为加重。中医看待西医是通过四诊的方法，依照中医疾病轻重进退的理论，评价其治疗的优劣。西医治疗后，可能某些指标好转，若从中医四诊上看也有好转，中医就会认同，若四诊判断没有好转，甚至加重，中医就会反对。实际上很多中医反对西医的原因，并非是反对某一具体疗法，而是发现很多病人经过西医的治疗，原本是正气足、抗邪有力的情况，治疗后转变成正气虚、无力抗邪的情况，也即从阳证转为阴证，从轻浅变为深重。其背后的本质含义是西医在调解某些指标平衡时，可能会伤害中医认为更重要的精、气、神等指标。

急症方面，因为“急则治其标，缓则治其本”，在紧急情况下，治标之法常是首选。紧急情况若不快速缓解症状，可能会非常痛苦，甚至有生命危险，所以即便西医疗法有副作用，也无暇顾及。但最好是熟悉中医诊疗方法，一方面提前发现问题，尽量不要让身体出现紧急情况。另一方面，万一出现紧急问题，能用中医方法解决。李可老中医被称为“中医ICU”，说明中医在急救方面也有独到之处。即便紧急情况用到西医急救，待情况缓解后，也应以中医治本方法调理。学好中医就会明白，方法手段只是工具而已，中医理论才是根本。在中医理论指导下，西医发明的方法，也大可成为中医的工具，只要能将其用在合适的时机即可。

3、外感与内伤

生病的病因主要有外感和内伤。外感病是外界寒暑之气侵袭形体肌表，使其失衡并由外向内发展。内伤病是因饮食不节制、起居不遵循天时或过度的情志变化造成脏腑先失衡，并由内向外发展。此即内经所说“故犯贼风虚邪者阳受之，饮食不节，起居不时者，阴受之。”

外感病，先伤皮毛。初期五脏未伤，以整体正邪相争的阳证为多，此时气血涌动到肌表抗邪，所以发热、脉浮。若经络正气不足，邪气就会由皮毛入络，再由络入经，甚至由经入脏腑，发生病证的传变。参考前面提到的部位划分方法中的“外邪入侵过程的部位划分”。

从阴经、阳经角度看：因阴经连脏，正常情况下，若五脏未伤，则注入阴经之气会强于阳经之气，所以阴经不容易受外感之邪，或者即便阴经受邪，邪气也不能停留，很快会被转移到腑器。内经说“邪入于阴经，则其藏气实，邪气入而不能客，故还之于腑”。而阳经因其经气弱于阴经，所以常常先受外邪。

黄帝曰：此故伤其藏乎？岐伯答曰：身之中于风也，不必动藏。故邪入于阴经，则其藏气实，邪气入而不能客，故还之于腑。故中阳则溜于经，中阴则溜于府。

《灵枢-邪气藏府病形》

所以邪入于阴经而脏气实，则邪气不能循经入脏，而外出于脏之表——腑。如伤寒少阴三急下证，少阴病得之二、三日，出现阳明腑实之象，或少阴病六、七日，腹胀不大便者，即是邪中少阴，传之于阳明，成为阳明腑实证的典型例子。治当大承气汤急下之，腑实去而脏阴存，则病可愈。

《黄帝内经讲解-病因与病位的差异》

从长度看：每条经脉都有一个对应的脏腑之气注入。假如注入之气相等的话，因十二经脉的长度各自不同，所以其经气密度有所区别。经脉越长，经气密度越小，运行速度越慢，则防御能力越弱。手经长度短，所以经气密度大；足经长度长，所以经气密度小，肌表邪气多从足经侵入。足三阳经中，足太阳经长度最长，防御面积最大，防御能力最弱，所以皮毛之邪最容易从足太阳经入侵。

黄帝曰：夫经水之应经脉也，其远近浅深，水血之多少，各不同...手之阴阳，其受气之道近，其气之来疾。

《灵枢-经水》

岐伯曰：巨阳主气，故先受邪，少阴与其为表里也，得热则上从之，从之则厥也。

《素问-评热病论》

足太阳经与后脑的督脉风府穴相连，而风府穴最容易受风邪。所以邪气从皮毛入侵太阳经时，往往先从该处侵入。此处被邪气入侵后，经气流转不畅，相关部位会有僵硬、疼痛的表现，表现为后脑、后颈（项）、后背僵硬疼痛。日久则形成现在的颈椎病。所以伤寒论太阳病的一个典型表现是头项僵痛。

尺寸俱浮者，太阳受病也，当一二日发。以其脉上连风府，故头项痛，腰脊强。

《伤寒论-伤寒例》

前面卫气部分谈到太阳经主管一身卫气在肌表的敷布。太阳经功能受损，人就有怕冷的表现。所以伤寒论太阳病的另一个典型表现是恶寒。

太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

《伤寒论-1条》

皮毛既与经络相关，也与肺的宣发功能相关。皮毛受邪，若影响肺向肌表宣发水气的功能，则可以有咳喘的表现。如果未能治好，邪气可以直接入肺，并通过肺脏传入其它脏器，变为阴证。皮毛至肺脏的病证转化过程不是沿经络转化，而是通过影响肺的宣发功能而转变的。

肺合皮毛，今表气闭郁，肺气不宣，故喘。

《伤寒论讲解-35条》

今风寒客于人，使人毫毛毕直，皮肤闭而为热。当是之时，可汗而发也。盛痹不仁肿病，当是之时，可汤熨及火灸刺而去之。弗治，病入舍于肺，名曰肺痹，发咳上气弗治，肺即传而行之肝...

《素问-玉机真藏论》

皮毛先受邪气，邪气以从其合也。其寒饮食入胃，从肺脉上至于肺则肺寒，肺寒则外内合邪，因而客之，则为肺咳。

《素问-咳论》

视人体正气情况，邪气或传或不传，或一日一传，或多日一传，或先作用于太阳经络后传于阳明经、少阳经，再传于三阴经络，或未经阳经而直接作用于三阴经，或由经传入脏腑，等等情况，不一而足。邪气作用于不同部位，则有对应表现与治法。

所谓传变，...邪气由此经进入彼经，则谓之传。随着邪气的转移，临床证候也必然相应地发生变化，有传必有变，故称传变，也即传经。传与不传与邪气的盛衰，正气的强弱，治疗与护理之是否得当有关，尤以正气的抗邪能力大小为关键。若正气虚衰，邪气则可由表传里，由浅入深，使病证渐趋沉重；若正气恢复，抗邪有力，邪气又可由里达表，由阴出阳，使病向愈。辨传与不传，传至何经，当以脉证变与不变为据。

《伤寒论讲解-绪论》

比如邪气先入侵三阳经，如果未入腑，则可以考虑用发汗的方法治疗。如果邪气先入侵了三阴经，但三阴经经气充足，则会将邪气转至六腑。入腑之后，可以用下法治疗。

此三（阳）经皆受病，未入于腑者，可汗而已。...此三（阴）经皆受病，已入于腑，可下而已。

《伤寒论-伤寒例》

内伤病先伤五脏，起步就是阴证。假设某脏先失衡，其传变有多个方向。若其它脏器正气也不足，可按照五行乘侮传变，造成多脏器同时失衡，这是病情向重发展；

今风寒客于人...弗治，病入舍于肺...肺即传而行之肝...弗治，肝传之脾...弗治，脾传之肾...弗治，肾传之心...弗治，满十日，法当死。肾因传之心，心即复反传而行之肺...此病之次也。

《素问-玉机真藏论》

若其它脏器正气充足，本脏正气经过调理也恢复，则病证可向其表里关系之腑器传变，也可能通过本脏经络向表里之腑经或肌表传变，这是病情向轻发展。注意，这种减轻是指脏病减轻的前提下出现腑病。如果脏病未轻，同时增加了腑病，并不是减轻，而是加重。

五藏之久咳，乃移于六府。...

这种从脏移腑的传变方式与一般疾病的从脏传腑的情况不同，它不是疾病向愈的表现，而是疾病的发展。

《黄帝内经讲解-咳嗽类》

以上是单论内伤或者外感，如果人先有内伤五脏疾病，整体正气已不足，此时若再有外感侵袭，则极易由外而入里，形成严重问题。若伤及五脏，则内外夹击，会有性命之忧。所以历代疫情，都是原本脏腑健康者易活，原本有脏腑疾病者易死。因此，人在平时就要积精全神、保养脏腑、培养正气，以备特殊情况下能有足够的力量抵御各种异常侵袭。

黄帝曰：邪之中人脏奈何？岐伯曰：愁忧恐惧则伤心。形寒寒饮则伤肺，以其两寒相感，中外皆伤，故气逆而上行。

《灵枢-邪气藏府病形》

三阴三阳，五脏六腑皆受病，荣卫不行，五脏不通，则死矣。

《素问-热论》

凡伤于寒则为病热，热虽甚不死。若两感于寒而病者，必死。...

若相表里的阴阳两经，如太阳与少阴，阳明与太阴，少阳与厥阴，同时受邪发病，则称“两感于寒而病”。两感则多因素体阳虚，正气抗邪无力，致使邪气得以深入所致，故其预后每多不良

《伤寒论讲解-伤寒例》

岐伯曰：皮毛者肺之合也。皮毛先受邪气，邪气以从其合也。其寒饮食入胃，从肺脉上至于肺，则肺寒，肺寒则外内合，邪因而客之，则为肺咳。

《素问-咳论》

在后面要学习的四大经典中，《伤寒论》论外感伤寒，所以以六经为纲，以三阳经开头。《金匱要略》论内伤杂病，以五脏为主，用“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”的五行生克制化理论开篇。

《伤寒论》既论述了健康人外感风、寒之邪而形成表病的表现和治法，也论述了外感风寒被误治、或其原本就有内伤，形成里病后的一些表现和治法。因此，《伤寒论》既能治疗外感也能治疗内伤，又因其内容论述精准、配方合理，用之于临床常见奇效，所以是中医必学的经典。

此外，《伤寒论》主要论述寒邪伤人阳气，形成阳虚寒实格局的处理方法，虽也涉及部分阴虚热实的情况，但还不够详细。后世医家为补其不足，做温病学说，重点论述阴虚热实的辨别与处理方法，其中以吴鞠通所著的《温病条辨》为代表。

由此，《伤寒论》、《金匱要略》、《温病条辨》构成了比较完善的处理各类外感、内伤杂病的中医辨证治疗体系，再结合《黄帝内经》对人体运转机制的讲解，形成了以四大经典为主的中医理论教育体系。

第六章 人体各类平衡波动

前面说过，中医的阴阳指的是某件事物中，其维持平衡所需的各类指标要素在时间上的波动和空间上的差异。本章谈一谈波动的问题。

自然界，一年阳光的变化形成四季，这是能量的波动。河流有汛期和枯水期，海水有涨潮落潮，这是液态物质的波动。各种波动在平衡范围之内，就是正常的。超过范围，就是失常。阳光的波动失常可造成酷热或者严寒，河流的波动失常可造成水灾或者干旱。同样，人体中也包含类似的道理。

1、人体内部的主要波动关系

人体要素产生与传递、使用的各个环节都可以有波动变化。比如人饱食之后气血增加，饥饿之时气血减少，这就是一种波动。运动的时候，四肢肌表气血增加，休息时减少，这也是一种波动变化。

人体某个部位可以有各类要素整体增加或减少的波动，也可以有单个要素增减的波动。在不同部位，可以有此增彼减、此减彼增的波动。这里谈两点人体内部主要的波动关系。

1.1、局部环境平衡波动

人体内部各处皆有能量与物质固、液、气三态形成的环境平衡。其中，元气、津血、气都容易有数量上的波动，只要不超出平衡范围，皆为正常。

如前所述暖气的例子，暖气完成供暖功能，需要火、水皆在平衡范围内。火可以有大小的波动，水也可以有多少的波动。

在平衡范围内：水火偏多，则气偏多，工作能力强；水火偏少则气偏少，工作能力稍弱。两者皆为正常。

超出平衡范围：

过多：火过多，则阳实而热；水过多则阴实而寒；

过少：水火有一个过少，都会气虚。若只是火过少，则阳虚而寒兼气虚，为气阳两虚；只是水过少，则阴虚而热兼气虚，为气阴两虚。水火皆不足，气更不足，即为阴阳两虚兼气虚。阴阳两虚情况下，水火还可有偏，火偏多则热，水偏多则寒。此时调节能力差，稍补水则变寒，稍补火则变热。

水火相对而言，火为阳，有主动性；水为阴，有被动性。所以火易调而水难调。在水量适度情况下，通常以调火来控制气的多少。调节暖气的输出功率时，只要调节火的大小，水温和蒸汽量即随之增减。火大则水、气皆热，火小则水、气皆寒，这就是阳主而阴从。

《内经》强调阴阳关系的协调平衡，并不排斥阳气的主导作用，因为阴和阳两个方面，并非完全处于同等的地位，而是有主有从...

《黄帝内经讲解-阴阳互根互用的关系》

阳气虽然重要，但不要走入极端，只强调阳气是错误的。阳气主导的平衡波动是在阴液适量的前提下进行的。如果暖气中的水量很少，小于平衡范围，也需要补水，否则火稍大一点，就容易烧干。自然界也是如此，四季的形成是由阳光的多少变化而主导，但前提是大地有足够的水土。如果在水土贫瘠的沙漠，光靠阳光的增减是无法形成茂密森林的。

因此，阳主阴从、阳气为主导的含义是水火在平衡波动的过程中，火起主导作用，而非不考虑水的多少，一味的增加火量。

在临床上治疗一些气虚，阳虚患者，需大量或长期用温燥药物，致使胃津不足者，常常间断使用益胃汤或合入益胃汤，以防止温燥药物耗伤胃阴。

《温病条辨讲解-中焦篇-风温-十二》

人体也一样，中医往往通过阳气的波动来代表整个气血的波动，但不意味着不考虑阴液的因素。人的津血正常的情况下，阳气适当增加，则人体的气足，反之则气稍弱。但若在津、液、血虚的情况下，单纯增加阳气会更加消耗津液。

人体单纯阳虚则补阳；单纯阴虚则补阴；阴阳两虚则用侧重补阳的甘温之剂，虽侧重补阳，但也兼顾补阴。

有的中医有“贵阳贱阴”的说法。这个提法容易让不懂原理者走偏。理解了阴阳平衡的道理，应该明白阴阳各有其用途，谈不上谁贵谁贱。物以稀为贵，在阴阳平衡过程中，阴少则阴贵，阳少则阳贵。如果说不清平衡原理就妄谈贵贱，必然走偏而害人害己。

有一种观点说人死亡的时候躯体还在，而躯体是物质，物质为阴，所以阴永远都是足够的，只是缺阳，从而得出死亡都是阳不足的错误结论。其实躯体只代表人体固、液、气物质中的固态物质。固态物质存在，并不代表躯体中的参与形成内环境的液态、气态物质是充足的，所以说人的死亡全都是阳不足。从历代中医的实践看，阴液不足造成的病危案例屡见不鲜。实际上，正阴不足、正阳不足、阴阳俱不足都可以造成病危。

肯定阳气的主导作用。这不意味着“贵阳贱阴”，而是在以“阴为基础”的前提下来认识阳气的重要作用。与只重视阳气者自有区别。就临床来看，阳虚者固当扶阳，阴虚者亦当滋阴，这在调整阴阳的治疗过程中是无可非议的。但如果证属阴阳两虚，一般都侧重阳虚而用甘温分剂，《灵枢·终始》说：“阴阳俱不足，补阳则阴竭，泻阴则阳脱，如是者可将以甘药，不可饮以至剂。”

《黄帝内经讲解-阴阳互根互用的关系》

前述伤寒为病，多伤阳气，临证治疗，首在扶阳，补阳则可摄阴，阳生方能阴长。但若阴阳两伤，而阴伤亦甚之时，阴阳双补，滋阴和阳之法则不可忽视。

《伤寒论讲解-69条》

一般来讲，阳易补而阴难复。阳为能量，通过干姜、附子等药物刺激，通常可以快速促使精转化元气，达到补阳目的。阴为物质，其产生与传送较为困难，所以补阴显效慢，且其传送环节有一环出问题就会送不到该去的位置，容易停留于某处形成湿气、痰饮等邪气。这些湿气、痰饮、瘀血类的邪气，在脏腑，会影响脏腑化物、藏精、藏神、产生气血

等功能；在三焦、气脉、血脉等通道，会使能量及气液物质的传递发生障碍。这样就不但没有达到补阴的目的，反而增加了新的病证。

西医发明的输血、输液等手段，可以大量快速的补充津血。这种手段属于外来补充，而非人体自身产生，比较粗犷。人短时间大量失血、流失津液的时候，津血的整体缺失过多是主要矛盾，用这种手段比较好。非此类情况，则要考虑输入的阴液能否准确到达需要的地方？过量的阴液是否会让体内环境变寒？多余的水液是否会变为湿气、痰饮？从中医角度看，过量输液容易导致湿寒体质，而湿寒体质如果过量输液，会加重病情。

1.2、整体气血资源波动

人整体的资源运转为脏腑产生气血，通过经络传输，供给形体使用。这个过程中，气血的总量与分布不是一成不变的，而是在一个范围内波动。

人的主要功能是行动、思维、感受、表达等。这类功能的使用强度决定了气血的消耗量。多动、多思、多言等偏阳性的行为会消耗较多的气血；反之，少动、少思、少言等偏阴性的行为消耗较少的气血。

形体获得较多气血的时候，有利于形体组织健康，使人的皮肤致密、肌肉结实、各种通道通畅，能够更好的保护身体不受外界侵袭，即为养阳，这里的阳是指形体。此时脏腑的工作量较大。

形体获得较少气血的时候，脏腑可以获得休息，有利于脏腑化物、藏精等后勤保障工作，让脏腑健康，藏精更多，即为养阴，这里的阴指脏腑。

阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也。

《素问-生气通天论》

以开车进行比喻，养阳就是踩油门，速度快，力量大，但耗油量大；养阴就是收油门，省油。这里提到的养阴与养阳是人体非常重要的波动关系，涉及到很多处的变化，为表达清晰，分类逐条讲解：

1、脏腑所消耗气血：养阳时，需要脏腑产生更多气血供给形体，此时脏腑工作量加大，其自身也要消耗较多气血。反之，脏腑气血消耗较少。

2、气血总量与整体抗邪能力：气血总量为形体气血和脏腑气血之和。养阳时，形体气血偏高，脏腑气血也偏高，所以气血总量高，即为正气足，整体抗邪能力强。反之，气血总量低，抗邪能力弱。

3、精的消耗量：因气血来自精的转化，所以气血总量高时，精的消耗量大；反之，精的消耗量小。

4、脏腑藏精量：脏腑所藏之精分为先天之精和后天之精。

后天之精：胃、肠、脾以一定的速度持续吸收着水谷精微。精的消耗量小的时候，可以有多余的后天之精存入脏腑，脏腑藏精量增加。精的消耗量大的时候，则需要从脏腑中调出精，脏腑藏精量减少。

先天之精：先天之精难以补充。气血总量高的时候，先天之精消耗的快。反之，消耗的慢。

5、肌表的腠理与汗：养阳时，肌表的阴阳气血皆充足，腠理容易打开，容易出汗。此时因津血在肌表多而脏腑相对少，所以小便偏少。反之，肌表的阴阳气血减少，腠理闭合，不容易出汗而小便偏多。

6、肌表的护卫抗邪能力：养阳时，肌表的气血多，抗邪能力强。反之，肌表的抗邪力弱；

7、气血的分布：

气血为流动之物，其在全身内外上下的分布应尽量均匀，各处可有一定差别，但不应过大。

形体应天，波动幅度较大；脏腑应地，波动幅度较小。养阳时，形体气血增加较多，脏腑气血增加较少，两者相比，形体气血量大于脏腑。养阴时，形体气血减少较多，脏腑气血减少较少，两者相比，形体气血量小于脏腑。

这里内外的气血量差异是指正常范围内的差异。如果两者差别过大，说明气血之出入有问题，是病证。

阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂。阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通。是以圣人陈阴阳，筋脉和同，骨髓坚固，气血皆从。如是则内外调和，邪不能害，耳目聪明，气立如故。

《素问-生气通天论》

8、五脏之间的差异：五脏之间比较，养阳的时候，心、肝的工作量相对更多；养阴的时候，肺、肾的工作量相对多。这是因为养阳的时候，气血总量增加，需要心调集更多肝所藏之血，输出到全身。而养阴的时候，气血总量减少，需要肺收隐气血于内，肾负责藏精。

一身之血，均在脉中运行，这依赖心阳的温煦与心气的推动，方可周流不息，濡养全身。

《中医学概论-心、小肠》

9、肝的藏血量：肝主藏血。养阳时，气血传输量大，需要调集肝所藏之血，输布于形体，所以肝的藏血量减少。反之，肝的藏血量增加。

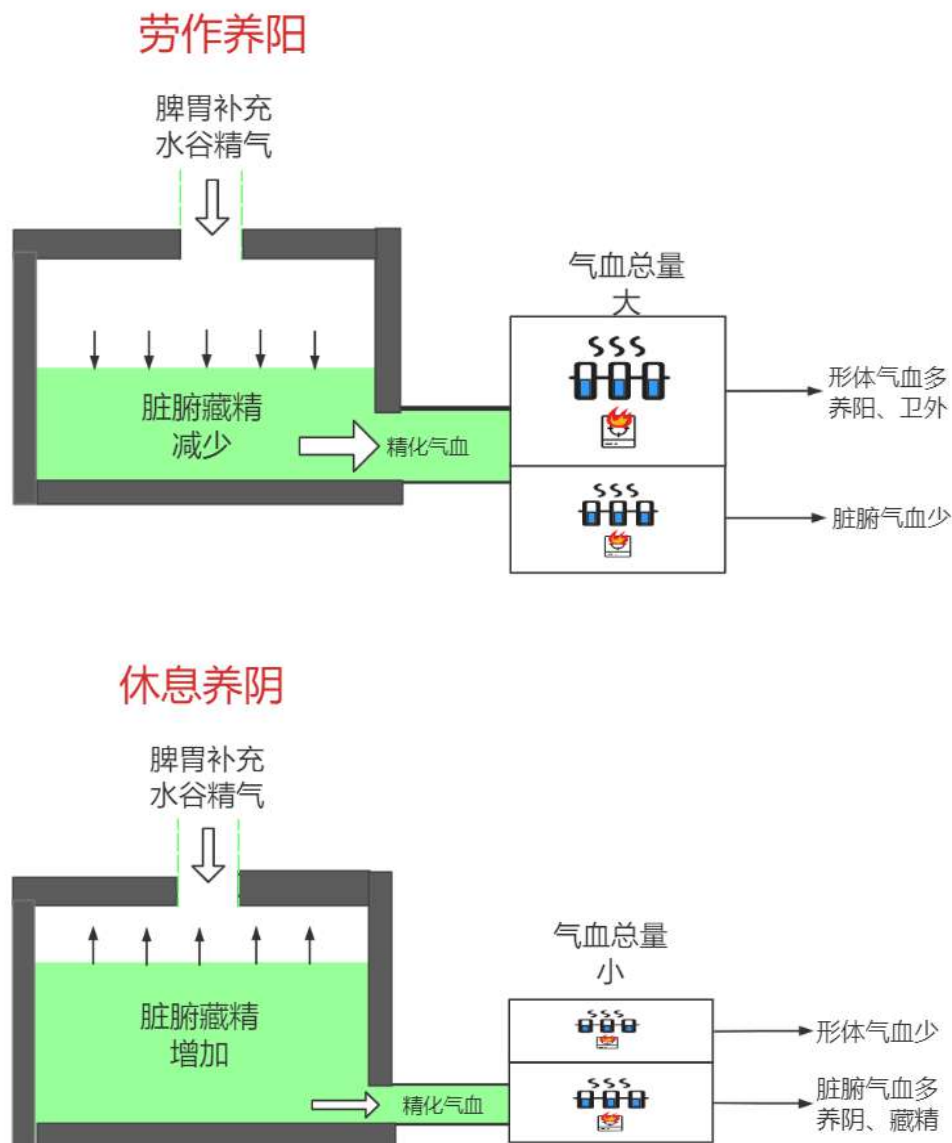
人体内的血液分布，常随着各种不同的生理状况而改变，这种血量的改变，主要取决于肝的贮藏与调节。当人处于休息或睡眠时，人体的活动量减少，血液的需要量亦相对减少，部分血液便藏于肝。当人处于活动状态时，肝脏就把所贮存的血液输布于人体，以供人体的需要。

《中医学概论-肝、胆》

10、气血通道的扩张：养阳时，气血通道扩张，气血流动快、量大。养阴时相反，气血通道收缩，气血流动慢、量小。

有很多因素可以影响气血的整体波动，最常见的即为劳作与休息。劳作运动时，形体需要消耗大量气血，就可以形成养阳的格局。休息睡眠时，形体消耗气血少，就可以形成养阴的格局。此外，邪气干扰、中药方剂、情志变化、气温变化、日月变化也可以对养阴养阳产生影响，但各有细节不同。这里暂时以劳作与休息举例。

劳作养阳与休息养阴的关系如下图。



因劳作健壮了形体，形体才能在休息时卫护于外，保证脏腑不被外界邪气侵袭。因休息时脏腑积累了精气，才能在劳作时提供足够的精来转化气血。休息与劳作一阴一阳，互为因果。两者都有合适的度，需要劳作以养阳，又不能过度劳累；需要休息以养阴，又不能过度休息。人的一生就是在这种养阴、养阳的波动中消耗肾精，逐渐衰老，直到先天之精耗尽，度天年而去。

人要想健康长寿，既需要通过休息内养五脏以藏足精气，又需要通过劳作外健形体以抵御邪气侵袭，再加思想恬淡以养神，就如内经开篇《素问-上古天真论》所说：圣人形体不敝，精神不散，可以活到百岁。

其次有圣人者，处天地之和，从八风之理，适嗜欲于世俗之间，无恚嗔之心，行不欲离于世，被服章，举不欲观于俗，外不劳形于事，内无思想之患，以恬愉为务，以自得为功，形体不敝，精神不散，亦可以百数。

《素问-上古天真论》

按：“阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也”，传统上，此处理解阴为阴精，阳为阳气，因解释不通顺，是中医的一个难点。此处的阴应理解为内在脏腑，可藏精，阳理解为外在形体，可护卫人体不受外界邪气的侵袭，对应内经的“内为阴，外为阳”，“阴藏精，阳卫外”。同样，“春夏养阳，秋冬养阴”，这里的阳也不是指阳气，而是指形体；阴不是指精血，而是指脏腑。春夏适合养形体，秋冬适合养脏腑。

阴精是阳气的物质基础，阳气要发挥应有的作用，需要阴精的支持，所以阴精要不断地输送精气于全身，以供给阳气的需要，这叫“阴者，藏精而起亟”。阳气对阴精有固摄作用，阴精要藏守于内，需要阳气固密于外，所以阳气要不断敷布于体表，以抗御外邪，固密阴精，这叫“阳者，卫外而为固也”。

《黄帝内经讲解-阴精与阳气的主要功能和关系》

1.3、小结

本结提到的两部分内容分别指的是局部阴阳平衡与内外整体波动。局部平衡是指任何部位都有阴阳气血的平衡，以及阴阳气血之偏。其所偏之程度在平衡范围之内为正常，超过平衡范围为失常。整体波动是指整体上，人的阴阳气血总量可以有偏阳性和偏阴性的变化。偏阳性的时候为养阳，整体机能强，气血外多里少，精的消耗加快；偏阴性的时候为养阴，整体机能弱，气血外少里多，精的消耗减慢。

2、天体波动的影响

天体日、月、星以及地球自传，对自然界和人体要素都有各自的影响。

夫变化之用，天垂象，地成形，七曜纬虚，五行丽地；地者，所以载生成之形类也。虚者，所以列应天之精气也。形精之动，犹根本之与枝叶也，仰观其象，虽远可知也。

《黄帝内经-五运行大论》

以太阳为例，一年四季，自然界阳气波动。自然界的生命顺应这种变化进行生、长、收、藏的活动。农民要按照节气在春天播种，夏天灌溉，秋天收获，冬天储备。遵循这个规律，就收获丰富，违反这个规律，就生活困难。说天道无私，就是自然界的阴阳变化按照规律运转，并不因人的行为而受影响。但是人的行为却要遵循天地的阴阳变化规律，违反则自己受损，与天地无关。所以两者之间，人要顺从天地。

故阴阳四时者，万物之终始也；死生之本也；逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。

从阴阳则生，逆之则死；从之则治，逆之则乱。

《素问-四气调神大论》

这里对几种天体的主要影响做一下介绍。

2.1、太阳四季波动变化

2.1.1、正常人顺应四季变化的规律

一年阳气波动对人体影响的规律是：春夏时，人整体阳气增加，且阳气由内出外；秋冬时，人整体阳气减少且阳气由外入内。这是类似大海潮汐的一种波动。

五月之时，阳气在表，... 阳气内微... 十一月之时，阳气在里...。

《伤寒论-辨脉法》

是故冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。

《素问-脉要精微论》

人体阳气的活动，白天多倾向于体表，夜间多倾向于体内，随着昼夜阴阳的消长而产生相应的变化

《黄帝内经讲解-阴阳对立统一规律》

认为人体阳气的活动能对天气的变化，随时作出应答反应……天热则腠理开，阳气外泄，故汗出而小便少；天寒则腠理闭，阳气内敛，故汗少而小便多，这正是通过阳气的适应性反应实现的。

《黄帝内经讲解-人与自然变化的关系》

这种波动是自然界施加给人的干预力量，无法避免，只能顺应。

人体为了保持体内的阴阳平衡，必须顺应这种变化，这就需要神恰到好处的调控精、气、津血等要素以配合。

春夏，受自然界阳气变化影响，人体的阳气增加，经脉扩张。此时，人要通过自身的调节，增强脏腑的工作，让津血也增加，并逐渐向肌表汇集。这与春夏之时，自然界会增加降雨、农民种地要浇水是一个道理，也即内经所说的“阳生阴长”。此时，自然界热量、水分增加，植物可以发芽、成长。人的阳气和津血都增加，就可以让血脉通畅、形体健壮，也就是实现了前述养阳的目的。

秋冬，人体的阳气减少，津血也减少，脏腑可以休息藏精，即内经的“阳杀阴藏”，自然就实现了养阴的效果。

“阳生阴长，阳杀阴藏”是指四季是以偏阳的太阳能量波动为主导，偏阴的水土波动进行跟随，逐步营造春温、夏热、秋凉、冬寒的动态平衡的自然环境。自然界的生命随着这种波动进行年复一年的生、长、收、藏的生命活动。人的体内也是这种变化。春夏的时候气血充盈以养形体，秋冬时气血缩减以养脏藏精，所以内经说人虽以天地之气生，但是却以四时之法成。

上述人体顺应自然四季变化的过程，包含了本章第一小节谈到的两类波动关系，即局部部位的阴阳平衡以及气血资源的整体波动。人体顺应自然四季的变化需要其具备较强的阴阳调节能力。如果调节能力弱，在四季变化时无法适应，就会发生病证，具体见下面“病人不能适应四季变化的情况”小节。

通常四季的寒热转化是平滑的，并非突然变热或者变冷。自然生物与人体都会对这种变化进行跟随适应。但如果在某个时间点打破了规律，就会带来连锁变化。比如春天热的过早，自然界就会产生偏热的失衡，从而影响其中的生命。对于人体来讲，春热过早，人体热量突然增加却来不及增加津血与之匹配，就容易产生偏温热的失衡，即温病。

少阳主火，冬末春初，气候本应由寒而渐转温，如果出现过于温暖气候，属于“未至而至”的反常情况，所以，容易发生温病。

《温病条辨讲解-原病篇》

一年四季，气血的波动环环相扣。春天生发的气血，到了夏天壮大，供形体成长之用。夏天壮大的气血，供秋天收养之用。秋天收养之气血，通过精血互转，供冬天藏精之用。冬天所藏之精，再供春天生发气血所用。每一个环节如果出现问题，则既伤害本环节的脏器，又影响下一环节的功能。

故曰：冬伤于寒，春必温病；春伤于风，夏生飧泄；夏伤于暑，秋必痄疰；秋伤于湿，冬生咳嗽。

《素问-阴阳应象大论》

但天地动静，阴阳鼓击者，各正一气耳。是以彼春之暖，为夏之暑；彼秋之忿，为冬之怒。...

《伤寒论-伤寒例》

春三月，此谓发陈。天地俱生，万物以荣；夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生；生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。

夏三月，此谓蕃秀。天地气交，万物华实；夜卧早起，无厌于日；使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外，此夏气之应，养长之道也。逆之则伤心，秋为痾疟，奉收者少，冬至重病。

秋三月，此谓容平。天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴；使志安宁，以缓秋刑；收敛神气，使秋气平；无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。

冬三月，此谓闭藏。水冰地坼，无扰乎阳；早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得；去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺，此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。

《素问-四气调神大论》

春天，人的形体如大地解冻一般，经脉通道扩张，更多的气血充实于经脉。到夏天经脉中的气血已经充满，进入络脉、皮肤。到了长夏，经脉、络脉中的气血都已充满，开始向内充实到肌肉。春夏之时，肌表阴阳气血皆充足，很容易出汗。汗可以排出邪气。所以如果形体有邪气，春夏是很好的出汗排邪时机。

秋天，表皮气血减少。冬天，气血多藏于内部的骨髓与五脏。秋冬时，形体如大地冰封，经脉通道收缩，从内部获得的气血减少。但是因为前面春夏时送来很多精华储备，所以虽内部传来的气血减少，但是肌表自身也可产生一定气血。这个道理与人们秋天收获、冬天存储的道理是一样的。

岐伯曰：春者天气始开，地气始泄，冻解冰释，水行经通，故人气在脉。夏者经满气溢，入孙络受血，皮肤充实。长夏者，经络皆盛，内溢肌中。秋者天气始收，腠理闭塞，皮肤引急。冬者，盖藏血气在中。内着骨髓，通于五脏。是故邪气者，常随四时之气血而入客也。至其变化，不可为度，然必从其经气，辟除其邪，除其邪则乱气不生。

四季的五脏特性：春天精化气血由肝主导；夏天气血充养形体，由心主导；秋天气血收隐，由肺主导。冬天精气潜藏，由肾主导。

帝曰：藏象何如？岐伯曰：心者，生之本，神之变也；……通于夏气。

肺者，气之本，魄之处也；……通于秋气。

肾者，主蛰，封藏之本，精之处也；……通于冬气。

肝者，罢极之本，魂之居也；……通于春气。…

肝主疏泄而调畅气机，同时又主升发阳气，促进全身气血的流畅，这本身就具有生养人体之气的作用。

《黄帝内经讲解-五脏功能与形体组织、四时阴阳的关系》

五藏者，所以参天地，副阴阳，而连四时，化五节者也。

《灵枢-本藏》

人应该调节自己的作息与情志，以更好的适应这种养阳、养阴的变化。春夏应晚睡早起，多接触太阳阳气，保持心情舒畅、乐观积极。秋天的时候，应早睡早起。冬天的时候，应早睡晚起。秋冬宜意志安宁，平静内敛。

2.1.2、正常人不顺应四时规律的后果

内经推荐正常人按照四时的规律进行养生。如果违反，可能会有不好的后果产生。

故阴阳四时者，万物之终始也；死生之本也；逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。

《素问-四气调神大论》

正常人春夏应适度劳作。如果春夏过于休息，则形体未能得到足够的气血，而形体不健壮，护卫能力差，遇到自然界外感邪气，易被侵入皮肉

筋骨而形成血痹、风湿等病，甚至进一步内侵发展为五脏疾病。

正常人秋冬应该休养为主。因秋冬经脉收缩，阳气潜藏于内，而过度劳作需要产生大量的阴阳气血走向形体。这就如逆水行舟，需要消耗更多的精来转化阳气与气血。如此一来，一方面会导致脏腑藏精不够，不利于来年春夏养阳使用。另一方面也需要消耗更多的先天肾精，会缩短人的寿命。再有就是，冬天劳作出汗，皮肤腠理打开，寒气容易经皮肤而入，可能直接发为伤寒病，或者潜伏于体内，到春夏发为其它病。

冬时严寒，万类深藏，君子固密，则不伤于寒，触冒之者，乃名伤寒耳。其伤于四时之气，皆能为病，以伤寒为毒者，以其最成杀厉之气也。中而即病者，名曰伤寒。不即病者，寒毒藏于肌肤，至春变为温病，至夏变为暑病。暑病者，热极重于温也。是以辛苦之人，春夏多温热病者，皆由冬时触寒所致，非时行之气也。...

从霜降以后，至春分以前，凡有触冒霜露，体中寒即病者，谓之伤寒也。

《伤寒论讲解-伤寒例》

前面“天地平衡”章节谈到过自然界一年四季温度动态平衡。人体小自然也存在这种四季动态平衡。无论春夏秋冬哪个时间点，都有当时的温度平衡点。温度向上超过平衡范围为热病，也称温病；向下超过平衡范围为寒病。

以温病为例。春天的时候，人体的阳气受大自然的影响而增加。如果人体的津血阴气未能随之匹配增加，就会形成阳多阴少而失衡的格局。导致这种情况的原因有多种。前面提到一种情况是春天热的过早，津血来不及跟随。还有一种情况，就是冬天五脏藏精不足，到春天的时候，即便气候的转变是平滑的，也可能因精不足而无法转化更多津血以匹配阳气的正常增加，就产生了温病。如内经所说“藏于精者，春不病温”。

夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温。

《素问-金匱真言论》

如果冬季过于寒冷或人体不能顺时调养而使阳气泄，损耗了人体的阴精，那么到了春天，由于阴精不足，不能抵御温邪，就易患温病。

《温病条辨讲解-原病篇》

自然界四时阳气波动，人体阳气也随之内外波动。人应顺应这种波动来调节自身以进行养阳、养阴，就是“与万物沉浮于生长之门”。逆此波动，就如人逆着波浪的起伏而游泳，非常费力，肾精消耗速度快，人易病、早衰、短寿。

夫四时阴阳，万物之根本也，所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本。坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则荷疾不起。

《素问-四气调神大论》

2.1.3、病人不能适应四季变化的情况

前述健康人应顺应四时变化来养生。如果是原本不健康的人，其本身就某些虚实失衡，此时在四时阴阳变化的影响下，就会出现病症。有病应先治病，病愈再谈养生。所以当病证出现时，应结合天时与身体失衡情况，扶正祛邪恢复平衡，而不是不考虑人体状态，教条的认为某季节必然用某些调理方法。

《伤寒论》辨脉法章节中，谈到如果让病人过量出汗，则伤人体阳气，过度泄下，则伤人体阴气。人体阴阳两伤，则调节平衡的能力不足。在阴历五月份夏至前后，阳气的分布为表多里少。调节能力弱的人，里部阳气不足而无法自我补充，就会里寒。这样虽然天气很热，但是病人却要求多穿衣服且喜热饮，此时应补里部之阳。阴历十一月冬至前后，阳气表少里多。里部阳气多则需要增加里部阴气以达到平衡，里部阴气不足而无法自我补充，就会里热，这样虽然天气很冷，但病人却要求少穿衣服甚至饮冰水，此时应补里部之阴。

大发其汗，又数大下之，其人亡血，病当恶寒，后乃发热，无休止时。夏月盛热，欲著复衣，冬月盛寒，欲裸其身。所以然者，阳微则恶寒，阴弱则发热，此医发其汗，使阳气微，又大下之，令阴气弱。五月之时，阳气在表，胃中虚冷，以阳气内微，不能胜冷，故欲著复衣。十一月之时，阳气在里，胃中烦热，以阴气内弱，不能胜热，故欲裸其身。

《伤寒论-辨脉法》

病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也。身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

《伤寒论-11条》

以上说的是伤寒误治，使人阴阳两伤，不能顺应季节变化而出现的状况。推而广之，可知当人的调节能力过弱之时，就会随着四季变化而表现出特定的寒热现象。

春温夏热，元气外泄，阴精不足，药宜养阴；秋凉冬寒，阳气潜藏，勿轻开通，药宜养阳。

《神农本草经疏》

如春夏形体未养好，护卫能力弱，到秋冬的时候，肌表阳气过少，则畏寒怕冷，不能完成保护脏腑的功能。严重者，形体有风寒、瘀血、痰饮等邪气，春夏时未能借助天时排出，处于爆发疾病的边缘，到秋冬之时，气血内藏，形体正气减少，更容易爆发疾病，则此时也可以临时鼓动气血以缓解问题。秋冬本宜休息藏精，不宜驱动气血走向形体，但因形体问题紧急，只好行权宜之法，不得已而为之。

秋冬应该加强脏腑藏精。如过于开泄，精未能藏足，到来年春夏的时候，气血生发就没有来源。如果教条的认为春夏应该补阳气、多劳作以健形体，强行调动本不多的精转化气血，则犯虚虚之戒。此时应该视情况休息以养脏腑之精。春夏本不宜休息养精，但因秋冬藏精不足，也是不得已而为之。

如人表里皆有问题，里部五脏藏精不足，肌表护卫能力又弱，则“阳（形体）不能卫外，阴（脏腑）不能藏精”，就很危险了。此时应该按照“急则治标、缓则治本”的原则，酌情处理。

必须认识到，形体也好，脏腑也好，阳气能量与固、液、气态物质的平衡关系是最基本的。无论何时这种平衡关系出现失衡，都是必须要调节的。此时即便是违背了春夏养阳、秋冬养阴的规律，也不得不先处理这种失衡，否则可能没等到天年，人就先天折了。

2.1.4、小结

本节内容首先探讨了为什么春夏适宜养阳，秋冬适宜养阴，以及违背这个规律的后果。其次探讨了人体若不能顺应四季变化，可能产生的病证以及治疗原则。

养阳时，人之气血增加，充实于形体，有助于形体的健康。但是重点要认识到，气血流动之物从内部脏腑运动到外在形体的过程并不简单，需要消耗大量能量。如能在春夏时，借助自然界阳气的力量完成这个过程，就能节省自身能量的消耗。这是春夏养阳的意义所在。

另外，还要注意适度劳作与剧烈运动的区别。从内经与伤寒等经典的论述看，中医不提倡出大汗的剧烈运动，而提倡在养阳的时候适度劳作，可出微汗。劳作的目的是让气血波动到形体，以健壮五体。当出微汗的时候，说明气血已经行至肌表，腠理已经打开，持续一段时间即可达到养阳的目的。过度出汗的剧烈运动，消耗的气血过多，虽然形体可以得到很多的营养，但消耗的精过多，不利于养生。所以内经谈到春夏养阳的时候，说可以“广步于庭”，即多走路；《伤寒论》谈到汗的时候，说春夏宜汗，又说凡是出汗，以全身包括手足小汗潮润为标准，不提倡“如水流离”的大汗。

大法，春夏宜发汗。...

凡发汗，欲令手足俱周，时出似漦漦然，一时间许益佳。不可令如水流离。若病不解，当重发汗。汗多者必亡阳，阳虚不得重发汗也。

2.2、一昼夜的波动变化

一昼夜的阳气波动，原理与一年的阳气波动原理差不多，所以人应白天工作，晚上休息。昼夜阳气波动幅度不如四季大，所以中医常用四季变化来举例。

以一日分为四时，朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。朝则人气始生，病气衰，故旦慧。日中人气长，长则胜邪，故安。夕则人气始衰，邪气始生，故加。夜半人气入藏，邪气独居于身，故甚也。...

尽管昼夜阴阳变化的幅度不如四时，但同样具有类似的运动规律。张介宾说：“人身之阴阳，亦与一日四时之气同。故子后则气升，午后则气降，子后则阳盛，午后则阳衰。”

《黄帝内经讲解-正邪消长的昼夜节律》

阳气者，一日而主外，平旦人气生，日中而阳气隆，日西而阳气已虚，气门乃闭。

《素问-生气通天论》

2.3、月周期的波动变化

前述年周期，自然界阳气变化会引动人体的阳气变化。在内经中还谈到，一月周期，月圆月缺的变化会引动人体阴血的变化。

自然界海水受月亮的影响出现潮汐现象，人体内的津血等液态物质也有对应的潮汐现象。内经说，月满之时，自然界海水西盛，人体的气血波动于形体肌表，使肌肉充实，皮肤致密，毛发坚韧，腠理闭合，易生脂垢；月缺之时，自然界海水东盛，肌表血气不足，卫气消沉，肌肉消减，皮肤弛缓，腠理开泄，毛发摧残，肌肤纹理疏薄，脂垢剥落。

因此，月圆之时，肌表的气血充足，护卫能力强，邪气难以进入。反之，月缺之时，肌表气血不足，护卫能力弱，此时如有外邪侵袭，容易

深入而爆发急病。

人与天地相参也，与日月相应也。故月满则海水西盛，人血气积，肌肉充，皮肤致，毛发坚，腠理郄，烟垢著，当是之时，虽遇贼风，其入浅不深；至其月郭空，则海水东盛，人气血虚，其卫气去，形独居，肌肉减，皮肤纵，腠理开，毛发残，腠理薄，烟垢落，当是之时，遇贼风，则其入深，其病人也卒暴。

《灵枢-岁露》

天气温暖的时候，肌表气血的流动顺畅，适宜针刺调理气血。环境寒冷的时候，肌表气血的流动慢，不适宜针刺。这是“天寒无刺，天温无疑”。

月满的时候，肌表气血充足，针刺时无需用补法。月初生的时候，肌表气血少，针刺时不宜用泻法。月无光时，肌表气血过少，连针刺治法都不宜使用。

可以推论，环境寒冷的时候，即便月满也不适宜针刺，因为气血流动慢；月无光的时候，即使环境温暖也不适宜针刺，因为肌表气血过少。

是故天温日明，则人血淖液而卫气浮，故血易泻，气易行；天寒日阴，故人血凝泣而卫气沉。月始生，则血气始精，卫气始行；月郭满，则血气实，肌肉坚；月郭空，则肌肉减，经络虚，卫气去，形独居。是以因天时而调血气也。是以天寒无刺，天温无疑。月生无泻，月满无补，月郭空无治，是谓得时而调之

《素问-八正神明论》

以上是内经提到的针刺法与日月的关系。从中应能体会出阴阳的特点。阳足，为热量足，气血流动快；阴足为津血的量大。就像前述烧水的例子，水火具足才能产生足够的气，火不足或水不足皆不能正常工作。

2.4、其它周期的波动变化

除了上述波动变化外，中医还有六十年周期的五运六气变化。太阳系五大行星，每年地球与五大行星的距离发生变化，各个行星对地球天气、

地气也有一定程度的扰动。这种扰动可以对自然界的气候产生一定影响，也可影响地球生物的健康状态。好在其力度不算太大，如果是非常健康的人，其保持平衡能力强，受影响较小。而对于不健康的人，如果是虚证，其维持平衡的能力差，轻微的扰动即可以让其失衡发病；如果是实证，已经处于某方面失衡的临界点，在同类型扰动的加强下，也可能发病。如果疾病过重，这种扰动甚至可以成为压倒骆驼的最后一根稻草。

岐伯曰：岁木太过，风气流行，脾土受邪。民病飧泄，食减体重，烦冤、肠鸣、腹支满，上应岁星。甚则忽忽善怒，眩冒巅疾，化气不政，生气独治，云物飞动，草木不宁，甚而摇落，反胁痛而吐甚，冲阳绝者，死不治，上应太白星。...

气相胜者和，不相胜者病；重感于邪则甚也。

《素问-气交变大论》

星体随年份变化影响天气、地气的情况是比较复杂的，内经中已经进行了规律总结，大约就是以六十年为周期，不同的年份对六气和五运各有不同的作用，或加强或减弱。光明教材《黄帝内经讲解-运气学说》是专门讲述这方面的知识，有兴趣的人可以自行参考。

此外传统文化中，还有风水中的三元九运一百八十年周期，《皇极经世经》的元、会、运、世十二万年周期，而佛学中的成、住、坏、空周期更长。这些波动变化周期已经超出普通人的寿命，不属于常规中医的内容范畴，也不在此处探讨。

2.5、小节

本节谈到了天体相关的各种波动变化，看似复杂，但是核心原理还是一个，就是能量与物质固、液、气这四大要素的平衡。天体的波动力量大多为一种干预因素，对一种或者多种要素有干预力量。

如果有利因素叠加在一起，对人就有很好的帮助作用。不利因素叠加的时候，就有很大的危害作用。内经《岁露》谈到，年、月、四季三个周期叠加，若某时三个因素皆对人有利，称为三实，此时人抵御外邪的能

力非常强。若某时三个因素皆对人不利，称为三虚，此时外邪就非常容易侵入人体。三虚之时，即便没有其它致病因素，也可能出现暴病暴死。

有寒温和适，腠理不开，然有卒病者，其故何也？...

黄帝曰：其有卒然暴死暴病者，何也？少师答曰：三虚者，其死暴疾也；得三实者邪不能伤人也。黄帝曰：愿闻三虚。少师曰：乘年之衰，逢月之空，失时之和，因为贼风所伤，是谓三虚。故论不知三虚，工反为粗。帝曰：愿闻三实。少师曰：逢年之盛，遇月之满，得时之和，虽有贼风邪气，不能危之也。

《素问-岁露》

对于这些波动中的一些不良干扰，如果人自身的正气强大、平衡控制力强，就可以抵御，反之若正气弱，则稍有干扰就会发病，甚至死亡，所以最终还是要回归“积精全神，修身养德，正气存内，邪不可干”。

3、年龄增长的相关波动变化

3.1、气血与形体的关系变化

从人的一生角度看，气血与形体都有波动性。

与成人相比，孩童形体幼小，气血也少，容易感受外界邪气而发病。其气血与形体相比，气血超过形体基本需求，所以生命力强，喜动。因气血相对较多，所以当形体遇到损伤的时候，其自我修复力强。

青壮年，形体长成，气血也充沛，两者配合比较合适。

老年气血衰减，形体也随之衰弱，两者相比，气血少于形体需求，所以喜静。

岐伯曰：人生十岁，五脏始定，血气已通，其气在下，故好走；二十岁，血气始盛肌肉方长，故好趋；三十岁，五脏大定，肌肉坚固，血脉盛满，故好步；四十岁，五脏六腑十二经脉，皆大盛以平定，腠理始疏，荣卫颓落，发颇斑白，平盛不摇，故好坐；

五十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始减，目始不明；六十岁，心气始衰，若忧悲，血气懈惰，故好卧；七十岁，脾气虚，皮肤枯；八十岁，肺气衰，魄离，故言善误；九十岁，肾气焦，四脏经脉空虚；百岁，五脏皆虚，神气皆去，形骸独居而终矣。

《灵枢-天年》

3.2、精神与气血的关系变化

随年龄的增长，气血衰减的根本原因是先天之精越来越少，以肾精为代表的脏腑藏精也逐渐减少，则脏腑产生气血的能力越来越弱，其供给给全身的气血能量越来越不足，也就是正气在逐渐减弱。正气减弱，则排除邪气的能力也下降，于是身体中积累的痰饮、瘀血等邪气越来越多。正气减少，邪气增多，人就逐渐衰老，疾病增多、变重。

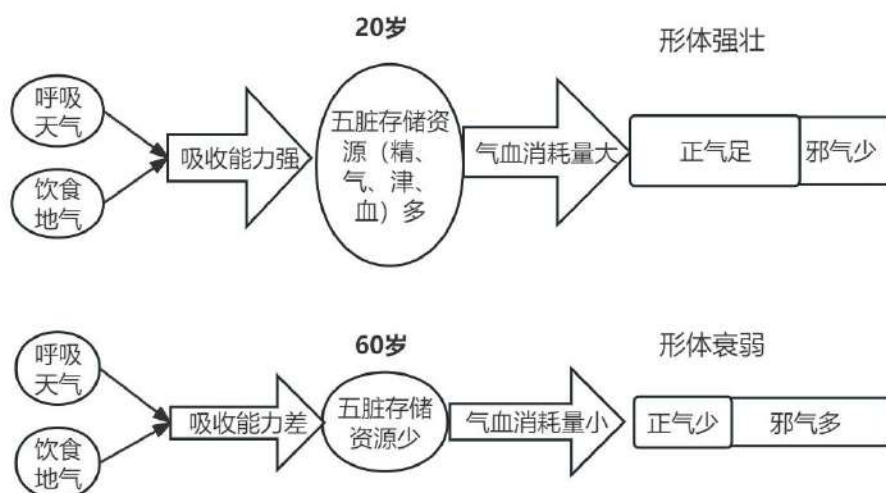
年四十，而阴气自半也，起居衰矣。年五十，体重，耳目不聪明矣。年六十，阴痿，气大衰，九窍不利，下虚上实，涕泣俱出矣。

《素问-阴阳应象大论》

五脏所藏之神也需要正气的滋养，随着精、气、血、津液的减少，神获得的滋养也减少。同时再加上邪气增加的干扰，神也就开始变弱。神变弱对外表现为感知、记忆、思辨、执行、志向等智力行为都下降；对内则是对气、血、津液的调控管理能力下降。这样我们就理解了为什么年轻时意气风发的人，到了老年容易变得糊涂、悲观、胆小、恐惧等等。

血、脉、营、气、精、神，此五藏之所藏也。至其淫佚离脏则精失，魂魄飞扬，志意恍乱，智虑去身。

《灵枢·本神》



孩童天真无邪，神思不乱，所以神足；孩童肾精中的先天之精充足，精可补充一身的阴阳。

老人则相反，精、神都衰弱，脏腑功能下降，产生的气血不足以供养形体，所以行动迟缓，齿枯发落。虽然可以靠药物对脏腑虚实进行一定的调节，但是因其自身精神的调节能力已经很差了，所以效果也是有限。

总体来说，人的精神气血，在前半生可用“有余”二字概括，即精神气血超过形体基本需求；后半生可用“不足”二字概括，即精神气血不能满足基本需求，人出现衰老之像。前半生尚可适当消耗多余的气血追求身外之物。后半生应保养精神气血以养护形体健康。这就是人一生的气血、精神波动趋势。

3.3、得病性质

从得病的病证性质来说，一般青少年因五脏较健康，气血较足，所以病证大多偏阳证。而中老年因五脏开始衰弱，气血不足，所以病证多偏阴证。但现在由于社会习惯的影响，比如喜食冷饮、熬夜、滥用抗生素等等，使年轻人也容易五脏受邪发病，所以年轻人得阴证的情况也越来越多。

小儿因思想简单，所以很少出现七情伤五脏的情况。但其形体较弱，容易外感风寒等六淫邪气，再有贪食无度，容易伤脾胃。外感邪气侵入肌

表后，大多进入足太阳经，也可传至手太阴肺。饮食无度多影响脾、胃、肠。所以中医总结其得病特点多为太阳病或者太阴病（脾、肺），即二太。

小儿病，多伤寒，稚阳体，邪易干。

凡发热，太阳观，热未已，变多端，太阳外，仔细看，遵法治，危而安。

若吐泻，求太阴；若吐甚，变风淫；慢脾说，即此寻。

阴阳证，二太擒，千古秘，理蕴深，即痘疹，此传心，谁同志，度金针。

《口诀-医学三字经-小儿》

以上是根据年龄特点对得病性质的概况，但不要拘泥于这些结论。小儿或者年轻人可有阴证，老年人也可有阳证，都需要仔细辨别才可做结论。

3.4、年龄与医药的关系

精是最好的药物，神是最好的医生。无论脏腑形体何处有虚实失衡，精、神皆可进行调节。精神充足，则正气充足，普通病邪难以深入，人一般无大病，有病也容易治愈。若精、神不足，一旦得病，小病易变大病、大病容易死亡，需要有高明的医生做精细的对证调节，才能治好。如果遇到鲁莽的大夫，胡乱攻补，小则伤身，重则送命。

黄帝问曰：余闻古之治病，惟其移精变气……岐伯对曰：……此恬淡之世，邪不能深入也。…

当今之世不然，忧患缘其内，苦形伤其外……内至五脏骨髓，外伤空窍肌肤，所以小病必甚，大病必死。…

上古……理色脉而通神明，……所以远死而近生……。中古之治病……标本已得，邪气乃服。……暮世之病也……治不本四时，不知日月，不审逆从……粗工凶凶，以为可攻，故病未已，新病复起。

青少年的时候，精、神充足，需要医药的情况相对少；中老年，精、神衰弱，需要更多医药来辅助补充调节；到晚年，精神衰竭，单凭医药就无能为力了。精神是控制人体平衡的主体，医药是辅助精神来调节人体，所以积精全神是健康长寿的根本。

养生方法虽然以保养精气神为核心，但是以节欲保精为第一要义。因为精气神是不分割的统一体，存则俱存，亡则俱亡。精能化气，气能生神，精、气、神存在着相互依存、相互转化的关系，而精是神气的本源，所以《内经》有“积精全神”之说。

《黄帝内经讲解-养生学说》

4、小结

本章探讨了人体几大要素的波动情况。总体来讲，人的一生周期是以精的变化为主；年、日周期是以阳气变化为主；月周期是以阴气变化为主；这些要素波动，会导致人体的平衡发生各种变化。为了维持平衡，人体需要在神的主导下针对这些变化进行对应的调节。如果能够调节成功，则可以保持健康。反之，若不能调节，则生病。

至此，中医理论中人体运转的相关概念和原理基本探讨完毕。大家掌握了这些基础知识，我们才能基于这些知识做一些总结性的说明。

4.1、养生与治病的关系

养生：

养生是研究身体无病的时候，如何避免生病并且延长寿命的学问，主要包括积精全神、培养正气、躲避邪气的内容。养生需要做到以下几点：

1、神最重要。神以心情安静为平衡点，适度七情为正常。不要七情过度，不要失神。

2、精为其次。五脏藏精以精满为最好。积精应注意开源与节流。开源以强健脾胃为主。节流以节制房事，不过度劳累，心情平和，顺应自然

规律为主。精充髓满，可养神，可化生阴阳气血，自然正气充足，寿命长久。

3、形体不衰。形体的主要功能保护内在脏腑不被外界寒暑之气所伤，需要适度的气血保养。因此健壮形体与与五脏藏精为一对矛盾，所以需要养阳与养阴依次循环，不可偏废。

4、环境平衡。人体各处都有适度的能量与物质维持内环境平衡，即阴阳平衡。

做到以上几点，即神全、精足、形体正常、体内环境平衡，就是一个非常健康的人，可达到内经要求的养生标准。这是根本。

若人能养慎，...更能无犯王法禽兽灾伤，房室勿令竭乏，服食节其冷热苦酸辛甘，不遗形体有衰，病则无由入其腠理

《金匱要略-臟腑經絡先後病脈証第一》

治病：

治病是研究，在人体精生阴阳气血，以及阴阳气血传输、分布于全身内外，形成适宜内环境的过程中，出现阴阳失衡、正邪相争、升降失常等各类型病证后，如何调治的学问。

治病首先要恢复环境平衡。体内重要部位出现阴、阳、气、血中任何一个要素严重失衡的时候，必须将其调节回平衡范围。

其次为了增强排邪能力，促进组织器官恢复，治病时通常要将身体调节到正常波动范围内的偏养阳状态，类似自然界的春夏状态，所以治病常被称为“回春”。这种状态下，人体的各种机能都偏活跃，可以有更强的抗邪能力和自我修复能力。要注意，这种状态是在阴阳气血皆平衡的范围内，适度增加阳气，使身体内环境呈现偏阳性的波动。营造这种养阳状态，既不能无限制的加热，也不能不考虑阴液的数量。如果无限制的加热，就相当于向自然界过度增加太阳的热量，即使有水也会被晒干；如果不考虑阴液的数量，就相当于期望给沙漠加热就获得春天的森林。两者都是错误的。因这些关系比较微妙，很多优秀中医虽会应用，但用理论解释却很难。

当身体处于这种养阳状态的时候，人体正气较足，可以自主排出一些邪气。如果再结合一些直接去除风寒暑湿、痰饮、瘀血、积食、积聚的祛邪手段，一般的疾病都会很快治愈。病愈之后就可以进入调养阶段，让身体进入平衡范围内的养阴状态，以恢复养阳时消耗的精津血。

养阳的目的有二：一是体弱时，健壮形体以卫外；二是有病邪时，增强正气以排邪。其它时候，应注意养阴藏精。若总是维持养阳状态，虽看起来一时的状态好，但五脏之精消耗较快，有短命之虑。《伤寒论》为治病之书。当病证发生时，常需用阳药激发元气、消耗脏精以抗邪。有人只学伤寒，不学内经，不明人体小自然阴阳平衡之道，每每用阳药后，短时觉得身体状态好，就容易形成依赖阳药的习惯。这种行为会加快肾精的消耗速度，属内经所说的“若春无秋”、“阳强不能密，阴气乃绝”。有的中医治病虽好，但寿命不长，部分原因在此，大家引以为戒！

凡阴阳之要，阳密乃固，两者不和，若春无秋，若冬无夏，因而和之，是谓圣度。故阳强不能密，阴气乃绝，阴平阳秘，精神乃治，阴阳离决，精气乃绝。

《素问-生气通天论》

治病过程比较消耗精与神，所以最好是能够养生，做到不生病且寿命长久才好。治病是靠外力调节人一时的、局部的失衡。养生是人自身维护长久的、整体的平衡。治病相对养生，是不得已而为之的下策。

每个人都应该理解人体小自然的概念，最好还能学会这个小自然失衡时的判断方法和调节方法，这样可以把健康把握在自己手中。但是因中医诊治技术比较复杂，并非所有人都能掌握，所以生病时求医在所难免。这就需要了解求医时的一些相关事项。

4.2、关于求医

中医的治疗实际上是医生帮助病人管理身体的健康，帮助病人打赢其体内正邪相争的战争。这个过程中，除了医药力量外，病人本身的思想、作息也是非常强大的干预力量。这个力量不受控制，就不能保证治疗结果。所以需要医者与病者相互密切配合。医者应透彻的掌握诊治原则与

方法，即医道与医术，做一个合格的中医。病者应该积精全神以配合，做一个合格的病人。两者缺一不可。

然而遗憾的是，合格的医者和合格的病人都有较高的门槛。

从培养医生的角度看，中医的传统教育内容繁杂，重于术而轻于道，需要学生有极高的悟性才能融会贯通医道。同时还要有大量的实践来掌握医术。较高的门槛导致成材率不高，高明的中医比较少见。

从病人角度看，现在社会，各种力量为吸引人们的关注，以“声色名利”动人心神为能事，造成很多人的神是乱的。其生病不知调神养精，只想靠医药治疗，甚至想靠医药来维持其错误的生活习惯。这边医生刚刚调理好平衡，那边神又耗精乱气，病情反反复复。还有一些人，例如古代的皇族，以权力压制、利益诱惑等手段控制医生，要求其按照自己的认知进行治疗。这种做法颠倒了医患之间的主次关系，使医生在治疗过程中束手束脚。

服药不如方法，纵意违师，不须治之。

《伤寒论-伤寒例》

这些状况造成中医诊疗活动中经常有不合格中医或者不合格病人，所以时灵时不灵、碰运气、看缘分的情况非常常见。

合格中医看病，都要先观察一下病人的精、神状态。这两个要素，调节起来难度较大。精中的后天之精还可以通过健脾胃、调饮食、益精髓药物来补充，若先天之精耗尽，天年已到，医药没什么办法。而神主要与道德修养、内环境状态和外在刺激有关。如果神的失常是由内环境失衡引起的，可以通过医药对内环境进行调节而治愈。如果神的失常是与外界事物的纠葛引起的，医药只能起到辅助作用。精、神是人体的基石。基石不牢，大楼一碰就倒。若精衰、神乱，会导致各处脏腑经络的各类虚实失衡纷纷出现，顾此失彼，很难治疗。如果精、神尚可，对于一般的正邪失衡，合格的中医还是有很多办法的。

病人应该学习中医基本知识，提高认知水平，才能与合格的中医配合好，获得较好的效果。不懂道理的病人，当治疗中出现阴证转阳证之类

的波折时，是难以理解并且配合治疗的。在生死大病面前，如果认知不同，即便亲密如父母子女也是难以沟通的。

第七章 判断人体失衡情况

前面介绍的是中医理论下人体运转的基本原理。基本原理清晰后，我们就可以进入诊断、治疗的环节。诊治内容较多，本章初步对诊治的道理进行说明。

1、诊断基本原理

前面介绍了人体的要素包括精、神、元气、气、血、津液、形等，这类要素的失衡就称之为证。判断要素失衡状态的过程称为辨证。中医辨证的原理主要包括以下两方面：

1) 有形与无形的关系

人体几种要素中，精、神、元气能量、气态物质属于肉眼不可见的要素，称为无形之物。血、津液、形体属于肉眼可见的有形之物。无形之物难以观察测量，有形之物易于观察测量。有形与无形的物质相互作用，可以通过有形之物的状态反推无形之物的状态。这个原理就像风吹旗子，风为无形的空气流动，其风力大小无法直接观察，但是我们可以根据旗子被风吹后的表现，来判断风力的大小。

2) 内与外的关系

人体内外有别，有形的物质虽然容易观察，但若隐藏在人体内部，则观察也是有难度的。但人是一个整体，内在的失衡必有外在的表现。如果掌握了内在失衡和外在表现的关系，就可以通过外在表现判断内在状态，这就是中医“有诸内，必形诸外”、“司外而揣内”的道理。

以我知彼，以表知里，以观过与不及之理，见微得过，用之不殆。善诊者，察色按脉，先别阴阳，审清浊而知部分；视喘息，听音声，而知所苦；观权衡规矩，而知病所主；按尺寸，观浮沉滑涩，而知病所生。以治无过，以诊则不失矣。

《素问-阴阳应象大论》

基于以上两点，把无形转化为有形，把内在转化为外在。搜集人体外在、有形的表现，来判断人体内在、无形的状态，判断精、神、元气、气态物质、血、津液等要素的平衡或者失衡，这就是中医诊断的道理。比如五脏之气本无形，但其外溢于全身，作用于腹背、五体、面部、经络、五官等处，就可以通过诊查这些部位了解脏气状态。再如五脏之液虽有形，但藏于内部不易观察，就可以通过泪、涎、唾、涕、汗、尿等外在表现进行间接判断。

人体外在、有形的病态表现称为“症”，内在各要素的失衡称为“证”。在中医中，这两字同音但内涵不同。

证，是机体在疾病发展过程中的某一阶段的病变部位、原因、性质，以及邪正关系的概括。因此，证是反映疾病发展过程中，某一阶段的病变的本质，所以它比症状对疾病的揭示更全面、更深刻、更正确。

《中医学概论-辨证论治》

无论中医、西医，诊断的原则都是要把内在、无形而难以观察的要素状态，通过某种方法转化为可以方便观察的状态。科技界发明了很多检测工具，比如CT、核磁等。这些工具扩展了人的观测能力，可以在一定程度上更清晰的显示某些内在要素状态。从观察角度看，这是值得肯定的事情。

因中医的“司外揣内”法属于间接判断，学习的难度很高，不易掌握，所以中医也希望有某些设备，能够更准确、直接的显示构建人体内环所需的精、神、能量、固液气态物质等要素的状态。但是因科技发展的局限，现在这类工具还达不到中医的要求，其检测结果对中医有一定参考价值，但对具体的辨证、用药指导性并不强，所以目前中医主要还是使用传统方法，通过外在表现来间接的判断内在状态。以后，如果科技设备可以清晰的诊查精、神、能量、气血等要素状态，中医会非常欢迎。

2、诊断基本常识

中医收集人体外在表现有一套成熟的体系，即大家熟知的“望闻问切”四诊。这四诊概括了人体各方面的正常与异常表现。这些外在表现与内

在要素的基本关系，就是中医诊断的基本常识。

这方面的内容比较多，这里只能介绍一些初步内容，从判断精、神、气、血的角度讲起。更详细的内容需要学习《概论》的四诊章节、《口诀》的四诊、《内经》的诊法、《伤寒论》的脉法等等。

2.1、判断神的状态

神藏于心，外候在目。

判断神的状态主要看双目。目光明亮、眼神灵活、目中润泽，目睛清莹，了了分明，此为神气充足。若是两目呆滞、目光晦暗、蒙混不清，是神气不足的表现。瞳仁散大，为肾精不足或将竭；瞳仁固定，为精绝神亡。

其次看神志是否清楚、反应是否灵活、说话是否有条理、发音是否清亮等等。

另外，注意是否是假神的情况。假神是指久病而重危的病人，突然精神转佳，言语不休，索饮索食，呼吸平匀，如同常人，这种假象，称为假神。假神往往是回光返照，很可能短时间即告死亡。

2.2、判断精的状态

精有先、后天之分。先天之精在肾，后天之精在脾。

肾的功能主生殖、主骨。

从生殖角度，当男子溢精和女子月经来潮的功能出现问题的时候，标志肾精不足。

从主骨角度看，齿为骨之余，肾主骨，精生髓。所以精开始不足的时候，先从牙齿上体现出来，松动掉落。进一步不足的时候，从骨骼上体现出来，老年人弯腰驼背、容易骨折。到比较严重的时候出现肩垂，项倾，腰折，膝败，脊骨突起的现象，称为大骨枯槁，表明肾精已经衰弱到相当严重，预后不良。

脾主消化吸收，主肌肉。

从消化吸收角度看，当人的饮食能力下降，标志脾精开始不足。

从肌肉角度看，当出现肌肉不结实、人中沟变浅缩短的情况，代表脾的能力下降。严重的出现臂、腿、臀等部位的肌肉失养、瘦削，称为大肉陷下，则代表脾精衰败。

骨为肾所主，肾为先天之本；肉为脾所主，脾为后天之本。如果人中沟深而长，面部肌肉高厚，轮廓方正，面部上、中、下三部耸起而不平陷，肌肉丰满，骨骼高起者，则提示先后天精气皆旺盛，所以人能长寿，活百岁而终其天年。

《黄帝内经讲解-寿夭与先后天的关系》

2.3、判断气血的状态

中医判断气血的内容最多。这里简单介绍：面色、脉象、舌诊等几种方法的大概原则，算是索引，具体要参考教材诊断的内容。

2.3.1、面色

面色包括面部的颜色和光泽。一般来说面色光泽明亮，为身体气血充足的表现，即使得病，问题也不大。

张三锡说：“五脏六腑之精华，上彰于明堂，……但当求其有神，虽困无害，神者色中光泽明亮是也，脉有胃气，同一理也。”

《黄帝内经讲解-色脉互参》

为什么面部的色泽能反应人体气血的状态呢？因为人体脏腑与经络相联，全身的经络都与面部相联。只有脏腑正气充足，功能强健，邪气很少，才能在面部体现出光泽明亮的状态。

天有五气，食入入鼻，藏于五脏，上华面颐，

肝青心赤，脾脏色黄，肺白肾黑，五脏之常。

《中医诊法 中药 方剂口诀-望诊》

十二经脉，三百六十五络，其血气皆上注于面而走空窍。

《灵枢-邪气脏腑病形》

具体面部不同的部位与脏腑的关系，内容也比较多。《概论-诊法》不太详细，应该参看国医大师孙光荣主编的《口诀浅释》的望诊部分。

两眉之间，名为印堂，又称阙中，在面部中间的最高之处，是相关肺病的部位；印堂的上部，名为阙上，阙上到头发边缘，名为天庭，天庭处在整个面部最高最上的地方，是相关头面疾病的部位；阙上处在天庭和印堂之中，所以是相关头面及咽喉疾病的部位，印堂略向下，在两眼之间，名为山根，又称下极，是相关心病的部位.....

《口诀浅释》

2.3.2、脉象

诊脉是非常重要的诊断方法。人体的气血流转全身，与邪气相对抗，其状态会反应于某些动脉跳动之处。通过感受这种动脉跳动，可以了解体内的正邪状态。

脉诊的知识比较多，传统的讲解方法不够简单明了，导致大多数人都觉得的很难。我将在以后的诊治部分中系统整理脉诊内容。

2.3.3、舌象

舌象也是一种重要的诊断方法，属于望诊的一种。舌象主要包括舌体与舌苔两部分。舌体就是舌的肉质部分。舌苔是舌头上的那一层苔。两者合称舌象。舌象可以反应人体的气血状态。舌体代表固液态的地气，舌苔代表天气。

体内的精、元气、血、津液等要素正常时，体现在舌象为：

舌体颜色粉红、质地润泽、柔软灵活、无裂纹、厚薄适中、边缘光滑、形状标准；

舌苔颜色淡白、干湿适中、薄薄一层、全面覆盖舌体。

反之各要素有失衡时，在舌象上有对应变化，比如气热则舌苔黄、血热则舌体红、气血不足则舌体颜色淡白、津血亏则有裂纹等等。

详见《中医药学概论-望舌》、《口诀浅释-吴坤安察舌辨证歌》

舌诊是一种简便的诊断方法，每个人都应该掌握。

2.4、小节

诊断总的原则是，无论望色、切脉、舌诊还是其它方面，我们都需要先知道正常人的情况是如何的，比如*正常的面色是怎样的？正常的脉象是怎样的？正常的舌象是怎样的？*然后才能知常达变，通过病人面色、脉象和舌象与正常情况的区别，来分析人体内部虚实失衡的部位、性质与程度，并施以补泻的调理方案。然后再根据调理后面色、脉象、舌象的变化，来确定调理方向是否正确。如此反复，最终调理到正常为止。

除了上述色、脉、舌的诊断外，其它的诊断多与部位的功能有关。比如肌表有护卫身体的功能，该部位失衡就有对外界寒热感受的异常。脾胃有消化饮食的功能，失衡则有多食或者不能食的异常。肺有呼吸的功能，失衡则有咳喘的异常。如此等等，具体可参看《概论》的辨证章节。

中医关注的外在表现很多，大方面包括舌、脉、目、面、发、齿、唇、鼻、耳、皮、肉、筋、骨、渴、饮、食、便、寒、热、睡、汗、精神、体力、头、颈、项、背、胸、腹、肩、腰、手、足等等，每个大方面下面还有各种小指标。这些指标各有意义，可与内在各个部位的环境、功能相对应，从而反应内在平衡或者失衡状态，属于诊断基本功。算下来至少几百个指标需要学习并能熟练应用，这不是一个简单的东西。

...既要抓住重点，又要了解一般。不抓住重点，就抓不住疾病的辨证关键，会造成辨证时无所适从；不了解一般，又会遗漏病情。

《中医药学概论-问诊》

诊断知识需要系统学习，全面掌握。诊断知识掌握不全，临证就容易发生漏诊。明明病人已经有某个明确外在表现表明内部的失衡情况，

医者不知，必然不能正确辨证，也就谈不上正确治疗。所以诊断基本功是否扎实，是专业人士和业余人士的关键区别。中医专业人士对外在表现非常敏感，比如面色变化、舌象变化、脉象变化、寒热变化、声音变化、形体变化等等，会立刻联想到人体内部的阴阳气血精神问题。而业余人士则没有这个能力，经常纠结于一些粗浅的表面症状，对关键表现却视而不见，自然无法进行系统的辨证分析，也无法给出正确解决方案。

合格的专业中医师都应该具备证、诊、治三位一体的能力。所谓证、诊、治三位一体，是指医生能够根据三项之一推断出另外两项。比如根据外在表现推断出证型与治法，或者根据证型推断表现与治法，或者根据方药推断出证型与表现。三者之间通达无碍。要想获得这种能力，学习者需要进行系统学习和大量实践。三者中，尤以由诊到证的环节最为复杂，也就是辩证最难。好在现在光明中医网校提供了ai人工智能辅助辩证的功能，可以大大降低了辩证的难度。

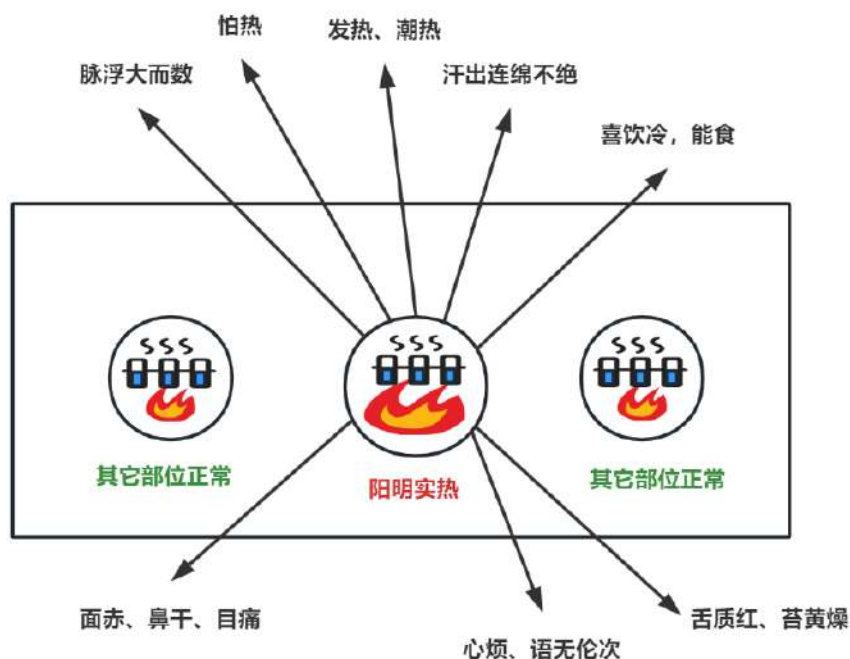
3、从多个角度判断一个证

中医的“司外揣内”是根据人的外在表现判断内部状态，因其属于外在间接判断，而不是直接看到到内在状态，因此，难免有一定误差。这就像我们通过汽车的故障灯判断发动机的故障，大多时候是正确的。但如果灯本身出了故障，发动机坏了而灯不亮，或者发动机没坏反而灯亮，这样就会出现误判。因此，尽量从多个角度进行判断。如果多个角度的外在表现都指向了某个部位的某种失衡，那么误判的可能性就要小多了。所以中医一直强调要尽量多的收集四诊信息，只凭脉，或者只凭舌象都是不够严谨的。

比如对阳明部位实热的判断。阳明部位包含胃经、大肠经及相关胃腑和大肠腑，其功能是负责饮食的消化和废物的排出，所以阳气很足。实热的含义是该部位正气不虚，多出了无形的热邪。

判断这种情况的几个角度，从脉象看应浮大而数且有力；因里热外传，对外界寒热的感受应该是怕热，体温角度可能有发热或潮热，且发热不随汗出而减轻；汗的角度可能有大汗，汗出连绵不断，《伤寒论》称之为“汗出濇（jì）濇然”；因胃热，所以渴饮方面应该是口渴、喜欢喝

冷饮且能够大量饮入，饮食方面应该是能食；从舌象看有舌质红而舌苔黄燥；因阳明经络通于面部而有面赤、鼻干、目痛；热邪过盛影响到心可导致心烦，严重可出现语无伦次、神识昏糊、狂躁不安（谵语）；体力方面应为有力；热邪严重，蒸发肠胃津液可能造成便秘。



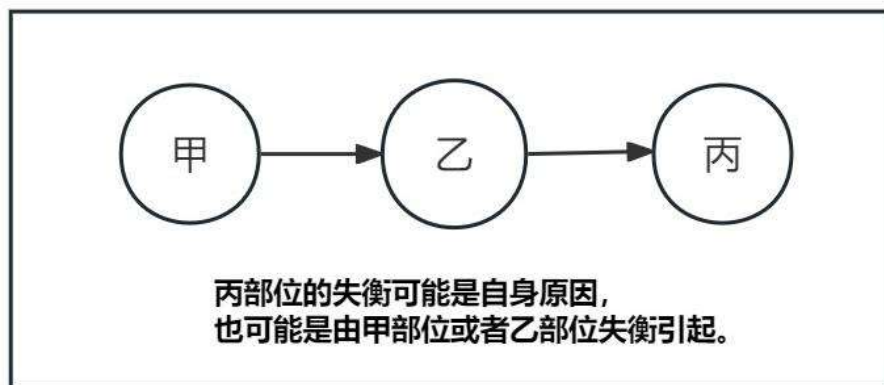
如果一个人同时具有上面这些表现，就说明多个角度都指向是阳明热实的情况，辨为阳明实热证就比较有把握。如果只有一、两个表现，则要谨慎，再分析分析是否有其它可能。

人体的目、面、舌、脉搏及各种生理功能就像汽车的故障指示灯，能够表示出内在指标的各种问题。但是因为指示灯本身也可能失灵，为了防止不被单一的指示灯误导，我们要收集尽量多的指示灯信息，进行综合判断。如果多个指示灯都指明是同一内部故障，才能比较准确的确定故障位置和性质。

有时还会出现不同的指示灯表达了相反的故障信息，这时要根据经验判断哪个指示灯表示的问题更准确，需要进行取舍，并在后继的调理过程中进行观察，判断取舍是否正确。这就是“舍脉从证”或者“舍证从脉”。

4、功能之间的逻辑关系判断主证

外在表现正常需要一系列内部器官协同工作，这些器官的功能构成了一种串联的逻辑关系。若出现某种病症，则需要排查相关各个内部环节，寻找哪个环节出现了哪方面的问题。排查过程需要更多信息。比如家里的灯不亮，如果其它电器正常，就是灯本身的问题。如果其它电器也没电，那么就可能是家里的电路问题。如果邻居家也没电，那就可能小区变压器问题。如果通过这类排查确定了是小区变压器问题，这就是确定了病位。下一步还需要查看变压器是失火、受潮还是短路，这就是确定病性。确定了病位、病性才能给出解决办法。只有灯不亮这一个信息，是无法确定病位、病性的，必须结合其它信息。



人体的饮食、呼吸、睡眠、大小便、护卫肌表、精神、体力等功能都是如此。这些功能若正常，代表体内相关一系列器官工作协调。人体每个器官都与其他器官有多种关系。比如肺脏。肺与其他四脏有能量方面的五行生克乘侮胜复关系；肺与脾在物资的传递上有接受脾上升的营气的关系；肺与肾、膀胱在水气循环方面有接受下焦蒸腾上升的水气的关系；肺与大肠有废物排出的表里关系；肺与皮毛有宣发水气营养皮毛的关系；肺与肺经有肺气入经的关系等等。因为有这些关系，如果相关部位先出现失衡而功能失常，那么肺也会跟随出现失衡。也就是如果某个器官出现失衡，就会引起相关的器官也出现失衡，并且继续延伸引发连锁反应。因此，如果某外在功能异常，比如呕吐、哮喘、失眠、便秘

等等，我们并不能立刻定位根本问题在哪个部位，需要通过更多的症状来缩小范围，寻找根本原因。下面举几个例子说明：

病证的性质，往往由几个相关的症状共同揭示。临证中任何一个症状，均需其他症状而限定。因此，一个症状只有放在症状之间去考察，方具备其揭示病证本质的功能，方赋予临床意义。

《中医临证程序与辩证思维方法-诊察》

1、怕冷：

卫气负责护卫肌表，如果散布于皮肤表面的卫气不足，就会出现异常的怕冷。但是此时我们还无法判断原因在哪里。因为卫气产生于脏腑，传输于经络，通过肌表腠理散布于皮肤表面。其产生、传递、散布的过程中，任何一个环节有问题都可以导致表面卫气不足。这就需要更多的信息来帮助定位。

如果怕冷还兼有发热，因发热往往表明肌表的正气比较充足，说明这个怕冷不是因为内部产生的卫气不够，而是肌表的问题。反之，如果怕冷不兼发热，则很有可能是内部产生或传输到肌表的卫气不够。这就是《伤寒论》第7条“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”的含义。这里的“发于阳”指的是根本问题在肌表，“发于阴”指的是根本问题在内在的脏腑经络。

病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳，七日愈；发于阴，六日愈，以阳数七阴数六故也。[7]...

注家对“发于阳”主要有三种说法，一是指太阳中风，中风初起即有发热恶风寒。二是指发于太阳，太阳病多是发热与恶寒并见。三是指发于阳经、发于三阳，是阳证，凡以发热为主要特征的，都是阳气抗邪有力的反映，所以都属阳证，是三阳经病。注家对“发于阴”也有三种说法。一是指太阳伤寒，太阳伤寒初起常以恶寒为著，而不见发热。二是指发于少阴、少阴病，阳气虚衰，故以无热畏寒为主要特征。三是指发于阴经，发于三阴，是阴证，凡以恶寒为主而不发热的，多是阳气虚衰，抗邪无力

的反映，所以都属阴证，是三阴经病。此三说皆对临证有指导意义。

《伤寒论讲解-7条》

人出现怕冷有很多原因，这里以受风寒侵袭为例进行分析。人体在肌表感受风寒后的正常表现应为气血向肌表波动，正邪相争于肌表而使身体发热，正气战胜邪气，通过自主出汗将邪气排出体外。汗后，邪气排出，发热等异常症状消失，身体恢复正常。如果未能按此进程发展，则为病态，需要医药帮助。

受风寒之后，出现怕冷兼发热的症状，说明是“发于阳”，即根本问题在肌表。此时要再看有汗、无汗。

如果怕冷兼发热而无汗：此时无汗是皮肤汗孔腠理被寒邪闭合，卫气无法通过汗孔散布到皮肤表面，就会导致怕冷。卫气无法散布于外而郁集于皮下，所以可能发热比较重。严重的话，皮肤腠理闭合，影响肺气向肌表的宣发功能，可能会出现喘的现象。由此，恶寒、发热、无汗而喘这一组症状，就成为“寒邪闭表”的典型表现（此时脉象应为脉浮紧）。这里的病位为肌表，病性为寒邪实证，治法用麻黄汤。此时寒邪阻碍经络气的运行，可能会造成身痛、腰痛等各种痛症，这种痛症是辅助症状，不作为用药的主要依据。

风寒客于人，使人毫毛毕直，皮肤闭而为热，当是之时，可汗而发也。

《素问-玉机真藏论》

太阳病，头痛、发热、身疼、腰痛、骨节疼痛、恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。[35]...

这八个症状，可归纳为发热，恶风寒，诸痛，和无汗而喘三组，“恶风”是“恶寒”的互词，这是寒邪伤阳，温煦失司所致。发热是寒邪闭表，阳气被郁而不得发泄所致。...寒主收引，寒主痛，寒邪袭表，使营血涩滞，筋脉拘紧，故见诸痛。...”“无汗”乃因寒邪闭敛毛窍所致，是伤寒表实证最具特征性的表现。...无汗为表闭，表闭则肺气不宜，肺不宜乃生喘。

《伤寒论讲解-35条》

如果怕冷兼发热且有汗：汗出而身体未恢复，不适症状仍在，这是不正常的，表明这个汗没有排邪，是病汗。有汗代表汗孔腠理没有被闭合，有热代表肌表阳气并不衰弱。卫气并不缺少，且可以通过汗孔到达皮肤表层，所以怕冷不会那么厉害。营卫相协而行，营行脉中，卫行脉外。营血与卫气互相配合才能正常完成功能。如果两者配合不协调，可导致异常出汗，即营卫不合的病汗。如果这种营卫不合是肌表受风邪影响而产生的，就有怕冷、怕风、发热、汗出的表现，用桂枝汤发微汗，调和营卫治疗。

太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

[12]...

太阳中风是风邪袭表，营卫不和，卫强营弱之证，治当解肌祛风，调和营卫，唯桂枝汤是至当之方，所以说“桂枝汤主之”。

《伤寒论讲解-12条》

病常自汗出者，此为荣气和，荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。[53]...

但卫阳行脉外而固护营阴，营阴行脉中而资助、制约卫阳，营与卫，内与外相合而不相离。今营行脉中，卫行脉外，相离而不相合，卫不固营，营阴失护而外泄，故用桂枝汤发汗以和营卫，使二者相合则自汗可止。

《伤寒论讲解-53条》

所谓“调和营卫”，即调和人体气血以增强人体生理调节、代偿及抵抗能力；所谓“解肌”，即解除人体肌表因致病因素作用而产生的障碍，以增强人体肌表调节体温的能力

《温病条辨讲解-上焦-风温-四》

如果只怕冷，不发热，说明是“发于阴”，问题应在内在脏腑经络，再去寻找相关功能失常的表现协助判断。

以上是对相对健康的人感受风寒原理的粗略分析，主要是想说明中医根据功能逻辑关系判断病位的思路，即单纯一个怕冷的症状不足以判断病位病性，需要一组症状相互印证才能定位。对于原本就不太健康的人，比如原来就有阳虚、阴虚、湿气、内热等问题，则还有更多考虑，需要根据特定的表现进行辨证和治疗。像《伤寒论》346条的死证，发热、汗出不止伴随有下利（拉肚子）。有下利，说明里部阳不足，里部阳不足而表部有发热，说明表部这个热不是正气充足，而是阴盛格阳、孤阳外越。此时汗出不止，这个汗就不是正常的排邪外出，也不是营卫不和，而是营卫不足加虚阳外越，不能正常控制汗孔和营血。这种情况的关键问题在里部阴阳离绝，脏腑已经不能正常工作，是非常危险的。

伤寒六七日，不利，便发热而利，其人汗出不止者，死。有阴无阳故也。[346]...

今下利，发热同时并见，可知“发热”非为阳气来复，而是阴盛格阳，孤阳外越的假象。如果此时又见汗出不止，则是阳气外亡而营卫不固之象，终致有阴无阳，阴阳离绝，多难救治，故曰“死”。

《伤寒论讲解-346条》

2、便秘：

大便是由大肠部位的食物糟粕和适度的水混合而成。如果出现干燥的情况，有多种可能，比如肠胃的热过多或者水不够等等。如果此症状同时伴有“口渴喜饮冷水”、“怕热”等表现，就有可能是阳明肠胃热量过多，蒸发水液而造成的，也就是阳明热实的证型。若没有这些表现，反而有“不太能吃饭”、“小便不顺畅”，且大便只是开始的时候干燥，后面又稀溏，那就比较符合阳明部位阳虚寒实的证型。此时是脾胃寒不能正确的消化吸收饮食（水谷不别），所以产生大便先干后溏的现象。这种胃寒的便秘和前面胃热的便秘，原因截然不同，治法正好相反。如

果不仔细判断，就犯虚虚之戒。其它还有气虚、血虚等原因形成的便秘，都是需要综合判断，具体可参考《中医内科学》的“便秘”章节。

问曰：脉有阳结阴结者，何以别之？答曰：其脉浮而数，能食，不大便者，此为实，名曰阳结也，期十七日剧。其脉沉而迟，不能食，身体重，大便反鞭，音硬，下同。名曰阴结也，期十四日当剧。

《伤寒论-辨脉法》

阳明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濇然汗出，此欲作固瘕，必大便初鞭后溏；所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。
[191]

《伤寒论-191条》

如“便结”一症，只有放在口渴欲冷饮，烦躁，溺短赤，脉数诸症状中方提示该便结属热。若单独讲便结，则无法确定其属性。因此，便结一症便失去了临床意义了。

《中医临证程序与辩证思维方法-诊察》

3、阴虚口干：

当人体津液不足，也就是阴虚的时候，往往有口干燥，严重会口渴的情况。这种情况，大家直觉上会认为需要滋阴补水。但是实际上，阴虚的原因有多种，不可一概而论。

首先，当人受到外界温热邪气的影响，或者自身的元气过度时，会在体内形成热盛伤阴的格局，导致津液消耗而口干渴。以暖气的例子来理解就是因为火过大而烧干了水。这就是温病的产生机理。此时的根本原因在温热邪气，应祛除邪热、补充津液，需根据情况决定祛热和补津的比例，具体参考温病的治法。

其次，当人出大汗或者泻下过度的时候，体内津液会大量流失，导致出现阴虚的情况。此时的主因是津液的流失，所以治法主要就是补充津液。

肺痿之病，从何得之？师曰：或从汗出，或从呕吐，或从消渴，小便利数，或从便难，又被快药下利，重亡津液，故得之。

《金匮要略-肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》

再次，一些阴虚是因为胃、肠、脾、肺、肾、三焦、膀胱等水液代谢器官因虚实失衡而减弱运输水液的能力，就会造成其下游部位不能获得足够的水液而形成局部阴虚。这类情况，直接补阴是无效的。就像家里水龙头不出水，可能是水源真的不足（缺阴），也可能是加压的水泵坏掉（缺阳），也可能是水管堵塞（邪气）。如果是水管堵塞，补水是没有用的，必须疏通水管。此时应调理这类功能障碍，恢复水液代谢功能。恢复相关器官的运水功能，人体就可以自行补阴，直接用补阴药反而补不进去。

这些水液代谢器官的失衡性质虚实都有。

虚类，比如脾阳虚或者肾阳虚的时候，就会因阳虚不能蒸化水液，造成水气流转障碍而出现口干渴的现象。此时可用补阳的方法恢复器官阴阳平衡，然后其运水功能恢复，缺少的水液得到补充，口干渴现象消失。这种治法，后世称为“扶阳阴自回”。

如临床上的阳虚水饮证候，反而出现口干，口渴，但渴不欲多饮，或喜热饮等表现，是因为阳虚不能化水为津，津液不足，故出现口干等现象。

《中医药概论-阴阳学说在中医学的应用》

不少人在临床上一见口渴，便谓阴虚内热，多用养阴生津之剂，有如吴氏原注中所谓：“今人见渴投凉，轻则用花粉、冬、地，重则用石膏、知母，全然不识病情。”用药无效。我们在临床治疗中，只要在辨证上确属因寒生湿，由湿困脾。而在临床上表现为口渴的患者，恒遵吴氏“饮家反渴，必重用辛”的治疗原则，效果甚好。例如我们在西医诊断为“干燥综合征”及糖尿病患者时，有的用丁呋桂附理中汤，有的用加味理中汤，有的用金匮肾气丸，效果都较好。

《温病条辨讲解-下焦-寒湿-五十》

一妇女教师 62 岁，患“干燥综合症”8 年，先用激素疗法无效。口干无津，饮水愈多，干渴愈甚，... 舌光红如去膜猪腰子，唇干裂，口舌疮频发。曾服... 养阴增液之类... 不效。... 以大剂参附汤直温命火，... 10 剂后... 舌上生出薄白苔，津液满口。...

除温热伤阴之外，则在杂病中阳虚气化不及，津液不能蒸腾上达，便是病根。

《李可老中医急危重症疑难病经验专辑-重症结核性腹膜炎合并胆囊炎》

实类，有时器官失衡性质为邪气堵塞，比如痰饮之气堵塞肠道、三焦等部位，使水气的升降传输失常，也会导致需要的地方得不到水而产生阴虚。此时需要用祛邪的方法恢复平衡。

三焦水道不通，升降机能窒塞，则水饮停滞而腹部胀满，水不化气而口舌干燥。

《金匱要略讲解-痰饮-二十九条》

先渴后呕，为水停心下，此属饮家，小半夏加茯苓汤主之...

因停饮致渴，终因渴饮更益其饮而致呕，故当治饮邪而不必治其渴，以饮去则呕止；津通则渴自己。

《金匱要略讲解-痰饮咳嗽病脉证并治第十二》

以上几种情况虽同为缺水，但病因不同，则治法不同，不可混淆。因未明此理，有人一见口渴，就用治疗温病的寒凉滋阴法。此法对功能障碍导致的阴虚无效甚至加重。其中一些人未反思自己辨证不明，却说温病治法无用。也有人走向另一个极端，一见口干渴，不加分析就认为是阳虚不化水而进行补阳。这些人遇到确为实热造成阴虚的情况，就属于误用阳药，必然进一步伤阴，严重可导致阴虚血热、吐血、暴亡，或者患上西医急性白血病类重病。总之，若不清理人体运转的道理，只根据寥寥几个症状就妄谈寒热补泻，非常容易走偏。

4、小结

以上怕冷、便秘、阴虚三个例子，都说明出现某个问题，原因有多种。这就需结合其它表现来进一步进行筛查，找出真正原因。其它像血虚原因可能是外伤失血，也可能是内部造血不足；瘀血原因可能是外部跌打，也可能是内部气未能推动血正常运转；湿气原因可能是外部环境湿气入侵，也可能是内部水气运输问题；生痰的原因可能是肺的宣降水气功能障碍，也可能是脾的运化功能障碍。

各种显而易见的外在病症表现都可能有更深层次的本质原因，所以咳嗽不一定用止咳药、呕吐不一定用止呕药、失眠不一定用安眠药、疼痛不一定用止痛药、痰饮不一定用祛痰药。正虚不一定直接补正，有时是需要解决自身产生、传输正气相关环节的问题。邪实不一定直接泻邪，有时是需要解决排邪能力和排邪通道相关环节的问题。

人体自身就有维护平衡的能力，研究病证的第一件事情是要分析这种能力为何没有正常工作？理解这些需要对人体的运转原理、各器官的功能、器官之间的相互关系非常熟悉，并有扎实的诊断基本功。

自然气候潮湿可以影响人体正常生理功能而产生病理产物成为“湿证”；人体正常生理功能低下也可以产生病理产物成为“湿证”。

《温病条辨讲解-中焦篇-湿温 寒湿》

先哲曰：“见痰休治痰，见血休治血，无汗不发汗，有热莫攻热，喘生毋耗气，精遗勿涩泄，明得个中趣，方是医中杰”。

《中医内科学-治病求本，对证施治》

按：中医先贤常说不可见病治病、见证治证，其意为不要被表象迷惑，应探求本质。很多学习者一辈子也理解不了这句话。究其根源，是对人体的运行原理不清晰，对其中涉及的各种因果关系理解不透彻。造成这种现象与中医对理论的讲解过于模糊有主要关系。此点，中医界确应反思！

5、总结

本章主要包含四个部分内容，如果把人体比喻成一座大楼的话：

第一部分：因为我们不能进入大楼去观察其水、电等要素的运转情况，所以我们只能通过大楼物资进出情况以及各种外在表现来间接判断，也就是“司外揣内”。这是中医诊断的基本原理。

第二部分：为了能全面判断大楼的情况，我们需要系统掌握大楼各种内部要素状态与外部表现的基本关系。这就是中医诊断的基本常识。

第三部分：为了辩证准确，在掌握诊断基本常识的基础上，需要从多个角度互相参照才能比较准确的判定内在的问题。

第四部分：在掌握辩证基本能力后，还要根据大楼的内部运转机制进行逻辑分析，寻找多个内在问题中的最根本问题，即定位主证。

诊断的内容散落于内经、伤寒等经典以及后世医家的书籍之中，需要反复研读、记忆、实践。熟悉中医诊断的内容，可达到看透人体的效果，让人的健康状态无所遁形。

我们要求中医学习者在了解寒热虚实、精神气血等基本概念后，必须**系统掌握**诊断的内容。如此，才能及早觉察精、神、阴、阳、气、血层面的失衡变化，在失衡比较轻微的时候就可以提前预知疾病的发生，不必像普通人那样，要等到疾病发展至形质变化阶段，重要功能失常，感受到痛苦，才能重视并治疗。这也是中医“治未病”的原理。

当组织器官实体形状发生病态变化时，往往体内环境要素失衡已经比较严重。变化初期，如果病人洗心革面，戒掉不良习惯，调整思想、饮食、作息，积精全神，再配合正确的中医疗法，扶正祛邪，恢复气血平衡，尚有自我修复的可能。如果形质变化严重，通过调理身体环境的方法来让形质恢复正常所花费的时间是比较长的。此时，若形质变化已经成为失衡的主要矛盾，直接处理形质失衡之处也是一种选择。

中医治病有“一剂知，两剂已”的说法，意思是用药对证的话，常可一剂药即感受到变化，两剂药就可治愈疾病。这种情况是指对内环境的调节可以非常快速迅捷，而形质的变化显然不是一两天能够转化回来的。

初学者因掌握的知识不全，经验不足，非常容易在重要方面发生漏诊。比如病人本有里部五脏虚弱，又复有外感，如果只看到外感，未能发现里虚，只用了治疗外感的方药。治疗外感的方药往往要调动里部气血走向表部，这样会造成里部虚上加虚，就犯了虚虚之戒，形成严重的里部失衡，有可能给病人造成严重伤害。像桂枝汤为补充气血且驱动更多气血走向肌表的方剂，适合于里部无病，表部气血虚的情况。但是如果里虚较重之人，服后则气血过于走表，导致里部虚上加虚，可能会出现咽干、烦躁、呕吐、手脚凉、脚抽筋等表现。这种情况，应该先解决里部之虚证，然后再解决表部的问题。这就是中医“虚人外感先建其中”的原则。

伤寒，脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝欲攻其表，此误也。得之便厥，咽中干，烦躁、吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳。……

《伤寒论-29条》

此足证虚人伤寒当先扶正而不可发汗的原则，对临床的指导意义很大。后人对虚人外感的治法，也有许多发展，如助阳解表，益气解表，滋阴解表，养血解表等等，但对于虚人，即使是使用这些扶正祛邪的方剂，也应谨慎为是。

《伤寒论讲解-50条》

系统学习中医的意义就是能够全面的看待人体，避免出现因医误病的情况。全面看待人体需要收集足够多的外在表现，也就是“四诊合参”。否则，如果漏掉一些关键症状，必然导致辨证结论的片面，进而导致治疗的失败。中医不应轻率给出方药。因为方药一出，就代表开始对人体的状态进行调整。如果前期辨证不明，就容易错误的选择方药，给病人带来伤害。《伤寒论》中说“观今之医，不念思求经旨…相对斯须，便处方药”，说的就是这种情况。

前人云：有是症则有是病。对病人所反映出来的症状要不厌其多，资料越多越有利于辨证。因此，可以说诊察是辨证论治的起点。

观今之医，不念思求经旨，以演其所知，各承家技，始终顺旧，省疾问病，务在口给，相对斯须，便处方药，按寸不及尺，握手不及足，人迎跌阳，三部不参，动数发息，不满五十，短期未知决诊，九候曾无仿佛，明堂阙庭，尽不见察，所谓窥管而已。夫欲视死别生，实为难矣

《伤寒论-序》

光明教材中的《概论》、《内经》侧重于基础理论的论述。《本草》、《方剂》是以证为起点，介绍一证或者多证共存时，相关的表现和典型方药，属于战术知识。《伤寒》、《金匱》不但在局部诊治方面非常经典，而且对病证的轻重进退和治疗次序介绍的比较详细，所以对理解中医治疗战略帮助极大。《温病条辨》则是在热、湿、阴虚等方面对伤寒、金匱进行补充。内、外、妇、儿等专业课是以病种为索引，讲解某病可能为哪些证引发，以及相关的辨别与治疗经验。《口诀》课程是以上内容的浓缩，尽量简洁以方便学习者背诵记忆。《口诀》内容大家应能背诵，最起码也要熟读、熟听。实际临床中，各种证型组合颇多，且随着治疗进程随时变化，应该活用教材内容，随证治之。

中医提倡积精全神、培养正气，不生病，或者将疾病消灭于萌芽状态。不提倡平时不注重养生，等五脏虚实重症已成再进行治疗。但真遇到重症病人，中医也不应束手无策。治疗此类病人，推荐参考《李可老中医危急重症疑难病经验专辑》一书。重症病人的病证，其病位深、程度重、病性复杂、变化快，新手很难处理。作者李可老中医被称为中医ICU，具有丰富的重症治疗经验。他从实践的角度，验证了依据中医基本理论治疗重症的有效性，所依理论内容包括依证不依病、治局部考虑整体、扶正祛邪、病证轻重转化、精神为本等等方面。李老对中医诊治方法的应用已达极高水准，此方面可以为师！因该书侧重重症实战，其所用名词及内在思路，皆需在掌握中医基础知识后才能真正读懂，所以应定位为学完教材后的实战辅导书。重症用药偏性较大、剂量也大，如果没有系统学过教材，没经过实践，很难驾驭这类猛药，一旦用错就会引发事故，切忌！！

附录

附1：再论中医的阴阳概念

所有中医经典书籍中都大量包含“阴阳”二字，如何准确理解“阴阳”一词是学中医必须面临的问题。遗憾的是，传统中医界对阴阳的解释总是不够简单、清晰，造成的结果就是几乎所有中医学习者对此都疑惑不解，很多中医一辈子行医，会用阴阳名词看病用药，却说不清阴阳到底是什么。

笔者在论坛与中医学习者讨论阴阳的时候，发现绝大部分中医学习者是困惑的，有人以为阴阳是一种不可琢磨、不可描述的玄幻的事物，也有人认为阴阳是二分法，不能描述六气、五行等非二分的事物。说明阴阳定义不清的问题实为中医学习的最大障碍。

本书第一章虽然对阴阳做了浅显的解释，但因篇幅所限，没有引经据典做更有说服力的阐述。因此这里再详细说一下。

阴阳的疑惑古人早已有之。《灵枢》阴阳系日月篇，黄帝问，十天干之甲，在五行中，以东方甲乙木为春，春对应人体的肝，是足厥阴。那为什么该篇中又说甲为左手之少阳？

岐伯回答，两者不是指一个事物。甲对应左手少阳，是在天地阴阳的范畴内比较阴阳。甲对应足厥阴肝经，是在一年四季变化范畴内比较阴阳。进而做了更明确的阐述，说“阴阳”有名无形。意思就是阴阳只是代号，并无确定所指的事物。如果想落实阴阳具体含义，必须先明确何种事物及其机理。在此处，分别是指天地交互和四时变化两种事物。

黄帝曰：五行以东方为甲乙木主春。春者，苍色，主肝，肝者，足厥阴也。今乃以甲为左手之少阳，不合于数，何也？岐伯曰：此天地之阴阳也，非四时五行之以次行也。且夫阴阳者，有名而无形，故数之可十，离之可百，散之可千，推之可万，此之谓也。

内经《素问》阴阳离合篇，黄帝提问，说天阳地阴、日阳月阴，这些都是二分，为什么三阴三阳是六分，与二分不同？岐伯回答，阴阳虽

然用两个字表达，但是实际上用十、百、千、万都可以，甚至可以分成无数份，并非一定是阴阳两分。选择哪种划分方法主要取决于如何描述更简单、更有益于解决问题。

黄帝问曰：余闻天为阳，地为阴，日为阳，月为阴。大小月三百六十日成一岁，人亦应之。今三阴三阳不应阴阳，其故何也？岐伯对曰：阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数，然其要一也。

《素问》五运行大论篇，说有天地阴阳，也有人之阴阳。人的阴阳相对简单，还可以计数。天地之阴阳过于复杂，不能以数来计算，只能以“象”来描述。这个象，指的是一种概括性描述。过于复杂的事情很难描述清楚细节，所以用一种概括性的词语描述其主要特征即可以。

岐伯曰：是明道也，此天地之阴阳也。夫数之可数者，人中之阴阳也。然所合，数之可得者也。夫阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，天地阴阳者，不以数推以象之谓也。

基于以上，我们可以知道，阴阳是一种抽象代号，可以代表万事万物，但具体代表哪个事物，需要落实到实际语境中。有了具体事物，在其运转过程中，才有各维度的平衡，随之才有主动与被动、高与低、明与暗、多与少、强与弱等阴阳关系。

比如汽车，从推动角度讲，发动机推动车轮转动前行，发动机为推动者为阳，车轮为被推动者为阴；从保护角度讲，车壳保护发动机不被雨淋日晒，车壳为保护者为阳，发动机为被保护者为阴。这里发动机在不同的功能中分属不同的阴阳属性。

再比如人体内在脏腑与外在形体相比较，内在脏腑为阴，外在形体为阳。但外在形体的筋骨与皮肤相比较，筋骨为阴，皮肤为阳。其中的筋骨在不同的比较方式下，就有不同的阴阳属性。

少师答曰：阴中有阴，阳中有阳，审知阴阳，刺之有方。得病所始，刺之有理。谨度病端，与时相应。内合于五脏六腑，外合

于筋骨皮肤。是故内有阴阳，外亦有阴阳。在内者，五脏为阴，六腑为阳，在外者，筋骨为阴，皮肤为阳。

《灵枢-寿夭刚柔第六》

即便是太阳。中医虽公认太阳属阳，其实也是默认谈自然界或者谈人体的情况下，因太阳带来了热量能量，所以属阳。如果把太阳放到整个银河系的范围内考虑，太阳也是跟随银河系的核心运动，属于从属者，属阴。

所以必须说清楚具体事物功能，否则阴阳歧义太多，没法学习。

还有阴阳二分的问题，以前面发动机推动车轮的例子来说，如果考虑更细一些，发动机到车轮之间还有传动轴，发动机、传动轴、车轮三者共同完成了推动车子的功能，这样就需要三分。所以阴阳二分也只是为了概括，涉及到具体情况，三分、四分、五分、六分、甚至更多都可以，无论怎么分，事物还是那个事物，所以说“其要一也”。这样大家就明白所谓五运、六气都在阴阳范畴之内，不必纠结于二分的问题。

阴阳只是一种描述事物的方法术语，与现代常用的术语本质没有不同。阴阳概念包含万物，自然也包括现代的各种科技成果。甚至西医也在不知不觉中使用阴阳术语，其化验病毒含量的时候，也使用阴性、阳性的概念，一般阳性代表超标而异常，阴性代表低于指标而正常。

如果愿意的话，大可以把现代生活中的各种事物用阴阳术语描述。比如一栋四层的楼，可以称下两层为阴，上两层为阳，第一层为阴中之阴，第二层为阴中之阳，第三层为阳中之阴，第四层为阳中之阳。如果是五层楼，可以设定下三层为阴，上两层为阳。下三层不好用阴阳二分，可以再设定一系列名词，用阴中之少阳、阴中之太阴、阴中之至阴表示。

如果是十八层楼，楼层太多，再这样表达就太复杂了，所以用低层、高层来表示就可以。这里低层、高层就是象，复杂事物用象来表示就很方便。

因阴阳所能表示的事物太多，所以不要再在概念上浪费时间，而应把阴阳落到实处，在天人合一的思想下，分析中医经典中每一处阴阳，其具体所指是何功能？阴阳之间是如何交互配合？如此方能一步步构建稳健的中医基础理论体系，也才能真正读懂黄帝内经。

比如内经讲“夫言人之阴阳，则外为阳，内为阴；言人身之阴阳，则背为阳，腹为阴；言人身之脏腑中阴阳，则脏者为阴，腑者为阳”，这里谈到的内外、腹背、脏腑，其阴阳交互合作的机理如何？这些机理如能明确，中医的治法会像常识一样简单。大家都知道天气热可在地上引入水源，这是天病治地；大地干旱可增加天空降雨，这是地病治天。两者都属于常识。如果理解了人体的几种主要阴阳关系，则中医的左病右治、外病内治，上病下治、脏病治腑、血病治气等治法也会变成常识。

要承认，中医中很多阴阳概念，其背后所指的事物功能还没有完全清晰解读，但知之为知之，不知为不知，把明确的概念说清楚，不明确的概念存疑待考。当遇到说不清楚的阴阳时，要明白之所以说不清楚，是因为我们对其所表达的事物、机理不清晰，所以必然无法解释。此时不必纠结，存疑即可。

明白阴阳的道理后，以后我们学习中医，遇到阴阳二字，就要思考其所指何事、机制如何？反之，遇到一些功能，即使没提到阴阳，我们也能想到如果用阴阳名词解释，何为阴，何为阳。

在我们教材《中医药学概论》的阴阳章节，说“自然界一切事物无不存在着相互对立的阴阳两个方面”。这个意思已经隐含了谈阴阳是基于“事物”而谈，也就是不同的事物有不同的阴阳。但是这个解释还不够透彻，应该进一步关注该事物的运转机制，以及维持其正常运转涉及的多角度的平衡。然后基于这些平衡关系，才能谈其阴阳波动与差异。这个问题没解释清楚，导致很多学习者没法透彻理解阴阳概念，在中医界逐渐形成了空谈阴阳的不良风气。空谈阴阳就是不谈事物，不谈其机制，不谈其平衡点，随意用阴阳胡乱解释问题，牵强附会。结果就是讲的人自己也不清晰，听的人更是糊涂。本该是此层面阴阳的配合问题，却用彼层面的阴阳解释与治疗，自然是错误的。不

同层次阴阳的混用，使阴阳概念成了空中楼阁，成为玄学、迷信的代名词，无法完成交流、传承中医知识的任务。在一些被错误理解的阴阳理论指导下，会形成一些偏颇的中医学派，危害不小。

阴阳学说认为自然界一切事物无不存在着相互对立的阴阳两个方面。如上与下、南与北、动与静、寒与热，以及动物的雌与雄等等，它们之间虽然或者为一事物内部的两个方面，或为相关联的两个事物，但它们有一个共同点即相互对立。

《中医学概论-阴阳的相互对立与消长平衡》

以前虽然阴阳概念不太清晰，但按传统的中医教育方法，即通过大量背诵、大量阅读、大量实践、拜师并且体悟等手段，也能培养一部分比较合格的中医师。只是这种方式门槛太高，产生优秀中医的比例太低。过于抽象的理论解释也使普通人理解中医非常艰难，难以形成坚实的群众基础。以前中医靠疗效来获得群众的认可，但现在受药材质量、医师证制度、法律制度的限制，中医的疗效传播效果大大受限。所以在当今时代，如果想传播中医，降低中医理论的学习难度势在必行，而阴阳的准确解释首当其冲。

附2：证与病的关系

本书全书都在谈人体的运转原理，运转环节失常的证，而并未谈病。原本觉得大家理解了证之后，自然会理解证与病的区别。但是根据读者反馈看，还是有不少人没有搞清两者的区别，所以这里进一步再说一下。

证与病的直接关系

中医说人体是一个小自然，用现代语言描述，就是人体由能源、控制、能量、固液气态物质等要素形成了一个适宜的内在环境。这个内在环境给各种实体组织器官的细胞提供生存条件。该内环境的失衡问题称之为证。这些失衡如果严重到影响人的重要功能，或者造成实体损伤，就会让人感受到痛苦，成为大众普遍认知的病。大多情况下，证是根本，病是证延伸出来的表象。

这就像树根缺水导致枝叶枯萎的时候，直接修复枯萎的枝叶是非常困难的，但是给树根浇水就能轻松解决。树根缺水为证。枝叶枯萎为病。证与病的关系大致如此。有时在病的层次上很难的问题，在证的层次上却非常简单。

每一种证都可能会出现多种病的表象。每种病，其在环境失衡层面的原因也可能为不同的证。证与病是多对多的关系，两者不在一个维度上。如前述树木的例子，水过少、过多，气候过寒、过热都可能造成枝叶枯萎。这里枝叶枯萎为病，环境的燥、湿、寒、热为证，所以一病可以对应多证。

在人体中，比如肝经通道产生湿热的失衡。当这种失衡很轻微时，人只是稍有不适，就难以被重视，也不被认为是病。当程度加重时，则肝经巡行的多个相关部位会出现实体损伤或者功能失常的病态表现，上可有口苦、目赤、耳聋耳肿、牙痛，中可有胁肋胀满疼痛，下可有小便淋浊、阴痒阴肿等。这些病态表现在现代定义中被区分为不同的病种，比如牙痛、耳聋、淋病等等，而从内环境失衡的角度看，此时是一个原因，即为肝经湿热。

夫相火寄于肝胆，其性易动，动则猖狂莫制，挟身中素有之湿浊，扰攘下焦，则为种种诸证。或其人肝阴不足，相火素强，正值六淫湿火司令之时，内外相引，其气并居，则肝胆所过之经界，所至之筋脉，亦皆为患矣。

《成方便读-龙胆泻肝汤》

反之，同一种病，比如耳鸣，多种证皆可以导致此病。因为通过耳部的经络主要为胆经、三焦经，所以耳部气血受两经络影响较大。如果其中某经，比如胆经火旺，就可能导致耳鸣。同时，肾开窍于耳。耳部的气血也受肾气的影响，如果肾气虚，也可导致耳鸣。也就是耳部发病可能与多个其他部位有关，所以其发病的根本原因就有多种可能。

中医的定位为辨别并治愈证，即为辨证论治。看起来是同为耳鸣的疾病，因其证的不同而治法不同，称为同病异治。看起来淋病与耳鸣为不同的疾病，如果其原因皆为肝经湿热证，则治法相同，称为异病同治。

辨证论治...既可看到一种病可以包括几种不同的证，又看到几种不同的病在其发展过程中可以出现同一种证。因此，在临床治疗时，还可以在辨证论治的原则指导下，采取“同病异治”和“异病同治”的方法来处理。

《中医学概论-辨证论治》

中医不是辨病论治。病名分中医病名和西医病名。无论中西病名，皆是通过某些局部特征命名，所以只能提供一些参考，都不能准确的反应病人的内部环境失衡状态，也就不能准确指导辨证。要想准确辨证，必须辅以详细的舌、脉等四诊信息。除一些病因单一、病性简单的疾病外，大多疾病的病态表现与根本原因之间都有多层因果关系，需要对证治疗，而非依病名用药。

如西医诊断的“阑尾炎”病，与中医的肠痈相似，为固态层面疾病。其虽为固态层面疾病，但产生原因却是该处阴阳气血等气液能量要素失常。而气液能量失常又有多种虚实性质以及底层原因，需要分析才

能确定。该病在《金匱要略》和《中医外科学》有论述，初起脓未成时，用大黄牡丹汤，后期脓已成用薏苡附子败酱散。这是热瘀邪实而正不虚时的治法，属常见情况。该病也有因阳气不足、寒气凝结而导致的情况，可用真武汤类方剂治疗。

化脓性阑尾炎初期... 大黄牡丹皮汤即为有效方剂之一... 然而，非热瘀互结者，用上述方药治疗，就离开辨证论治原则... 弦紧不数... 小便清长... 下亢阳虚，寒气凝结，结则不通，不通则痛。遂以... 真武汤加味治之... 虽然西医诊断为阑尾炎在先，但席氏仍以脉、舌、证合参，据中医学理论加以辨证。若拘于西医诊断出的病名，不遵循中医辨证论治，则必然治疗失误

《中医临证程序与临床辨证思维方法-不宜凭西医病名选取常用方》

再如前述耳鸣病，即便初步辨证其为胆经火旺，还要进一步分析胆经火旺的原因。是胆火自生还是肝火外传于胆？是否有年运季节、地理环境、情志过度、饮食作息类的更深层次原因？过旺之胆火本应从胆经或者肠道排出，为何其未能自行排出？是否有大肠淤堵，排邪不畅的原因？是否有其它看似与耳鸣无关的病证存在，比如脾虚、心火实等等。这些都需要综合考虑，才能找到真正的根源进行治疗，并且避免治疗此证的时候加重彼证。

证的变化与病的关系

证与病的治疗有时会有矛盾之处。有时证减轻，病反而会加重。如前所述，五脏正气增强，排邪而出的时候，从证的角度是好事，因为证从深转浅，但该人的皮肤湿疹等病反而可能加重。

很多人都不能透彻理解病与证的底层关系。其依病名用药治好一部分人，就以为该病用该药可以全部治好。实际上，病名即无法详细体现病人当前内环境失衡的状态，更无法体现治疗过程中，证的轻重进退变化。即便治疗一个小病，中医也应该依照人体运转机制，沿着精神、五脏、六腑、经络、筋骨、肌表的路径，依次分析其各部分是否平衡？如果某部分有失衡，则需判断其虚实状态如何？虚为何种正气

虚？实为哪类邪气实？如此对病人的总体状态有所了解后，才能在此基础上决定治疗次序，进行选方用药。用药后，需要时刻关注病人的病证如何变化？是转轻浅？还是转深重？再根据这些变化进一步调节，直至将内环境调节至平衡状态为止。如果简单根据病名或者寥寥几个症状就用确定方药，极可能有关键证并未诊出，从而导致误治、漏治。很多时候，虽是同一病名，但是因内部的失衡状态不同，用同样方药，一部分病人有好转，但另一部分病人就无效、加重、甚至死亡。

胸中若不证脉讲明，论方得法，但同庸俗，一概妄治，此杀人不用刃耳。非惟杀人功大，亦且阴鹭匪轻。

《伤寒家秘的本一卷之二》

如果根据病名就可以判断人体的寒热虚实，那还要中医的诊断有何用？只要西医诊断出癌症、肝硬化、心脏病，根据病名套方岂不是极简单的事情。事实上，老一辈中医早就在实践中证明，根据病名套方，会造成中医的疗效急剧下降，甚至犯虚虚实实之戒。

如患者宋某某...诊断为急性黄疸性肝炎。开始我们拘泥于急性黄疸性肝炎应属阳黄的认识，按阳黄湿偏重处理...3周后加，症状加重...经仔细观察分析，发现患者畏寒喜热...舌质淡嫩，苔白而腻，脉息无力...决定改投温阳散寒化湿之茵陈四逆汤...逐渐治愈。

《关幼波治肝病-病毒性肝炎黄疸证治-二、喻森山论阴黄证治》

对病与证关系的理解，会体现在一个医者的言行之中。在实际临床中，当一个医者轻率的说某病可用某方治疗的时候，我们立刻就知道，该人对人体的运转道理并不十分清晰，缺失了对人整体状态的分析。一个医者，如果具有清晰的中医思维，必然是先对人的整体运转进行认知，然后进行辨证分析，依证给出解决方案，不会有简单依病用药的言行。

一到病家，不先看脉审证，遂听病家自述病情，随即写药数味，曰：某汤主治。粗知大略，用某药能除某病，如此治病，则仁人

必深虑而痛恨之。

《本草害利-自序》

光明中医教材中基本没有单纯依据病名用药的内容。内、外、妇、儿、眼、喉各科中谈及的几百种病，包括感冒、中风、眩晕、头痛、便秘、黄疸、遗尿等等，都会附着辨证要点，提示需要辩证分析。不理解证的根本原理，不理解证与病的关系，是读不懂教材的。

《诊治入门》目录

常脉

1、脉的基础知识

1.1、脉的定义

1.2、脉跳动提供的信息

1.3、诊脉位置

2、寸口脉的基础知识

2.1、寸口脉部位

2.2、寸口脉的原理

2.3、诊脉的时间

2.3、诊脉的力度

2.4、脉与人体的部位对应关系

2.4.1、初步对应

2.4.2、更细的对应关系

按

3、人体正常脉象

3.1、标准气血平衡状态下的基准脉象

1、脉之柔和

2、脉之力度

3、脉之频率

4、脉之宽度

5、单个脉之长度

6、整个脉之长度

7、脉之流动来去

8、脉之起伏来去

9、脉之分布均衡

10、基准平脉

3.2、气血正常阴阳波动与差异的脉象

3.2.1、空间差异

3.2.2、时间波动

3.3、小结

4、阴脉、阳脉的含义

4.1、性质阴阳

4.2、部位阴阳

4.3、小结

5、总结

病脉

1、病脉类别

1.1、虚类

阴虚、血虚

阳气虚

营气弱

气血两虚

精伤

脏腑衰弱

阴绝阳绝脉

无胃气的真脏脉：

1.2、实类

1.2.1、邪气来源

1.2.2、邪气位置

1.2.3、邪气形态

1.2.4、综合

1.3、升降出入失衡类

1.4、小结

2、同样脉象在不同正邪势态下含义不同

2.1、伤寒的阴脉阳脉为病愈的情况

2.2、微脉在不同情况下的意义

1、阳证病人出现微脉。

2、阴证病人出现微脉。

3、治愈后出现微脉。

4、未病之人出现微脉。

5、其它杂病的脉微。

6、实证之微脉。

3、引申内容

革脉

衄脉战汗

脉浮迟不出汗而身痒

伏脉

数脉有正热邪热之分

4、其它

脉病与人病

脉平和而死

治病主导思想

1、关于孔窍通道

1.1、功能简介

1.2、孔窍闭、脱

1.3、闭、脱昏迷的判断与治法

1.4、小结

2、治病基本原理

3、汗吐下三法基本介绍

3.1、汗

鼻血：

3.2、吐

3.3、下

3.4、小结

4、治法汗吐下的应用原则

4.1、标准适用情况

邪气外来

邪气内来

小结

4.2、三种方法不可互相替代

该汗误下、该吐误下

该下误汗

该汗误吐

4.3、阴位不虚，阳位多处同时有邪气，应遵循次序

4.4、阴位虚而阳位有邪气

4.4.1、脏虚紧急补里为主

4.4.2、脏虚不急则阴位阳位同治

4.4.3、错误治疗

4.4.4、例外情况

4.5、小结

5、汗窍、口窍、二阴窍的异常表现

5.1、内热导致的持续汗出

5.2、阴证虚寒导致的吐、下异常

5.3、虚脱类的汗异常

5.4、肌表营卫不和的异常汗

5.5、小结

6、三种排邪功能的时间特点

7、总结

少阳病

1、少阳病原理

2、少阳病表现

2.1、部位影响。

1、胆经的巡行路线

2、三焦经的路线

2.2、功能影响

往来寒热

呕

利

3、少阳病治法

3.1、少阳本病

3.2、少阳与阳位病

3.2.1、少阳与太阳

3.2.2、少阳与阳明

3.2.3、小结

3.3、少阳与阴位病

4、小结

5、青蒿

痰饮证的分析

1、饮之成因

2、饮病总的治疗原则

3、饮在不同部位的分析

3.1、饮在胸部、胸膈（支饮）

3.2、饮在胁（悬饮）

3.3、饮在腹部（痰饮）

3.4、饮在四肢（溢饮）

4、其它

4.1、饮邪对于水气升降的影响

4.2、饮病在脉象的表现

4.3、支饮与渴、呕吐的关系

4.3.1、饮与渴的关系

4.3.2、呕与渴的关联

4.4、小青龙汤的分析

后记

1、写作说明

我从2008年开始学习中医，至今已有15年。期间学习各种中医书籍，一直似懂非懂，直到学习光明中医教材。学习教材期间虽然也有很多疑问，但是能明显感觉到教材编者们在努力培养学生的辨证论治思维。

在系统学完了光明教材的四大经典之后，恰逢母亲犯头晕病，一侧视力模糊。经医院CT检查，诊断为脑梗压迫视神经。我在为母诊断、治疗的过程中，反复查阅光明中医教材，最后用醒脑开窍、扶阳化湿的思路治好了母亲的疾病，视力基本恢复。在这个过程中，我比较透彻的理解了中医寒热虚实的道理，悟出了光明前辈的本意。

回首自己的学习过程，一方面感慨中医学习之艰难，另一方面也觉得中医理论的传统讲解方式过于晦涩难懂，耗费了中医学习者太多时间。学习中医，要过很多关卡，有基本原理关、诊断关、识药用药关等等。要说哪一关最难，还是基本原理关。任何人如不透彻理解中医原理，都很难对中医产生真正的信任。原理关一过，思路清晰，诊治只是经验的积累而已，虽也艰难，但有路可循。很多中医，一生行医浑浑噩噩，至死也未能真正通过原理关。

庄子说，“以道驭术，术必成，离道之术，术必衰”。中医原理就是道，中医诊治之法就是术。中医之衰落就是因为原理讲的不清楚，诊治方法却复杂而多变，导致疗效不稳定，也就变成了“离道之术”。写这本中医基础概念入门书，就是为了让后来的中医学习者能够打好医道的基础，少走弯路。

本书的定位是教材的补充，所以不求大而全，而是要把中医基本逻辑，以及原理中比较难懂的部分讲解清楚，方便大家学习教材，对于教材中已经讲解很完善的部分则没有必要重新再写一遍。所以本书没有过多的讲诊断与治疗，因这方面的内容太多，如果全讲，篇幅过

大。教材这方面讲的很好，内容丰富，而且都是经验丰富老中医的实战经验，后人很难超越。诊断与治疗是中医原理的延伸，大家只要理解了概念和原理，认真学习教材就可以学的很好了。

本书的写作标准是所有人都能看懂。如果以后有一天，我的孩子也想学中医，我希望他们也能通过这本书轻松的入门中医。为了达到这个标准，本书对于各种观点的表达力求浅显易懂，对于可能产生误解的地方，哪怕稍显啰嗦，也要多说几句。

俗语说“师傅领进门，修行在个人”。对于中医的学习而言，入门之后，还要不断的学习、实践。付出多少努力，就有多少收获，这方面其它人只能起到一点辅助作用，主要还要看自己。

因中医基础理论晦涩难懂，让人难以清晰理解阴阳平衡的道理，所以学习中医之人非常容易走偏。有人胆大，敢用猛药，可能治好一些重症沉疴，也容易造成事故。有人胆小，谨小慎微，该用重剂而不敢用，错失良机。有人偏阳，有人偏阴，有人偏脾胃，有人偏肝肾，造成中医流派纷呈。著名流派有伤寒派、温病派、火神派、寒凉派、脾胃派、滋阴派、温补派和柴胡派等等。学完本书，就应该明白，这些流派都是侧重于人体平衡的某个方面。门派创始人多为大家，可能为了纠正当时风气之偏或补前人之不足，而强调某一方面。后学者不懂，执着于门派之争，就变成盲人摸象。更有甚者喜欢逞自己的长处，贬低其它学派，以此来获取名声。这种人遇到适合自己门派的疾病，确实效果不错，遇到不适合的疾病，无论是治人还是治己，直到治死可能都不明白死因。

中医学博大精深，各种书籍资料汗牛充栋，内容良莠不齐。有人为了吸引眼球，语不惊人死不休。新手不具备辨别能力，如果盲目选择，就容易学偏。所以还是依据光明中医教材比较稳妥，毕竟教材所引内容是老前辈们集体筛选过的，比较中正平和，可以保证权威性。光明中医教材的内容是老一代中医毕生经验的无私总结，除了本书引用的部分内容外，具体病种方面，《内》、《外》、《妇》、《儿》、《骨》、《眼》、《喉》对各病种的辨证经验非常有价值。用药方

面，《本草》、《方剂》、《伤寒》、《金匱》、《温病》都需熟读。

本书的内容到此为止！至于更高级的诊治部分，我会与光明中医的学员们一同研究，把深奥难懂的教材内容用浅显的语言表达出来。如果内容达到一定的量，以后可以再汇集为一本新书。

后继相关信息将发布于下面这个链接：

<https://gmzyjx.com/qa/question/7012/>。

李文强

2023年1月1日

2：关于版权

经常有读者关心本书的版权问题，并询问能否将本书的内容转发到个人网站等等。这里统一回复一下：

本书定位为公益书籍，所以大家可以自由转发，不必担心版权问题。

但请注意以下几点：

- 1、转发不要断章取义。本书内容前后逻辑贯通，如需转发最好转发全部内容。如果只截取一部分，容易让人误解。如果条件所限只能转发部分内容，请一定注明书名、作者，以便读者能够查找来源。
- 2、不要将本书用于商业目的。本书内容免费向大众开放，所以不要用本书获取商业利益。如有商业方面的计划，请联系作者本人。
- 3、关于出版。本书已在国家版权局登记版权，但并未出版纸质书。原因是我不太有兴趣应出版相关的琐碎事务，如果读者中有熟悉流程的朋友愿意协助出版，我亦欢迎。

作品登记证书(电子版)		
登 记 号: 国作登字-2023-A-00295129		
作品名称: 中医概念入门	作品类别: 文字作品	
作 者: 李文强	著作权人: 李文强	
创作完成日期: 2023年10月31日	首次发表日期: 未发表	
以上事项, 由李文强申请, 经中国版权保护中心审核, 根据《作品自愿登记试行办法》规定, 予以登记。		
登记日期: 2023年12月11日	登记机构签章	
中华人民共和国国家版权局统一监制		

目录

作者简介	2
书评节选	3
绪言	5
第一章 阴阳平衡	8
第二章 天地自然	25
第三章 中医人体观念	53
3.1 人体基本概念及运转机制	54
3.2 人体元气	74
3.3 人体地气	90
3.4 人体天气	104
3.5 精	118
3.6 神	132
第四章 人体运行框架	146
第五章 人体部位的划分及病证的轻重传变	166
第六章 人体各类平衡波动	183
第七章 判断人体失衡情况	212
附录	232
附1：再论中医的阴阳概念	233
附2：证与病的关系	238
附3：诊治入门目录	243
后记	248